

عُثْمَانِيہ

گائناکالوجی

**GYNAECOLOGY / OBSTETRICS
&
NEONATOLOGY**

(بمعہ فیملی پلاننگ، گائناکالوجی، ماں اور بچے کی صحت)



ڈاکٹر محمد عثمان

عثمانیہ گائنا کالوجی

GYNAECOLOGY / OBSTETRICS
&
NEONATOLOGY

(بمعہ فیملی پلاننگ، گائنی الٹراساؤنڈ، ماں اور بچے کی صحت)

مؤلف

ڈاکٹر محمد عثمان

عثمانیہ پبلی کیشنز، پشاور - فون: 091-2262443

All rights reserved, no part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means i.e. electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher.



نام کتاب	: گائنا کالوجی
مؤلف	: ڈاکٹر محمد عثمان
ایڈیشن	: پہلا، جنوری 2019ء
تعداد	: 1000
کمپوزنگ	: ڈاکٹر محمد ارشد اقبال - فون: 0300-5911358
ڈایا گرامز	: ڈاکٹر خیر اللہ - فون: 0306-9749945
ٹائٹل	: عمار گرافکس - فون: 0335-2661623
ڈیجیٹل سپورٹ	: عابد منیر - فون: 0315-9955394
پرینٹر	: القلم پبلشرز محلہ جنگی پشاور - فون: 0335-9409818
نمائندہ	: اعتماد صدیقی، پشاور - فون: 0300-4640644
ڈسٹری بیوٹرز	: ناصر بک ایجنسی، ڈھکی نعلبندی، پشاور - فون: 091-2572277
پبلشرز	: عثمانیہ پبلی کیشنز، پشاور - فون: 091-2262443
قیمت	: 1250/- روپے

صفحہ	فہرست مضامین	پونٹ
06	گائنا کالوجی (GYNAECOLOGY)	1
17	مردانہ نظام تولید (MALE REPRODUCTIVE SYSTEM)	2
27	عورتوں میں تولیدی نظام کے ہارمونز (REPRODUCTIVE HORMONES IN FEMALES)	3
30	دوران حیض - مینسٹروئل سائیکل (THE MENSTRUAL CYCLE)	4
37	زنانہ امراض (FEMALE DISEASES)	5
98	امبریالوجی یعنی علم الجنین (EMBRYOLOGY)	6
107	فیٹس اور پلے سینٹا (FOETUS AND PLACENTA)	7
112	حمل اور اس کی ممکنہ پیچیدگیاں (PREGNANCY AND IT'S COMPLICATIONS)	8
159	حاملہ کی ہسٹری اور طبی معائنہ (HISTORY & CLINICAL EXAM: OF PREGNANT WOMAN)	9
175	حاملہ کا عمومی طبی معائنہ (GENERAL PHYSICAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMAN)	10

صفحہ	فہرست مضامین	پونٹ
181	حاملہ کے لئے مفید مشورے (ADVICES FOR PREGNANT FEMALE)	11
196	ولادت اور اس کی ممکنہ پیچیدگیاں (LABOUR AND IT'S COMPLICATIONS)	12
249	جڑواں بچوں کی پیدائش کے انتظامات (LABOUR MANAGEMENT OF TWIN BABIES)	13
251	پری میچورٹی (PREMATURITY)	14
261	پوسٹ میچورٹی (POST MATURTITY)	15
266	قبل از ولادت اور بعد از ولادت حاملہ کی نگہداشت (PRENATAL AND POSTNATAL CARE)	16
278	گائنا کولاجیکل اینڈ آبسٹیٹرککل الٹراساؤنڈ (GYNAECOLOGICAL & OBSTETRICAL ULTRASOUND)	17
304	نومولود بچہ (NEWBORN BABY)	18
313	نوزائیدہ کی اقسام (KINDS OF NEWBORN)	19
338	نومولود بچہ کی پیچیدگیاں (COMPLICATIONS OF NEWBORN)	20

صفحہ	فہرست مضامین	پونٹ
371	رضاعت، دودھ پلانا (LACTATION)	21
373	ماں کو ہدایات (ADVICES TO MOTHER)	22
379	بچوں کے متعدی امراض (INFECTIOUS DISEASES OF CHILDREN)	23
421	جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں (SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES)	24
436	توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات (ای۔پی۔آئی) (EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION, E.P.I)	25
444	فیملی پلاننگ کی اہمیت (IMPORTANCE OF FAMILY PLANNING)	26
453	گائنا کولاجیکل اینڈ آبسٹیٹریکل فارماکالوجی (GYNAECOLOGICAL & OBSTETRICAL PHARMACOLOGY)	27
495	نارمل لیبارٹری ویلیوز (NORMAL LABORATORY VALUES)	28
498	طبی معلومات عامہ (GENERAL MEDICAL KNOWLEDGE)	29
521	گائنا کولاجیکل ٹرمینالوجی (GYNAECOLOGICAL TERMINOLOGY)	30

یونٹ: 1

گائنا کالوجی

(GYNAECOLOGY)

گائنا کالوجی (Gynaecology): گائنا کالوجی میڈیکل سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں عورتوں کے اعضائے مخصوصہ اور ان سے متعلق بیماریوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

It is a branch of medical science which deals with the female reproductive system & its diseases.

آبسٹیٹرکس (Obstetrics): آبسٹیٹرکس میڈیکل سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں حمل، زچگی اور بعد از ولادت سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

It is a branch of medical science which deals with the pregnancy, labour & postnatal stages.

گائنا کالوجی اور آبسٹیٹرکس و امراض نسواں سے متعلق تفصیل سمجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے درج ذیل موضوعات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔

(Female Reproductive System)	1	زنانه نظام تولید۔
(Embryology)	2	امبریالوجی یعنی علم الجنین۔
(Menstrual Cycle)	3	دوران حیض۔
(Puberty in Females)	4	زنانه بلوغت۔
(Virginity)	5	کنوارہ پن۔
(Menopause)	6	سن یاس۔

درج بالا موضوعات سمجھ لینے کے بعد قارئین گائنا کالوجی اور آبسٹیٹرکس کے موضوعات تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر سمجھ لینے کے قابل ہو جائیں گے اگلے صفحات میں پہلے زنانه نظام تولید، مردانه نظام تولید، امبریالوجی، دوران حیض، زنانه بلوغت، کنوارہ پن اور سن یاس سے متعلق بحث کی جائیگی پھر اس کے بعد گائنا کالوجی اور آبسٹیٹرکس کے موضوعات پر سیر حاصل بحث کی جائے گی۔



زنانه نظام تولید

(FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

جس طرح سانس لینا، کھانا پینا، حرکت کرنا اور نشوونما پانا جانداروں کی بنیادی خصوصیات ہیں بالکل اسی طرح افزائش نسل یا نسل کو آگے بڑھانا بھی جانداروں کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی بناء پر جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا یہ عمل نظام تولید کے ذریعے قائم رکھتے ہیں۔ نسل کو آگے بڑھانے کیلئے نر اور مادہ دونوں کے نظام تولید حصہ لیتے ہیں اور ان دونوں کے نظام تولید ہی کے کام کر نیکی وجہ سے نسل آگے بڑھتی ہے انسانوں میں نر کا نظام تولید مردوں کا نظام تولید ہوتا ہے جبکہ مادہ کا نظام تولید عورتوں کا نظام تولید ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے نظام تولید میں فرق ہوتا ہے اور دونوں کے نظام تولید کے اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM)	زنانه نظام تولید
------------------------------	------------------

عورتوں کے نظام تولید کے اعضاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(External Reproductive Organs)	بیرونی اعضاء تولید	1
(Internal Reproductive Organs)	اندرونی اعضاء تولید	2

1۔ بیرونی اعضاء تولید (External Reproductive Organs): عورتوں کے بیرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہوتے ہیں جن کو مجموعی طور پر ولوا (Vulva) کہا جاتا ہے۔

The external reproductive organs of female contain following organs combinely called Vulva;

(Mons Pubis)	مونز پوبیس	i
(Labia Majora)	لیبیا میجورا	ii
(Labia Minora)	لیبیا مینورا	iii
(Vestibule)	ویسٹی بیول	iv
(Clitoris)	کلائی ٹورس	v
(Hymen)	ہائی مین	vi
(Bartholin's Glands)	بارتھولین گلینڈز	vii
(Perineum)	پیری نیئم	viii

i۔ مونز پبلس (Mons Pubis): یہ ایک چکنائی کی موٹی سی تہہ ہوتی ہے جو کہ سیم فیئرز کے سامنے اور بڑے لب کے اوپر موجود ہوتی ہے اور بلوغت کے دوران اسکے اوپر بہت سے بال اُگ آتے ہیں۔

It is a pad of fats laying in front of symphysis pubis & at above the labia majora. This area becomes with full of hairs at puberty.

ii۔ لیبا میجورا (Labia Majora): بڑے لب موٹی سی دو تہیں ہوتی ہیں جو کہ ولوا کی سائڈس بناتے ہیں۔ بڑے لب، جلد، چکنائی، خون کی رگوں اور اعصاب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بڑے لب تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔

The Labia majora are two thick folds which form the sides of the vulva. They are composed of skin, fats, blood vessels and nerves. The labia majora are about 7.5 cm long.

iii۔ لیبا مینورا (Labia Minora): چھوٹے لب، چھوٹی سی دو تہیں ہوتی ہیں جو کہ بڑے لب کے اندر اوپری حصہ میں واقع ہوتی ہیں۔ چھوٹے لب تحریک پانیوالے ایریکٹائل ٹشوز سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے لبوں میں بہت سارے سپے شیس گلینڈز ہوتے ہیں۔

The labia minora are two small folds of skin situated between the upper part of the labia majora. Labia minora contains erectile tissues. It contains numerous sebaceous glands.

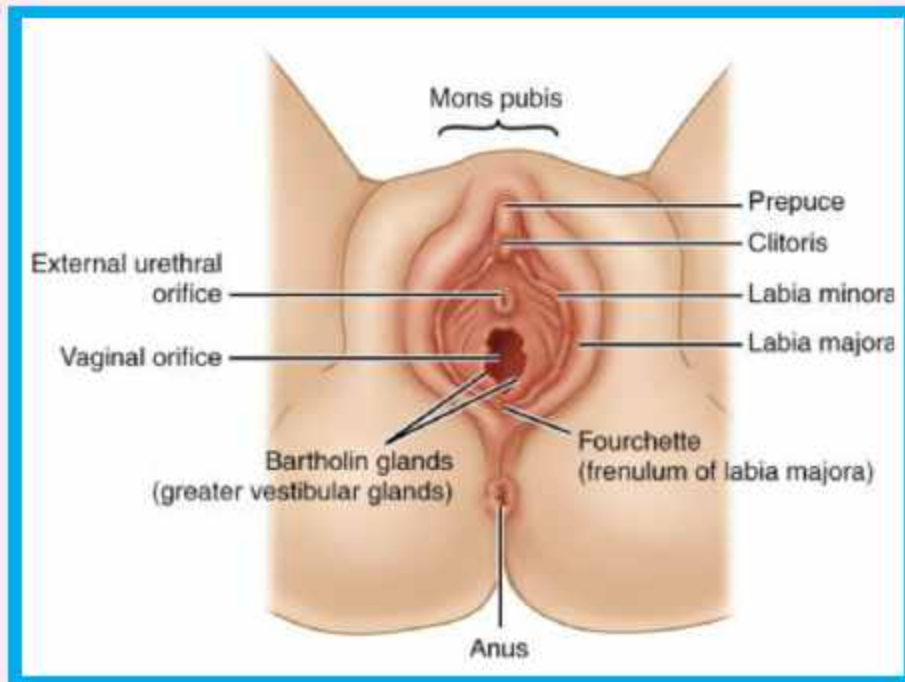
iv۔ ویسٹی بیول (Vestibule): چھوٹے لبوں کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے اسے ویسٹی بیول کہتے ہیں۔ اندام نہانی کا سوراخ، یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی کا سوراخ اور بارتھولین گلینڈز کی نالیاں ویسٹی بیول میں کھلتی ہیں۔

The cleft between labia minora is called vestibule. The vaginal orifice, urethral orifice & the ducts of the bartholin's glands open into the vestibule.

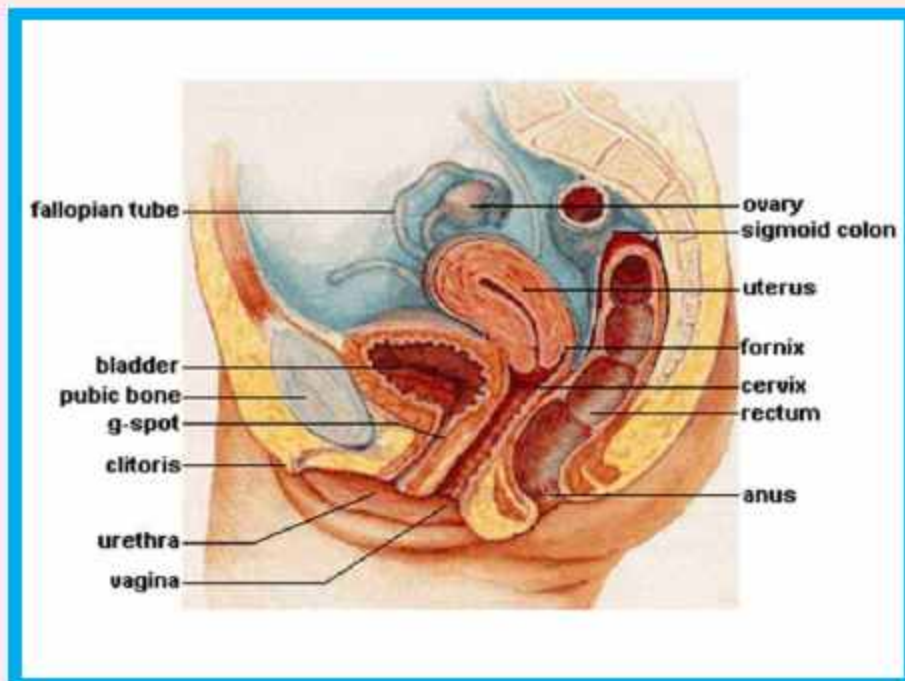
v۔ کلائی ٹورس (Clitoris): کلائی ٹورس ایک چھوٹی سی تحریک پانے والی چیز ہے جو کہ عورتوں میں مردوں کے عضو تناسل کی طرح تحریک پاتی ہے کلائی ٹورس میں تحریک پیدا ہونے کی وجہ سے عورتیں سیکس کی خواہش محسوس کرتی ہیں۔

The clitoris is a small erectile body which corresponds with the penis of male and the stimulation of clitoris causes desire of sexual intercourse in females.

vi۔ ہائی مین (Hymen): پردہ بکارت دراصل ایک پتلی سی میوکس ممبرین ہے جو کہ اندام نہانی کے سوراخ پر موجود ہوتی ہے۔ اس پردہ بکارت کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جو کہ اس لئے موجود ہوتا ہے تاکہ خون حیض اندر سے باہر کی جانب جاسکے۔ پردہ بکارت عورت کے بیرونی اور اندرونی اعضائے تولید کو جدا کرتا ہے۔



Female External Reproductive Organs



Female Internal Reproductive Organs

The hymen is a thin mucous membrane at the orifice of vagina. This hymen is perforated centrally to allow the menstrual discharge to drain away. Hymen separates external & internal genitalia.

vii۔ **بارتھولین گینڈز (Bartholin Glands):** بارتھولین گینڈز بڑے لبوں کے اندر دونوں جانب موجود ہوتے ہیں یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں اور سائز میں مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور ان کی نالیاں اندام نہانی کے سوراخ کے پاس کھلتی ہیں یہ گینڈز میوکس خارج کرتے ہیں جو کہ ولوا کو چکنائی سے تر رکھتے ہیں۔

The bartholin's glands lie in labia majora, one on each side near the vaginal opening. They are about the size of pea and have ducts, opening into the vestibule. They secrete mucous that keeps the vulva moist.

viii۔ **پیری نیم (Perineum):** یہ وہ حصہ ہے جو بیچانہ کے سوراخ اور مقعد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسکی لمبائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ پیری نیم دراصل مسلز اور فائبرس ٹشوز سے ملکر بنتی ہے جس پر بال اگ آتے ہیں۔ پیری نیم وضع حمل کے وقت پھیل کر بچے کی پیدائش میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ پیری نیم اگر سخت ہو اور وضع حمل کے وقت نہ پھیل سکے تو یہ پھٹ بھی سکتی ہے اور بچے کی پیدائش میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔

It is an area between vaginal orifice and anus. Its length is 5cm long. Perineum is made up of muscles & fibrous tissues, on which hairs grow. At the time of delivery perineum dilates and facilitate the process of child birth. If perineum is hard and could not dilate at the time of delivery then it may burst and may cause difficulty in delivery of baby.

2۔ اندرونی اعضاء تولید (Internal Reproductive Organs): عورتوں کے اندرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہیں؛

The internal reproductive organs of female contain following organs;

(Vagina)	i	بیچانہ۔
(Uterus)	ii	یوٹرس۔
(Fallopian Tubes)	iii	فیلوپین ٹیوبز۔
(Ovaries)	iv	اووریز۔

i۔ وچائندہ (Vagina): اندام نہانی 7.5 سینٹی میٹر لمبی فائبر و ماسکولر ٹیوب ہے جس پر سٹریٹی فائیڈ کی بنی ہوئی ممبرین چڑھی ہوتی ہے۔ اندام نہانی اندرونی اور بیرونی اعضائے تولید کو آپس میں ملاتی ہے۔ اندام نہانی کی باہری سطح ایریو لرنٹوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، درمیانی سطح سموٹھ مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور جبکہ اندرونی سطح سٹریٹی فائیڈ سکوائموس اپی تھیلیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اندام نہانی میں کسی طرح کے اخراجی گلینڈز موجود نہیں ہوتے لیکن اندام نہانی سرویکس کی خارج کردہ رطوبتوں کی وجہ سے تر رہتی ہے۔ بلوغت اور سن یاس کی درمیانی عمر میں اندام نہانی میں لیکٹو بیسی لس ایسڈو فیلس بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا لیکٹک ایسڈ خارج کرتے ہیں اور اندام نہانی کا پی ایچ، 4.9 سے 3.5 کے درمیان تک رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف جراثیم جو اندام نہانی میں آ جاتے ہیں یا اندام نہانی کے راستے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں اور اندر جا کر انفیکشن نہیں پھیلا سکتے۔ اندام نہانی کے اوپر کی جانب کے حصے نے رحم کے نچلے حصے سروکس کو پلپٹ رکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر اندام نہانی کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔

The vagina is a fibro muscular tube of about 7.5cm long, lined with stratified epithelium, connecting the external and internal organs of reproduction. The vagina has an outer covering of areolar tissue, a middle layer of smooth muscles & an inner lining of stratified squamous epithelium. It has no secretory glands but the surface is kept moist by cervical secretions. Between puberty and the menopause "Lactobacillus Acidophilus" bacteria are present. These microbes secrete "Lactic Acid" maintaining the pH between 4.9 and 3.5. The acidity inhibits the growth of most microbes that may enter into vagina. The vagina surrounds the lower part of cervix of the uterus and the walls of the vagina are normally in contact.

ii۔ یوٹرس (Uterus): یوٹرس یعنی رحم ایک موٹے مسلز کا بنا ہوا عضو ہے جو کہ پیلوئس میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس ریٹم اور مثانے کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن تقریباً ساٹھ گرام ہوتا ہے۔ یوٹرس کے تین حصے ہوتے ہیں اوپر والا حصہ فنڈس کہلاتا ہے، درمیانی حصہ باڈی اور نیچے والا حصہ سرویکس کہلاتا ہے۔ یوٹرس نیچے کی جانب اندام نہانی سے ملا ہوتا ہے اور اوپر کی جانب یوٹرائن ٹیوبز یا فیلوپین ٹیوبز یوٹرس کے فنڈس کے دائیں اور بائیں جانب تعداد میں ایک ایک واقع ہوتی ہیں۔ یوٹرس کی دیواریں تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں سب سے بیرونی تہہ پیری میٹریم کہلاتی ہے جو کہ اصل میں پیری ٹونیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری تہہ جو کہ سب سے موٹی ہوتی ہے مایو میٹریم کہلاتی ہے یہ تہہ کالمز اپی تھیلیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تہہ میں بہت سارے میوکس گلینڈز ہوتے ہیں۔ یوٹرس کے

افعال میں یہ شامل ہے کہ یہ فریلائزڈ اووم کو اپنے پاس رکھے اور اسے بڑھنے میں مدد دے۔ اس کے علاوہ جب اووم، اووری سے نکلتا ہے تو فیلوپین ٹیوب کے راستے یوٹرس میں آتا ہے۔ بلوغت کے بعد یوٹرس میں خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں اور یوٹرس حیض جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اینڈومیٹریم میں تبدیلیاں آتی ہیں تاکہ اگر اووم فریلائزڈ ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے تو اینڈومیٹریم میں رہ سکے۔ حمل کے دوران جو کہ عام طور پر چالیس ہفتے رہتا ہے یوٹرس بڑھتا رہتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو یوٹرس آہستہ آہستہ سکڑتا ہے اور بچے کی پیدائش میں مدد دیتا ہے اور پلاسینٹا کو باہر نکالتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس آہستہ آہستہ دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ یوٹرس کے واپس اپنی اصلی حالت میں آنے کو ان والیوشن آف یوٹرس کہتے ہیں۔

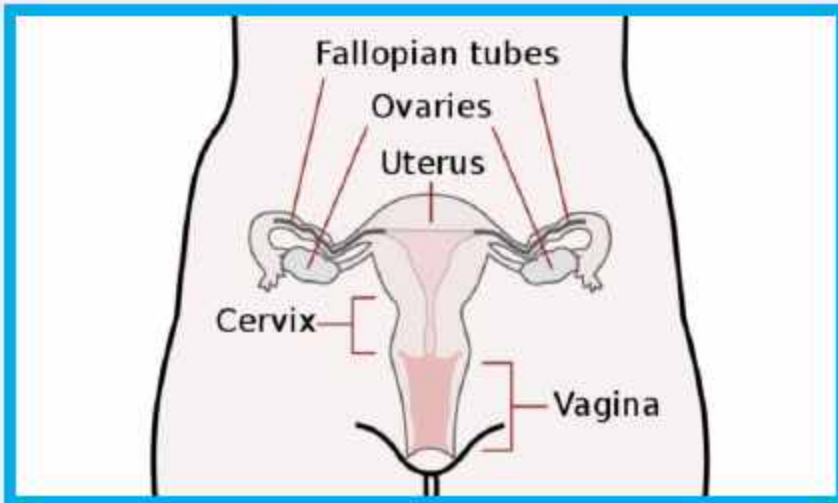
The uterus is a thick, muscular pear shaped organ situated in the pelvis between the rectum behind and bladder in front. The uterus is about 7.5 cm long and weighs about 60 grams. It contains three parts, the upper one is called 'FUNDUS', the middle one is called 'BODY' & the lower part is called 'CERVIX'. The uterus communicates below with vagina and above with the fallopian or uterine tubes, which lies at the sides of uterus. The walls of uterus are composed of three layers of tissues the Perimetrium, Myometrium and the Endometrium. The perimetrium consists of 'Peritoneum' is distributed differently on the various surfaces of the uterus. Myometrium is the thickest layer of tissue in the uterine walls. It consists of a mass of smooth muscle fibres interlaced with areolar tissues, blood vessels and nerves. Endometrium consists of columnar epithelium. It contains large numbers of mucous secreting lobular glands. The function of uterus is to retain the fertilized ovum during development and an ovum when it is released from an ovary is conveyed along a uterine tube to the uterus. After puberty, uterus goes through a regular cycle of changes called the menstrual cycle. The endometrium has been prepared for the reception of the fertilized ovum. During pregnancy, which normally lasts for 40 weeks, the uterus increases in size. When the time of labour comes, the uterus contracts rhythmically & expels the baby & placenta. After the process of labour the uterus returns approximately to its normal size by a process known as "Involution Of Uterus".

iii۔ **فیلوپین ٹیوبز (Fallopian Tubes):** فیلوپین ٹیوبز یا یوٹرائن ٹیوبز تعداد میں دو ہوتی ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں جانب اوپر کے حصے میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز یوٹرس کے دائیں اور بائیں جانب باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ یوٹرس سے شروع ہوتے ہوئے یہ تنگ ہوتی ہیں اور اس حصے کو یوٹرائن اینڈ کہتے ہیں۔ آگے جا کر یہ ٹیوب پھیل جاتی ہے اور ایمپیو لاکھلاتی ہے اور پھر آخر کار نیچے کی جانب مڑ کر پھیل جاتی ہے، ٹیوب کے اس حصے کو فمپریڈ مارجن کہتے ہیں۔ ان ٹیوبز میں سیلی ایڈاپی تھیلیم ہوتے ہیں۔ یوٹرائن ٹیوبز کا کام یہ ہے کہ یہ اووری سے پیدا شدہ اووم کو یوٹرس تک پہنچاتی ہیں اور اووم کو فرٹیلائزیشن کے لئے جگہ مہیا کرتی ہیں۔

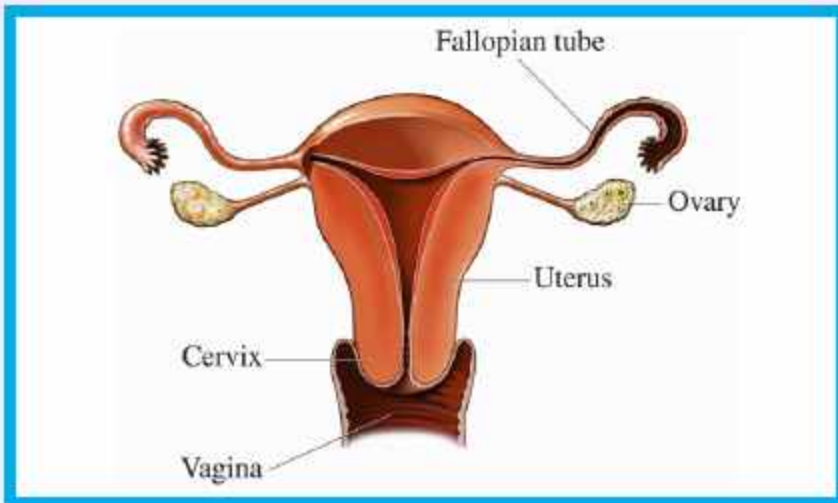
The uterine tubes are two in numbers pass one on each side from the upper angles of the uterus outwards. They are about 10 cm long and there uterine ends are narrow then they enlarge forming the ampulla and finally bends downwards to end in fimbriated margin. The uterine tubes are lined with ciliated epithelium. The normal function of the uterine tubes are to convey the ovum from the ovary to the uterus. It also provides the site where fertilization occurs.

iv۔ **اووریز (Ovaries):** اووریز یا خصبیۃ الرحم دو بادام نما گلینڈ ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں طرف تعداد میں ایک ایک موجود ہوتے ہیں۔ اووریز دونوں جانب یوٹرائن ٹیوب کے عین نیچے واقع ہوتی ہیں اور یوٹرس کے ساتھ اوویرین لیگامینٹ کے ذریعے ملی ہوتی ہیں۔ اووریز کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے اووم ہوتے ہیں جنہیں پرائمری اووسائٹس کہتے ہیں۔ ہر دفعہ ہر مہینے کے شروع میں ان پرائمری اووسائٹس میں سے ایک اووسائٹ بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور گریفین فالیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس گریفین فالیکل میں سے ایک اووم نکلتا ہے اور یوٹرائن ٹیوب میں سے ہوتا ہوا یوٹرس کی جانب جاتا ہے۔ اووریز کے تین افعال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اووریز اووم بناتی ہیں، دوسرے یہ کہ ایسٹروجن ہارمون بناتی ہیں اور تیسرا یہ کہ پروجیسٹرون ہارمون بناتی ہیں۔

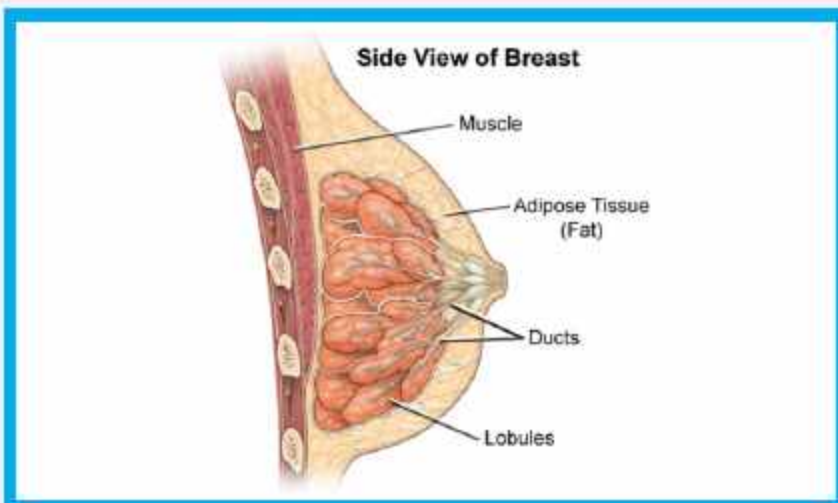
The ovaries are two almond shaped glands placed one on each side of the uterus below the uterine tubes. The ovaries are attached with the uterus through the ovarian ligaments. The ovaries contain a large numbers of immature ova called "Primary Oocytes". At each menstrual cycle one of these premature ova begins to mature & quickly develops into a "Graffian Follicle". Each month one follicle develops & one ovum sets free and extruded at about the middle (14th day) of the menstrual cycle. The ovaries produce oestrogens hormone & also progesterone hormone.



Female
Reproductive
Organs



Vagina
Uterus
Fallopian Tubes
Ovaries



Female
Breast

پستان (Breasts): پستان تعداد میں دو ہوتے ہیں جو کہ سترنم اور بغل کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ پستان دوسری یا تیسری پسلی سے شروع ہوتے ہیں اور چھٹی یا ساتویں پسلی تک موجود ہوتے ہیں اور دودھ پیدا کرتے ہیں۔ بلوغت کے دوران پستان بڑے ہو جاتے ہیں اور حمل کے دوران اپنے نارل سائز سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں پستان سکڑ جاتے ہیں۔

پستان سینے پر آگے کی جانب ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پستانوں کے درمیان میں ایک ابھار سا ہوتا ہے جسے نپل کہتے ہیں یہ نپل پستان کی نسبت ذرا گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور نپل جلد اور تحریک پانے والے ایریکاکل ٹشوز سے ملکر بنا ہوتا ہے۔ نپل کے ارد گرد پستانوں پر ایک دائرہ سا موجود ہوتا ہے جسے ایریولا کہتے ہیں۔ نپل کے نچلے ایریا میں خاص قسم کے سپیش گلینڈز موجود ہوتے ہیں جنہیں گلینڈز آف مٹنگری بھی کہتے ہیں۔ یہ گلینڈز اپنی رطوبت کے ذریعے نپل کو چمکانا رکھتے ہیں۔ نپل میں پندرہ سے لے کر بیس تک سوراخ موجود ہوتے ہیں جو کہ دراصل پستان کے دودھ کی نالیاں ہوتی ہیں۔

پستان میں میمری گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور ان گلینڈز میں بہت سارے ایلیولائی ہوتے ہیں۔ یہ ایلیولائی ایک خاص قسم کی نالیوں میں کھلتے ہیں۔ ان نالیوں کو لیٹی فیرس ڈکٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری لیٹی فیرس ڈکٹس آپس میں مل کر بڑی ڈکٹس بناتی ہیں اور جوں ہی یہ بڑی ڈکٹس نیچے نپل تک پہنچتی ہیں تو نپل میں داخل ہونے سے پہلے پھیل کر لیٹی فیرس سائی نسر بناتی ہیں۔ ان سائی نسر میں دودھ میمری گلینڈز سے نکل کر جمع رہتا ہے پھر یہ سائی نسر دوبارہ تنگ ہو کر ملک ڈکٹس بناتے ہوئے نپل میں کھل جاتی ہیں۔

پستانوں کا کام یہ ہے کہ یہ دودھ بنائیں اور جب بچہ پستان کو چوسے تو پستانوں میں سے دودھ نکل کر بچے کے منہ میں جائے اور اس کی غذا بنے۔ حمل کے سولہویں ہفتے ہی سے پستانوں میں ایک خاص قسم کی رطوبت بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دودھ کی نالیوں کو کھلا رکھتی ہے اور پستانوں کو اپنے افعال سرانجام دینے کے لئے تیار رکھتی ہے۔

بچے کی پیدائش کے بعد دو سے تین دن تک پستانوں سے ایک پتلی سے رطوبت آتی ہے جسے کلا سٹرم کہتے ہیں۔ یہ رطوبت پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر پستانوں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے کا ایک ہارمون پرولکٹن پستانوں میں دودھ بنانے کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔

The mammary glands are two in numbers which lie in the superficial fascia on the pectoral region between the sternum and axilla and extended from about the 2nd or 3rd to the 6th or 7th ribs. The mammary glands secrete milk. The mammary glands enlarge at puberty and increase in size during pregnancy and after delivery. They atrophy in old age.

The breasts are convex anteriorly with a prominence in the middle called nipple which consists of skin and erectile tissues and is dark in colour. The nipple is encircled by an area called the Areola. Near the base of nipple there are sebaceous glands called the glands of Montgomery which secrete fatty substances for keeping the nipple supple. The nipple is perforated by 15-20 orifices, which are milk ducts of a gland.

The breasts consist of mammary gland substances. Each lobule consists of a cluster of alveoli opening into tubules or lactiferous ducts which unite with other ducts to form the larger ducts and terminate in the excretory ducts. As the ducts approach to nipples, they expand to form reserves for the milks, these are called the Lactiferous sinuses, the ducts then narrow to pass through the nipple and open on to its surface.

Lactation or the secretion of milk and its discharge from the breasts in suckling is the function of the breast. There is a little secretion in the breast from 16th week of pregnancy, which keeps the ducts open and ready to function.

After a birth of a baby a thin fluid "Colostrum" which is rich in protein is secreted during the first 2 to 3 days then a free flow of milk is established gradually becoming a mature milk. A hormone of anterior pituitary prolactin is important in stimulating the secretion of milk.



یونٹ: 2

مردانہ نظام تولید

(MALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

تعارف (Introduction): مرد کے نظام تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہوتے ہیں؛

The male reproductive system consists of the following organs;

(Scrotum)	1	خصیوں کی تھیلی سکروٹم۔
(Two testes)	2	دو خصیے یعنی ٹیسٹس۔
(Two epididymis)	3	دو اپی ڈیڈیمی مس۔
(Two deferent ducts)	4	دو ڈیفرینٹ ڈکٹس۔
(Two spermatic cords)	5	دو سپرمینک کارڈز۔
(Two seminal vesicles)	6	دو سمنل ویزیکلز۔
(Two ejaculatory ducts)	7	دو ایجاکولیٹری ڈکٹس۔
(One prostate gland)	8	ایک پراسٹیٹ گلینڈ۔
(One penis)	9	ایک عضو تناسل یعنی پی نیس۔

1۔ سکروٹم (Scrotum): سکروٹم جلد کی بنی ہوئی ایک تھیلی ہے جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے سکروٹم کے ہر حصے میں ایک خصیہ ایک اپی ڈیڈیمی مس اور سپرمینک کارڈ کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے سکروٹم سیکشی سزپوبس کے نیچے اور رانوں کے درمیان اوپری جانب پی نیس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔

The scrotum is a pouch of skin divided into two compartments, each of which contains one testicle, one epididymis and the testicular end of spermatic cord. Scrotum lies below the symphysis pubis, in front of the upper parts of the thighs and behind the penis.

2۔ ٹیسٹیز (Testes): ٹیسٹیز نظام تولید کے غدود ہیں جو کہ مردوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ عورتوں میں اورریز ہوتی ہیں۔ ٹیسٹیز تعداد میں دو ہوتے ہیں ہر ٹیسٹیکل کی لمبائی تقریباً 4.5 سینٹی میٹر، چوڑائی 2.5 سینٹی میٹر اور موٹائی تقریباً 3 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ ٹیسٹیز سکروٹم میں سپرینٹک کارڈز کے ذریعے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کے ٹیسٹیز خود بچے کے پیٹ میں گردوں کے نیچے نشوونما پاتے ہیں اور پھر حمل کے آٹھویں مہینے میں یہ ٹیسٹیز سکروٹم میں اتر آتے ہیں۔ ٹیسٹیز میں سپرمز پچھوٹری گلیڈنڈ کے اگلے حصے کے ایک ہارمون فالیکل سٹیولیٹنگ ہارمون کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں جبکہ ٹیسٹیز، پچھوٹری گلیڈنڈ کے اگلے حصے کے ایک اور ہارمون لیوٹی ٹائزنگ ہارمون کے زیر اثر مردوں کا سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرتے ہیں۔ بلوغت کے وقت ٹیسٹیز سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مردوں میں کئی قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں مثلاً داڑھی کے بال آنا، آواز میں گہرائی اور بھاری پن آ جانا اور اعضائے تناسل کا اپنے نارمل سائز سے بڑھ جانا وغیرہ۔

The testes are reproductive glands of the male equivalent of the ovaries in the female and are two in numbers. These are about 4.5 cm long, 2.5 cm wide and 3 cm thick and are suspended in the scrotum by the spermatic cords. The testes develop in the abdominal cavity just below the kidneys during fetal life and descends through the right and left inguinal canals in to the scrotum by the 8th month of pregnancy. In testes the spermatazoa are formed and the male sex hormone, testosterone is produced. The spermatazoa are formed under the effect of Follicle Stimulating Hormone (F.S.H) of anterior pituitary and testosterone hormone is produced under the effect of Leutienizing Hormone (L.H) of anterior pituitary. The secretion of testosterone increases markedly at puberty and is responsible for the development of secondary sexual characteristics e.g. growth of beared, deeping of the voice and enlargement of the genetalia etc.

3۔ اپی ڈیڈیمی (Epididymis): اپی ڈیڈیمی مس ایک چھوٹا سا جسم ہے جو کہ ہر ٹیسٹیکل کے پیچھے موجود ہوتا ہے اور ٹیسٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپی ڈیڈیمی مس ایک لمبی سی تنگ مڑی مڑی نالی ہوتی ہے جو کہ ٹیسٹیز کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ سپرم ٹیسٹیز سے نکل کر اپی ڈیڈیمی مس سے گزرتے ہوئے ڈیفیرینٹ ڈکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔

The epididymis is a small organ lying behind the testes and attached to it. It consists of a very long narrow tube which is extensively ascends up behind the testes. Through this tube the sperms pass from the testes in to the deferent ducts.

4۔ ڈیفرینٹ ڈکٹس (Deferent Ducts): ڈیفرینٹ ڈکٹس ایک نالی نما چیز ہے جو کہ اپنی ڈیڈی مس کے نچلے حصے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر جا کر پیلوک کیوٹی میں داخل ہو جاتی ہے۔

The deferent duct is a duct passing from the lower aspect of the epididymis. It ascends behind the testes enters in to the spermatic cord and reaches the abdominal cavity through the inguinal canal and finally passes in to the pelvis.

5۔ سپرمٹک کارڈز (Spermatic Cords): سپرمٹک کارڈز تعداد میں دو ہوتی ہیں جو کہ ہر ٹیسٹیکل سے شروع ہوتی ہیں۔ سپرمٹک کارڈز کے ہی ذریعے ٹیسٹیکل سکرٹم میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سپرمٹک کارڈ، ڈیفرینٹ ڈکٹ کے گرد لپی ہوئی ہوتی ہے سپرمٹک کارڈ اوپر پیلوکس میں مٹانے کے عین پیچھے تک موجود ہوتی ہے۔

There are two spermatic cords, leading from each testicle in the scrotum. It surrounds the deferent duct. It passes through the inguinal canal upwards from the testes and ascends medially towards the posterior wall of the bladder.

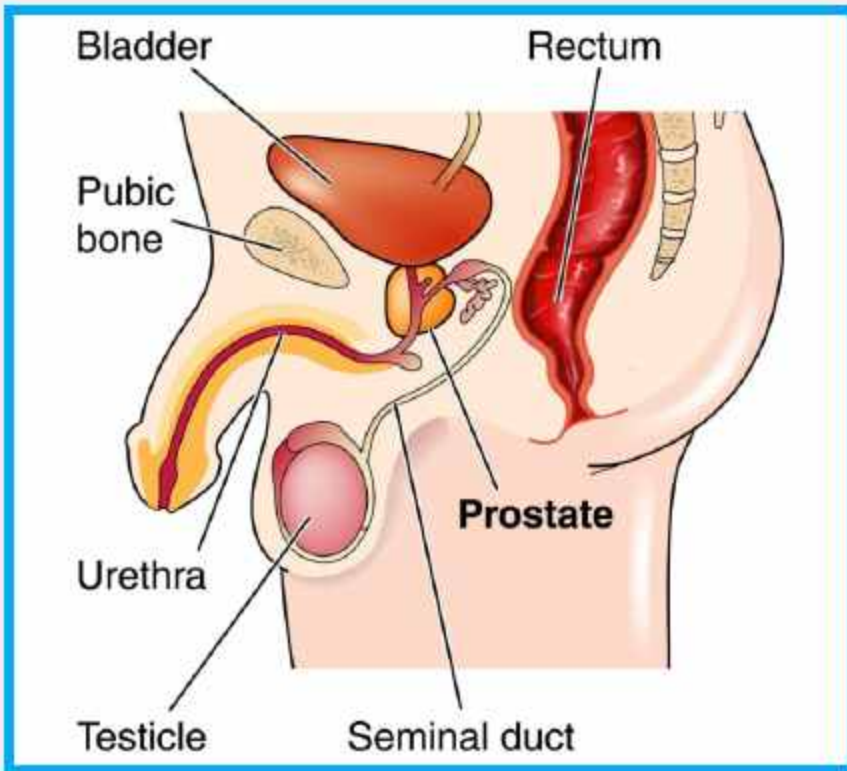
6۔ سیمینل ویزیکلز (Seminal Vesicles): سیمینل ویزیکلز دراصل دو غدد ہیں جو کہ مٹانے کی گردن کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ اس کی نالیاں ڈیفرینٹ ڈکٹ کے ساتھ ملتی ہیں اور ایجا کو لیٹری ڈکٹ بناتی ہیں۔ سیمینل ویزیکلز کی رطوبت مادہ تولید منی کا ایک اہم اور ضروری جزو ہے۔

The seminal vesicles are paired tubular glands situated behind the neck of bladder, its ducts join with the deferent ducts to form the common ejaculatory duct. The secretion of the seminal vesicles is an essential component of seminal fluid.

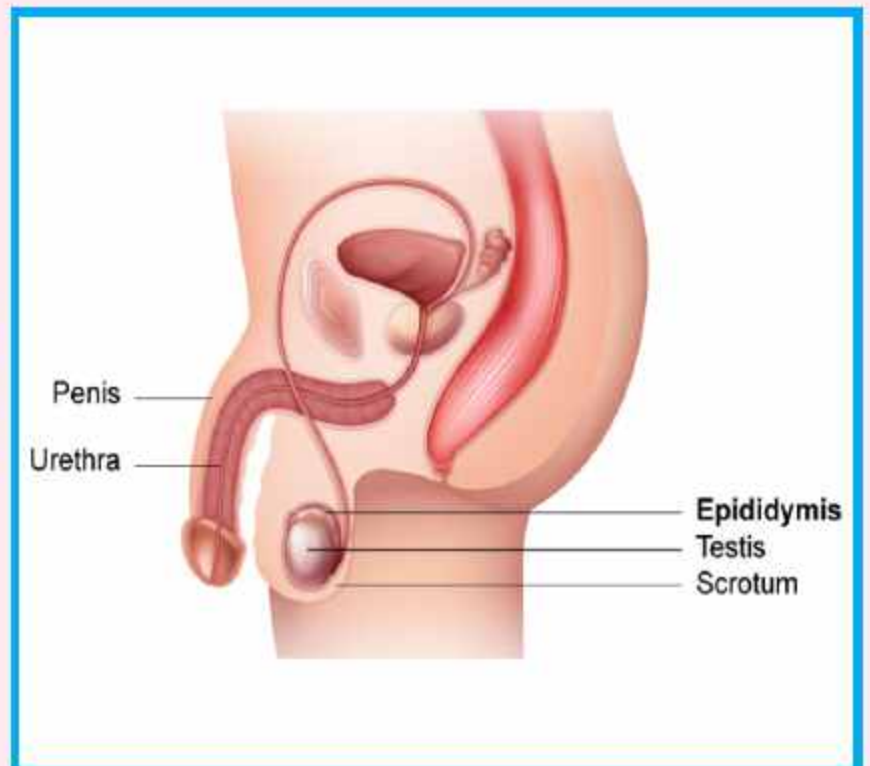
7۔ ایجا کو لیٹری ڈکٹس (Ejaculatory Ducts): ایجا کو لیٹری ڈکٹس دراصل دو عدد ٹیوب ہیں جو کہ دو سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں ہر ایجا کو لیٹری ڈکٹ، سیمینل ویزیکل کی ڈکٹ اور ڈیفرینٹ ڈکٹ کے ملنے سے بنتی ہیں یہ ایجا کو لیٹری ڈکٹ پراسٹیٹ گلینڈ سے گزر کر یوریتھرا میں کھلتی ہیں۔

The ejaculatory ducts are two tubes about 2 cm long, each formed by the union of duct from a seminal vesicle & a deferent duct. They pass through prostate gland & joins the prostatic urethra.

8۔ پراسٹیٹ گلینڈ (Prostate Gland): پراسٹیٹ گلینڈ مٹانے کے نیچے موجود ہوتا ہے جو کہ یوریتھرا کے ارد گرد موجود ہوتا ہے یہ یوریتھرا کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ ایک رطوبت خارج کرتا ہے جو کہ ٹیسٹیکل رطوبت کے ساتھ مل جاتی ہے۔



Male
Reproductive
Organs



Penis
Urethra
Bladder
Testicle

The prostate gland lies below the bladder, surrounding the urethra. The prostate gland secretes a thin lubricating fluid which mingles with the secretion of testes.

9۔ پی نیس (Penis): پی نیس ایک ٹیوب سی ہوتی ہے۔ اس کے پچھلے حصے کو جڑ اور درمیانے حصے کو باڈی کہتے ہیں اس میں ایریکٹائل یعنی تحریک پانے والے مسلز اور غیر ارادی مسلز ہوتے ہیں پی نیس کے سائیڈوں پر مسلز کے دو کالم ہوتے ہیں جنہیں کارپس کیورنوسا کہتے ہیں اور درمیانے کالم کو کارپس سپونجیوسم کہتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ گلانس پی نیس کہلاتا ہے جو کہ ذرا پھیلا ہوا اور ٹکونی شکل کا ہوتا ہے۔ پی نیس میں خون کی بہت زیادہ سپلائی ہوتی ہے۔ پی نیس کو آٹونومک اور سویٹک نرو سپلائی کرتی ہیں۔ پیرا سپے تھیک نروس سسٹم کی وجہ سے پی نیس میں خون بہت زیادہ چلا جاتا ہے اور پی نیس میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور پی نیس اپنے نارٹل سائز سے بڑھ کر اکڑ جاتا ہے۔

The penis has a root and a body. It is formed by three elongated masses of erectile tissues & involuntary muscles. The two lateral columns are called corpus cavernosa and the column between them is the corpus spongiosum. Its tip is expended into a triangular structure know as glands penis. The penis has a rich blood supply. The penis is supplied by autonomic & somatic nerves. Para-sympathetic nerves stimulation leads to engorgement with blood & erection of penis.



مردانہ نظام تولید کے افعال

(FUNCTIONS OF MALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

1۔ مردوں کے اعضاء تناسل پر کام کرنے والے گونیڈوٹروفنز ہارمون، فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹنیٹک ہارمون ہیں جو کہ پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہوتے ہیں۔

The male reproductive organs are stimulated by the gonadotrophic hormones Follicle Stimulating Hormone (F.S.H) and Leutienizing Hormone (L.H) from the anterior lobe of pituitary gland.

2- فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹیسٹیز پر اثر انداز ہو کر سپرم خارج کرواتا ہے۔

The F.S.H stimulates the testes to produce the male reproductive cells the spermatozoa.

3- مرد کے سپرمز جنسی عمل کے دوران عورت کے اندام نہانی میں جانے کے لئے اپنی ڈیڈی مس، سمینل ویزیکلز ڈیفیریٹ ڈکٹس، ایجاکولٹری ڈکٹ اور یوریتھرا سے ہو کر گزرتے ہیں۔

The Sperms pass through the epididymis, deferent ducts, seminal vesicles, ejaculatory ducts and the urethra to be implanted in the female vagina during coitus.

4- لیوٹنایزنگ ہارمون ٹیسٹیز پر اثر کر کے مردوں کا جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون خارج کرواتا ہے۔

The Leutenizing Hormone stimulates testes to products the male sex hormone the testosterone.

5- اپنی ڈیڈی مس اور ڈیفیریٹ ڈکٹ میں مردوں کے سپرمز مزید میچور ہو جاتے ہیں اور مزید حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

In the epididymis and in deferent duct the sperms become more mature and are more capable of independent movements.

6- مرد کے ایک مرتبہ ڈسچارج ہونے میں 2 سے 5 ملی لیٹر مادہ تولید خارج ہوتا ہے جسکے ہر ملی لیٹر میں 40 سے 120 ملین تک سپرمز ہوتے ہیں۔

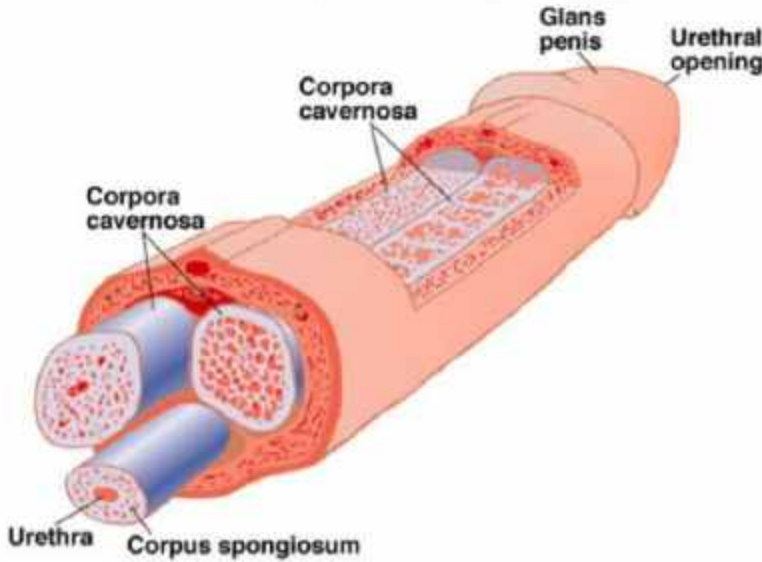
An ejaculation usually consist of 2 to 5 ml of semen containing 40 to 100 million sperms per ml.

7- اگر سپرمز پیپس سے خارج نہ ہو سکیں تو دوبارہ ٹیسٹیز کی ٹیوبولز میں جذب ہو جاتے ہیں۔

If the sperms are not ejaculated, the sperms are reabsorbed by the tubules in the testes.

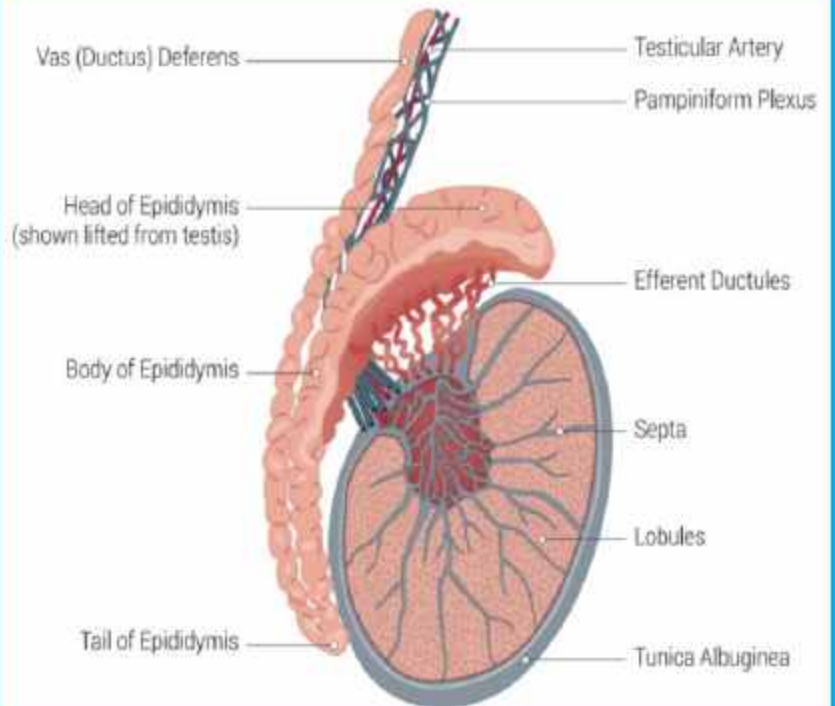
8- سپرمز بننے کا کامیاب عمل صرف تین سینٹی گریڈ پر ہی ہو سکتا ہے جو کہ عام جسم کی حرارت سے کافی کم ٹمپریچر ہے۔

Successfully spermatogenesis takes place at a temperature about 3 degree centigrade which is lower than normal body temperature.



**Penile
Internal
Anatomy**

**Testicle
Epididymis
Vas Deferens
Efferent Ductules**



9- سپرم بننے کیلئے اتنا کم ٹمپریچر ممکن ہے کیونکہ ٹیسٹیز سکروٹم میں موجود ہوتی ہے اور سکروٹم ٹشو کی بہت ہی پتلی اور باریک تہہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔

This lower temperature is possible because the testes in the scrotum are covered by only a thin layer of tissues.

10- مردوں میں نسل بڑھانے کا عمل اسی نظام تولید کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔

In males the process of reproduction takes place due to the male reproductive system.



منی (SEMEN): منی ایک ایسا گاڑھا مائع ہے جو کہ مرد جنسی عمل کے آخر میں یوریتھرا سے خارج کرتا ہے منی میں درج ذیل اجزاء شامل ہوتے ہیں

Semen is a fluid ejaculated from the male urethra during coitus. It consists of;

1- مادہ تولید میں سپرم شامل ہوتے ہیں۔

Semen contains sperms.

2- مادہ تولید میں ایک اور گاڑھی قسم کی رطوبت بھی شامل ہوتی ہے جو کہ سیمینل ویزیکل خارج کرتی ہے یہ رطوبت سپرمز کی پرورش کرتی ہے۔

A viscid fluid secreted by the seminal vesicles, which helps to nourish the sperms.

3- مادہ تولید میں پتلی سی چکنی رطوبت بھی شامل ہوتی ہے جو کہ پراسٹیٹ گلینڈ سے نکلتی ہے۔ یہ رطوبت سیکس کے دوران یوریتھرا کو چکنا کرکتی ہے۔

A thin fluid produced by the prostate which lubricates the urethra during sexual excitement.

4- مادہ تولید میں یوریتھرا کی جھلیوں میں موجود میوکس گلینڈز کا میوکس بھی شامل ہوتا ہے۔

Mucous secreted by glands in the lining membrane of urethra also mixed with semen.



مردانہ زمانہ بلوغت

(PUBERTY IN MALE)

تعارف (Introduction): پو برٹی مردوں میں بلوغت کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں مرد کی جسمانی نشوونما، جنسی نشوونما اور جنسی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے عام طور پر مردوں میں زمانہ بلوغت عموماً 14 سے 16 سال کی عمر میں آتا ہے۔

This is a period of increased general body growth sexual characteristic & sex organs, usually sets in at the age of 14 to 16 years of life.

بلوغت کی وجوہات (Caused Of Puberty): بلوغت سے پہلے پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے فالیکل سٹیمولینگ ہارمون اور لیوٹی ٹائزنگ ہارمون خارج نہیں ہوتے لیکن زمانہ بلوغت میں یہ ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مرد کی ٹیسٹیز پر اثر کرتے ہیں اور ٹیسٹیز پر مز اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یوں مردوں میں بلوغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔

Before puberty there is no secretion of Follicle Stimulating Hormone (F.S.H) and Leutienizing Hormone (L.H) from the anterior pituitary, but at puberty it starts to secrete, affecting the testes, which starts to secrete sperms and the testosterone hormone and puberty occurs.

بلوغت کی عمر میں تبدیلیاں (Changes During Puberty In Males): بلوغت کی عمر میں پہنچنے پر مردوں میں درج ذیل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں:

In males following changes occur during puberty;

(Muscular growth)	1 عضلات کی نشوونما ہوتی ہے۔
(Growth of bones)	2 ہڈیوں کی نشوونما ہوتی ہے۔
(Marked increase in height)	3 قد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
(Marked increase in weight)	4 وزن میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

(Enlargement of larynx & deeping of the voices)	5	لیرنکس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے۔
(Growth of hairs on face)	6	چہرے پر بالوں کی نشوونما ہو جاتی ہے۔
(Growth of hairs in axillae)	7	بغلوں میں بالوں کی نشوونما ہو جاتی ہے۔
(Growth of hairs on chest)	8	سینے پر بالوں کی نشوونما ہو جاتی ہے۔
(Growth of hairs on pubis)	9	زیر ناف بال بڑھ جاتے ہیں۔
(Enlargement of pens, scrotum & prostate)	10	عضوتناسل، خصیوں کی تھیلی اور پراسٹیٹ غدود بڑھ جاتے ہیں۔
(Testosterone starts to secrete)	11	ٹیسٹوسٹیرون ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
(Spermatozoa start to produce)	12	سپرمزوفٹا شروع ہو جاتے ہیں۔



عثمانیہ نیا پتہ سی کی میڈیٹر

یونٹ: 3

عورتوں میں تولیدی نظام کے ہارمونز

(REPRODUCTIVE HORMONES IN FEMALES)

تعارف (Introduction): جب کوئی لڑکی بلوغت کے مراحل کو طے کر لیتی ہے تو اس کے اندر اس کے تولیدی نظام میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بعد نسل کو بڑھانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔

بلوغت کے بعد لڑکی اور ریز (Ovaries) یا بیضہ دانیوں مختلف قسم کے ہارمونز خارج کرتی ہیں۔

اور ریز سے چار طرح کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔

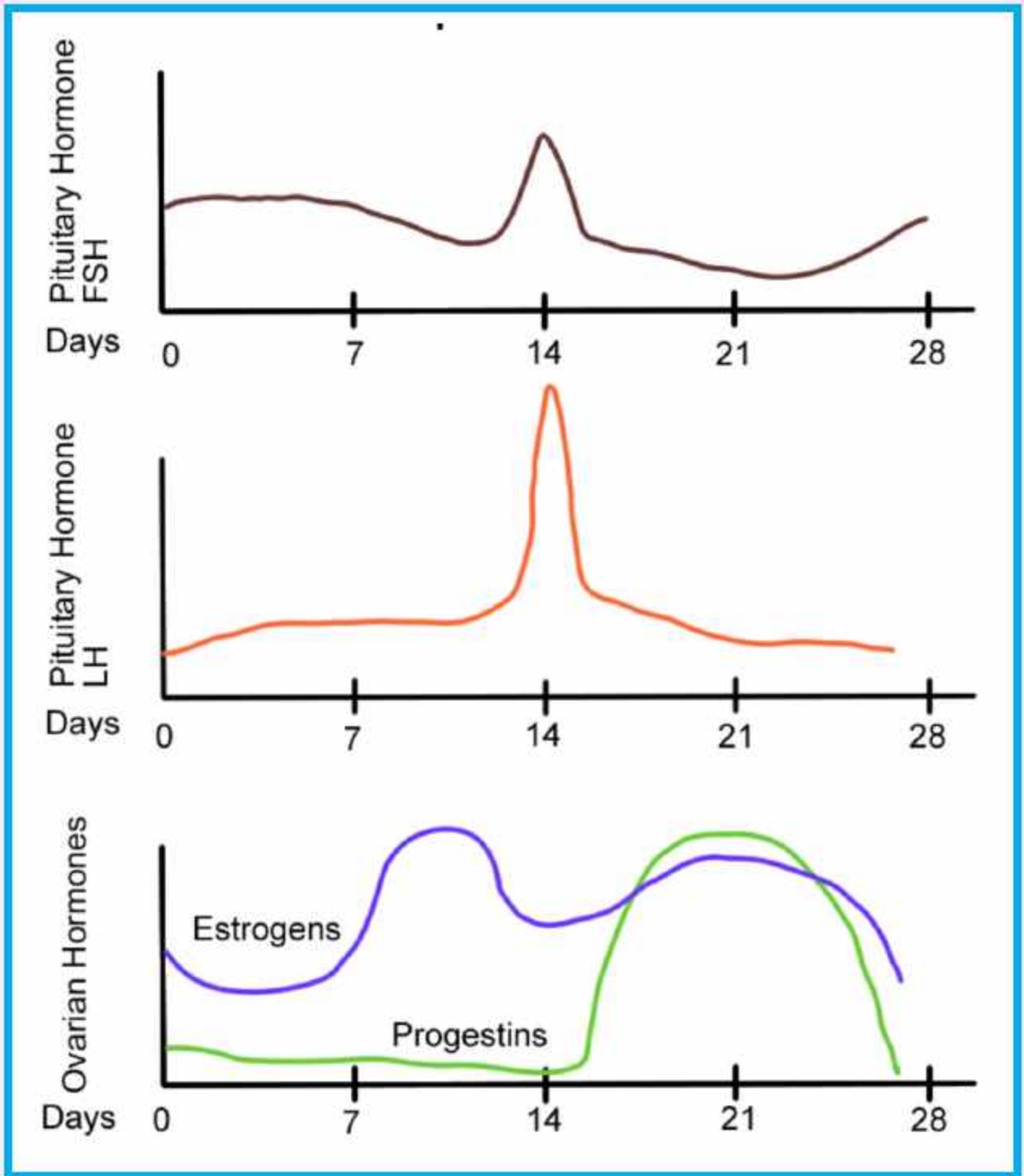
1	ایسٹروجن ہارمون۔	(Oestrogen Hormone)
2	پروجسٹرون ہارمون۔	(Progestron Hormone)
3	اینڈروجن ہارمون۔	(Andorgen Hormone)
4	ریلکسن ہارمون۔	(Relasin Hormone)

متذکرہ بالا چاروں ہارمونز میں دو ہارمون ایسٹرون اور پروجسٹرون زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان ہارمون کا تعلق پچوٹری گلینڈ کے ہارمونز F.S.H اور L.H سے ہے۔ ذیل میں ہم مذکورہ دو اہم ہارمونز کا ذکر کر رہے ہیں۔

ایسٹروجن ہارمونز کا تعلق پچوٹری گلینڈ کے ہارمون فولیکلر اسٹیمولیٹنگ ہارمون (ایف ایس ایچ) Follicles Stimulating Hormone سے ہے یہ F.S.H کے زیر اثر پیدا ہوتا ہے اسکی پیدائش گرینولوسا سیل (Granulosa Cell) اور تھیکا (Theca) سے ہوتی ہے یہ ہارمون کارپس لیوٹم کے ختم ہونے تک پیدا ہوتے رہتے ہیں

ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر بلوغت کی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں:

- ☆..... یہ ہارمون نظام حیض میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- ☆..... اس کی پیدائش Follicular Phase کے دوران ہوتی ہے اور Luteal Phase میں بھی جاری رہتی ہے۔
- ☆..... دوران حمل ہونے والی تبدیلیوں میں یہ ہارمون اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- ☆..... اعضائے تولید کی نشوونما میں یہ ہارمون اہم کام کرتا ہے۔



Female Reproductive Hormones

☆..... عورتوں کے پستان میں دودھ کے پیدا ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

☆..... اس ہارمون کی وجہ سے رحم کا سائز بڑھتا ہے۔

☆..... رحم سے ہونے والے اخراج خون کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔

☆..... یہ ہارمون رحم کی جھلی اینڈومیٹریم کی نشوونما میں حصہ لیتا ہے۔

☆..... یہ ہارمون Vaginal Epithelium کے بننے میں کام آتا ہے۔

☆..... ان ہارمونز کی وجہ سے عورتوں میں زیریناف اور بگلوں میں بال اگتے ہیں۔

☆..... عورت میں جسمانی دلکش آواز کے سریلے پن میں کام کرتے ہیں۔

پروجسٹرون ہارمونز (Progesterone Hormones):

☆..... استرا حمل میں یہ ہارمون کام کرتا ہے۔

☆..... حمل کی حفاظت کرنے میں اسقاط سے بچانے میں کام کرتا ہے۔

☆..... رحم کی بے ربط عضلاتی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔

☆..... اس ہارمون کی وجہ سے بیضہ کے خارج ہونے پر درجہ حرارت 15 درجہ سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے۔

☆..... یوٹرس کے غیر ضروری سکڑاؤ کو روکتا ہے۔

☆..... حمل قرار پانے کے بعد پروجسٹرون کی وجہ سے بیضہ کے بننے کا عمل رک جاتا ہے۔

☆..... رحم کی جھلی اینڈومیٹریم کی افزائش میں کام آتا ہے۔

☆..... اس کی وجہ سے کلائی کو جن کے اکٹھا ہونے میں مدد ملتی ہے۔

☆..... حیض کے نظام میں اہمیت رکھتا ہے۔

☆..... اینڈومیٹریم کو زائیگوٹ کو قبول کرنے کیلئے تیار کرتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

یونٹ: 4

دورات حیض

(مینسٹروئل سائیکل)

(THE MENSTRUAL CYCLE)

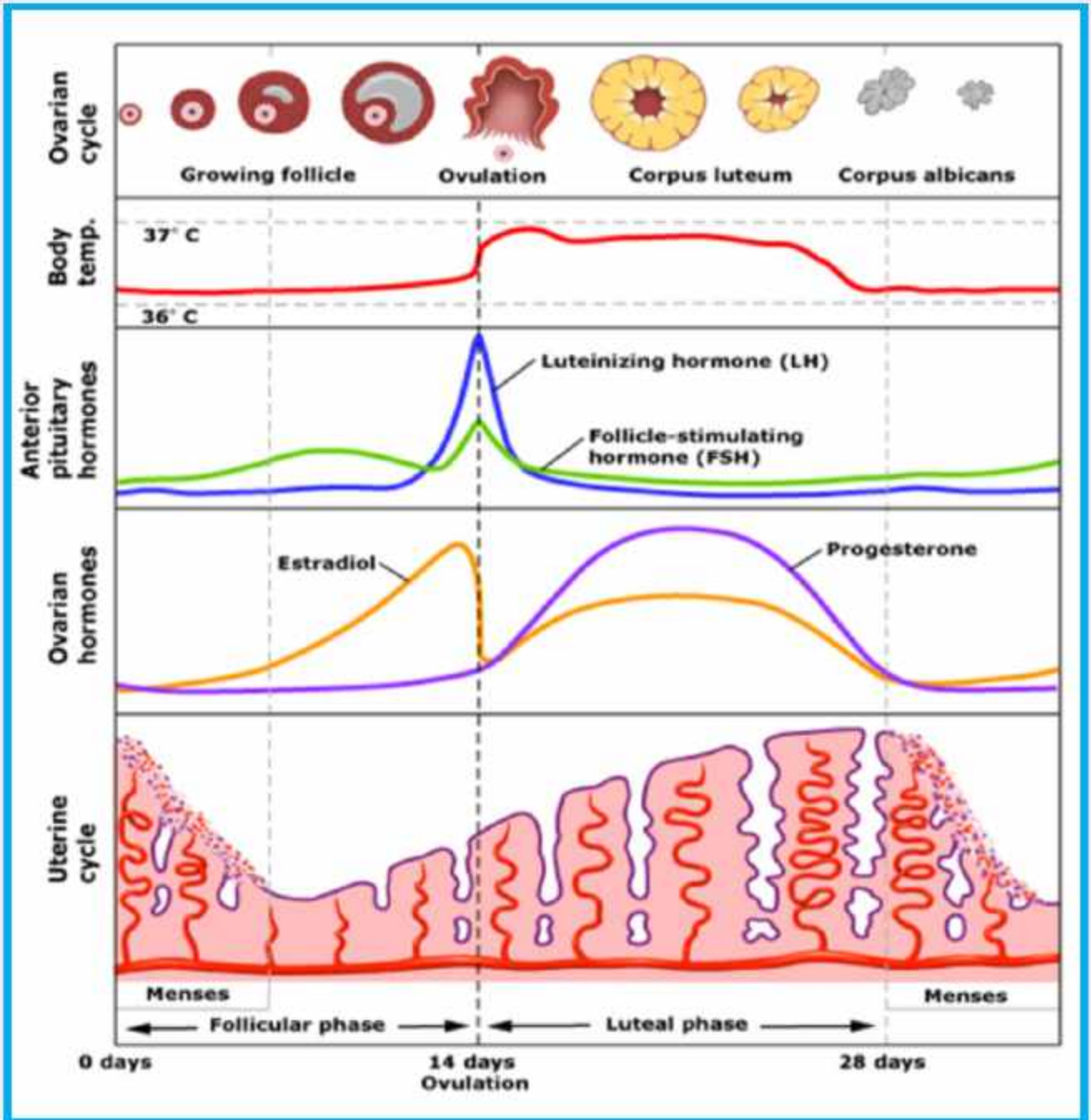
تعارف (Introduction): عورت جب بالغ ہوتی ہے تو اسے ہر مہینے اندام نہانی کے راستے خون کا اخراج ہوتا ہے جو کہ عام طور پر تین سے پانچ دن تک جاری رہتا ہے۔ حیض کے دوران خارج ہونے والا خون تیس سے چالیس ملی لیٹر تک ہوتا ہے اور اس خون میں جنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

دوران حیض (Menstruation Cycle): حیض دراصل اینڈومیٹریئم کے افعال کا ایک چکر ہے جو کہ تقریباً اٹھائیس دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اینڈومیٹریئم کے افعال کے اس چکر میں سات دن کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حیض کا یہ دوران تین مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

1	پروولی فیریٹو فیز: جو کہ دس دن تک جاری رہتا ہے۔	(Proliferative Phase)
2	سکریٹری فیز: جو کہ چودہ دن تک جاری رہتا ہے۔	(Secretory Phase)
3	مینسٹروئل فیز: جو کہ چار دنوں تک جاری رہتا ہے۔	(Menstrual Phase)

1۔ پروولی فیریٹو فیز (Proliferative Phase): اس مرحلے میں اوورین فالیکل جو کہ اووری میں موجود ہوتا ہے، اس پر فالیکل سٹیمولنگ ہارمون (F.S.H) اپنا اثر کرتا ہے اور اس اوورین فالیکل کو میچور کرتا ہے اور اس سے ایسٹروجنز ہارمون خارج کرواتا ہے اور یہ ایسٹروجنز ہارمون اینڈومیٹریئم پر اپنا عمل کرتا ہے اور اینڈومیٹریئم کو موٹا کرتا چلا جاتا ہے تاکہ اگر اووری سے نکلا ہوا اووم مرد کے سپرم کیساتھ مل کر فرٹیلائزڈ ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے تو ہا آسانی اینڈومیٹریئم میں رہ سکے۔ اینڈومیٹریئم میں موجود سیلز، بلڈ ویسلز اور میوکس گلینڈز بڑھ جاتے ہیں اور اینڈومیٹریئم موٹی ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ مرحلہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب اووری سے اووم خارج ہو جاتا ہے اور ایسٹروجنز ہارمون بننا بند ہو جاتا ہے۔

2۔ سکریٹری فیز (Secretory Phase): جونہی اووری سے اووم خارج ہوتا ہے تو خالی فالیکل پر لیوٹائزنگ ہارمون اپنا اثر کرتا ہے اور اس خالی فالیکل کو میچور کر کے کارپس لیوٹیم میں تبدیل کرتا ہے اور یوں یہ کارپس لیوٹیم پروجیسٹرون ہارمون خارج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس پروجیسٹرون ہارمون کے اخراج کی وجہ سے اور اسکے اثر سے اینڈومیٹریئم مزید موٹی ہو جاتی ہے اور اینڈومیٹریئل گلینڈز سے پانی کی سی میوکس رطوبت خارج ہوتی ہے تاکہ اینڈومیٹریئم آسانی کیساتھ فرٹیلائزڈ اووم کو قبول کر سکے اور اگر اووری سے نکلا ہوا اووم مرد کے سپرم کیساتھ نہ مل سکے اور فرٹیلائزیشن نہ ہو سکے تو یہ مرحلہ تیسرے مرحلے یعنی منسٹروئل فیز میں داخل ہو جاتا ہے۔



The Menstrual Cycle

3۔ **منسٹرول فیز (Menstrual Phase):** اگر اووری سے خارج شدہ اووم مرد کے سپرم سے مل کر فرٹیلائزڈ نہ ہو سکے تو خون میں موجود پروجسٹرون ہارمون کی زیادتی پچوٹری گلینڈ کے لیوٹینائزنگ ہارمون کی پیدائش روک دیتا ہے تو کارپس لیوٹیم تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پروجسٹرون ہارمون کا اخراج رک جاتا ہے اور یوں اووم کی پیدائش یعنی اووولیشن کے چودہ دن بعد یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریم تباہ ہو کر ٹوٹتی پھوٹتی شروع ہو جاتی ہے اور حیض جاری ہو جاتا ہے۔ حیض میں کچھ رطوبات اینڈومیٹریل سیلز، اینڈومیٹریم کی تباہ شدہ خون کی رگوں سے خون اور نان فرٹیلائزڈ اووم شامل ہوتا ہے اور یوں حیض جاری ہونے کے بعد اگلے ماہ کیلئے حیض کا نیا دوران شروع ہو جاتا ہے۔



زنانہ بلوغت (پیویرٹی ان فیمیلز) (PUBERTY IN FEMALES)

تعارف (Introduction): زنانہ بلوغت وہ زمانہ ہے جس میں کہ عورت کی جسمانی نشوونما اور جنسی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ عورتوں میں زمانہ بلوغت عموماً بارہ سے چودہ سال کی عمر میں آتا ہے۔

زمانہ بلوغت کی وجہ (Cause of Puberty): بلوغت سے پہلے گونیڈوٹروفن یعنی لیوٹینائزنگ ہارمون اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصہ سے خارج نہیں ہوتے لیکن زمانہ بلوغت میں پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے یہ ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ عورت کی اووریز پر اثر کرتے ہیں اور اووریز سے ایسٹروجنز اور پروجسٹرون ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسٹروجنز ہارمون کے اخراج کے زیر اثر عورتوں میں جسمانی نشوونما، جنسی نشوونما اور حیض جاری ہو جاتا ہے اور یوں عورتوں میں زمانہ بلوغت شروع ہو جاتا ہے۔

عورتوں میں زمانہ بلوغت کے دوران تبدیلیاں (Changes During Puberty In Females): لڑکیوں میں بلوغت شروع ہونے پر درج ذیل جسمانی و نفسیاتی اور جنسی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ زنانہ بلوغت ٹھہر جانے کی نشانیاں ہیں؛

(Enlargement of breasts)	☆..... لپستان بڑھ جانا۔
(Appearance of pubic hair)	☆..... زیر ناف بال نمودار ہو جانا۔
(Appearance of axillary hairs)	☆..... بغلوں میں بال نمودار ہونا۔
(Pelvic girdle widens)	☆..... کو لہجے کی ہڈیاں پھیل جانا۔
(Feminine voice)	☆..... آواز میں نسوانیت آ جانا۔
(Menarch)	☆..... پہلا حیض یعنی مینارک کا ہونا۔
(Diminution of height)	☆..... قد رک جانا۔
(Pigmentary skin)	☆..... عورتوں کی جلد چمکنائی والی موٹی سی اور نرم ہو جانا۔
(Labia majora increase in size)	☆..... لیبیا میجورا کا سائز میں بڑھ جانا۔
(Females become shy)	☆..... عورتوں میں شرمیلہ پن پیدا ہو جانا۔
(Females become modest)	☆..... عورتوں کا رجحان بناؤ سنگھار کی جانب ہو جانا۔
(Females blush easily)	☆..... عورتوں کا ہر بات پر جلد جلد شرم جانا۔
(Increase in size of uterus & vagina)	☆..... یوٹرس اور ویجاہ کا سائز بڑھ جانا۔
(Increase in sexual desire)	☆..... جنسی رغبت و خواہش کا بڑھ جانا۔
(Females become attractive & emotional)	☆..... عورتوں کا پرکشش و جذباتی ہو جانا۔



قبل از وقت بلوغت کے اسباب

(CAUSES OF PREMATURE PUBERTY)

کچھ لڑکیوں میں بلوغت بارہ سال کی عمر سے پہلے نمودار ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں میں قبل از وقت بلوغت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

- ☆..... ملکی آب و ہوا اگر گرم ہو تو اس کے زیر اثر لڑکی جلد بالغ ہو جاتی ہے۔
- ☆..... بعض سرد ممالک میں سردی کے باوجود لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں جنسی آزادی بہت زیادہ ہے۔
- ☆..... بہت زیادہ ماڈرن اور فیشن اسٹیل گھرانوں کی لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔
- ☆..... جنسی موضوعات کی فلمیں دیکھنے سے جسمانی نظام تحریک پکڑتا ہے اور لڑکی جلد بالغ ہو جاتی ہے۔
- ☆..... جو لڑکیاں جنسی لٹریچر کا مطالعہ کم عمری میں کرتی ہیں وہ جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔
- ☆..... اگر خوراک میں بہت زیادہ گرم غذائیں استعمال کی جائیں تو اس سے بھی قبل از وقت بلوغت ہو سکتی ہے۔
- ☆..... کم سن لڑکی کو محبت کی طرف راغب کرنے سے وہ جلد بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... اگر کوئی لڑکا کم عمر لڑکی کے جنسی اعضاء کو تحریک دیتا رہے تو وہ قبل از وقت بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... بڑی عمر کی لڑکیوں کی دوستی کم عمر لڑکی کو بالغ کر سکتی ہے۔
- ☆..... گھر کا آزادانہ ماحول، لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ، لڑکی کو جلد بالغ کر سکتا ہے۔
- ☆..... بعض اوقات ملازمین ماکان کی کم عمر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جس سے وہ قبل از وقت بالغ ہو جاتی ہیں۔
- ☆..... فحش اور غیر اخلاقی کتابیں پڑھنے سے لڑکی قبل از وقت بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... گاؤں میں جانوروں کے ملاپ کو دیکھتے رہنے سے لڑکی قبل از وقت بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... اگر لڑکی والدین کی غفلت کی وجہ سے ان کو مباشرت کرتے دیکھتی رہی تو وہ جلد بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... بازاری عورتیں خود ایسا سامان کرتی ہیں کہ ان کی لڑکی قبل از وقت بالغ ہو جائے۔
- ☆..... کم عمر لڑکی سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے وہ جلد بالغ ہو سکتی ہے۔
- ☆..... اگر مسلسل ایسا دودھ استعمال کیا جائے جو کسی ٹون کا ٹیکہ لگا کر حاصل کیا گیا ہو تو اس سے بھی لڑکی جلد بالغ ہو سکتی ہے۔

مندرجہ بالا وجوہات کی وجہ سے جسمانی نظام قبل از وقت تحریک پکڑ کر لڑکی کو بالغ کر سکتا ہے۔

☆☆☆.....

سن یاس (مینوپاز) (MENOPAUSE)

تعارف (Introduction): سن یاس سے مراد عورتوں کا وہ زمانہ ہے جس میں افزائش نسل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور حیض مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ سن یاس کا زمانہ عموماً 45 سے 50 سال کی عمر میں آتا ہے۔

سن یاس کی وجہ (Cause Of Menopause): سن یاس کے زمانہ میں عورتوں میں اووریز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں پروجسٹرون ہارمون کم ہو جاتا ہے اور فالیکل سٹیولیٹنگ ہارمون کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے جس سے عورتوں کے جسم میں کئی جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سن یاس میں عام طور پر حیض آہستہ آہستہ رک جاتا ہے لیکن کبھی کبھی حیض ایک دم بھی بند ہو جاتا ہے۔

سن یاس کی علامات و نشانیاں (Signs/Symptoms Of Menopause): زمانہ سن یاس جب شروع ہوتا ہے تو عورتوں میں درج ذیل جسمانی، نفسیاتی اور جنسی تبدیلیاں آہستہ آہستہ یا پھر یکدم ظاہر ہوتی ہیں۔

(Hot flushes in body)	☆..... جسم میں گرم لہریں محسوس ہونا۔
(Sweating after attacks of hot flushes)	☆..... گرم لہروں کے بعد پسینے آنا۔
(Slight rise of BP due to psychological changes)	☆..... نفسیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہلکا سا بلڈ پریشر بڑھنا۔
(Anxiety due to psychological changes)	☆..... نفسیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر تشویش کا پیدا ہو جانا۔
(Depression due to psychological changes)	☆..... نفسیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ڈپریشن کا پیدا ہو جانا۔
(Sleeplessness)	☆..... بے خوابی کا پیدا ہو جانا۔
(Physical fatigue appear)	☆..... جسمانی تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہونا۔
(Nervous fatigue appear)	☆..... اعصابی تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہونا۔
(Irritability)	☆..... جڑ جڑا پن پیدا ہو جانا۔

(Headache)	سر درد پیدا ہو جانا۔	☆.....
(Giddiness)	چکروں کا آنا۔	☆.....
(Indigestion)	بد ہضمی و نظام انہضام کا متاثر ہونا۔	☆.....
(Palpitation)	دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا۔	☆.....
(Joints pains)	جوڑوں میں دروں کا ہونا۔	☆.....
(Osteoprosis)	ہڈیوں کا جھڑنا۔	☆.....
(Tendency towards fractures)	ہڈیوں کے ٹوٹنے کا رجحان ہونا۔	☆.....
(Skin becomes dry)	جلد کا خشک اور کھردرا ہونا۔	☆.....
(Dryness and boring of bones)	ہڈیوں کا خشک اور کھردرا ہو جانا۔	☆.....
(Ovaries and uterus shrinks down)	اوریز اور یوٹرس کا سکڑ کر سخت ہو جانا۔	☆.....
(Vaginismus and vulvitis)	ویجائنہ کا سکڑ کر چھوٹا اور اس میں سوزش و خارش ہونا۔	☆.....
(Atrophy of breasts and fallopian tubes)	پستانوں اور فیلوپین ٹیوبز کا سکڑنا۔	☆.....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ نیشہ ملی کیشتر

یونٹ: 5

زنانه امراض

(FEMALE DISEASES)

تعارف (Introduction): اس یونٹ میں ہم عورتوں کو لاحق ہونے والی عام گائنا کالوجیکل بیماریوں سے متعلق بحث کریں گے۔ عام طور پر ایک لیڈی ہیلتھ وزیٹر اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس ان بیان کی گئی بیماریوں سے متعلق ہی عورتیں رابطہ قائم کرتی ہیں۔ اس یونٹ میں عورتوں کی ان عام بیماریوں کا تعارف، ان کی اقسام، علامات و نشانیاں، پیچیدگیاں، تشخیص، علاج اور احتیاط سے متعلق ڈسکشن کی جائے گی۔

بنداش حیض

(ایمینوریا)

(AMENORRHOEA)

تعارف (Introduction): لڑکیوں یا عورتوں میں حیض کا بند ہو جانا بندش حیض یا امینوریا (Amenorrhoea) کہلاتا ہے۔

ایمینوریا کی اقسام (Types Of Amenorrhoea): امینوریا کی درج ذیل دو اقسام ہیں؛

1۔ **پرائمری امینوریا (Primary Amenorrhoea):** اگر کسی عورت یا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی حیض جاری نہ ہوا ہو تو اس حالت کو پرائمری امینوریا (Primary Amenorrhoea) کہتے ہیں۔

2۔ **سیکنڈری امینوریا (Secondary Amenorrhoea):** اگر کسی عورت یا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد حیض جاری ہوئے ہوں اور پھر بعد میں کسی وجہ سے حیض آنا رک جائے تو اس حالت کو سیکنڈری امینوریا (Secondary Amenorrhoea) کہتے ہیں۔

ایمنوریا کی درجہ بندی (Classification Of Amenorrhoea): ایمنوریا کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

1۔ فزیولا جیکل ایمنوریا (Physiological Amenorrhoea) یعنی طبعی بندش حیض جو کہ درج ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے؛

1	بلوغت سے پہلے۔	(Before puberty)
2	حمل کے دوران۔	(During pregnancy)
3	دودھ پلانے کے زمانے میں۔	(During lactation)
4	سن یاس کے زمانے میں۔	(After menopause)

درج بالا ایمنوریا کی کنڈیشن چونکہ فزیولا جیکل ہیں لہذا اس اقسام کے ایمنوریا کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا یہ ایمنوریا قدرتی طور پر ہوتے ہیں۔

2۔ پیتھالا جیکل ایمنوریا (Pathological Amenorrhoea) یعنی غیر طبعی بندش حیض جو کہ درج ذیل صورتوں میں ہو سکتا ہے؛

1	یوٹرس کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Uterine diseases)
2	یوٹرس کی ٹی بی میں بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Uterine Tuberculosis)
3	اووریز کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Ovarian diseases)
4	اووریز میں سسٹ پیدا ہو جائیں تو بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Ovarian cysts)
5	پچوٹری گلینڈ کی بیماریوں کی وجہ سے بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Pituitary gland's diseases)
6	اینٹیریر پچوٹری کی نیکروس ہو جانے پر بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Anterior pituitary necrosis)
7	پچوٹری گلینڈ چھوٹا رہ جانے پر بھی بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Smaller pituitary gland)
8	اینٹیریر پچوٹری میں رسولی پیدا ہو جائے تو بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Tumor in anterior pituitary)
9	اینڈو کرائن گلینڈز کی خرابیوں کی وجہ سے بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Endocrine diseases)
10	اگر ایڈریئل گلینڈ میں ٹیومر ہو جائے تو بندش حیض ہو سکتا ہے۔	(Tumor in adrenal gland)
11	اگر ہائی مین کا سوراخ تنگ ہو تو بھی حیض کا خون باہر نہیں نکل سکتا۔	(Cryptomenorrhoea)
12	نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے بھی ایمنوریا ہو سکتا ہے۔	(Psychological diseases)
13	جذباتی دباؤ اور تناؤ بھی ایمنوریا کا باعث ہو سکتا ہے۔	(Depression & Tension)

14	مختلف ادویات کا زیادہ استعمال بھی ایمنیو ریا کا باعث بن سکتا ہے۔	(Heavy use of drugs)
15	مانع حمل ادویات کا استعمال بندش حیض کا باعث بنتا ہے۔	(Use of contraceptive drugs)
16	سٹیرائڈ ادویات کا زیادہ استعمال بندش حیض کر سکتا ہے۔	(Use of steroid drugs)
17	ہارمونل ادویات کا زیادہ استعمال بندش حیض کر سکتا ہے۔	(Use of hormonal drugs)
18	اگر پیلوک ایکس رے زیادہ کروائے جائیں تو بھی ایمنیو ریا ہو سکتا ہے۔	(Frequent X-Rays of pelvis)
19	ہائپو تھیلامس کی خرابیوں کی وجہ سے بھی ایمنیو ریا ہو سکتا ہے۔	(Hypothalamus diseases)
20	تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کے ہارمونز کی کمی بھی ایمنیو ریا کا باعث بنتی ہے۔	(Low thyroid hormones)
21	تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کے ہارمونز کی زیادتی بھی ایمنیو ریا کا باعث بنتی ہے۔	(High thyroid hormones)
22	یوٹرس کا پیدائشی طور پر نامکمل ہونا، چھوٹا ہونا یا نہ ہونا۔	(Uterine anomalies)
23	جسم میں خون یا آئرن کی کمی بھی ایمنیو ریا کا باعث بنتی ہے۔	(Anaemia)

درج بالا ایمنیو ریا کی کنڈیشن چونکہ پیتھالوجیکل ہیں لہذا مریضہ میں پیتھالوجی تشخیص کر کے اس کے مطابق ایمنیو ریا کا علاج کیا جاتا ہے۔

پیتھالوجیکل ایمنیو ریا کی علامات (Signs and Symptoms Of Pathological Amenorrhoea): پیتھالوجیکل ایمنیو ریا

میں درج ذیل علامات و نشانیاں (Signs and symptoms) پائی جاتی ہیں؛

☆.....	مریضہ کمر درد محسوس کرتی ہے۔	(Backache)
☆.....	مریضہ کو پیلوئس میں بھی درد محسوس ہوگا۔	(Pelvic pains)
☆.....	مریضہ میں بے چینی پائی جاتی ہے۔	(Uncomfortable)
☆.....	مریضہ میں افسردگی پائی جاتی ہے۔	(Depression)
☆.....	مریضہ میں بے زاری پائی جاتی ہے۔	(Lassitude)
☆.....	مریضہ میں مایوسی پائی جاتی ہے۔	(Dishearted)
☆.....	مریضہ میں چڑچڑاہٹ پائی جاتی ہے۔	(Irritation)
☆.....	یوٹرس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔	(Heaviness in uterus)
☆.....	کمزور مریضوں میں انیمیا کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔	(Signs of anaemia)

(Pelvic pains but no menses)	☆..... ماہواری کے دنوں میں پیلوک دروے ہوتی ہیں لیکن حیض نہیں آتا۔
(Obesity due to hormonal changes)	☆..... ہارمونل تبدیلیوں کے باعث عورتوں میں موٹاپے کا رجحان ہوگا۔
(Weakness and emaciation)	☆..... کئی عورتیں نحیف، کمزور اور ناتواں ہوں گی۔

ایمنوریہ کی تشخیص (Diagnosis Of Amenorrhoea): ایمنوریہ کی تشخیص کیلئے درج ذیل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں:

(Complete Blood Count)	☆..... خون کا مکمل امتحان۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان۔
(Pelvic Ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ۔
(Vaginal examination)	☆..... ویجائنل ایگزامینیشن۔
(Blood for glucose)	☆..... بلڈ فار گلوکوز۔

ایمنوریہ کا علاج (Treatment Of Amenorrhoea): پتھالوجیکل ایمنوریہ کی وجہ تشخیص کر کے علاج کیا جانا چاہیے۔ ایمنیہ ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بلکی ورزش، متوازن خوراک اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ عام طور پر ایمنوریہ کے علاج کے لئے درج ذیل ادویات استعمال کی جاتی ہیں:

(Menstrogen Inj)	☆..... منسٹروجن انجکشن۔
(Ovlogin Inj)	☆..... اوولو جن انجکشن۔
(Danocrine Tab)	☆..... ڈینوکرائن گولیاں۔
(Hydroxyprogesterone Inj)	☆..... ہائیڈروکسی پروجسٹرون انجکشن۔
(Premarin Tab)	☆..... پریمارین گولیاں۔
(Progyluton Tab)	☆..... پروگائیوٹون گولیاں۔
(Gynaecosid Tab)	☆..... گائنی کوسڈ گولیاں۔
(Depo-provera Inj)	☆..... ڈیپو پروویرا انجکشن۔
(Penorit Tab)	☆..... پنورٹ گولیاں۔



دِقتِ حیض

(ڈسمنوریا)

(DYSMENORRHOEA)

تعارف (Introduction): کچھ عورتوں اور لڑکیوں میں اکثر حیض ہر ماہ آتا تو ہے لیکن حیض کے دوران پیڑو یعنی پیلوئس اور پیٹ وکرم میں درد نارمل سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے لہذا اس طرح حیض کا درد کے ساتھ آنا ڈسمنوریا (Dysmenorrhoea) کہلاتا ہے۔

ڈسمنوریا کی وجوہات (Causes Of Dysmenorrhoea): ڈسمنوریا کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

(Pre-cancerous gynae condition)	☆..... گائنا کولاجیکل کینسر پیدا ہونے سے پہلے ڈسمنوریا ہو سکتا ہے
(Uterine fibroma)	☆..... یوٹرس میں اگر فائبروما کی کنڈیشن پیدا ہو جائے۔
(Associated gynaecological infections)	☆..... اعضائے مخصوصہ کے آس پاس کے انفیکشن ہوں۔
(At the start of puberty)	☆..... بلوغت کی شروعات میں بھی دقتِ حیض ہو سکتا ہے۔
(Spasmodic gynaecological pains)	☆..... اعضائے مخصوصہ میں تشنجی کیفیات ہوں۔
(Psychological complications)	☆..... نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔
(Uterine muscular spasm)	☆..... اگر یوٹرس کے مسلسل سکڑ جائیں تو بھی دقتِ حیض ہو سکتا ہے۔
(Uterine anomalies)	☆..... یوٹرس میں پیدائشی طور پر اگر کوئی نقص ہو۔
(Chronic pelvic diseases)	☆..... اگر پیلوک آرگنز کی کوئی پرانی بیماریاں ہوں۔
(Severe spasmodic uterine contraction)	☆..... اگر دورانِ حیض یوٹرس کے عضلات نہایت شدت سے سکڑیں
(Uterine muscular breakup)	☆..... یوٹرس کے عضلات میں توڑ پھوڑ ڈسمنوریا کا باعث بنتی ہیں۔
(Uterine muscular ischaemia)	☆..... یوٹرس کے عضلات میں خون کی کمی واقع ہو جائے۔
(Hysterical disorder)	☆..... بسا اوقات ہسٹریا کی وجہ سے بھی ڈسمنوریا ہو سکتا ہے۔
(Nerve weakness)	☆..... اعصابی کمزوری بھی اس مرض کی ایک بڑی وجہ ہے۔
(Metritis)	☆..... یوٹرس میں ورم ہو جانے سے بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔

ڈسمنوریہ کی علامات و نشانیوں (Signs/Symptoms Of Dysmenorrhoea): ڈسمنوریہ میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں؛

(Menstrual pains before 2 to 3 days)	☆..... حیض آنے سے دو یا تین دن پہلے درد شروع ہو جاتا ہے۔
(Backache)	☆..... مریضہ کو کمر درد ہوتا ہے۔
(Pelvic pains)	☆..... مریضہ کو پیلوں میں بھی درد ہوتا ہے۔
(Lassitude)	☆..... مریضہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔
(Wants to have bed rest)	☆..... مریضہ مکمل آرام کرنا چاہتی ہے۔
(Headache)	☆..... مریضہ کے سر میں درد ہوتا ہے۔
(Generalized Myalgia)	☆..... مریضہ تمام جسم میں درد محسوس کرتی ہے۔
(Heaviness in uterus)	☆..... مریضہ کو یوٹرس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔
(Pains decrease on menstruation)	☆..... حیض کھل کر ہونے کی صورت میں درودوں میں کمی آ جاتی ہے۔
(Weakness due to severe pains)	☆..... ڈسمنوریہ کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریضہ غمہال ہو جاتی ہے۔
(Nausea and vomiting)	☆..... مریضہ کو قے یا متلی بھی ہوتی ہے۔
(Pallor face)	☆..... مریضہ کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔

ڈسمنوریہ کی تشخیص (Diagnosis Of Dysmenorrhoea): ڈسمنوریہ کی تشخیص کیلئے درج ذیل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؛

(Complete Blood Count)	☆..... خون کا مکمل امتحان۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان۔
(Pelvic Ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ۔
(Vaginal examination)	☆..... ویجائنل ایگزامینیشن۔
(Blood for glucose)	☆..... بلڈ فار گلوکوز۔

ڈسمنوریہ کا علاج (Treatment Of Dysmenorrhoea): نوجوان لڑکیوں کو حیض سے متعلق معلومات فراہم کرنی چاہئیں تاکہ حیض شروع ہونے پر خوف کی وجہ سے وہ ڈسمنوریہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ درج ذیل ادویات اور مشورہ جات دیئے جاتے ہیں؛

(Analgesic drugs)	☆..... درد کش ادویات دینی چاہئیں۔
(Bed rest)	☆..... مناسب آرام کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Balance diet)	☆..... متوازن خوراک کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Hygienic principles)	☆..... حفظانِ صحت کے اصول اپنانے کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Hot applications on lower abdomen)	☆..... گرم پانی کی بوتل سے پیٹ کے نچلے حصے کی سٹائی کرنی چاہیے۔

ادویاتی علاج (Medicinal Treatment): ڈسمنوریہ کے علاج کے سلسلے میں عام طور پر درج ذیل ادویات استعمال کی جاتی ہیں؛

(Duphaston Tab)	☆..... ڈوفیسٹان گولیاں۔
(Orgametriol Tab)	☆..... اورگامیٹرل گولیاں۔
(Menstrogen Inj)	☆..... منسٹروجن انجکشن۔
(Ologyn Inj)	☆..... اولوجن انجکشن۔
(Buscopan Inj / Tab)	☆..... بسکوپان انجکشن / گولیاں۔
(Sosegon Inj)	☆..... سویگان انجکشن۔
(Hyoscin Inj)	☆..... ہائیوسین انجکشن۔
(Dicloran Inj)	☆..... ڈیکلوران انجکشن۔
(Panadol Tab)	☆..... پیناڈول گولیاں۔
(Poneston forte Tab)	☆..... پونسٹن فورٹ گولیاں۔
(No-spa Inj / Tab)	☆..... نوسپا انجکشن / گولیاں۔
(Brufen 400 mg Tab)	☆..... بروفن گولیاں 400 ملی گرام گولیاں۔
(Nuberol forte Tab)	☆..... نیوبرال فورٹ گولیاں۔

☆☆☆.....

بے قاعدہ کثرت حیض

(میٹرورجیا)

(METRORRHAGIA)

تعارف (Introduction): عام طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو مہینے میں ایک بار حیض ہوا کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ گائنا کالوجیکل بیماریوں کے باعث ایک مہینے میں دو مرتبہ بھی حیض جاری ہو سکتا ہے۔ حیض کی اس غیر معمولی کنڈیشن کو بے قاعدہ کثرت حیض یعنی میٹرورجیا کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ دو ماہواریوں کے درمیان ماہواری ہونے کو میٹرورجیا (Metrorrhagia) کہتے ہیں۔

میٹرورجیا کی وجوہات (Causes Of Metrorrhagia): میٹرورجیا کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

(Irregular hormones)	☆..... ہارمونز کا بے قاعدہ ہونا۔
(Carcinoma cervix)	☆..... سرویکس کا کینسر۔
(Carcinoma endometrium)	☆..... اینڈومیٹریئم کا کینسر۔
(Cervicitis)	☆..... سرویکس کی سوزش۔
(Endometritis)	☆..... اینڈومیٹریئم کی سوزش۔
(Purpura)	☆..... بلڈ پلیٹ لیٹس کی کمی کی بیماری پر پرا۔
(Psychological complications)	☆..... نفسیاتی پیچیدگیاں۔
(Hepatic diseases)	☆..... جگر کی بیماریاں۔
(Retained piece of placenta)	☆..... ولادت کے بعد پلوٹس میں پلے سینا کے کسی ٹکڑے کا رہ جانا۔
(Metrorrhagia due to abortion)	☆..... ابارشن کی وجہ سے بھی میٹرورجیا ہو سکتا ہے۔
(Hyper secretion of pituitary hormones)	☆..... پچوٹری ہارمونز کا زیادہ اخراج ہونا۔
(Hyperthyroidism)	☆..... تھائی رائیڈ گلینڈ کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے۔
(Ovarian cancer)	☆..... اووریز کا کینسر ہو۔

(Low secretion of progesteron)	☆..... پروجیسٹران کی کمی ہوتی ہے۔
(Hyper secretion of oestrogens)	☆..... ایسٹروجنز کی زیادتی ہوتی ہے۔
(Uterine fibroid)	☆..... یوٹرائن فائبرائیڈز کی وجہ سے۔
(Vaginal ulcer)	☆..... ویجائٹ میں السر ہو۔
(Gynaecological cancers & infections)	☆..... کینسر یا سوزش کی وجہ سے بھی میٹرورجیا ہو سکتا ہے۔

میٹرورجیا کی علامات و نشانیائیں (Signs/Symptoms Of Metrorrhagia): میٹرورجیا کی عام علامات و نشانیائیں درج ذیل ہیں:

(Severe vaginal bleeding)	☆..... بہت زیادہ ویجائٹل بلیڈنگ ہوتی ہے۔
(Bleeding between two menses)	☆..... دو ماہوار یوں کے درمیان بھی بار بار ویجائٹل بلیڈنگ ہوتی ہے۔
(Pallor face)	☆..... مریضہ کا رنگ پیلا ہوگا۔
(Hypotention)	☆..... بلڈ پریشر کم ہوگا۔
(Palpitation)	☆..... مریضہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔
(Sinking of heart)	☆..... مریضہ دل بیٹھنے کی شکایت کرتی ہے۔
(Anaemia)	☆..... مریضہ میں انیمیا پایا جاتا ہے۔
(E.S.R is high)	☆..... مریضہ کا ای ایس آر زیادہ ہوتا ہے۔
(Weaknes)	☆..... مریضہ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔
(Giddiness)	☆..... مریضہ کو چکر آتے ہیں۔
(Nausea and vomiting)	☆..... بسا اوقات متلی و قے ہوتی ہے۔
(Can't do any work)	☆..... مریضہ میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
(Hypogastric pain)	☆..... مریضہ کو پیٹ کے نچلے حصے ہائپوگیسٹریک میں درد محسوس ہوتا ہے۔
(Dark circles around the eyes)	☆..... مریضہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پائے جاتے ہیں۔
(Wants to have bed rest)	☆..... مریضہ ہر وقت آرام کرنا چاہتی ہے۔

میٹرورجیا کی تشخیص (Diagnosis Of Metrorrhagia): میٹرورجیا کی تشخیص کیلئے درج ذیل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؛

(Complete Blood Count)	☆..... خون کا مکمل امتحان۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان۔
(Pelvic Ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ۔
(Vaginal examination)	☆..... ویجائنل ایگزامینیشن۔
(Blood for glucose)	☆..... بلڈ فار گلوکوز۔
(Bleeding Time / Clotting Time)	☆..... بلیڈنگ ٹائم / کلاٹنگ ٹائم۔
(Prothrombin Time test)	☆..... پروتھرومبین ٹائم ٹیسٹ۔
(D & C)	☆..... ڈی اینڈ سی۔
(Endometrial biopsy)	☆..... اینڈومیٹریل بائیوپسی۔

علاج (Treatment): میٹرورجیا کی درست تشخیص کر کے درج ذیل ادویات استعمال کی جاتی ہیں؛

(Orgametriol Tab)	☆..... اورگامیٹریل گولیاں۔
(Vitamin K Inj)	☆..... وٹامن "کے" انجکشن۔
(Anaroxyl Inj)	☆..... اناروکسل انجکشن۔
(Transamin Inj)	☆..... ٹرانزامین انجکشن۔
(Daflon Tab)	☆..... ڈیفلون گولیاں۔
(Xed Cap)	☆..... زیڈ کیپسول۔
(Multi vitamin Tab)	☆..... ملٹی وٹامن گولیاں۔
(Ca C Tab)	☆..... سی اے سی گولیاں۔
(Primolut-N Tab)	☆..... پرائمولوٹ این گولیاں۔

☆☆☆.....

فیلوپین ٹیوب کی سوزش

(سال پنچائی ٹس)

(SALPINGITIS)

تعارف (Introduction): عورتوں اور لڑکیوں میں بچے دانی کے دونوں سائیڈ پر ایک ایک فیلوپین ٹیوب موجود ہوتی ہے۔ بسا اوقات کسی بھی وجہ کی بناء پر ان ٹیوبز میں انفیکشن ہو کر سوزش ہو جاتی ہے لہذا انہی فیلوپین ٹیوب کی سوزش کو سال پنچائی ٹس (Salpingitis) کہتے ہیں۔

سال پنچائی ٹس کی وجوہات (Causes Of Salpingitis): سال پنچائی ٹس کی عام وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Infection of fallopian tubes)	☆..... فیلوپین ٹیوب کا انفیکشن۔
(Metritis)	☆..... یوٹرس کی سوزش۔
(Endometritis)	☆..... اینڈومیٹریٹس کی سوزش۔
(Oophritis)	☆..... اووریز کی سوزش۔
(Carcinoma uterus)	☆..... یوٹرس کا کینسر۔
(Uterine fibroma)	☆..... یوٹرس کا فائبروما۔
(Post delivery infection)	☆..... زچگی کے بعد سوزش بھی پھیل کر فیلوپین ٹیوب تک آسکتی ہے۔
(Gonorrhoeal infection)	☆..... سوزاک بھی فیلوپین ٹیوب کی سوزش کا باعث بن سکتا ہے۔
(Abortion)	☆..... اسقاط حمل کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔
(Salpingitis may be acute or chronic)	☆..... فیلوپین ٹیوب کی یہ سوزش ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہے اور کراک بھی۔
(Unilateral or Bilateral)	☆..... یہ سوزش ایک ٹیوب میں بھی ہو سکتی ہے اور دونوں ٹیوبز میں بھی۔

سال پنچائی ٹس کی علامات و نشانیوں (Signs/Symptoms Of Salpingitis): سال پنچائی ٹس میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں؛

(Unilateral or Bilateral hypogastric pain)	☆..... مریضہ کو پیڑوں کے دونوں جانب یا ایک جانب درد ہوگا۔
(Severe pain during menses)	☆..... حیض کے دوران شدید درد ہوتا ہے۔
(Pelvic peritonitis)	☆..... پیری ٹونیم کے پیلووس والے حصے میں سوزش ہو سکتی ہے۔
(Hypogastric pain)	☆..... ہائپوگیسٹریک میں درد ہوتا ہے۔
(Watery secretion from fallopian tubes)	☆..... فیلوپین ٹیوبز سے پانی جیسی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔
(Puss secretion from fallopian tubes)	☆..... فیلوپین ٹیوبز سے پیپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔
(Bloody secretion from fallopian tubes)	☆..... فیلوپین ٹیوبز سے خون ملی رطوبت کا اخراج ہو سکتا ہے۔
(High graded fever)	☆..... مریضہ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے۔
(Irregular menses)	☆..... حیض میں بے قاعدگی آ جاتی ہے۔
(Abdominal pain during stool / urination)	☆..... پیشاب پاخانے کے وقت پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے۔
(Leucorrhoea)	☆..... لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے۔
(Anorexia)	☆..... بھوک کم ہو جاتی ہے۔
(Rapid pulse)	☆..... نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔
(Nausea & Vomiting)	☆..... بعض اوقات متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔

سال پنچائی ٹس کی تشخیص (Diagnosis Of Salpingitis): سال پنچائی ٹس کی تشخیص درج ذیل طریقے سے کی جاتی ہے؛

(Uterine smear test)	☆..... یوٹرس سے رطوبتی اخراج کا امتحان کرنا چاہیے۔
(Abdominal / pelvic ultrasound)	☆..... پیٹ / پیڑوں کا الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان کرنا چاہیے۔
(Endoscopy of uterus)	☆..... یوٹرس کی انڈوسکوپ کرنا چاہیے۔
(C.B.C and E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس، ایلس، آر کرنا چاہیے۔

سال پنچائی ٹس کی پیچیدگیاں (Complications Of Salpingitis): اگر سال پنچائی ٹس کا صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے تو درج ذیل پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں:

(Blockage of fallopian tubes due to infection)	☆ فیلوپین ٹیوبز سوزش کے نتیجے میں بند ہو سکتی ہیں۔
(Infertility)	☆ ایسی صورت میں بانجھ پن ہو سکتا ہے۔
(Ectopic pregnancy)	☆ بے محل حمل بھی قرار پا سکتا ہے۔
(Salpingitis may cause oophritis)	☆ فیلوپین ٹیوبز کی سوزش اور یز تک پھیل سکتی ہے۔
(Irregular menses)	☆ حیض میں بے قاعدگی آ سکتی ہے۔
(Weakness due to leucorrhoea)	☆ لیکوریا کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی ہے۔
(Backache)	☆ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔

سال پنچائی ٹس کا علاج (Treatment Of Salpingitis): سال پنچائی ٹس کی مریضہ کے علاج میں درج ذیل نکات کا خیال رکھنا چاہیے:

(Anti inflammatory & analgesic drugs)	☆ سوزش اور درد دور کرنے والی ادویات دیں۔
(Complete bed rest)	☆ مریضہ کو مکمل آرام کا مشورہ دیں۔
(Balance diet)	☆ متوازن خوراک کے استعمال کا مشورہ دیں۔
(Hygienic principles)	☆ حفظانِ صحت کے اصولوں کا خیال رکھنے کا مشورہ دیں۔
(Amoxil Inj)	☆ ایماکسل انجکشن۔
(Ceftriaxone Inj)	☆ سیف ٹرائی ایگزون انجکشن۔
(Dicloran Inj)	☆ ڈیکلوران انجکشن۔
(Sosegon Inj)	☆ سوسی گان انجکشن۔
(Voren Tab)	☆ ورین گولیاں۔
(Buscopan Plus Tab)	☆ بسکوپان پلس گولیاں۔
(Nospa Inj)	☆ نوسپا انجکشن۔

(Hyoscine Inj)	☆..... ہائیوسین انجکشن۔
(Augmentin Tab)	☆..... آگمینٹن گولیاں۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونستان فورٹ گولیاں۔
(Flagyle Tab 400mg)	☆..... فلیجیل گولیاں 400 ملی گرام۔



ولوا کی سوزش

(ولوائی ٹس)

(VULVITIS)

تعارف (Introduction): عورت کے اعضاء تناسلی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک بیرونی اعضاء تناسل یعنی ایکسٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنز اور دوسرے اندرونی اعضاء تناسل یعنی انٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنز۔ عورتوں یا لڑکیوں کے ان بیرونی اعضاء تناسل جن میں لیڈیا میجورا، لیڈیا مینورا، کلائی ٹورس، ویجائنل اوری فس، یوریتھریل اوری فس اور مونیوپوس وغیرہ شامل ہیں، کو مشترکہ طور پر ولوا (Vulva) کہا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں کے ان بیرونی اعضاء تناسل پر کسی بھی وجہ کے باعث سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو عورتوں میں پایا جانے والا ایک روزمرہ کا عام مرض ہے۔ عورتوں کے اسی بیرونی اعضاء تناسل یعنی ولوا کی سوزش کو ولوائی ٹس (Vulvitis) کہتے ہیں۔

ولوائی ٹس کی وجوہات (Causes Of Vulvitis): بیرونی اعضاء تناسل کی سوزش یعنی ولوائی ٹس درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے؛

(Fungal Infection especially candidiasis)	☆..... فنگل انفکشن خصوصاً کینڈیڈا انفکشن کی وجہ سے۔
(Parasitic infection)	☆..... پیراسائیک انفکشن کی وجہ سے۔
(Bacterial Infection)	☆..... بیکٹیریل انفکشن کی وجہ سے۔
(Viral Infection)	☆..... وائرل انفکشن کی وجہ سے۔
(Allergy due to cloths)	☆..... کپڑوں سے الرجی کی وجہ سے۔

(Allergy due to soap & powder)	☆..... صابن، پوڈر سے الرجی کی وجہ سے۔
(Allergy due to hair removal cream)	☆..... غیر ضروری بال صفا کریم سے الرجی ہو جائے۔
(Allergy due to antiseptic)	☆..... اینٹی سپٹک چیزوں سے الرجی۔
(Allergy due to contraceptives)	☆..... مانع حمل اشیاء سے الرجی۔
(Trauma on vulva)	☆..... ولوا پر اگر چوٹ لگ جائے۔
(Vaginal instrumentation)	☆..... ویجائنل آلات کے استعمال سے۔
(Carcinoma of cervix)	☆..... سرویکس کے کینسر کی وجہ سے۔
(Uses of chemicals)	☆..... کیمیکلز کے استعمال سے۔
(Allergy due to different drugs)	☆..... مختلف ادویات سے الرجی کی وجہ سے۔
(Unhygienic conditions of vulva)	☆..... ولوا کی اگر صحیح طور پر صفائی نہ کی جائے۔
(Irritated leucorrhoea)	☆..... لیکوریا کے تیزابی اخراج کی وجہ سے۔
(U.T.I can cause vulvitis)	☆..... پیشاب کی راستوں کا انفیکشن ولوا کی سوزش پیدا کر سکتا ہے۔
(Abundance in sexual intercourse)	☆..... جماع کی کثرت سے۔
(Diabetes mellitus)	☆..... ذیابیطس۔
(Due to Gonorrhea or Syphilis)	☆..... سوزاک یا سفلس کی وجہ سے۔

ولوائی ٹس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Vulvitis): ولوائی ٹس کی مریضہ میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں:

(Inflammation of vulva)	☆..... ولوا میں سوزش ہو جاتی ہے۔
(Redness of vulva)	☆..... ولوا سرخ ہو جاتی ہے۔
(Tenderness in vulva)	☆..... ولوا پر حس ہو جاتی ہے۔
(Pain in vulva)	☆..... ولوا میں درد ہوتا ہے۔
(Vaginal discharge)	☆..... ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے۔

(Irritation in vulva)	☆..... ولوایں خارش ہوتی ہے۔
(Irritation in vagina)	☆..... ویجائنہ میں بھی خارش ہو سکتی ہے۔
(Enlarged inguinal lymph nodes)	☆..... بعض اوقات جنگا سوں کے لمف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔
(Fever may or may not be present)	☆..... مریضہ کو بخار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔
(Infection may spread internally)	☆..... ولوایں انفیکشن اندرونی اعضائے تناسل تک بھی پھیل سکتا ہے۔

ولوایں ٹس کی تشخیص (Diagnosis Of Vulvitis): ولوایں ٹس کی تشخیص کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں؛

(Usually history is sufficient for diagnosis)	☆..... عموماً مریضہ کی ہسٹری ہی تشخیص کیلئے کافی ہوتی ہے۔
(Vaginal examination could diagnose)	☆..... ویجائنل ایگزامی نیشن سے بھی تشخیص ہو جاتی ہے۔
(C.B.C and E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس، آر کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان کرنا چاہیے۔
(Abdominal / pelvic ultrasound if needed)	☆..... ضرورت پڑنے پر پیٹ / پیڑو کا الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔

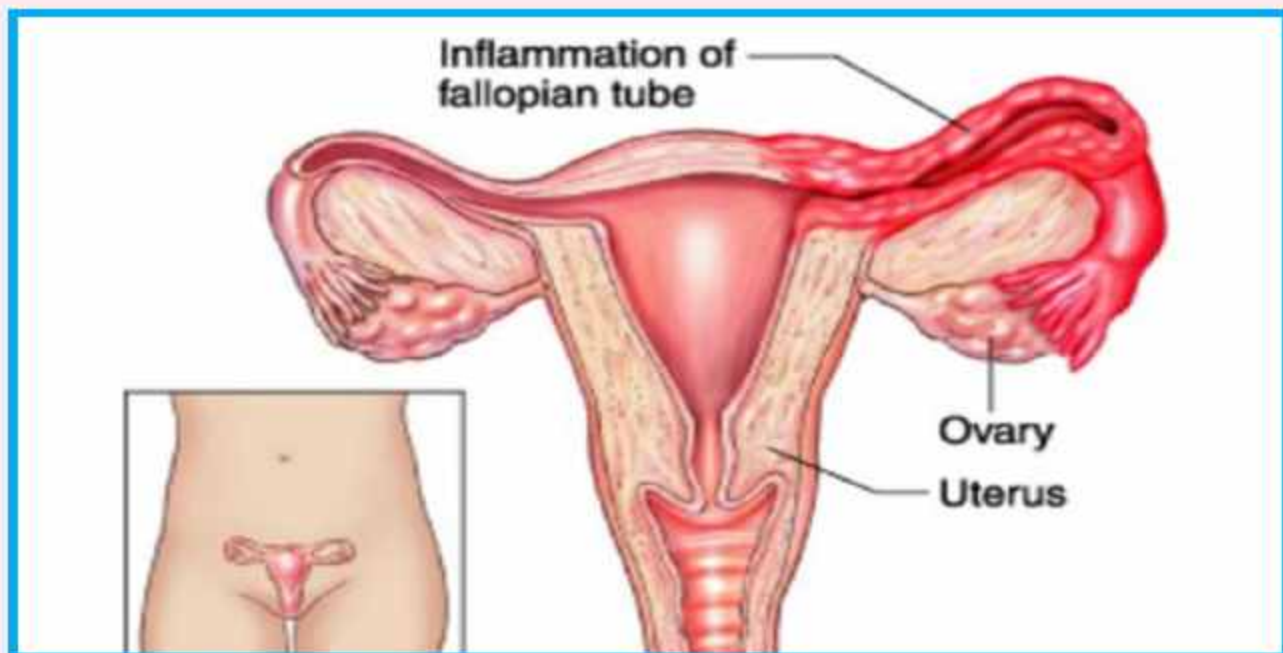
ولوایں ٹس کا علاج (Treatment Of Vulvitis): ولوایں ٹس کے علاج میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؛

(Anti-inflammatory drugs)	☆..... سوزش دور کرنے والی ادویات دینی چاہئیں۔
(Analgesic drugs)	☆..... درد کش ادویات دینی چاہیے۔
(Cleanliness of vulva)	☆..... ولوایں صفائی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔
(Diagnose and treat the cause)	☆..... ولوایں ٹس کی وجہ تلاش کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔
(Maintenance of vulval hygiene)	☆..... حفظانِ صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

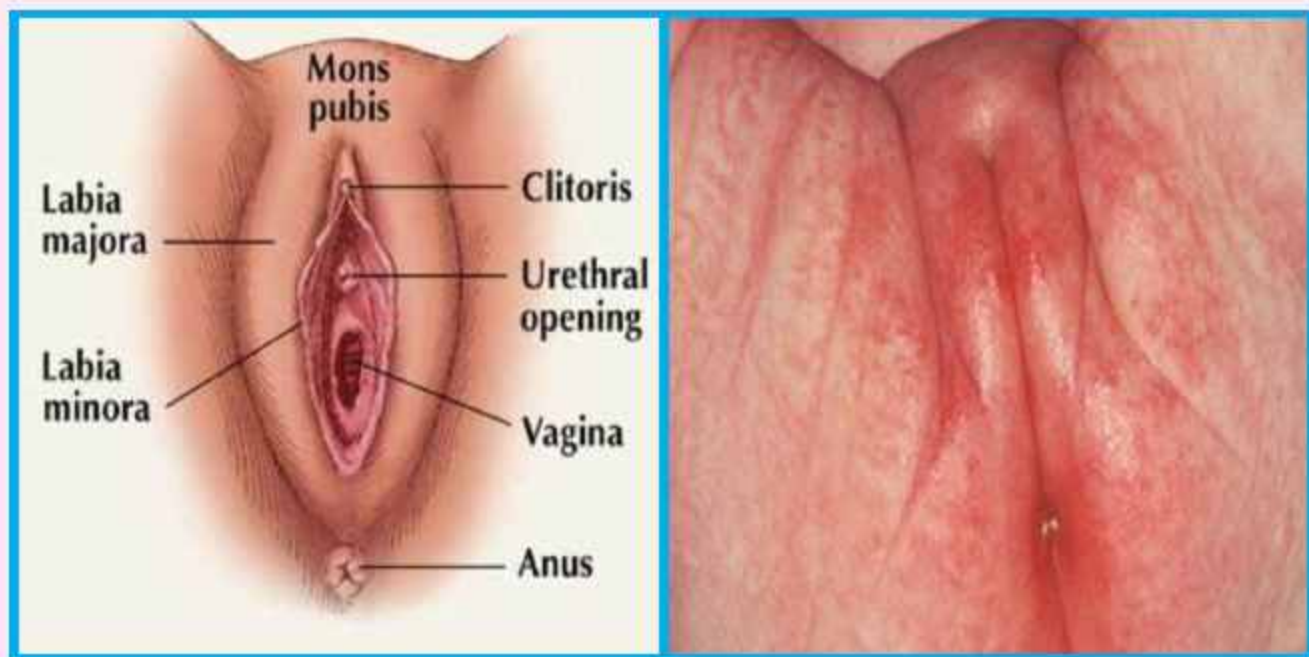
ولوائی ٹس کا ادویاتی علاج (Drugs Treatment Of Vulvitis): ولوائی ٹس علاج میں ادویاتی علاج کے دوران درج ذیل ہیں؛

(Canesten Cream)	کنینسٹن کریم۔	☆.....
(Gynosten Cream)	گائوسٹن کریم۔	☆.....
(Gynosporin Cream)	گائوسپورین کریم۔	☆.....
(Augmentin Tab)	آگ مینٹین گولیاں۔	☆.....
(Amoxil Cap 250mg)	ایماکسل کپسول 250 ملی گرام۔	☆.....
(Ampiclox Cap 250mg)	امپی کلاکس کپسول 250 ملی گرام۔	☆.....
(Velosef Cap 250mg)	ویلو سیف کپسول 250 ملی گرام۔	☆.....
(Lincocin Cap / Inj)	لنکوسین کپسول / انجکشن۔	☆.....
(Avil Tab / Inj)	اے ویل گولیاں / انجکشن۔	☆.....
(Gynodaktarin Cream)	گائوڈاکٹارین کریم۔	☆.....
(Cataflam Tab)	کیٹافلم گولیاں۔	☆.....
(T-Day Tab)	ٹی ڈے گولیاں۔	☆.....
(Softin 10mg Tab)	سافٹن 10 ملی گرام گولیاں۔	☆.....
(Decadron Inj)	ڈیکاڈران انجکشن۔	☆.....





Salpingitis



Normal Vulva

Vulvitis

ویجائنه کی سوزش

(ویجی نائی ٹس)

(VAGINITIS)

تعارف (Introduction): ویجائنه عورتوں کے انٹرنل آرگنز آف ری پروڈکشن کا ایک اہم عضو ہے۔ ویجائنه عورتوں کے اندرونی اعضائے تناسل کا پہلا عضو ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں میں کسی بھی وجہ سے ویجائنه میں انفلامیشن ہو جاتی ہے جسے ویجی نائی ٹس (Vaginitis) کہتے ہیں۔

ویجی نائی ٹس کی وجوہات (Causes Of Vaginitis): ویجی نائی ٹس کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں؛

(Due to Diabetes Mellitus)	☆..... شوگر کی بیماری کی وجہ سے۔
(Vaginal trauma)	☆..... ویجائنه پر چوٹ کا لگنا۔
(Vaginal instrumentation)	☆..... ویجائنه آلات کے استعمال سے۔
(Due to carcinoma cervix)	☆..... سرویکس کے کینسر کی وجہ سے۔
(Use of chemicals)	☆..... کیمیکلز کے استعمال سے۔
(Bacterial infections)	☆..... بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے۔
(Viral infections)	☆..... وائرل انفیکشن کی وجہ سے۔
(Parasitic infections)	☆..... پیراسائٹک انفیکشن کی وجہ سے۔
(Fungal infections)	☆..... فنگل انفیکشن کی وجہ سے۔
(Due to vulvitis)	☆..... ولو کی سوزش کی وجہ سے۔
(Due to allergy)	☆..... مختلف اشیاء سے الرجی کی وجہ سے۔
(Irritated leucorrhoea)	☆..... تیزابی لیکوریا کے اخراج کی وجہ سے۔

ویجی نائی ٹس کی علامات و نشانات (Signs & Symptoms Of Vaginitis): ویجی نائی ٹس میں درج ذیل علامات پائی جاسکتی ہیں؛

(Vaginal pain)	☆..... ویجائنہ میں درد ہوتا ہے۔
(Burning vaginal pain)	☆..... یہ درد جلن دار ہوا کرتا ہے۔
(Vaginal bleeding may be present)	☆..... ویجائنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔
(Vaginal discharge)	☆..... ویجائنل ڈسچارج ہوا کرتا ہے۔
(Pus discharge from vagina)	☆..... ویجائنہ سے پیپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔
(Redness of vagina)	☆..... ویجائنہ میں سرخی پائی جاتی ہے۔
(Inflammation of vagina)	☆..... ویجائنہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔
(Tenderness of vagina)	☆..... ویجائنہ پر حس ہوتی ہے۔
(Irritation in vagina)	☆..... ویجائنہ میں خارش بھی ہو سکتی ہے۔
(Mostly vaginitis occurs in pregnancy)	☆..... عموماً انفیکشن حمل کے دوران زیادہ ہوا کرتا ہے۔

ویجی نائی ٹس کی تشخیص (Diagnosis Of Vaginitis): ویجی نائی ٹس کی تشخیص عام طور پر درج ذیل طریقے سے کی جاتی ہے؛

(Vaginal smear test)	☆..... ویجائنہ سے رطوبتی اخراج کا امتحان کرنا چاہیے۔
(Abdominal / pelvic ultrasound if needed)	☆..... اگر ضرورت ہو تو پیٹ / پیڑ وکالٹرا ساؤنڈ کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان کرنا چاہیے۔
(Vaginal examination)	☆..... ویجائنل ایگزامی نیشن کرنا چاہیے۔
(C.B.C and E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر کرنا چاہیے۔
(Vaginal examination)	☆..... ویجائنل ایگزامی نیشن کرنا چاہیے۔
(Sometimes Hormonal Assay is needed)	☆..... بعض اوقات ہارمونل ایسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

علاج (Treatment): وہی نائی ٹس کا علاج عام طور پر درج ذیل اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے جس کے عموماً اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں؛

(Analgesic drugs)	دافع درد ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔	☆.....
(Anti-inflammatory drugs)	دافع سوزش ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔	☆.....
(Sexual intercourse is forbided)	جنسی ملاپ سے کچھ عرصے پرہیز کا مشورہ دینا چاہیے۔	☆.....
(Diagnose and treat the actual cause)	مرض کی اصل وجہ تلاش کر کے علاج کرنا چاہیے۔	☆.....
(Maintain gynaecological hygiene)	حفظان صحت و صفائی کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔	☆.....

وہی نائی ٹس کا ادویاتی علاج (Drugs Treatment Of Vaginitis): وہی نائی ٹس کا ادویاتی علاج درج ذیل ہے؛

(Canesten Cream / Tab)	کینسٹن کریم / گولیاں۔	☆.....
(Vagmycin Cream)	ویگ مائی سین کریم۔	☆.....
(Gynosporin Cream)	گائوسپورین کریم۔	☆.....
(Gynodaktarin Cream)	گائوڈاکٹارین کریم۔	☆.....
(Novidat Tab)	نودی ڈیٹ گولیاں۔	☆.....
(Ampiclox Cap)	ایمپی کلاس کپسول۔	☆.....
(Dicloran Tab)	ڈیکلوران گولیاں۔	☆.....
(Velosef Inj)	ویلو سیف انجکشن۔	☆.....
(Tramal Tab)	ٹرامال گولیاں۔	☆.....
(Ponstan forte Tab)	پونسٹان فورٹ گولیاں۔	☆.....
(Augmentin Tab)	آگ مینٹین گولیاں۔	☆.....
(Amoxil Cap 250mg)	ایماکسل کپسول 250 ملی گرام۔	☆.....
(Septran-DS Tab)	سپٹران ڈی ایس گولیاں۔	☆.....



ولوا کی خارش (پرورائی ٹس ولوائی) (PRURITUS VULVAE)

تعارف (Introduction): عورتوں کے ایکسٹرنل ریپر وڈ کیٹو آرگنز کو ولوا کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ولوا میں سوزش کے علاوہ خارش کی سی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ ولوا پر یہ خارش عورتوں یا لڑکیوں کیلئے انتہائی تکلیف دہ مرض ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی عورت یا لڑکی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر اس خارش سے جان چھڑانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے اس بیرونی اعضائے تناسل کی خارش کا علاج نہایت توجہ اور محنت سے کرنا چاہیے۔ عورتوں کے اس مرض یعنی ولوا میں تحریک اور خارش ہونے کو گائنا کی اصطلاح میں پرورائی ٹس ولوائی (Pruritis Vulvae) کہتے ہیں۔

پرورائی ٹس ولوائی کی وجوہات (Causes Of Pruritis Vulvae): پرورائی ٹس ولوائی درج ذیل وجوہات کی بناء پر ہو سکتا ہے؛

(Fungal Infection e.g. candidiasis)	☆..... فنگل انفکشن مثلاً کینڈیڈا کا انفکشن۔
(Parasites e.g. Trichomonas vaginalis)	☆..... پیراسائٹک مثلاً ٹرائیکوموناس ویجینی نیلس انفکشن۔
(Allergy due to soap)	☆..... صابن سے ری ایکشن ہو جانا۔
(Reaction due to use of antiseptic)	☆..... اینٹی سپٹک کے استعمال سے ری ایکشن ہو جانا۔
(Reaction due to vaginal drugs)	☆..... وائیجائیل ڈرگز سے ری ایکشن ہو جانا۔
(Contraceptive drugs reaction)	☆..... مانع حمل ادویات کا ویجائینہ پری ایکشن کرنا۔
(Unhygienic gynaecological conditions)	☆..... صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔
(Use of underwear & nighty)	☆..... ناکیٹ اندروئیر کے پہننے سے ری ایکشن ہونا۔
(Allergy due to eggs, fish etc)	☆..... انڈے مچھلی وغیرہ سے الرجی ہونا۔
(Eczema, Dermatitis, Psoriasis, Scabies)	☆..... چلدی بیماریاں، ایگزیم، جلد کی سوزش، سورائمز، خارش۔
(Diabetes Mellitus)	☆..... ذیابیطس کی بیماری کی وجہ سے۔

(Lack of vitamins)	☆..... وٹامنز کی کمی ہونا۔
(Disease of vulva)	☆..... ولوا کی بیماریوں کی وجہ سے۔
(Low estrogens in menopause)	☆..... سن یاس کے بعد ایسٹروجنز ہارمون کی کمی کی وجہ سے۔
(Vaginismus)	☆..... ویجائنزم کا سکڑنا۔
(Vulvitis)	☆..... ولوا کا انفیکشن ہونا۔
(Ulcer of vulva)	☆..... ولوا میں السر ہونا۔
(Associated infections of vulva)	☆..... ولوا کے آس پاس کسی جگہ کا انفیکشن ہونا۔
(Kidney diseases, Uraemia & uric acid)	☆..... گردوں کی خرابی، یوریمیا، یورک ایسڈ کی زیادتی۔
(Intercourse with different partners)	☆..... جنسی بے راہ روی کی وجہ سے۔
(Idiopathic causes)	☆..... نامعلوم وجوہات کی بناء پر بھی پردرائی ٹس ولوائی ہو سکتا ہے۔

پردرائی ٹس ولوائی کی علامات و نشانیائیں (Signs & Symptoms Of Pruritis Vulvae): اسکی درج ذیل علامات ہوتی ہیں:

(Irritation of vulva)	☆..... ولوا میں خارش ہوتی ہے۔
(Can spread to neighbouring areas)	☆..... ولوا کی یہ خارش ملحقہ حصوں پر بھی پھیل سکتی ہے۔
(Can spread to thighs, pubis, perineum)	☆..... خارش رانوں، زیر ناف حصہ پیری نیئم پر بھی پھیل سکتی ہے۔
(Vulvitis)	☆..... ولوا میں سوزش ہو جاتی ہے۔
(Tenderness of vulva)	☆..... ولوا پر حس ہو جاتی ہے۔
(Pain in vulva)	☆..... خارش کرنے کی وجہ سے ولوا میں درد ہوتا ہے۔
(Rednees in vulva)	☆..... خارش کرنے کی وجہ سے ولوا میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔
(Burning in vulva)	☆..... خارش کرنے کی وجہ سے ولوا میں جلن ہوتی ہے۔
(Patient can't sleep due to irritation)	☆..... خارش کی وجہ سے مریض کو نیند نہیں آتی ہے۔
(Ulcers on vulva due to irritation)	☆..... خارش کرنے کی وجہ سے ولوا پر زخم سے بن جاتے ہیں۔

پرورائی ٹس ولوائی کی تشخیص (Diagnosis Of Pruritis Vulvae): اس مرض کی تشخیص درج ذیل طریقے سے کی جاتی ہے؛

(Usually history makes diagnosis)	☆..... عموماً ہسٹری ہی سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔
(Gynaecological exam: makes diagnosis)	☆..... گائنا کولاجیکل ایگزامی نیشن سے تشخیص ہو جاتی ہے۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل امتحان کیا جاتا ہے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا امتحان کیا جاتا ہے۔
(Pelvic ultrasound if needed)	☆..... ضرورت ہو تو پیلوک الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے۔

علاج (Treatment): اس مرض کے علاج میں درج ذیل اصول اختیار کئے جاتے ہیں؛

(Try to avoid allergens)	☆..... الرجی کی صورت میں الرجین سے پرہیز کریں۔
(Anti allergic drugs)	☆..... دافع خارش ادویات کے استعمال کا مشورہ دیں۔
(Cleanliness of vulva)	☆..... ولوا کی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
(Diagnose and treat actual cause)	☆..... اصل وجہ تلاش کر کے علاج کریں۔
(Hygienic conditions must be maintained)	☆..... حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہیں۔

پرورائی ٹس ولوائی کا ادویاتی علاج (Drugs Treatment Of Pruritis Vulvae): اس مرض کا ادویاتی علاج درج ذیل ہے؛

(Canesten Cream / Tab)	☆..... کینسٹن کریم / گولیاں۔
(Vagmycin Cream)	☆..... ویک مائی سین کریم۔
(Gynosporin Cream)	☆..... گائوسپورین کریم۔
(Gynodaktaren Cream)	☆..... گائوڈاکٹارن کریم۔
(Novidat Tab)	☆..... نووڈی ڈیٹ گولیاں۔
(Ampiclox Cap)	☆..... امپیکلوکس کپسول۔
(Dicloran Tab)	☆..... ڈیکلوران گولیاں۔

(Velosef Inj)	☆..... ویلوسیف انجکشن۔
(Avil Tab / Inj)	☆..... اے ول گولیاں / انجکشن۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونستان فورٹ گولیاں۔
(Augmentin Tab)	☆..... آگ مینٹین گولیاں۔
(Amoxil Cap 250mg)	☆..... ایماکسل کپسول 250 ملی گرام۔
(T-Day Tab)	☆..... ٹی ڈے گولیاں۔
(Piriton Tab)	☆..... پیری ٹان گولیاں۔
(Softin Tab)	☆..... سافٹن گولیاں۔



سرویکس کی سوزش

(سروی سائی ٹس)

(CERVICITIS)

تعارف (Introduction): یوٹرس کے نچلے حصے سرویکس کی سوزش کو سروی سائی ٹس کہتے ہیں۔ یوٹرس کا نچلا حصہ سرویکس گائنی کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ یوٹرس کی ابتداء ہے اور یوٹرائن انفیکشنز عام طور پر یوٹرس کے اسی حصے سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسٹینٹرس کے لحاظ سے بھی یوٹرس کا سرویکس نہایت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوران زچگی سرویکس کے پھیلنے پر ہی برتھ کیٹال بنا کرتی ہے اور اس طرح بچے کی ڈیلیوری میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث سرویکس کی دیواروں پر خراشیں پڑ جاتی ہیں جنہیں گائنا کالوجیکل ٹرمینالوجی میں سروائیکل ٹئرز (Cervical Tears) کہا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اگر ڈیلیوری کے دوران پیچیدگی زیادہ ہو تو سرویکس کی دیواروں پر باقاعدہ زخم سے بن جاتے ہیں جنہیں سروائیکل السرز (Cervical Ulcers) کہا جاتا ہے۔ بہر حال عام طور پر عورتوں میں سرویکس کی سوزش یعنی سروائیکل انفلامیشن ہی ہوا کرتی ہے جسے سروی سائی ٹس (Cervicitis) کہتے ہیں۔

سروی سائیٹس کی وجوہات (Causes Of Cervicitis): سرویکس کی سوزش کے مرض کی عام وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Diabetes Mellitus)	☆..... ذیابیطس کی بیماری۔
(Cervical injury at the time of delivery)	☆..... بچے کی پیدائش کے وقت سرویکس کا زخمی ہونا۔
(Bacterial Infection)	☆..... بیکٹیریل انفیکشن۔
(Instrumentation)	☆..... آلات کا استعمال۔
(Unhygienic gynaecological conditions)	☆..... صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا۔
(Uterine inflammation can spread to cervix)	☆..... یوٹرس کی سوزش پھیل کر سرویکس تک جاسکتی ہے۔

سروی سائیٹس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Cervicitis): اس مرض میں درج ذیل علامات ہوتی ہیں؛

(Initially watery cervical discharge)	☆..... سرویکس سے پہلے پہل پتلی رطوبت خارج ہوتی ہے۔
(Severe cervical inflammation)	☆..... سرویکس کی سوزش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔
(Later on foully smelled pustulay discharge)	☆..... سرویکس سے گاڑھی بدبودار پیپ خارج ہوتی ہے۔
(Hypogastric pain)	☆..... سوزش کی وجہ سے ہائپوگیسٹریم میں درد ہوتا ہے۔
(Inflammation of cervix)	☆..... سرویکس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔
(Tenderness in cervix)	☆..... سرویکس پر حس ہو جاتی ہے۔
(Low backache)	☆..... کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔
(Burning in cervix)	☆..... سرویکس میں جلن ہوتی ہے۔
(Dysmenorrhoea)	☆..... حیض کے دوران درد ہوتا ہے۔
(Menorrhagia)	☆..... حیض میں زیادتی ہوتی ہے۔
(Dyspareunia)	☆..... جماع کے وقت درد ہوتا ہے۔
(Fear of intercourse)	☆..... مریضہ جماع سے خوفزدہ ہوتی ہے۔
(Fever may or may not be present)	☆..... زیادہ سوزش کی وجہ سے بخار ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔

سروی سائیٹس کی تشخیص (Diagnosis Of Cervicitis): سروی سائیٹس کی تشخیص کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؛

(Cervical smear test)	سرویٹس کے اخراج کا لیبارٹری معائنہ کرنا چاہیے۔	☆.....
(Pelvic ultrasound)	پیلوٹک الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔	☆.....
(Cervical endoscopy)	سرویٹس کی انڈوسکوپ کرنا چاہیے۔	☆.....
(Urine R/E)	پیشاب کا لیبارٹری تجزیہ کرنا چاہیے۔	☆.....
(C.B.C with E.S.R)	خون کا مکمل امتحان اور ایس، آر کرنا چاہیے۔	☆.....

سروی سائیٹس کا علاج (Treatment Of Cervicitis): سروی سائیٹس کے علاج میں درج ذیل ادویات استعمال کی جاتی ہیں؛

(Novidat 250mg Tab)	نووی ڈیٹ 250 ملی گرام گولیاں۔	☆.....
(Genticyn Inj)	جنٹامین انجکشن۔	☆.....
(Velosef Inj / Cap)	ویلو سیف انجکشن / کپسول۔	☆.....
(Dicloran Inj)	ڈیکلوران انجکشن۔	☆.....
(Proxen Tab)	پروکسن گولیاں۔	☆.....
(Ampiclox Inj / Tab)	امپی کلاکس انجکشن / گولیاں۔	☆.....
(Augmentine Tab)	آگ مینٹن گولیاں۔	☆.....
(Cataflam Tab)	کیٹا فلیم گولیاں۔	☆.....
(Ponstan forte Tab)	پونستان فورٹ گولیاں۔	☆.....
(Roxicam Cap)	روکسی کیم کپسول۔	☆.....
(Brufen 400mg Tab)	بروفن 400 ملی گرام گولیاں۔	☆.....
(Canesten vaginal cream)	کیناسٹین ویجاٹل کریم۔	☆.....
(Gynosporin vaginal cream)	گائوسپورین ویجاٹل کریم۔	☆.....
(Vagamycin vaginal cream)	ویگامائی سین ویجاٹل کریم۔	☆.....



اینڈومیٹریٹس کی سوزش

(اینڈومیٹرائٹس)

(ENDOMETRITIS)

تعارف (Introduction): زنانہ اعضاء تناسل میں بچے دانی یعنی یوٹرس ایک انتہائی اہم عضو ہے۔ یوٹرس اپنی ساخت کے لحاظ سے عضلات کی تین تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یوٹرس کی بیرونی تہ کو اپی میٹریم (Epimetrium) کہتے ہیں۔ اسی طرح یوٹرس کی درمیانی تہ کو مائیومیٹریم (Myometrium) کہتے ہیں اور یوٹرس کی اندرونی تہ کو اینڈومیٹریم (Endometrium) کہتے ہیں۔ اگر یوٹرس کی تینوں تہوں میں سوزش ہو جائے تو اسے میٹرائٹس (Metritis) کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ یوٹرس کی صرف بیرونی تہ کی سوزش ہو جایا کرتی ہے جسے گائنا کولاجیکل ٹرینالوجی میں اپی میٹرائٹس (Epimetritis) کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یوٹرس کی درمیانی تہ کی سوزش ہو جایا کرتی ہے جسے گائنا کی زبان میں مائیومیٹرائٹس (Myometritis) کہتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں عام طور پر یوٹرس کی اندرونی تہ کی سوزش بھی ایک نہایت ہی عام پایا جانے والا مرض ہے۔ یوٹرس کی اندرونی تہ اینڈومیٹریم کی سوزش کو اینڈومیٹرائٹس (Endometritis) کہتے ہیں۔

اینڈومیٹرائٹس کی وجوہات (Causes Of Endometritis): اینڈومیٹرائٹس کی عام پائی جانے والی وجوہات درج ذیل ہیں:

(Endometrial infection)	☆..... اینڈومیٹریٹس کا انفیکشن۔
(Salpingitis)	☆..... فیلوپیئن ٹیوبز کی سوزش۔
(Vaginitis)	☆..... ویجائنہ کی سوزش۔
(Cervicitis)	☆..... سرویکس کی سوزش۔
(Vulvitis)	☆..... ولوا کی سوزش۔
(Carcinoma cervix)	☆..... سرویکس کا کینسر۔
(Carcinoma endometrium)	☆..... اینڈومیٹریٹس کا کینسر۔
(Uterine wounds during delivery)	☆..... زچگی کے دوران یوٹرس کا زخمی ہونا۔
(Use of contraceptive medicines)	☆..... مانع حمل ادویات کا استعمال۔

(Endometrial T.B)	☆..... اینڈومیٹریٹس کی ٹی بی ہونا۔
(Vaginal instrumentation)	☆..... ویجائنل معائنہ کے دوران آلات کا استعمال۔
(Gonorrhoeal spread)	☆..... سوزاک کا پھیل جانا۔

اینڈومیٹرائٹس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Endometritis): اس مرض میں درج ذیل علامات ہوتی ہیں:

(Pelvic pain)	☆..... پیلوئس میں درد ہوتا ہے۔
(Vaginal discharge)	☆..... ویجائنہ سے رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔
(Bloody vaginal discharge)	☆..... ویجائنل اخراج میں خون ملا ہوا ہو سکتا ہے۔
(Backache)	☆..... کمر درد ہوتا ہے۔
(Irregular menses and polymenorrhoea)	☆..... بے قاعدہ اور کثرت سے حیض ہوتا ہے۔
(Anaemia)	☆..... خون کی کمی یعنی انیمیا ہوتا ہے۔
(General weakness)	☆..... مریضہ میں کمزوری پائی جاتی ہے۔
(Tenderness in hypogastrium)	☆..... زیر ناف حصہ انتہائی پردہ حس ہوتا ہے۔
(Fever may be present)	☆..... مریضہ کو بخار ہو جاتا ہے۔
(Inflammation may spread to other parts)	☆..... اینڈومیٹریٹس کی یہ سوزش دوسرے حصوں تک پھیل سکتی ہے۔
(Burning in vagina)	☆..... ویجائنہ میں جلن ہوتی ہے۔
(Itching in vagina)	☆..... ویجائنہ میں خارش ہوتی ہے۔
(Vaginal pain)	☆..... ویجائنہ میں درد کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔
(Urgency In Urine)	☆..... مریضہ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔
(Increase sexual desire)	☆..... مریضہ کی جنسی خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اینڈومیٹرائٹس کی تشخیص (Diagnosis Of Endometritis): اینڈومیٹرائٹس کی تشخیص کیلئے درج ذیل ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں:

(Gynaecological examination)	☆..... گائنا کولاجیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔
(Pelvic ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے۔
(Endometrial smear test)	☆..... اینڈومیٹریل سمیر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
(Endometrial biopsy)	☆..... اینڈومیٹریل بائیوپسی کی جاتی ہے۔
(Urin R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل امتحان اور ای ایس آر کیا جاتا ہے۔

اینڈومیٹرائٹس کا علاج (Treatment Of Endometritis): اینڈومیٹرائٹس کا علاج درج ذیل ادویات سے کیا جاتا ہے:

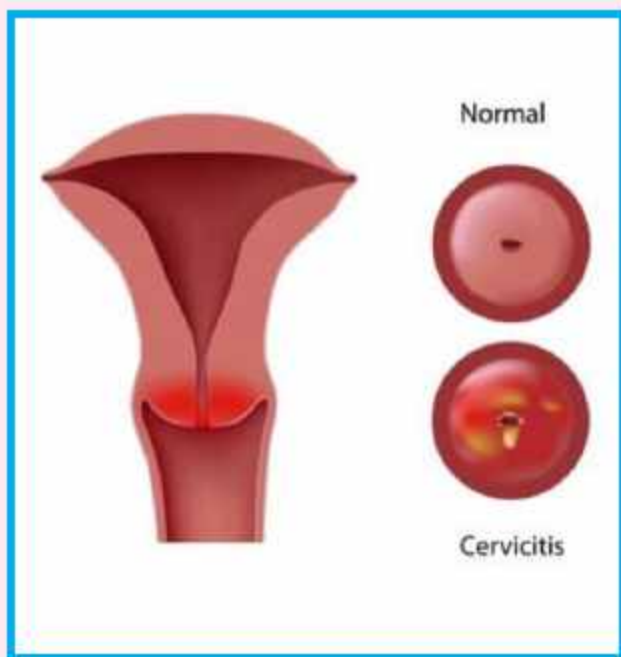
(Analgesic drugs)	☆..... دافع درد ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Anti-inflammatory drugs)	☆..... دافع سوزش ادویات کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Complete bed rest)	☆..... مریض کو مکمل آرام کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Avoid sexual intercourse)	☆..... کچھ عرصہ جماع سے پرہیز کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Maintain hygienic principles)	☆..... حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کا مشورہ دینا چاہیے۔
(Diagnostic D & C)	☆..... کئی مرتبہ ڈائگنوسٹک ڈی اینڈ سی بھی کی جاتی ہے۔
(Augmentin Tab)	☆..... آگ مینٹن گولیاں۔
(Amoxil Cap / Inj)	☆..... ایماکسل کپسول / انجکشن۔
(Velosef Cap / Inj)	☆..... ویلوسیف کپسول / انجکشن۔
(Bactrim forte Tab)	☆..... بیکٹرم فورٹ گولیاں۔
(Doxyn Cap)	☆..... ڈوکسن کپسول۔
(Froben Tab)	☆..... فروبن گولیاں۔
(Ansaid Tab)	☆..... انسڈ گولیاں۔



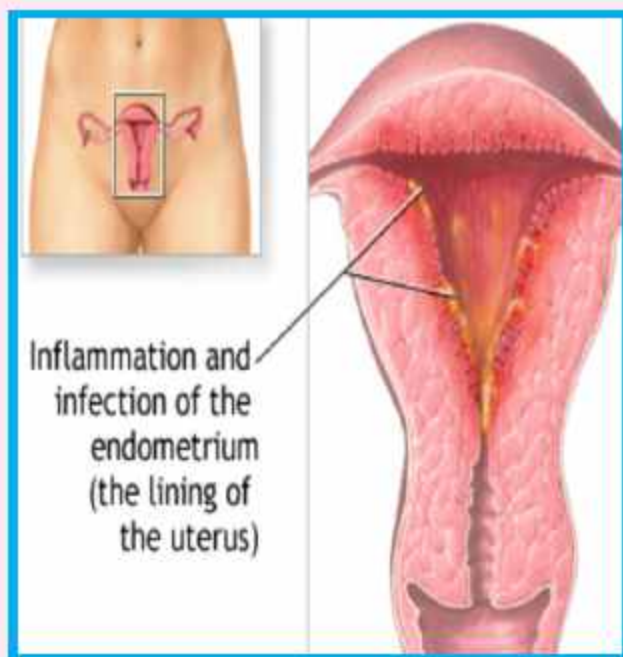
Vaginitis



Pruritus Vulvae



Cervicitis



Endometritis

(Dicloran Inj / Tab)	☆..... ڈیکلوران انجکشن / گولیاں۔
(Lincocin Cap / Inj)	☆..... لینکوسین کپسول / انجکشن۔
(Kanacin Inj)	☆..... کیناسین انجکشن۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونسٹان فورٹ گولیاں۔
(Brufen 400mg Tab)	☆..... برufen 400 ملی گرام گولیاں۔
(Cataflam Tab)	☆..... کیٹافلام گولیاں۔



سیلان الرحم (لیکوریہ) (LEUCORRHOEA)

تعارف (Introduction): کئی عورتوں اور لڑکیوں میں لیکوریا کی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ عام طور پر عورتوں کی ویجائنہ اپنی رطوبات کی سیکریشن کے باعث تر رہتی ہے لیکن اگر کسی وجہ کے باعث ویجائنہ سے ان رطوبات کا اخراج پانی کی شکل میں حد سے زیادہ ہو تو یہ کنڈیشن عورتوں کے لئے انتہائی تکلیف دہ اور کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ غرضیکہ ویجائنہ سے سفید رنگ کی رطوبت کا اخراج لیکوریا (Leucorrhoea) کہلاتا ہے۔

لیکوریہ کی وجوہات (Causes Of Leucorrhoea): لیکوریہ کے مرض کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

(Pregnancy)	☆..... حمل کے دوران عام طور پر عورتوں کو لیکوریا ہوا کرتا ہے۔
(Sexual excitement)	☆..... نوجوان لڑکیوں میں جنسی تحریک کے باعث لیکوریا ہوتا ہے۔
(Cervical tissues erosion)	☆..... اگر سرویکس کے ٹشو زخمی یا شروع ہو جائیں تو لیکوریا ہوتا ہے۔
(Vaginal instrumentation)	☆..... ویجائنل معائنہ کے دوران آلات کا استعمال بھی لیکوریا کرتا ہے۔

(Prolapsus of uterus)	☆..... اگر یوٹرس ٹل جائے تو بھی لیکور یا ہو سکتا ہے۔
(Trichomonas vaginalis, Candidiasis)	☆..... ویجائٹل انفیکشن خصوصاً ٹرائیکوموناس و بیجی نیلس یا کینڈیڈا انفیکشن۔
(Carcinoma uterus)	☆..... یوٹرس کا کینسر بھی لیکور یا کا باعث بنتا ہے۔
(Carcinoma cervix)	☆..... سرویکس کا کینسر بھی لیکور یا کا باعث بنتا ہے۔
(Pelvic inflammatory disease)	☆..... خواتین کے اعضائے مخصوصہ کے اندرونی حصوں کی سوزش۔
(Internal trauma of female genitalia)	☆..... خواتین کے اعضائے مخصوصہ میں اندرونی طور پر زخم یا چوٹ لگے۔

لیکور یا کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Leucorrhoea): لیکور یا کے مرض میں درج ذیل علامات ہوتی ہیں؛

(White discharge from vagina)	☆..... ویجائنہ سے سفید رنگ کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔
(Females afraid about cancer)	☆..... عورتیں خوفزدہ ہوتی ہیں کہ اعضائے مخصوصہ کا کینسر تو نہیں۔
(Irritative vaginal discharge)	☆..... ویجائٹل اخراج خراش دار بھی ہو سکتا ہے۔
(Discharge fix stains on clothes)	☆..... ویجائٹل اخراج کپڑوں پر داغ دھبے بھی چھوڑ دیتا ہے۔
(Pelvic pains)	☆..... مریضہ کی پیلووس میں درد ہوتا ہے۔
(Backache)	☆..... مریضہ کی کمر میں درد ہوتا ہے۔
(Generalized weakness)	☆..... مریضہ میں کمزوری پائی جاتی ہے۔
(Generalized myalgia)	☆..... مریضہ کے تمام جسم میں دردیں اور سستی پائی جاتی ہیں۔
(Hypogastric pains)	☆..... مریضہ کے پیٹرو میں بھی درد ہوتا ہے۔
(Anorexia)	☆..... مریضہ کی بھوک میں کمی ہو جاتی ہے۔
(Patient becomes pallor day by day)	☆..... مریضہ کی رنگت دن بدن پیلی پڑتی جاتی ہے۔
(Fever may be present)	☆..... مریضہ کو بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔

لیکوریا کی تشخیص (Diagnosis Of Leucorrhoea): لیکوریا کے مرض کی تشخیص درج ذیل ٹیسٹوں کے ذریعے کی جاسکتی ہے؛

(Vaginal discharge smear examination)	☆.....	ویجائنل رطوبت کا لیبارٹری امتحان کرنا چاہیے۔
(Pelvic ultrasound)	☆.....	پیلوٹک الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے۔
(Vaginal examination)	☆.....	ویجائنل معائنہ کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆.....	پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔
(C.B.C with E.S.R)	☆.....	خون کا مکمل امتحان اور ای، الیس، آر کرنا چاہیے۔

لیکوریا کا علاج (Treatment Of Leucorrhoea): لیکوریا کا علاج درج ذیل اصولوں اور ادویات کے تحت کیا جاتا ہے؛

(Anti-inflammatory drugs)	☆.....	دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینا چاہیے۔
(Complete bed rest)	☆.....	مکمل آرام اور حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہیں۔
(Balance diet)	☆.....	متوازن، سادہ خوراک کے استعمال کا مشورہ دیں۔
(Forbid to have heavy work)	☆.....	بوجھ اور وزن کے کاموں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیں۔
(Sulpha vaginal Cream)	☆.....	سلفا ویجائنل کریم۔
(Gyno Daktarin vaginal Cream)	☆.....	گائٹروڈیکٹارین ویجائنل کریم۔
(Vagmycine vaginal Cream)	☆.....	ویگمائی سین ویجائنل کریم۔
(Vagitab vaginal Tab)	☆.....	ویجی ٹیب ویجائنل گولیاں۔
(Lukol vaginal Tab)	☆.....	لیوکول ویجائنل گولیاں۔
(Vagmycine vaginal Tab)	☆.....	ویگمائی سین ویجائنل گولیاں۔
(Canesten vaginal Cream)	☆.....	کینسٹن ویجائنل کریم۔
(Canesten vaginal Tab)	☆.....	کینسٹن ویجائنل گولیاں۔
(Gynosporin vaginal Cream)	☆.....	گائٹنوسپورین ویجائنل کریم۔
(Nystatin oral Tab)	☆.....	نیسٹین اورل گولیاں۔

(Grisovin 125 mg Tab)	☆..... گرائی سووین 125 ملی گرام گولیاں۔
(Flagyl 400 mg Tab)	☆..... فلیجیل 400 ملی گرام گولیاں۔
(Ampicillin 250 mg Cap)	☆..... امپی سیلین کپسول 250 ملی گرام۔
(Ampiclox 250 mg Cap)	☆..... امپی کلاکس کپسول 250 ملی گرام۔
(Dicloran 50 mg Tab)	☆..... ڈیکلوران 50 ملی گرام گولیاں۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونسٹان فورٹ گولیاں۔



آتشک

(سفلس)

(SYPHILIS)

تعارف (Introduction): سفلس یعنی آتشک ایک جنسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتی ہے یہ پیدائشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری مرد و عورت دونوں کو لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری جنسی طریقے سے مرد سے عورت کو یا عورت سے مرد کو لاحق ہو سکتی ہے۔ سفلس ایک انتہائی سخت قسم کی بیماری ہے جس کی تشخیص جلد ہونا قدرے مشکل ہے۔ یہ بیماری اگر کراٹک شکل اختیار کر جائے تو اس کا علاج نہایت طویل اور صبر آزما ہوا کرتا ہے۔ یہ بیماری اگرچہ جنسی طور پر لاحق ہوتی ہے لیکن کئی مرتبہ یہ بیماری جسم کے دوسرے سسٹم اور آرگنز کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر یہ بیماری کسی حاملہ عورت کو لاحق ہو تو پھر یہ بیماری اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو پیدائشی طور پر لاحق ہو جایا کرتی ہے لہذا اس بیماری کی یہ تشخیص اور علاج نہایت احتیاط و توجہ اور جانفشانی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عورت کو دوران علاج اپنے مرد کے ساتھ انٹرکورس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ بیماری جنسی ذرائع سے پھیلا کرتی ہے اسی لئے اس بیماری کو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز (Sexual Transmitted Disease) کہتے ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے سلسلے میں یہاں یہ بات قابل ذکر اور انتہائی اہم ہے کہ اگر مرد یا عورت کسی ایک سیکشول پائتھر میں اس بیماری کی علامات اور نشانیوں مل جائیں اور پھر ان کی لیبارٹری تشخیص بھی ہو جائے تو نہ صرف متاثرہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ دوسرے پائتھر کا بھی احتیاطاً علاج شروع کر دیا جاتا ہے کہ کہیں دوسرا پائتھر اس بیماری کے انکیوبیشن پیریڈ میں نہ ہو لہذا دونوں پائتھر کا علاج شروع کرنا بہتر ہوتا ہے۔

سفلس کی وجوہات (Causes Of Syphilis): سفلس کے مرض کی عام اور بڑی وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Treponema pallidum)	یہ مرض ایک جراثیم ٹریپونیمائیلی ڈیم کے ذریعے لگا کرتا ہے۔	☆.....
(Its germs spread sexually)	یہ جراثیم متاثرہ فرد سے جنسی میل جول کے ذریعے پھیلتا ہے۔	☆.....
(It spreads through infected blood)	سفلس کا مرض متاثرہ خون کے ذریعے بھی پھیلا کرتا ہے۔	☆.....

سفلس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Syphilis): سفلس کے مرض کے تین درجے ہوتے ہیں جو کہ یہ ہیں؛

سفلس کی پہلی سٹیج (First Stage Of Syphilis): اعضاء تاسل و مخصوصہ کی جلد پر ہلکی سی خراش کے ذریعے سفلس کے جراثیم ٹریپونیمائیلی ڈیم (Treponema Pallidum) تقریباً تین سے چھ ہفتوں کے بعد ایک ہلکا سا زخم پیدا کر دیتے ہیں جسے شکر (Chancre) کہتے ہیں۔ شکر سے پانی کی طرح کا ڈسچارج ہوا کرتا ہے۔ جس میں سے بعد میں پیپ خارج ہوا کرتی ہے۔ اعضاء مخصوصہ کی متاثرہ جلد پر ورم آجاتا ہے اور وہ جگہ سخت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد متعلقہ لمف نوڈز بھول کر بڑھ جایا کرتے ہیں تاہم ان میں درد نہیں ہوا کرتا۔ سفلس کے یہ شکر عام طور پر وینچر، لیپیا مینورا، لیپیا میجورا، یوریتھرا، یا پھر سرویکس کے اندرونی حصوں پر ہوتے ہیں۔

سفلس کی دوسری سٹیج (Second Stage Of Syphilis): سفلس کا یہ شکر ایک سے آٹھ ہفتوں میں خود بخود غائب ہو جایا کرتا ہے۔ سفلس کے جراثیم مریضہ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور جلد پر ابھار سے نکل آتے ہیں جن میں خارش نہیں ہوتی۔ مریضہ کو بھوک نہیں لگتی۔ مریضہ کو جسمانی کمزوری اور تھکن ہو جاتی ہے۔ انیمیا، بخار، جسم درد، سر درد ہوتا ہے۔ سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے ظاہر ہوتے ہیں اور گلہ پک جاتا ہے۔ آنکھوں کے پردہ بصارت کارنیا (Cornea) اور آئرس (Iris) کی سوزش ہو جاتی ہے۔ جبکہ وینچر اور مقعد پر کنڈائی لومینا (Condylomata) بن جاتے ہیں۔

سفلس کی تیسری سٹیج (Third Stage Of Syphilis): اس سٹیج میں سفلس کے جراثیم ہڈیوں، جوڑوں، آنکھوں، خون کی نالیوں اور دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں جسم میں سخت اور چک دار گومز جیسے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں گوماز (Gummas) کہا جاتا ہے۔ یہ گومز جسم میں کسی بھی جگہ بن سکتے ہیں۔ اس سٹیج میں جلد کا سن ہونا، ناک کا بیٹھنا، تالو میں سوراخ ہونا، بلڈ وینسلز کا تنگ ہو جانا، دماغ و حرام مغز کی جھلیوں کی سوزش کے نتیجے میں فالج ہونا یا پاگل پن اور ہڈیان کی علامات کا ظاہر ہونا سامنے آتا ہے۔

سفلس کی تشخیص (Diagnosis Of Syphilis): اگر مریضہ پر سفلس کا شک ہو تو درج ذیل ٹسٹوں کے ذریعے تشخیص کو کنفرم کرنا چاہیے؛

(Chancres smear lab examination)	☆..... شکرز سے خارج شدہ رطوبت کا تجزیہ کرنا چاہیے۔
(V.D.R.L Test)	☆..... وی، ڈی، آر، ایل (V.D.R.L) ٹسٹ کرنا چاہیے۔
(Florescent Treponemal Ab absorption)	☆..... فلورسینٹ ٹریپونیمیل اینٹی باڈیز ایب زارپشن ٹسٹ کریں۔
(Blood Culture test)	☆..... مریضہ کا بلڈ کلچر ٹسٹ کرنا چاہیے۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل امتحان اور ای ایس آر کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔

سفلس کا علاج (Treatment Of Syphilis): سفلس کا علاج درج ذیل ادویات سے کیا جاسکتا ہے؛

(Teramycin Cap)	☆..... ٹیرامائین سین کپسول۔
(Augmentin Tab)	☆..... آگ مینٹن گولیاں۔
(Ampicilline Cap)	☆..... ایمپی سیلین کپسول۔
(Erythromycin Tab)	☆..... اریٹرومائین سین گولیاں۔
(Ocibid Tab)	☆..... اوسی بیڈ گولیاں۔
(Velosef Inj / Cap)	☆..... ویلوسیف انجکشن / کپسول۔
(Novidate Inj / Cap)	☆..... نووی ڈیٹ انجکشن / گولیاں۔
(Ampiclox Cap / Tab)	☆..... ایمپی کلاکس انجکشن / گولیاں۔
(Bectrim fort Tab)	☆..... بیکٹرم فورٹ گولیاں۔
(Doxyn Cap)	☆..... ڈوکسن کپسول۔
(Rocephin Inj)	☆..... روسی فن انجکشن۔



سوزاک

(گنوریا)

(GONORRHOEA)

تعارف (Introduction): سوزاک یعنی گنوریا ایک جنسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری مرد و عورت دونوں کو لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری جنسی طریقے سے مرد سے عورت کو یا عورت سے مرد کو لاحق ہو سکتی ہے۔ گنوریا ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے اور اس کا علاج نہایت صبر آزما ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کو خدا نخواستہ گنوریا کی بیماری لاحق ہو جائے تو اسے فوراً اس بیماری کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنا علاج فوری طور پر کسی مستند اور ماہر ڈاکٹر سے کروانا چاہیے۔ ایسی عورت کو دوران علاج اپنے مرد کے ساتھ انٹر کورس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر متاثرہ عورت جماع سے پرہیز نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنی یہ بیماری اپنے شوہر کو ٹرانسفر کر دے گی۔ چونکہ یہ بیماری جنسی ذرائع سے پھیلا کرتی ہے اسی لئے اس بیماری کو سیکسوال ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز (Sexual Transmitted Disease) کہتے ہیں۔

گنوریا کی وجوہات (Causes Of Gonorrhoea): سوزاک یعنی گنوریا کے مرض کی عام وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Gonococcus)	یہ مرض ایک جراثیم گونوکوکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔	☆.....
(Sexual spread)	یہ جراثیم متاثرہ شخص سے جنسی تعلق رکھنے سے پھیلتا ہے۔	☆.....
(Sometimes no signs & symptoms)	اکثر انفیکشن ہونے کے باوجود کوئی علامات نہیں ہوتیں۔	☆.....

گنوریا کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Gonorrhoea): اس مرض میں درج ذیل علامات و نشانیوں ہوتی ہیں؛

(Inflammation of urethra)	پیشاب کی نالی یوریتھرا میں سوزش ہو جاتی ہے۔	☆.....
(Burning micturation)	پیشاب کرتے ہوئے مریض کو جلن محسوس ہوتی ہے۔	☆.....
(Pain in urethra)	پیشاب کی نالی یوریتھرا میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔	☆.....
(Purulent, burning urethral discharge)	یوریتھرا سے بدبودار جلن والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔	☆.....
(Discharge fix stains on clothes)	یوریتھرا رطوبت کپڑوں پر لگے تو دھبہ ڈال دیتی ہے۔	☆.....

(Vaginitis)	☆..... ویجائنہ میں سوزش ہو جاتی ہے۔
(Burning & pain in vagina)	☆..... ویجائنہ میں جلن اور درد ہوتا ہے۔
(White pustular urethral discharge)	☆..... پیشاب کے راستے سفید گاڑھی پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔
(Leucorrhoea from vagina)	☆..... ویجائنہ سے لیکور یا بھی جاری ہو جاتا ہے۔
(Infection may cause cervicitis)	☆..... یہ انفیکشن سرویکس کی سوزش کر سکتا ہے۔
(Infection may cause salpingitis)	☆..... یہ انفیکشن فیلوپین ٹیوبز کی سوزش کر سکتا ہے۔
(Infection may cause metritis)	☆..... یہ انفیکشن یوٹرس کی سوزش کر سکتا ہے۔
(Pelvic pain)	☆..... مریضہ پیٹرو میں درد محسوس کرتی ہے۔
(Backache)	☆..... کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔
(Heaviness in back & pelvic area)	☆..... کمر اور پیٹرو میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔
(It may cause Miscarriage)	☆..... سوزاک میں مبتلا حاملہ کومس کیرج بھی ہو سکتا ہے۔
(Gonorrhoeal ophthalmitis in neonate)	☆..... سوزاکی زچہ کے نومولود کی آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔

گنوریا کی تشخیص (Diagnosis Of Gonorrhoea): گنوریا کی تشخیص درج ذیل ٹسٹوں کے ذریعے کی جاسکتی ہے؛

(Gonorrhoeal discharge culture test)	☆..... گنوریل ڈسچارج کلچر ٹیسٹ کریں۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس آر کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔

گنوریا کا علاج (Treatment Of Gonorrhoea): گنوریا کا علاج درج ذیل اصولوں اور ادویات کے تحت کیا جاتا ہے؛

(Canesten vaginal Tab)	☆..... کینسٹن ویجائنل گولیاں۔
(Gynotravogen Tab)	☆..... گائوٹروجن گولیاں۔
(Canesten vaginal Cream)	☆..... کینسٹن ویجائنل کریم۔

(Gynosporin vaginal Cream)	☆..... گائوسپورین ویجائٹل کریم۔
(Grifulvin Tab)	☆..... گرائفولون گولیاں۔
(Vagitab vaginal Tab)	☆..... ویجی ٹیب ویجائٹل گولیاں۔
(Vagmycine vaginal Tab)	☆..... ویکمائی سین ویجائٹل گولیاں۔
(Amoxil 500mg Cap)	☆..... ایماکسل 500 ملی گرام کپسول۔
(Velosef 500mg Cap)	☆..... ویلوسیف 500 ملی گرام کپسول۔
(Ceclor 500mg Cap)	☆..... سیکلور 500 ملی گرام کپسول۔
(Lincocin 500mg Cap)	☆..... لنکوسین 500 ملی گرام کپسول۔
(Augmentin 675mg Tab)	☆..... آگ مینٹن 675 ملی گرام گولیاں۔
(Teramycine 250mg Cap)	☆..... ٹیرامائی سین 250 ملی گرام کپسول۔
(Ampicillin 500mg Cap)	☆..... امپی سیلین کپسول 500 ملی گرام۔
(Ampiclox 500mg Cap)	☆..... امپی کلاکس کپسول 500 ملی گرام۔
(Dicloran 50mg Tab)	☆..... ڈیکلوران 50 ملی گرام گولیاں۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونستان فورٹ گولیاں۔
(Vibramycin 100mg Cap)	☆..... ویرامائی سین 100 ملی گرام کپسول۔
(Novidat 500mg Tab)	☆..... نووی ڈیٹ 500 ملی گرام گولیاں۔
(Novidat Inj)	☆..... نووی ڈیٹ انجکشن۔
(Rocephin Inj)	☆..... روسی فن انجکشن۔
(Cefixime Inj)	☆..... سیفکسیم انجکشن۔



رحم کے فائبرائیڈز

(یوٹرائن ٹیومرن)

(UTERINE FIBROIDS / TUMOURS)

تعارف (Introduction): عورتوں کی بچے دانی میں کئی مرتبہ گوشت کی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں یوٹرائن فائبرائیڈز یا ٹیومرز کہتے ہیں۔ عام طور پر یوٹرائن فائبرائیڈز بچوں والی عورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کم عمر اور کنواری لڑکیوں کی بچے دانی میں بھی یہ فائبرائیڈز پیدا ہو سکتے ہیں۔ یوٹرس کے ان فائبرائیڈز کا اصولی علاج تو سرجری یعنی آپریشن کے ذریعے پورے یوٹرس کو ہی نکال دینا ہے لیکن کئی مرتبہ مریضہ خود یا اس کی صحت سرجری کی اجازت نہیں دیتی لہذا ایسے کیسوں میں ان یوٹرائن فائبرائیڈز کا علاماتی علاج کیا جاتا ہے۔

یوٹرائن ٹیومرز کی اقسام (Types Of Uterine Tumours): کلاسی فی کیشن کے لحاظ سے یوٹرائن ٹیومرز کی دو اقسام ہو سکتی ہیں؛

- 1۔ **یوٹرس کا بی نائن ٹیومر (Benign Tumour Of Uterus):** اسے عام طور پر فائبرو مائیوما (Fibromyoma) کہتے ہیں۔ یہ ایک نہ پھیلنے والا اور کم خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتیں اور عموماً سرجری کے ذریعے اسے نکال دینے کے بعد یہ دوبارہ نہیں ہوا کرتا۔
- 2۔ **یوٹرس کا میلگنٹ ٹیومر (Malignant Tumour Of Uterus):** یہ یوٹرس کا پھیلنے والا ایک خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر کارپوریل فائبرو ایڈینوما (Corporeal Fibroadinoma) کہتے ہیں۔ عام طور پر اس خطرناک ٹیومر کی جڑیں ہوتی ہیں جو بچے دانی کے علاوہ جسم کے دوسرے آرگنز میں پائی جاسکتی ہیں۔ اس ٹیومر کو سرجری کے بعد نکال دینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا لہذا آنکالوجسٹ یعنی کینسر کے مرض کے ماہرین سرجری کے بعد اس کی جڑوں کو ختم کرنے کے لئے ریڈی ایشن (Radiations) کروانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔

یوٹرائن ٹیومر کی وجوہات (Causes Of Uterine Tumour): یوٹرائن ٹیومر کے مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

☆.....	ابھی تک یوٹرائن ٹیومرز کی کوئی صحیح وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔	(Exact cause is unknown)
☆.....	پچیس سال سے کم عمر خواتین میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔	(Uncommon in below 25 years of age)
☆.....	شادی کے بعد حاملہ نہ ہونیوالی خواتین میں اکثر ہوتا ہے۔	(Common in infertile females)
☆.....	یوٹرائن ٹیومر نیگرو عورتوں میں زیادہ عام ہوتا ہے۔	(Common in negresses)

(Increase sexual activity)	☆..... شادی شدہ عورتوں میں کثرت جماع سے ہوتا ہے۔
(Old genital ulcer)	☆..... زنانہ اعضائے تناسل میں پرانے زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔
(Over use of hormonal drugs)	☆..... ہارمونل ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔
(Idiopathic causes)	☆..... یوٹرائن ٹیومرز کی صحیح وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔

یوٹرائن ٹیومر کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Uterine Tumour): اس مرض کی درج ذیل علامات ہوتی ہیں:

(Abdominal swelling)	☆..... پیٹ میں ورم آ جاتا ہے۔
(Heaviness in pelvis)	☆..... پیلوں میں وزن کا احساس ہوتا ہے۔
(Slight pain in Pelvis)	☆..... پیلوں میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔
(Menorrhagia / Metrorrhagia)	☆..... حیض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔
(Polyuria)	☆..... پیشاب بار بار اور زیادہ آتا ہے۔
(Urinary obstruction)	☆..... بعض اوقات پیشاب رک بھی سکتا ہے۔
(Enlarged abdomen)	☆..... مریضہ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔
(Palpation reveals pelvic mass)	☆..... پیلوں میں ٹٹول کر دیکھنے سے حجم محسوس ہوتا ہے۔
(Cervical mass)	☆..... سرویکس میں حجم محسوس ہوتا ہے۔
(Tenderness in pelvis)	☆..... مریضہ کی پیلوں پر حس ہوگی۔
(Leucorrhoea)	☆..... مریضہ کو لیکوریا ہوتا ہے۔
(Vaginal bleeding)	☆..... یوٹریس سے جریان خون ہوتا ہے۔
(Backache)	☆..... مریضہ کو کمر درد ہوتا ہے۔
(Bleeding may cause anaemia)	☆..... جریان خون کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے۔
(Loss of weight day by day)	☆..... مریضہ دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔

یوٹرائن ٹیومر کی تشخیص (Diagnosis Of Uterine Tumour): یوٹرائن ٹیومر کی تشخیص درج ذیل ٹسٹوں کے ذریعے کی جاسکتی ہے؛

(Pelvic ultrasound)	☆.....	پیلوک الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے۔
(Pelvic X-Ray)	☆.....	پیلوک ایکس رے کیا جاتا ہے۔
(X-Ray I.V.U)	☆.....	ایکس رے آئی، وی، یو کیا جاتا ہے۔
(Pelvic C.T.Scan)	☆.....	پیلوک سی، ٹی، اسکین۔
(Pelvic M.R.I)	☆.....	پیلوک ایم، آر، آئی۔
(Hystero-salpingo Graphy)	☆.....	ہسٹیروسالپنگو گرافی کی جاتی ہے۔
(Laparoscopy)	☆.....	لیپراسکوپ کی جاتی ہے۔
(Uterine tumour biopsy)	☆.....	یوٹرائن ٹیومر بائیوپسی کی جاتی ہے۔
(Urine R/E)	☆.....	پیشاب کا عام امتحان کیا جاتا ہے۔
(C.B.C and E.S.R)	☆.....	خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر ٹسٹ کیا جاتا ہے۔

یوٹرائن ٹیومر کا علاج (Treatment Of Uterine Tumour): یوٹرائن ٹیومر کا علاج درج ذیل اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے؛

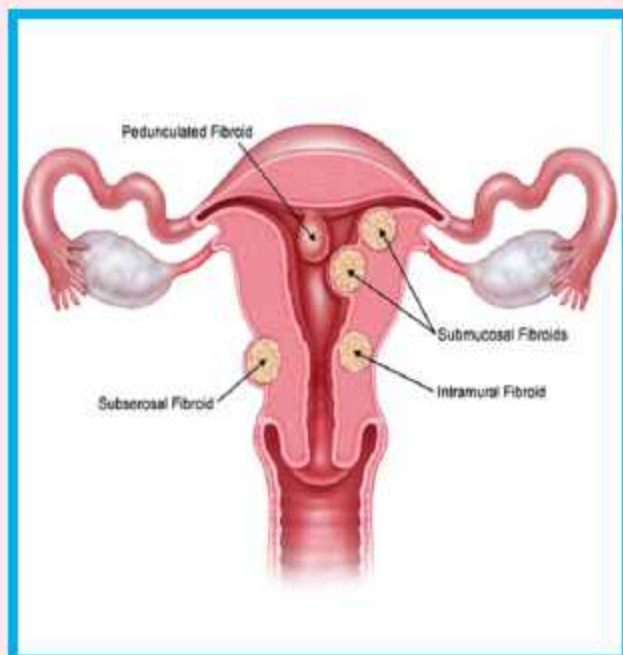
(Anagesic & Anti-inflammatory drugs)	☆.....	دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینا چاہیے۔
(Anti cancer medicines)	☆.....	دافع کینسر ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔
(Balance diet)	☆.....	متوازن، سادہ خوراک کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(Forbid to have heavy work)	☆.....	بوجھ، وزن کے کاموں سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(Symptomatic treatment)	☆.....	مریضہ کا علاماتی علاج کیا جاتا ہے۔
(Consult surgeon)	☆.....	سرجن سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
(Surgical resection of uterus)	☆.....	سرجری کے ذریعے بچے دانی نکال دی جاتی ہے۔
(Radiations adviced if needed)	☆.....	اگر ضرورت ہو تو ریڈی ایشن کی جاتی ہیں۔
(Rocephin Inj)	☆.....	روی فن انجکشن۔

(Cefixime Inj)	سیفکزام انجکشن۔	☆.....
(Transamin Inj)	ٹرانزامن انجکشن۔	☆.....
(Claforan Inj)	کلیفوران انجکشن۔	☆.....
(Jectofer Inj)	جیکٹوفر انجکشن۔	☆.....
(Neurobion Inj)	نیوروبیان انجکشن۔	☆.....
(Methargine Tab)	میٹھرجن گولیاں۔	☆.....
(Voren 50mg Tab)	ورین 50 ملی گرام گولیاں۔	☆.....
(Ponstan forte Tab)	پونستان فورٹ گولیاں۔	☆.....
(Buscopan plus Tab)	بسکوپان پلس گولیاں۔	☆.....
(Nospa forte Tab)	نوسپا فورٹ گولیاں۔	☆.....
(Fefol vit Cap)	فی فال وٹ کپسول۔	☆.....
(Abocal Tab)	ایبو کال گولیاں۔	☆.....
(Folic acid Tab)	فولک ایسڈ گولیاں۔	☆.....
(Sangobion Cap)	سینگوبیان کپسول۔	☆.....
(E-vion Cap)	ای ویان کپسول۔	☆.....
(Eplazyme Syp)	اپلازائم سیرپ۔	☆.....
(Lysovit Syp)	لائیسو وٹ سیرپ۔	☆.....
(Surbex Syp)	سربیکس سیرپ۔	☆.....
(Vitamin-B compound Syp)	وٹامن بی کمپاؤنڈ سیرپ۔	☆.....

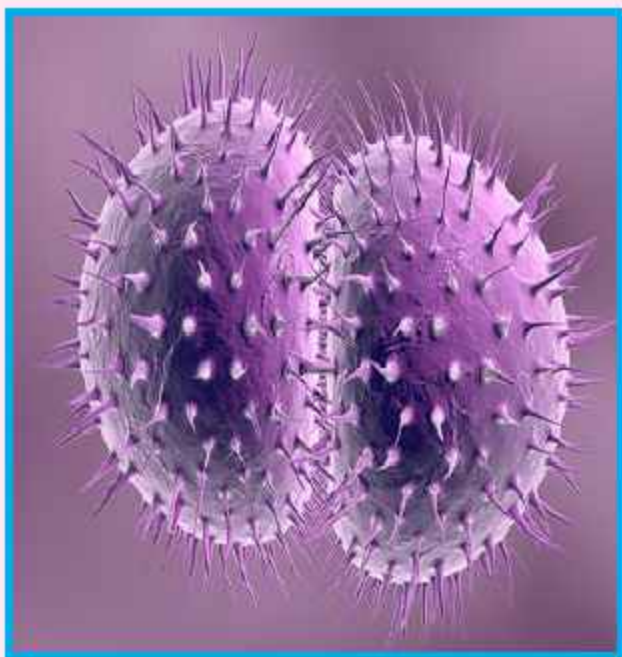




Leucorrhoea



Uterine Fibroids



Neisseria Gonorrhoeae



Treponema Pallidum

سرویکس کا کینسر

(کارسی نوما سرویکس)

(CARCINOMA CERVIX)

تعارف (Introduction): سرویکس عورتوں کے اعضائے مخصوصہ و تناسل کا ایک اہم عضو ہے۔ عورتوں کی بچہ دانی کے نچلے حصے کو سرویکس کہا جاتا ہے۔ سرویکس کے مقام سے بچہ دانی کی شروعات ہوتی ہیں۔ عورتوں میں اعضائے مخصوصہ کے کینسر میں ایک عام کینسر سرویکس کا پھیلنے والا خطرناک کینسر ہے جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کارسی نوما سرویکس (Carcinoma cervix) کہا جاتا ہے۔ سرویکس کا بی نائٹ کینسر عموماً نہیں ہوا کرتا بلکہ سرویکس کا کینسر عام طور پر ایک خطرناک اور پھیلنے والا کینسر کارسی نوما ہوا کرتا ہے۔

کارسی نوما سرویکس کی وجوہات (Causes Of Carcinoma Cervix): کارسی نوما سرویکس کے مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

(Idiopathic causes)	☆	کارسی نوما سرویکس کی ابھی تک کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
(Marriage in little age)	☆	کارسی نوما سرویکس جلد شادی ہونے والی خواتین کو ہوتا ہے۔
(Over sexual intercourse)	☆	کثرت مباشرت کے باعث کارسی نوما سرویکس ہو سکتا ہے۔
(Females with multiple sexual partners)	☆	بہت زیادہ جنسی تعلقات والی عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔
(Herpes virus type-II)	☆	ہرپیز وائرس ٹائپ ٹو کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔
(Mostly occur at the age of 45-55 years)	☆	یہ عموماً پینتالیس سے پچپن سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔

کارسی نوما سرویکس کی علامات و نشانات (Signs & Symptoms Of Carcinoma Cervix): اس کی عام علامات یہ ہوتی ہیں؛

(Irregular vaginal Bleeding)	☆	ویجائنہ سے بے قاعدہ جریان خون ہوتا ہے۔
(Vaginal ulcers)	☆	ویجائنہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔
(Purulent discharge from vagina)	☆	ویجائنہ سے بدبودار رطوبتی اخراج ہوتا ہے۔
(Pelvic pain)	☆	پیلوئس میں درد ہوتا ہے۔

(Urinary tract infection)	☆..... پیشاب کی تکالیف ہوتی ہیں۔
(Cervix cancer can cause renal failure)	☆..... کاری نو ماسرویکس گردے فیل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
(Anaemia)	☆..... مریضہ انیمیا کا شکار ہوگی۔
(Cervical ulcers)	☆..... سرویکس کی جگہ پر زخم ہوں گے۔
(Generalized weakness)	☆..... مریضہ حد درجہ کمزور ہوگی۔
(Patient becomes pallor)	☆..... مریضہ کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔
(Tenderness in cervix)	☆..... سرویکس پر حس ہو جاتا ہے۔
(Instrumentation causes bleeding)	☆..... سرویکس کو آلات سے چھونے پر خون بہتا ہے۔
(Cervical mass on rectal examination)	☆..... ریکٹل ایگزامی نیشن پر سروائیکل حجم محسوس ہوتا ہے۔
(Anxious on severe vaginal bleeding)	☆..... زیادہ ویجاٹل بلیڈنگ سے مریضہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔
(Backache & mental irritation)	☆..... مریضہ ذہنی طور پر چڑچڑی ہوگی اور کمزور ہوتا ہے۔

کاری نو ماسرویکس کی تشخیص (Diagnosis Of Carcinoma Cervix): کاری نو ماسرویکس کی تشخیص درج ذیل ٹسٹوں سے ہوتی ہے؛

(Pelvic Ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ۔
(Pelvic C.T.Scan)	☆..... پیلوک سی، ٹی، اسکین۔
(Pelvic M.R.I)	☆..... پیلوک ایم، آر، آئی۔
(Cervical biopsy)	☆..... سروائیکل بائیوپسی۔
(Vaginal smear microscopic examination)	☆..... ویجاٹن کے رطوبتی اخراج کا خوردبینی معائنہ کرنا چاہیے۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان۔
(C.B.C and E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس، ایس، آر ٹسٹ۔

کاری نو ماسرویکس کا علاج (Treatment Of Carcinoma Cervix): کاری نو ماسرویکس کا علاج درج ذیل طریقے سے ہوتا ہے؛

(Anagesic & Anti-inflammatory drugs)	دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینا چاہیے۔	☆.....
(Anti cancer medicines)	دافع کینسر ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔	☆.....
(Balance diet)	متوازن، سادہ خوراک کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Forbid to have heavy work)	بوجھ، وزن کے کاموں سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Symptomatic treatment)	مریضہ کا علاماتی علاج کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Consult surgeon)	سرجن سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Surgical resection of uterus)	سرجری کے ذریعے بچے دانی نکال دی جاتی ہے۔	☆.....
(Radiations adviced if needed)	اگر ضرورت ہو تو ریڈی ایشن کی جاتی ہیں۔	☆.....
(Rocephin Inj)	روی فن انجکشن۔	☆.....
(Cefixime Inj)	سیفکزام انجکشن۔	☆.....
(Transamin Inj)	ٹرانزامن انجکشن۔	☆.....
(Claforan Inj)	کلینوران انجکشن۔	☆.....
(Jectofer Inj)	جیکٹوفر انجکشن۔	☆.....
(Neurobion Inj)	نیوروبیان انجکشن۔	☆.....
(Transamin Cap)	ٹرانزامن کپسول۔	☆.....
(Dicloran 50mg Tab)	ڈیکلوران 50 ملی گرام گولیاں۔	☆.....
(Maltofer Tab)	مالٹوفر گولیاں۔	☆.....
(Nospa forte Tab)	نوسپا فورٹ گولیاں۔	☆.....
(Surbex-Z Tab)	سربیکس زی گولیاں۔	☆.....

☆☆☆.....

کارسی نو مایوٹرس

(CARCINOMA UTERUS)

تعارف (Introduction): یوٹرس زنا نہ اعھائے مخصوصہ میں خاص طور پر اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ یوٹرس سے ہی مینسٹروئل بلیڈنگ ہوتی ہے اور شادی کے بعد حمل ٹھہر جانے کی صورت میں اسی یوٹرس میں نو ماہ تک بچے کی نشوونما اور پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ڈیلیوری کے وقت یوٹرس کی دیواروں کے سکڑنے کے باعث ہی لیبر پین شروع ہوتے ہیں اور یوٹرس کی دیواروں ہی کی حرکات کے باعث بچے کی ڈیلیوری ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات کئی عورتوں میں یوٹرس کا خطرناک اور پھیلنے والا کینسر ہو جاتا ہے جسے کارسی نو مایوٹرس (Carcinoma Uterus) کہتے ہیں۔ کارسی نو مایوٹرس میں بچے دانی کی اندرونی تہہ کا مہلک کینسر لاحق ہو جایا کرتا ہے لہذا یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریٹم کے پھیلنے والے کینسر کو کارسی نو مایوٹرس کہتے ہیں۔ کارسی نو مایوٹرس ایک توجہ طلب مرض ہے جس کا علاج فوری طور پر موثر طریقے سے کرنا ناگزیر ہے۔

کارسی نو مایوٹرس کی وجوہات (Causes Of Carcinoma Uterus): کارسی نو مایوٹرس کے مرض کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

☆..... سن یاس کا دیر سے شروع ہونا۔	(Delayed menopause)
☆..... عام طور پر یہ سن یاس کے بعد ہوتا ہے۔	(Mostly occur after menopause)
☆..... ذیابیطس کی بیماری کی وجہ سے۔	(Diabetes Mellitus)
☆..... موٹاپا بھی اس مرض کی ایک اہم وجہ ہے۔	(Obesity)
☆..... اینڈومیٹریٹم کا ہائپر پلازیا۔	(Endometrial hyperplasia)
☆..... خون حیض کی بے قاعدگی اور شدید اخراج۔	(Irregular & sever vaginal bleeding)
☆..... سن یاس کے بعد خون کا جاری ہونا۔	(Vaginal bleeding after menopause)
☆..... اینڈومیٹریٹم کی پرانی سوزش۔	(Chronic endometrial inflammation)
☆..... اینڈومیٹریٹم میں پاپلس ہونا۔	(Endometrial polyps)
☆..... اینڈومیٹریٹم میں فائبرائڈ ہونا۔	(Endometrial fibroids)
☆..... لیکوریا کا ہونا۔	(Leucorrhoea)

کاری نو مایوٹرس کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Carcinoma Uterus): اس کی درج ذیل علامات ہیں:

(Irregular menses)	☆..... سن یا اس کے بعد خون حیض کا بے قاعدہ اخراج ہوتا ہے۔
(Leucorrhoea)	☆..... مریضہ کو لیکوریا ہوتا ہے۔
(Sever menstrual bleeding)	☆..... حیض کے دنوں میں خون کا شدید بے قاعدہ اخراج ہوتا ہے۔
(Heaviness in pelvis)	☆..... مریضہ کو پیلوکس میں بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔
(Backache)	☆..... مریضہ کے کمر میں درد ہوتا ہے۔
(Sever vaginal bleeding)	☆..... مریضہ کو شدید اخراج خون ہوتا ہے۔
(Anaemia)	☆..... مریضہ انیمیا کا شکار ہو جاتی ہے۔
(Enlarged uterus)	☆..... یوٹرس کا سائز نارمل سے بڑھ جاتا ہے۔
(Patient becomes pallor)	☆..... مریضہ کی رنگت دن بہ دن پیلی پڑتی جاتی ہے۔
(Severe weakness)	☆..... مریضہ میں شدید کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے۔

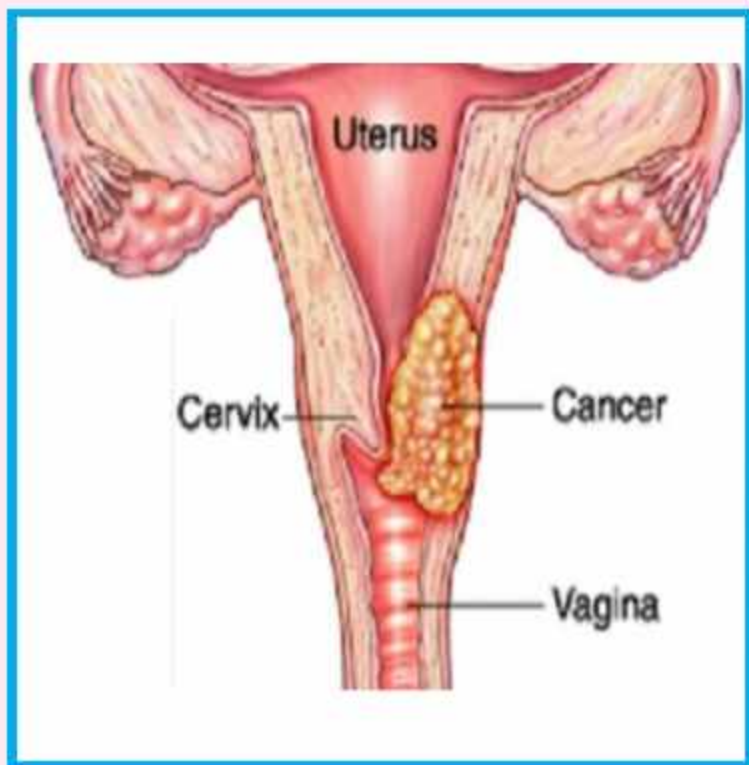
کاری نو مایوٹرس کی تشخیص (Diagnosis Of Carcinoma Uterus): کاری نو مایوٹرس کی تشخیص درج ذیل ٹسٹوں سے کی جاتی ہے:

(Pelvic ultrasound)	☆..... پیلوک الٹراساؤنڈ۔
(Pelvic X-Ray)	☆..... پیلوک ایکس رے۔
(Pelvic C.T.Scan)	☆..... پیلوک سی، ٹی، اسکین۔
(Pelvic M.R.I)	☆..... پیلوک ایم، آر، آئی۔
(Endometrial biopsy)	☆..... اینڈومیٹریل بائیوپسی۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس۔ایس، آر ٹیسٹ۔

کاری نو مایوٹرس کا علاج (Treatment Of Carcinoma Uterus): کاری نو مایوٹرس کا علاج درج ذیل طریقے سے ہوتا ہے:

(Anagesic & Anti-inflammatory drugs)	دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینا چاہیے۔	☆.....
(Anti cancer medicines)	دافع کینسر ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔	☆.....
(Balance diet)	متوازن، سادہ خوراک کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Forbid to have heavy work)	بوجھ، وزن کے کاموں سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Symptomatic treatment)	مریضہ کا علاماتی علاج کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Consult surgeon)	سرجن سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Surgical resection of uterus)	سرجری کے ذریعے بچے دانی نکال دی جاتی ہے۔	☆.....
(Radiations adviced if needed)	اگر ضرورت ہو تو ریڈی ایشن کی جاتی ہیں۔	☆.....
(Rocephin Inj)	روی فن انجکشن۔	☆.....
(Cefixime Inj)	سیفکزام انجکشن۔	☆.....
(Transamin Inj)	ٹرانزامن انجکشن۔	☆.....
(Claforan Inj)	کلینوران انجکشن۔	☆.....
(Calcium sandoz Inj)	کیلشیم سنڈوز انجکشن۔	☆.....
(Neurobedoxin Inj)	نیوروبی ڈاکسن انجکشن۔	☆.....
(Methargine Tab)	میٹھرجن گولیاں۔	☆.....
(Diclofenac 50mg Tab)	ڈیکلو فینک 50 گولیاں۔	☆.....
(Maltofer Tab)	مالٹوفر گولیاں۔	☆.....
(Buscopan plus Tab)	بسکوپان پلس گولیاں۔	☆.....
(Sangobion Cap)	سینگوبیان کپسول۔	☆.....

☆☆☆.....



Carcinoma
Cervix

Carcinoma
Uterus



پستان کی سوزش

(ماسٹائی ٹس)

(MASTITIS)

تعارف (Introduction): پستان یعنی بریسٹ جہاں ایک جانب صنفِ نازک کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسری جانب شادی کے بعد بچے کی پیدائش پر بچے کے لئے ماں کے دودھ کی صورت میں ایک قدرتی اور توانا غذا مہیا کرتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ تقریباً ایک سال تک ماں کے دودھ پر پرورش پاتا ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں میں پستانوں کی سوزش ہو جایا کرتی ہے۔ گائنی کی اصطلاح میں پستان کی سوزش ہو جانے کو ماسٹائی ٹس (Mastitis) کہتے ہیں۔ پستان کی سوزش دودھ پلانے والی ماؤں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔

ماسٹائی ٹس کی وجوہات (Causes Of Mastitis): پستان کی سوزش کے مرض کی عام طور پر پائی جانے والی وجوہات درج ذیل ہیں:

(Breast trauma)	پستان پر چوٹ کا لگنا۔	☆
(Infection in the breast)	پستان میں انفیکشن ہو جانا۔	☆
(Infection at the adjacent sides of breast)	پستان کے آس پاس کی جگہوں پر انفیکشن ہونا۔	☆
(Obstruction of milk secretion)	پستان سے دودھ کے اخراج میں رکاوٹ پیدا ہونا۔	☆
(Ulcer in nipple)	نیل میں زخم ہو جانا۔	☆
(Carcinoma breast)	پستان کا کینسر۔	☆

ماسٹائی ٹس کی علامات و نشانیائیں (Signs & Symptoms Of Mastitis): اس مریض میں درج ذیل علامات و نشانیائیں ہوتی ہیں:

(Breast pain)	پستان میں درد ہوتا ہے۔	☆
(Breast infection)	پستان میں سوزش ہوتی ہے۔	☆
(Redness in breast)	پستان میں سرخی پائی جاتی ہے۔	☆
(Tenderness in breast)	پستان پر حس ہوتا ہے۔	☆

(Disfunctional breast)	پستان اپنے افعال صحیح طور پر سرانجام نہیں دے سکتا۔	☆.....
(Supports affected breast)	مریضہ چلتے ہوئے ہاتھ سے متاثرہ پستان کو سہارا دیتی ہے۔	☆.....
(Fever upto 104 to 105 F)	مریضہ کو 104 سے 105 ڈگری فارن ہائیٹ نمبر تک ہوتا ہے۔	☆.....
(Breast pain refers to relevant hand)	متاثرہ پستان کی جانب کے ہاتھ میں بھی درد ہوتا ہے۔	☆.....
(Enlarged axillary lymph nodes)	بغل کے لمف نوڈز میں سوزش ہو جاتی ہے۔	☆.....
(Presence of nodes in breast)	اگر انفیکشن بڑھ جائے تو پستان میں گانٹھیں سی بن جاتی ہیں۔	☆.....

ماشائی ٹس کا علاج (Treatment Of Mastitis): ماشائی ٹس کے علاج میں درج ذیل ادویات استعمال کی جاتی ہیں؛

(Anti-inflammatory drugs)	دافع سوزش ادویات دیں۔	☆.....
(Analgesic drugs)	دافع درد ادویات دیں۔	☆.....
(Antipyretic drugs)	دافع بخار ادویات دیں۔	☆.....
(Unhygienic breast)	پستان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔	☆.....
(Augmentin Tab)	آگ مینٹن گولیاں۔	☆.....
(Amoxil Cap)	ایماکسل کپسول۔	☆.....
(Velosef Cap / Inj)	ویلو سیف کپسول / انجکشن۔	☆.....
(Ampiclox Cap)	ایمپی کلاکس کپسول۔	☆.....
(Doxyn Cap)	ڈوکسن کپسول۔	☆.....
(Ceclor Cap)	سیکلور کپسول۔	☆.....
(Proxen Tab)	پروکسن گولیاں۔	☆.....
(Dicloran Inj)	ڈیکلوران انجکشن۔	☆.....
(Septran D.S Tab)	سپٹران ڈی ایس گولیاں۔	☆.....

(Enzytan Tab)	ایزی لان گولیاں۔	☆.....
(Ponstan Tab)	پونشان گولیاں۔	☆.....
(Brufen Tab)	بروفن گولیاں۔	☆.....
(Oflomed Tab)	اوفلومیڈ گولیاں۔	☆.....
(Ocibid Tab)	اوسی بیڈ گولیاں۔	☆.....
(Chymocin Tab)	کایموسین گولیاں۔	☆.....



پستان کا پھوڑا

(بریسٹ ایب سس)

(BREAST ABSCESS)

تعارف (Introduction): پستان میں پھوڑا بن جانے کو بریسٹ ایب سس (Breast Abscess) کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر پستان کی سوزش کے بعد ہوا کرتا ہے۔ عورتوں میں پستان کی سوزش پر خاص توجہ دیتے ہوئے فوری طور پر اس کا موثر علاج کرنا چاہیے کیونکہ اگر ماسٹائیٹس یعنی پستان کی سوزش کا موثر علاج نہ ہو تو یہی ماسٹائیٹس کراٹک صورت اختیار کرتے ہوئے پستان کا پھوڑا یعنی بریسٹ ایب سس بن سکتا ہے۔

پستان کا پھوڑا ہونے کی وجوہات (Causes Of Breast Abscess): بریسٹ ایب سس کے مرض کی وجوہات درج ذیل ہیں:

(Breast trauma)	پستان پر چوٹ لگنا۔	☆.....
(Obstruction in excretion of milk)	پستان سے دودھ نکلنے کے راستوں میں رکاوٹ پیدا ہونا۔	☆.....
(Bactaeremia)	خون میں بیکٹریا کی زیادتی۔	☆.....
(Idiopathic causes)	نامعلوم وجوہات کی بناء پر پستان میں پھوڑا بن سکتا ہے۔	☆.....
(Chronic mastitis)	پستان کی پرانی سوزش بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔	☆.....

پستان کا پھوڑا ہونے کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Breast Abscess): اس مرض کی علامات یہ ہوتی ہیں؛

(Breast pain)	☆..... پستان میں درد ہوگا۔
(Breast inflammation)	☆..... پستان میں سوزش ہوگی۔
(Redness in breast)	☆..... پستان میں سرخی ہوگی۔
(Hotness in breast)	☆..... پستان گرم ہوگا۔
(Feeling of hotness in breast)	☆..... پستان میں گرمی کا احساس ہوگا۔
(Disfunctional breast)	☆..... پستان اپنا فعل صحیح انجام نہیں دے سکتا۔
(Pustular discharge from breast)	☆..... پستان سے پیپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔
(Bloody discharge from breast)	☆..... پستان سے خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔
(Enlarged associated lymph nodes)	☆..... اکثر پستان کے آس پاس کے لفف نوڈز بڑھ جاتے ہیں۔
(High graded fever)	☆..... مریض کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔
(Burning in breast)	☆..... پستان میں جلن کا احساس ہوگا۔
(Tenderness in breast)	☆..... پستان پر حس ہوگا۔

پستان کے پھوڑے کا علاج (Treatment Of Breast Abscess): بریسٹ ایب سس کے علاج میں یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں؛

(Anti-inflammatory drugs)	☆..... دافع سوزش ادویات دیں۔
(Analgesic drugs)	☆..... دافع درد ادویات دیں۔
(Antipyretic drugs)	☆..... دافع بخار ادویات دیں۔
(Cleanliness of breast)	☆..... پستان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
(If medicines fail then refer to surgeon)	☆..... اگر ادویات رزلٹ نہ دیں تو کیس سرجن کو ریفر کرنا چاہیے۔
(Antibiotics)	☆..... اینٹی بائیوٹک ادویات دیں۔

(Anti-inflammatory drugs)	☆..... دافع سوزش ادویات دیں۔
(Analgesic drugs)	☆..... دافع درد ادویات دیں۔
(Antipyretic drugs)	☆..... دافع بخار ادویات دیں۔
(Unhygienic breast)	☆..... پستان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔
(Terivid Tab)	☆..... ٹیری ویڈ گولیاں۔
(Lincocin Cap)	☆..... لینکوسین کپسول۔
(Novidat Tab / Inj)	☆..... نووی ڈیٹ گولیاں / انجکشن۔
(Miroclox Cap)	☆..... ماروکلکس کپسول۔
(Doxycyclin 100mg Cap)	☆..... ڈوکسی سائیکلین 100 ملی گرام کپسول۔
(Cefiget Cap)	☆..... سیفی گیٹ کپسول۔
(Roxen Tab)	☆..... راکسن گولیاں۔
(Fenac Inj)	☆..... فینک انجکشن۔
(Danzen D.S Tab)	☆..... ڈین زین ڈی ایس گولیاں۔
(Enzytan Tab)	☆..... اینزی لان گولیاں۔
(Ponstan forte Tab)	☆..... پونستان فورٹ گولیاں۔
(Gentacin Inj)	☆..... جنٹاسین انجکشن۔
(Gentacin Cap)	☆..... جنٹاسین کپسول۔
(Dicloran Inj)	☆..... ڈیکلوران انجکشن۔
(Dicloran 50mg Tab)	☆..... ڈیکلوران 50 ملی گرام گولیاں۔



پستان کا کینسر

(کارسی نوما بریسٹ)

(CARCINOMA BREAST)

تعارف (Introduction): پستان میں پھیلنے والے کینسر کا پایا جانا کارسی نوما بریسٹ (Carcinoma breast) کہلاتا ہے۔ جس طرح عورت کے بریسٹ میں سوجن یعنی انفلامیشن اور پھوڑا یعنی ایب کس ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح عورت کے پستان میں بعض اوقات کینسر کی کنڈیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے پہل ماضی بعید میں بریسٹ کینسر زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ پہلے زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو کئی کئی مہینوں تک اپنا دودھ پلاتی تھیں مگر آج کل کے اس فیشن اسٹیل دور میں یہ خیال زور پکڑ گیا ہے کہ مائیں اگر بچوں کو اپنا دودھ پلائیں گی تو ان کے پستانوں کی خوبصورتی متاثر ہوگی حالانکہ قدرت نے عورت کے پستانوں کی خوبصورتی اور تندرستی ان کے دودھ پلانے میں ہی پوشیدہ رکھی ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو مقررہ وقت تک اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ نہ صرف پستانوں کی دوسری بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں بلکہ انہیں پستانوں کا کینسر جیسا موذی مرض بھی عام طور پر لاحق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی عورت یا لڑکی اپنے پستانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی گانٹھ یا گٹلی محسوس کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پستان میں اس تبدیلی کو کسی طور انور نہ کرے اور فوری طور پر کسی قابل اور مستند گائنا کالوجسٹ سے مشورہ کرے۔

پستان کے کینسر کی وجوہات (Causes Of Carcinoma Breast): بریسٹ کینسر کے مرض کی کچھ عام وجوہات درج ذیل ہیں؛

☆.....	کارسی نوما بریسٹ عموماً بوڑھی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔	(Mostly occurs in old females)
☆.....	یہ مرض جوان عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔	(Can be developed in yong females)
☆.....	یہ مرض بے اولاد عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔	(Mostly occurs in infertile females)
☆.....	یہ مرض مغربی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔	(Mostly occurs in westren females)
☆.....	یہ مرض مشرقی عورتوں میں نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔	(Rarely occurs in eastren females)
☆.....	یہ مرض دودھ نہ پلانے والی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔	(Occurs in females who does'nt lactate)
☆.....	یہ کینسر اکثر ایک ہی خاندان کی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔	(Mostly occurs in specific family)
☆.....	عورتوں میں ایسٹروجنز ہارمون کا غیر متوازن ہونا۔	(Disbalancy in estrogens hormone)
☆.....	عورتوں میں پروجیسٹرون ہارمون کا غیر متوازن ہونا۔	(Disbalancy in progesterone hormone)
☆.....	بعض اوقات بریسٹ کینسر کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔	(Idiopathic causes)

پستان کے کینسر کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Carcinoma Breast): اس کی علامات درج ذیل ہیں:

(At first appearance of breast tumour)	☆..... سب سے پہلے چھاتی میں گٹھی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔
(Initially it is painless tumour)	☆..... شروع شروع میں اس گٹھی میں کوئی درد نہیں ہوتا۔
(Later on feeling of pain in tumour)	☆..... پھر مریضہ گٹھی والے حصے میں کچھ بے چینی محسوس کرتی ہے۔
(Retraction of breast nipple)	☆..... اکثر مریضہ کانپل چھاتی میں پیچھے کی جانب کھینچ جاتا ہے۔
(Displacement of breast nipple)	☆..... نپل کا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہونا۔
(Changes in nipple shape)	☆..... نپل کی ظاہری شکل و صورت میں تبدیلی واقع ہونا۔
(Changes in breast shape)	☆..... متاثرہ پستان کی ظاہری شکل و صورت میں تبدیلی واقع ہونا۔
(Painful breast tumour)	☆..... پستان کی گٹھی میں درد ہونا۔
(Enlargement of axillary lymph nodes)	☆..... بغلوں میں لمف نوڈز کا بڑھ جانا۔

اگر کارسینوما بریسٹ کا فوری اور موثر علاج نہ کیا جائے تو یہ کینسر سارے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ چھاتی میں پھیلتا ہے اس کے بعد آس پاس کے عضلات میں پھیلتا ہے اور پھر کینسر کے سیلز لمف و سیلز کے ذریعے جسم میں دور دراز حصوں تک پھیل جاتے ہیں۔ کینسر کے سیلز بذریعہ خون پیٹ، گردن، جسم میں موجود لمف گینڈز، پیچھے پھو، جگر، دماغ، اسپائنل کارڈ، گردوں، مثانے اور کئی دوسری جگہوں تک پھیل جاتے ہیں۔

پستان کے کینسر کی تشخیص (Diagnosis Of Carcinoma Breast): کارسینوما بریسٹ کی تشخیص کے لئے یہ ٹیسٹ کئے جاتے ہیں:

(Mammography)	☆..... میموگرافی۔
(Chest X-Ray)	☆..... سینہ کا ایکس رے۔
(Breast C.T.Scan)	☆..... بریسٹ سی، ٹی، اسکین۔
(Breast M.R.I)	☆..... بریسٹ ایم، آر، آئی۔
(Breast tumour biopsy)	☆..... بریسٹ ٹیومر بائیوپسی۔
(Urine R/E)	☆..... پیشاب کا عام امتحان۔
(C.B.C with E.S.R)	☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ایس، ایس، آر ٹسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے۔

پستان کے کینسر کا علاج (Treatment Of Carcinoma Breast): کاری نو مایریسٹ میں ادویاتی علاج کیساتھ ساتھ سرجیکل علاج کی نہایت اہمیت ہے سرجری کے ذریعے متاثرہ پستان اور لمف نوڈز کو نکال دیا جاتا ہے۔ ریڈیائی علاج بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

(Anagesic & Anti-inflammatory drugs)	دافع درد اور دافع سوزش ادویات دینا چاہیے۔	☆.....
(Anti cancer medicines)	دافع کینسر ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔	☆.....
(Forbid to have heavy work)	بوجھ، وزن کے کاموں سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Symptomatic treatment)	مریضہ کا علاماتی علاج کیا جاتا ہے۔	☆.....
(Consult surgeon)	سرجن سے کنسلٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Mastectomy)	سرجری کے ذریعے پستان نکال دیا جاتا ہے۔	☆.....
(Radiations adviced if needed)	اگر ضرورت ہو تو ریڈی ایشن کی جاتی ہیں۔	☆.....
(Rocephin Inj)	روسی فن انجکشن۔	☆.....
(Cefixime Inj)	سیفکسیم انجکشن۔	☆.....
(Claforan Inj)	کلیفوران انجکشن۔	☆.....
(Neurobedoxin Inj)	نیوروبی ڈاکسن انجکشن۔	☆.....
(Diclofenac 50mg Tab)	ڈیکلو فینک 50 گولیاں۔	☆.....
(Maltofer Tab)	مالٹوفر گولیاں۔	☆.....
(Sangobion Cap)	سینگویان کپسول۔	☆.....

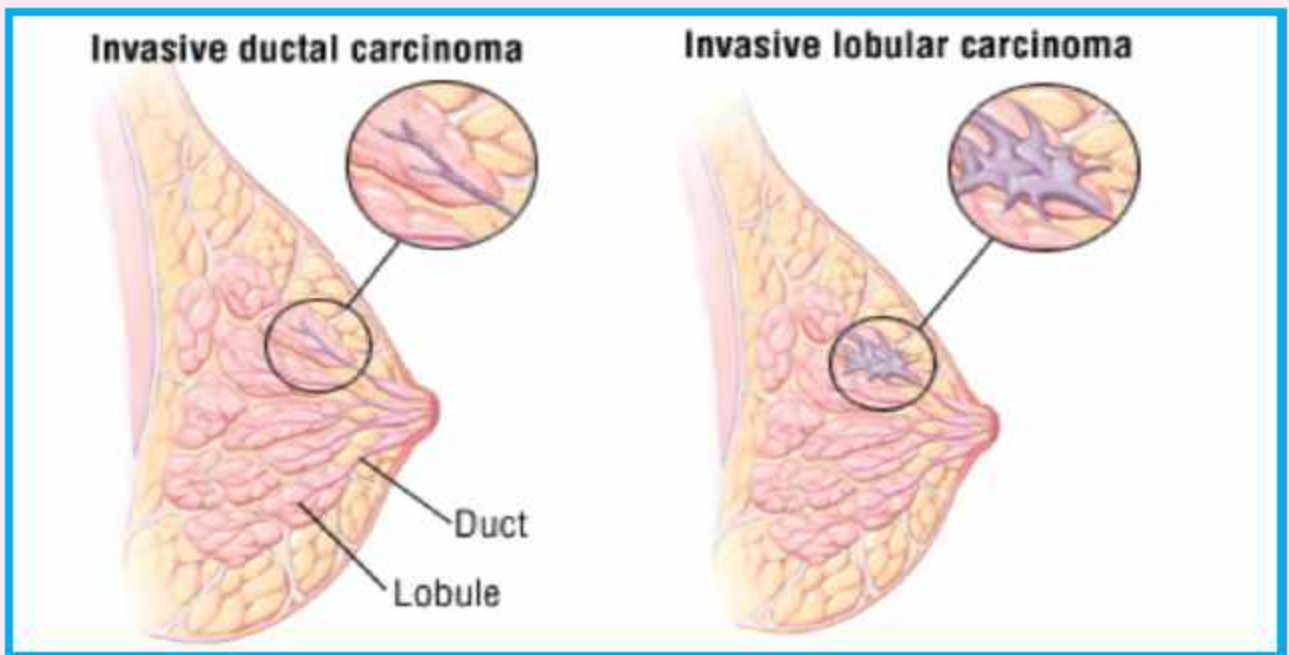
☆☆☆☆☆☆☆☆



Mastitis



Mastitis



Ductal & Lobular Carcinoma Breast

یونٹ: 6

امبریالوجی یعنی علم الجنین

(EMBRYOLOGY)

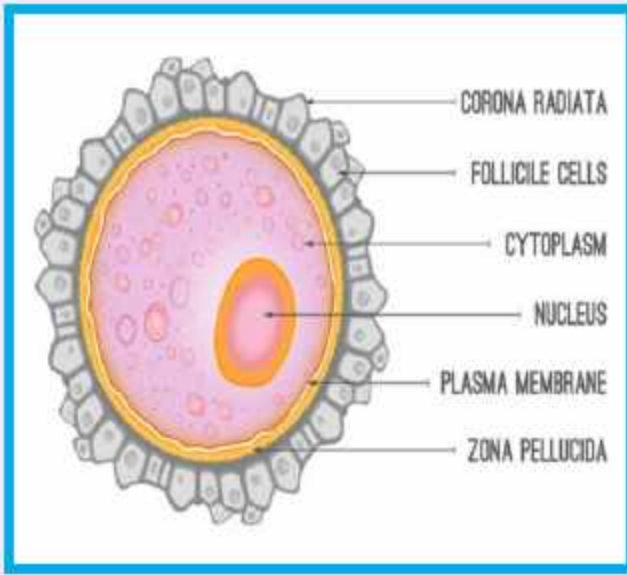
تعارف (Introduction): علم الجنین یا امبریالوجی اناٹومی کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق جنین کی بناوٹ اور اسکی نشوونما سے ہے۔ امبریالوجی کے علم میں ماں کے یوٹرس میں پرورش پانیاوالے امبریو کے مختلف اوقات و ادوار میں اعضاء کے بننے کا عمل اور انکی تکمیل کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ امبریو کی نشوونما کا دور عورت کے اووم اور مرد کے سپرم کے ملنے کے بعد سے لیکر بچے کی پیدائش تک ہوتا ہے جو کہ تقریباً نو مہینے اور کچھ دن پر محیط ہوتا ہے۔

اووم (Ovum): اووم عورتوں کی اوریز سے پیدا شدہ بیضے کا نام ہے اور یہ عورتوں کا جرم سیل ہے۔ اووم عورتوں کی اوریز میں خاص قسم کی تھیلیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں گرے فین فایکلز کہتے ہیں۔ ان گرے فین فایکلز میں سے ہر ایک کا قطر تقریباً دو سو سے لے کر تین سو مائیکرون تک ہوتا ہے۔ ہر اووم کے ارد گرد ایک موٹا سا صاف شفاف غلاف ہوتا ہے جسے زونا پیلو سیڈا کہتے ہیں۔ اووم کے اوپلازم میں بڑے بڑے چربی پر مشتمل مادے ڈیوٹوپلازم موجود ہوتے ہیں اور یہی ڈیوٹوپلازم دراصل امبریو کی نشوونما کے ابتدائی دنوں میں اسے خوراک اور غذائیت مہیا کرتے ہیں۔ اووم بالکل ایک عام انسانی سیل کی مانند تمام خصوصیات رکھتا ہے لیکن اس کا نیوکلیس سائز میں قدرے بڑا ہوتا ہے۔ اووم کے نیوکلیس کو جریٹل ویزیکل کہا جاتا ہے۔ یہ جریٹل ویزیکل شروع میں اووم کے درمیان میں موجود ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ اووم کے ایک کونے پر چلا جاتا ہے اور اسی جریٹل ویزیکل کے نزدیک سینٹروسوم بھی موجود ہوتا ہے۔ عورت کا اووم 23 کروموسومز لئے ہوئے ہوتا ہے جن میں سے 22 کروموسومز تو ایک جیسے ہوتے ہیں جنہیں آٹوسومز کہتے ہیں جبکہ تیسواں کروموسوم ایکس کروموسوم ہوتا ہے۔

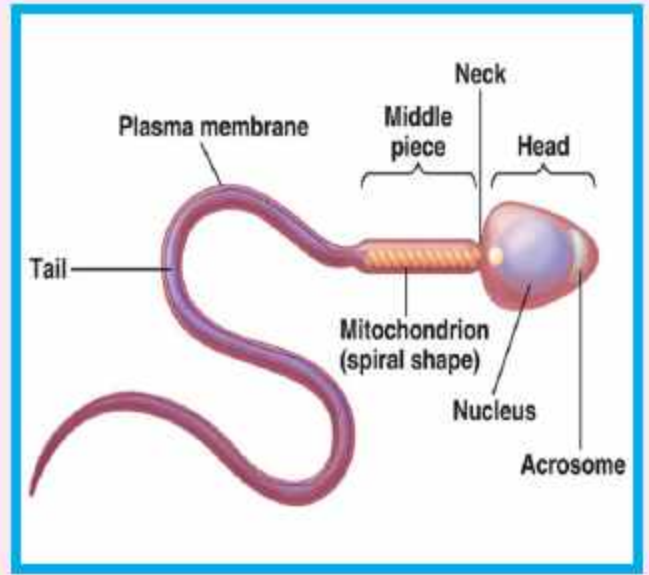
سپرم (Sperm): سپرم مردوں کی ٹیسٹیز سے پیدا شدہ حیوانیہ کا نام ہے اور یہ مردوں کا جرم سیل ہے۔ مردوں کے ایک سپرم کی لمبائی تقریباً 0.05 ملی میٹر ہوتی ہے۔ ایک سپرم کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سپرم کے اوپری حصے کو سپرم کا سر (Head) کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو سپرم کی گردن (Neck) کہتے ہیں۔ تیسرے حصے کو سپرم کا جسم (Body) کہتے ہیں اور جبکہ سپرم کے نچلے آخری حصے کو سپرم کی دم (Tail) کہتے ہیں۔ سپرم کا سر قدرے پھیلا ہوا ہوتا ہے جس میں سپرم کا نیوکلیس موجود ہوتا ہے جبکہ سپرم کا جسم اور گردن قدرے تنگ ہوتی ہے۔ سپرم کی گردن میں ایک سینٹروسوم ہوتا ہے۔ سپرم کے جسم کے نیچے سپرم کی دم لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سپرم اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرد کا سپرم 23 کروموسومز لئے ہوئے ہوتا ہے جن میں سے 22 کروموسوم تو ایک جیسے ہوتے ہیں جنہیں آٹوسومز کہتے ہیں جبکہ تیسواں کروموسوم ایکس کروموسوم ہوتا ہے۔

اووم اور سپرم کا ملاپ (Fertilization): عورتوں کی اووریز میں اووم جو نئی مکمل نشوونما پالیتا ہے تو وہ اووریز سے خارج ہو جاتا ہے اور فیلوپین ٹیوبز کے ذریعے یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے اور اگر اس عرصہ کے دوران مرد نے عورت سے جنسی ملاپ کر لیا ہو تو مرد کا سپرم عورت کے اووم سے ملاپ کر لیتا ہے اور اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن کا عمل عام طور پر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ مرد کا سپرم اپنی دُم کی وجہ سے حرکت کرتا ہوا ویجائنہ اور یوٹرس سے گزرتا ہوا فیلوپین ٹیوب میں پہنچ جاتا ہے اور اووم کے قریب پہنچ کر اووم کے اندر اوو پلازم میں داخل ہو جاتا ہے اور جس مقام سے اوو پلازم میں داخل ہوتا ہے وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ اوو پلازم کی بیرونی دیوار اب مزید کسی اووم سے اووم کے اندر داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ اب سپرم اور اووم دونوں کے نیوکلئس ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور اووم کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپس میں ضم ہو جاتے ہیں اور ایک نیوکلئس بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپرم اور اووم کے نیوکلئس کے اندر کروموسمز کی تعداد 23 ہوتی ہے اور اب جبکہ سپرم اور اووم کے اندر نیوکلئس ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک نیوکلئس بناتے ہیں تو اس نیوکلئس میں کروموسمز کی تعداد 46 ہو جاتی ہے جو کہ ایک سویٹک یعنی عام جسمانی خلیہ میں بھی ہوتی ہے اور اس کیساتھ ہی فرٹیلائزیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ سپرم اور اووم کے ملنے سے ایک نیا خلیہ تشکیل پاتا ہے جسے اب زائیگوٹ (Zygote) کہتے ہیں اور یہی زائیگوٹ پہلا انسانی سویٹک سیل ہوتا ہے۔

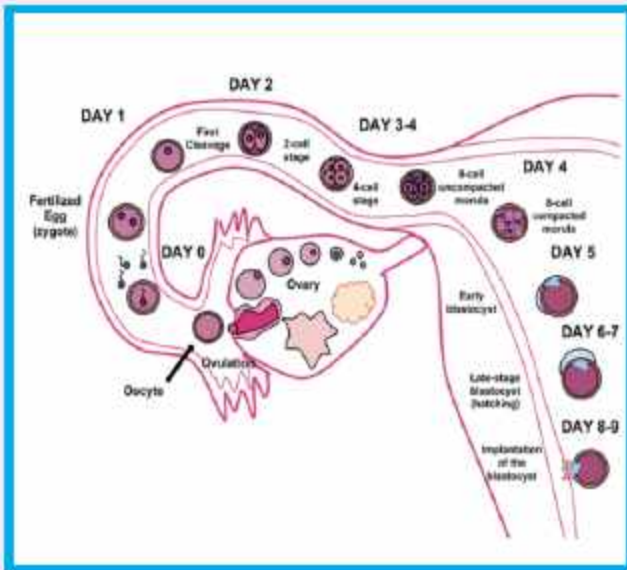
جنس کی تخصیص (Determination Of Sex): جنس کی تخصیص فرٹیلائزیشن کے موقع پر ہی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے ہر خلیہ میں 46 کروموسمز ہوتے ہیں اور خلیہ کی تقسیم میں جو کہ مائٹوسس (Mitosis) کے ذریعے ہوتی ہے، نوزائیدہ خلیے بھی 46 کروموسمز لیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مرد کی ٹیسٹیز اور عورت کی اووریز میں خلیاتی تقسیم می اوکس (Meiosis) کے ذریعے ہوتی ہے جس کے نتیجے کے طور پر نوزائیدہ خلیوں میں کروموسمز کی تعداد آدھی یعنی 23 رہ جاتی ہے اور اب یہ خلیات گیمیٹ (Gamete) کہلاتے ہیں اور یہی گیمیٹ مرد میں سپرم اور عورت میں اووم کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر انسانی خلیہ میں 46 کروموسمز ہوتے ہیں جن میں سے 44 کروموسمز تو ایک جیسے یعنی آٹوسمز ہوتے ہیں جبکہ دو کروموسمز یکس کروموسمز کہلاتے ہیں۔ مردوں میں یہ یکس کروموسمز X اور Y کی شکل کے ہوتے ہیں اور عورتوں میں یہ یکس کروموسمز X اور X کی شکل کے ہوتے ہیں چونکہ سپرم اور اووم میں آدھے کروموسمز یعنی 23 کروموسمز ہوتے ہیں اسلئے مردوں کے آدھے سپرمز میں 22 کروموسمز اور ایک یکس کروموسمز X ہوتا ہے اور آدھے سپرمز میں 22 کروموسمز اور ایک یکس کروموسمز Y ہوتا ہے جبکہ عورتوں میں ہر اووم میں 22 کروموسمز اور ایک یکس کروموسمز X ہوتا ہے۔ اب اگر فرٹیلائزیشن کے دوران عورت کے اووم سے مرد کا X کروموسمز والا سپرم ملتا ہے تو پھر عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اگر عورت کے اووم سے مرد کا Y کروموسمز والا سپرم ملتا ہے تو پھر عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ جب فرٹیلائزیشن کا عمل ہو جاتا ہے تو یوں جنس کی تخصیص بھی ہو جایا کرتی ہے۔



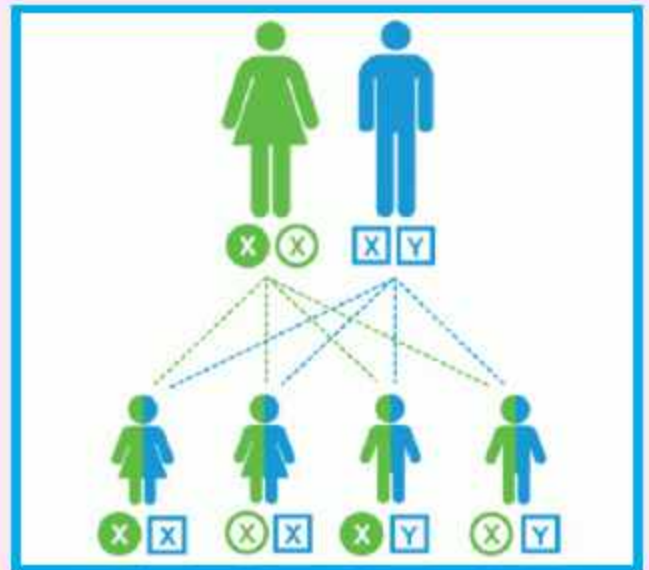
Female Ovum



Male Sperm



Fertilization



Sex Determination

سیگمنٹیشن (Segmentation): یوٹرس کی جانب جاتے ہوئے زائگوٹ میں خلیاتی تقسیم ہوتی رہتی ہے اور ان میں سے ہر ایک خلیہ بلاسٹوسائٹ (Blastocyte) کہلاتا ہے اور یوں خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جوں ہی خلیات کی یہ تعداد بارہ سے لے کر سولہ تک پہنچ جاتی ہے تو اب خلیات کے اس مجموعے کو زائگوٹ کے بجائے مارولا (Morula) کہتے ہیں۔ اس مارولا کے بیرونی خلیات جو کہ سائز میں ذرا کم ہوتے ہیں مارولا کی غذائی ضروریات پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ مارولا کے اندرونی خلیات جو کہ سائز میں ذرا بڑے ہوتے ہیں حقیقت میں جنین کی نشوونما کرتے ہیں اور یوں مارولا یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے۔ ابتداء میں تو مارولا کے خلیات میں کچھ اس طرح سے تفریق اور امتیاز ہوتا ہے کہ مارولا میں بیرونی خلیات کی ایک تہہ صاف طور پر نظر آتی ہے جسے ٹروفوبلاسٹس (Trophoblasts) کہتے ہیں اور دوسری اندرونی خلیوں کی تہہ نظر آتی ہے جسے ایمبریونک سیل ماس (Embryonic Cell Mass) کہتے ہیں۔ اب اس سارے سٹرکچر کو بلاسٹوسسٹ (Blastocyst) کہتے ہیں۔ اس بلاسٹوسسٹ کے خلیوں کی بیرونی تہہ ٹروفوبلاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمبریو اور فیٹس کو یوٹرس کی دیواروں کے ساتھ رابطہ کر کے غذائیت مہیا کرے۔ خلیوں کی یہ تہہ بذات خود ایمبریو کے بنانے میں کوئی مدد نہیں دیتی بلکہ ایک خاص ممبرین کو ریان (Chorion) بناتی ہے جو یوٹرس کی دیواروں سے پیوست ہو جاتی ہے جبکہ بلاسٹوسسٹ کے خلیوں کی اندرونی تہہ ایمبریو کے مختلف حصے بناتی ہے اور ایمبریو کے گرد لپٹی ہوئی ممبرین ایمنیون (Amnion) بھی بناتی ہے۔

ایمپلانٹیشن (Implantation): بلاسٹوسسٹ یوٹرس میں خلیوں کی بیرونی تہہ ٹروفوبلاسٹ کے ذریعے یوٹرس کی میوکس ممبرین کے ساتھ کسی بھی جگہ سوائے سروکس کے جڑ جاتا ہے۔ بلاسٹوسسٹ کے یوٹرس کے ساتھ جڑ جانے کو ایمپلانٹیشن کہتے ہیں۔ اس اثناء میں یوٹرس کی دیواروں میں خاص قسم کی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں تاکہ وہ بلاسٹوسسٹ کو مطلوبہ ماحول فراہم کر سکیں اور جو نہی بلاسٹوسسٹ یوٹرس کی دیوار کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بلاسٹوسسٹ بڑی تیزی سے مائیٹوٹک تقسیم کے ذریعے اپنے خلیات کی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہے کیونکہ اب اس کو براہ راست ماں کے خون سے غذائی اجزاء اور آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بلاسٹوسسٹ اپنے آپ کو یوٹرس کی پچھلی دیوار میں مدغم کر لیتا ہے۔ کچھ روز کے بعد بلاسٹوسسٹ میں خاص قسم کی خلیاتی تہیں بن جاتی ہیں۔ ایک تہہ کے خلیات چپٹے ہوتے ہیں اور ان کا رخ اندرونی طرف ہوتا ہے اس تہہ کو اینڈوڈرم (Endoderm) کہتے ہیں جبکہ دوسری تہہ کے خلیات لمبوترے ہوتے ہیں اور ان کا رخ ٹروفوبلاسٹ کی جانب ہوتا ہے اس تہہ کو ایکٹوڈرم (Ectoderm) کہتے ہیں۔ انہی خلیات کی مزید تقسیم کے نتیجے میں ایک تیسری تہہ میزوڈرم (Mesoderm) نشوونما پاتی ہے۔ میزوڈرم نہ صرف اینڈوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان جگہ گھیرتی ہے بلکہ یہ بلاسٹوسسٹ کی اندرونی سطح پر بھی پھیل جاتی ہے۔ یہ میزوڈرم ٹروفوبلاسٹک سیلز کے ساتھ مل کر کو ریان (Chorion) بناتی ہے۔ جو کہ ایمبریو کے گرد سب سے بیرونی ممبرین ہے۔ اسی ممبرین کو ریان کے ہی ذریعے ایمبریو آکسیجن اور غذائیت ماں سے حاصل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے فاسد بے کار مادوں کا اخراج کرتا ہے۔

ایمریو کی نشوونما کے اگلے مرحلوں میں ایکٹوڈرم میں ایک کیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جسے ایمنیوٹک سیک (Amniotic Sac) کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اینڈوڈرم میں بھی ایک کیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جسے یوک سیک (Yolk Sac) کہتے ہیں۔ ان دونوں کیوٹیز کے درمیان میں موجود میزوڈرم کا حصہ میزوڈرمل شالک (Mesodermal Stalk) کہلاتا ہے۔ یہی میزوڈرمل شالک ایک طرف ابتدائی کیفیت کے پلا سینٹا سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور بعد میں اسی میزوڈرمل شالک کے اندر خون کی نالیاں نشوونما پاتی ہیں اور اسے امبالانکیل کارڈ (Umbilical Cord) کی شکل دے دیتی ہیں۔ اصل میں یہ تینوں تہیں یعنی ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم ہی ایمریو کے تمام اعضاء کی نشوونما کی بنیاد بنتی ہیں اور ایمریو کے جسم کے تمام اعضاء اور بافتیں انہیں تین تہوں سے وجود میں آتی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ایکٹوڈرم (Ectoderm): اس سے بدن کا بیرونی حصہ، جلد، بال، ناخن، حرام مغز اور حواس خمسہ کے اعضاء، آنکھ، کان اور ناک وغیرہ بنتے ہیں۔

میزوڈرم (Mesoderm): اس سے عضلات، ہڈیاں، خون کی نالیاں، تولیدی اعضاء اور نظام اخراج کے اعضاء وغیرہ بنتے ہیں۔

اینڈوڈرم (Endoderm): اس سے اندرونی اعضاء مثلاً غذا کی نالی، ہوا کی نالی، لیرکس، مثانہ، غدود معدہ اور بے نالی غدود وغیرہ بنتے ہیں۔



جنین کی نشوونما کے عام مراحل

(GENERAL DEVELOPMENT OF EMBRYO)

تعارف (Introduction): حمل ٹھہر جانے کے بعد ایمریو کو تقریباً نو مہینے یعنی چالیس ہفتے یا تقریباً 280 دن تک ماں کے یوٹرس میں رہنا پڑتا ہے اور اس نو مہینے کے عرصے کے دوران بچے کے مختلف اعضاء تشکیل پاتے ہیں۔ یوٹرس میں موجود بچے کی نشوونما میں بنیادی طور پر مندرجہ ذیل چار مراحل ہوتے ہیں:

- 1۔ **خلیہ کی تقسیم (Cellular Division):** اس مرحلے میں زائگوٹ مائٹوسس کی تقسیم کے ذریعے تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزرتا ہے اور یوں خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
- 2۔ **نشوونما (Growth):** اس مرحلے میں زائگوٹ میں خلیات کا سائز بڑھتا ہے جس کے نتیجے میں ایمریو کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔
- 3۔ **خیالیاتی امتیاز (Differentiation):** اس مرحلے میں مختلف خلیات سے مختلف اعضاء اور بافتیں بنتی ہیں۔
- 4۔ **خیالیاتی تنظیم (Organization):** اس مرحلے میں مختلف خلیات مختلف بافتیں اور مختلف اعضاء اپنی اپنی انفرادی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں منظم ہو کر جسم انسانی کی تشکیل کرتے ہیں۔



جنین کی انفرادی نشوونما

(INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF EMBRYO)

تعارف (Introduction): یوٹرس میں موجود ایمبریو اور فیش کی انفرادی نشوونما اور سائز میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں؛ پہلا ہفتہ (First Week): پہلے ہفتے کے دوران ایمبریو فیلوپین ٹیوب میں سے حرکت کرتا ہوا یوٹرس کی جانب آتا ہے اور ساتھ ساتھ زائگوٹ میں تقسیم کا عمل جاری رہتا ہے۔

دوسرا ہفتہ (Second Week): دوسرے ہفتے کے دوران ایمبریو میں دو جھلیاں ایمنیان اور کوریان بنتی ہیں جبکہ ایمبریو میں نقطہ قلب بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور ایمبریو کی لمبائی سو انچ ہو جاتی ہے۔

تیسرا ہفتہ (Third Week): تیسرے ہفتے کے دوران ایمبریو کے دماغ کے حصے، کان اور ناک بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ایمبریو بیل کھا کر ترچھا ہو جاتا ہے جبکہ ایمبریو کی لمبائی ڈیڑھ سو انچ ہو جاتی ہے۔

چوتھا ہفتہ (Fourth Week): چوتھے ہفتے کے دوران ایمبریو میں آنکھوں کے گرد سیاہ نقطے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ منہ کے مقام پر ایک گہرا نشان سامنودار ہو جاتا ہے۔ پینکریاز اور لنگر بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ایمبریو کا وزن تقریباً 1.25 گرام تک ہو جایا کرتا ہے اور ایمبریو کی لمبائی پونے دو انچ ہو جاتی ہے۔

پانچواں ہفتہ (Fifth Week): پانچویں ہفتے کے دوران ایمبریو میں ہاتھ، پاؤں اور ایارٹا بننے لگتی ہے جبکہ ہنسل کی ہڈی کلیوکیل اور نچلے جڑے کی ہڈی مینڈیبل کے مراکز بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

چھٹا ہفتہ (Sixth Week): چھٹے ہفتے کے دوران ایمبریو کے سر اور دھڑ دونوں علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں جبکہ آنکھ، کان اور ناک کے سوراخ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ریڑھ کا ستون اور پسلیاں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبریو میں گردے، مثانے، زبان اور دانتوں وغیرہ کے ابھار بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

ساتواں ہفتہ (Seventh Week): ساتویں ہفتے کے دوران ایمبریو میں مسلز واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ایمبریو کی پسلیاں، بازو، کندھے، پنڈلیاں، ران، بالائی جڑے اور تالو کی ہڈیوں کے مراکز بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

آٹھواں ہفتہ (Eighth Week): آٹھویں ہفتے کے دوران ایمبریو میں کلائی اور کوہے کی ہڈیوں کے مراکز پیدا ہو جاتے ہیں اور ایمبریو میں کلائی، بازو، ران، ناک اور انگلیاں قابل شناخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبریو میں لعاب دہن پیدا کرنے والے غدود سلائیوری گینڈز اور تلی یعنی اسپلین بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔

نواں ہفتہ (Ninth Week): نویں ہفتے کے دوران ایمر یوکواب فیٹس (Foetus) کہا جاتا ہے اور فیٹس میں ٹیسٹیز یا اووریز بنتی ہے جبکہ پتہ یعنی گال بلیڈر بھی اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس دوران فیٹس کی لمبائی ایک انچ اور وزن تقریباً چار گرام ہو جاتا ہے۔

تیسرا مہینہ (Third Month): تیسرے مہینے کے دوران فیٹس کا وزن تیس سے پچاس گرام تک ہو جاتا ہے جبکہ لمبائی 2.25 انچ سے لے کر 3.5 انچ تک ہو جاتی ہے۔

چوتھا مہینہ (Fourth Month): چوتھے مہینے کے دوران ماں کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور فیٹس کے کولہے کی ہڈی کا مرکز بھی بننا شروع ہو جاتا ہے جبکہ جلد کے نیچے چربی بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ فیٹس کا وزن تقریباً 150 سے لے کر 200 گرام تک ہو جاتا ہے اور لمبائی 5 سے 6 انچ تک ہو جاتی ہے۔

پانچواں مہینہ (Fifth Month): پانچویں مہینے کے دوران فیٹس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی دھڑکن کی رفتار 120 سے لے کر 160 دھڑکن فی منٹ تک ہوتی ہے۔ فیٹس کے سر پر بال پیدا ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے مراکز بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیٹس میں پسینے کے غدود اور لمف کے غدود بھی واضح ہو جاتے ہیں جبکہ فیٹس کا وزن تقریباً 350 گرام ہو جاتا ہے اور لمبائی 10 انچ تک ہو جاتی ہے۔

چھٹا مہینہ (Sixth Month): چھٹے مہینے کے دوران فیٹس میں پلکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ فیٹس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ فیٹس کا وزن تقریباً 500 گرام تک ہو جاتا ہے اور لمبائی 12 انچ تک ہو جاتی ہے۔

ساتواں مہینہ (Seventh Month): ساتویں مہینے کے دوران فیٹس کے دماغ کی جھلیاں واضح ہو جاتی ہیں اور فیٹس کی ٹیسٹیز اپنی سکروٹم میں آ جاتی ہیں۔ فیٹس کا وزن تقریباً ایک کلو گرام سے سوا کلو گرام تک ہو جاتا ہے جبکہ فیٹس کی لمبائی تقریباً 15 انچ تک ہو جاتی ہے۔ ساتویں مہینے میں فیٹس ان تمام خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے جس سے کہ وہ زندہ رہ سکے لہذا اگر ساتویں مہینے کے دوران فیٹس پیدا بھی ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔

آٹھواں مہینہ (Eighth Month): آٹھویں مہینے کے دوران اب فیٹس کو بچہ (Baby) کہا جاتا ہے۔ آٹھویں مہینے میں بچہ لمبائی کی نسبت چوڑائی اور موٹائی میں زیادہ بڑھتا ہے جبکہ بچے کا وزن دو کلو گرام تک ہو جاتا ہے اور لمبائی تقریباً 17 انچ تک ہو جاتی ہے۔

نواں مہینہ (Ninth Month): نویں مہینے کے دوران بچے کی نشوونما مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ بچے کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام تک ہو جاتا ہے اور لمبائی 18 سے لیکر 20 انچ تک ہو جاتی ہے اور حمل کی مدت پوری ہونے کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔



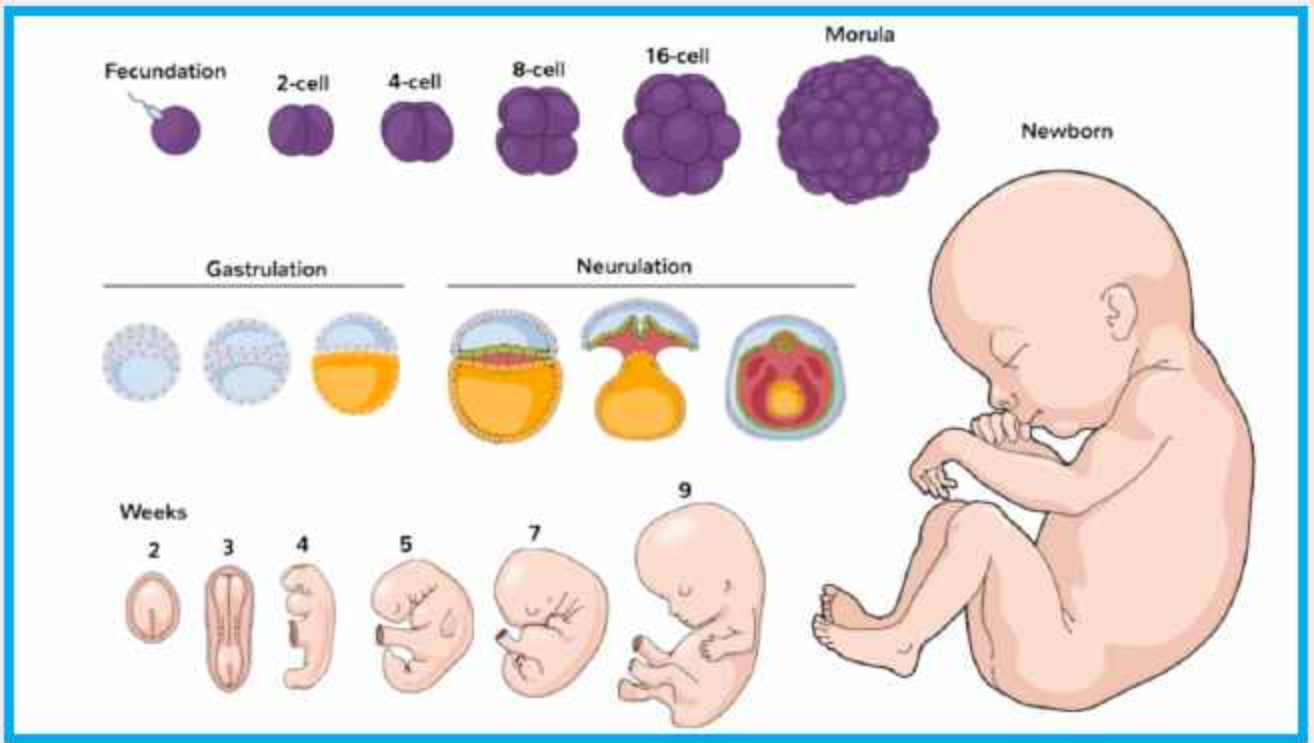
فیٹس کا دورانِ خون

(FOETAL CIRCULATION)

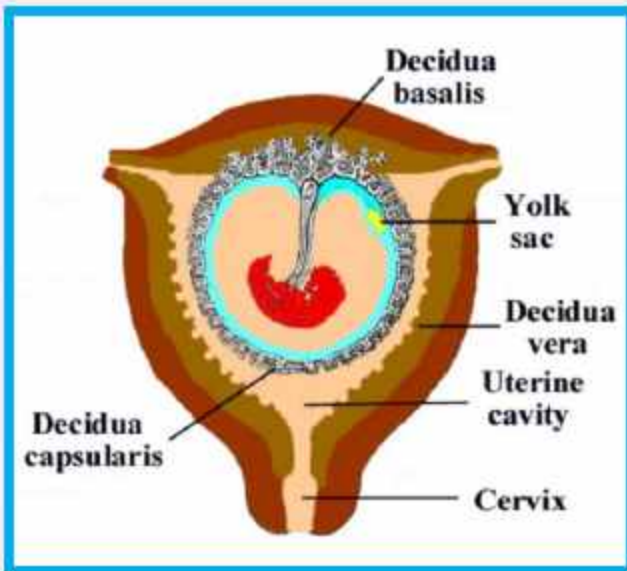
تعارف (Introduction): یوٹرس میں موجود بچے کا نظام دورانِ خون عام آدمیوں کے نظام دورانِ خون سے بالکل مختلف ہوتا ہے کیونکہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بچے کے نظام دورانِ خون میں فرق ہوتا ہے کیونکہ پیدائش سے پہلے یوٹرس میں موجود بچے کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور خون صاف نہیں کرتے بلکہ پلاسینیا سے خون تازہ آکسیجن اور غذا کے اجزاء لے کر امبالائیکل وین کے ذریعے فیٹس کے جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ وین جگر کی طرف جانے والی پورٹل وین سے مل جاتی ہے اور یوں خون جگر میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا ہپاٹک وین کے ذریعے انفریئر وینا کیو میں ڈکٹس وینوس کے ذریعے براہ راست چلا جاتا ہے۔ انفریئر وینا کیو میں پلاسینیا سے آنے والا صاف خون پیروں اور نچلے دھڑ سے آنے والا گندہ خون دونوں مل جاتے ہیں اور یہ تمام خون انفریئر وینا کیو کے ذریعے دل کی دائیں ایٹریم میں پہنچ جاتا ہے اور یوں اس خون میں ستر فیصد صاف خون اور تیس فیصد گندہ خون موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ خون دونوں ایٹریم کے درمیان موجود سوراخ فورامین اوویلی (Foramen Ovale) کے ذریعے بائیں ایٹریم سے ہوتا ہوا بائیں وینٹریکل میں چلا جاتا ہے اور جہاں سے یہ خون ایارٹا کے ذریعے جسم کی بالائی وزمیریں حصوں کی جانب سپلائی ہونے کے لئے چلا جاتا ہے۔

سر اور اوپر کے دھڑ سے واپس آنے والا خون سپریئر وینا کیو کے ذریعے رائیٹ وینٹریکل میں آتا ہے اور رائٹ وینٹریکل کے سکڑنے پر یہ خون پلمونری آرٹری میں سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں کی جانب جاتا ہے اور چونکہ بچے کے پھیپھڑے ابھی کام نہیں کر رہے ہوتے اس لئے مزاحمت کی وجہ سے خون پھیپھڑوں میں داخل نہیں ہو سکتا اور یوں یہ خون پلمونری آرٹری سے ڈکٹس آرٹریوسس (Ductus Arteriosus) کے ذریعے آیارٹا میں چلا جاتا ہے اور آیارٹا اس خون کو بشمول باقی خون کے نچلے دھڑ کی جانب لے آتی ہے اور یہاں سے خون صاف ہونے کی خاطر اور غذائی اجزاء حاصل کرنے کی خاطر دو عدد امبالائیکل آرٹریز کے ذریعے پلاسینیا کی جانب چلا جاتا ہے اور اس طرح سے پلاسینیا سے خون فیٹس کی جانب اور فیٹس سے خون پلاسینیا کی جانب آتا اور جاتا رہتا ہے اور یوں فیٹل سرکولیشن قائم رہتی ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو فیٹل سرکولیشن کا یہ عمل تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ پیدائش کے بعد بچے میں پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے کا گندہ خون صاف ہونے کیلئے پھیپھڑوں کی جانب جاتا ہے۔ اسی لئے بچے میں پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد نظام دورانِ خون بالکل مختلف ہوتا ہے۔

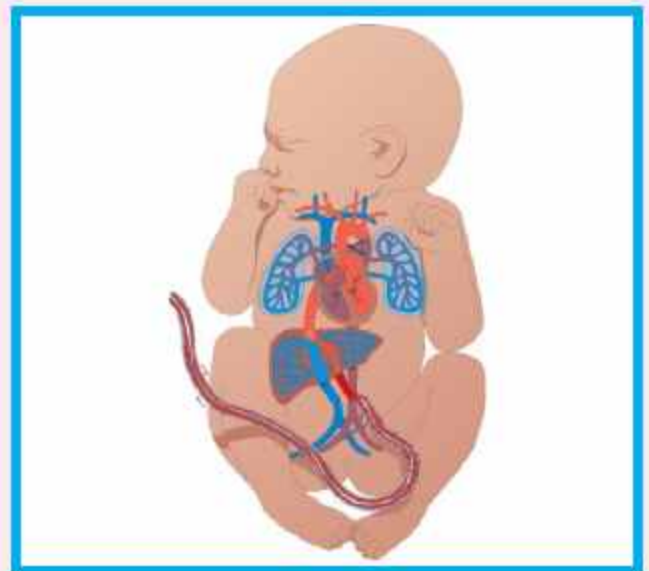




Human Embryo and Fetal Development



Gestational Sac



Fetal Circulation

یونٹ: 7

فیٹس اور پلے سینٹا (FOETUS AND PLACENTA)

جنین (FOETUS)

تعارف (Introduction): حاملہ کے یوٹرس میں نشوونما پانے والے بچے کو فیٹس یا جنین کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حمل قرار پا جانے کے بعد پہلے تین ہفتے کے انڈے کو اووم (Ovum) کہتے ہیں جبکہ تین ہفتے سے آٹھ ہفتے تک کے حمل کو ایمبریو (Embryo) کہا جاتا ہے اور آٹھ ہفتے کی عمر سے لے کر پیدائش تک کا بچہ ماں کے پیٹ میں فیٹس یعنی جنین کہلاتا ہے۔ عورتوں کا فریٹلائزڈ اووم جب یوٹرس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر خاص قسم کے سیلز کی تہہ چڑھ جاتی ہے جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں ٹروفوبلاسٹ کہتے ہیں۔ اسی ٹروفوبلاسٹ سے آگے چل کر فیٹس کی بیرونی جھلی کو ریان ترتیب پاتی ہے اور پھر اسی سے پلے سینٹا یعنی آنول وجود میں آ جاتا ہے۔ فریٹلائزڈ اووم یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریم سے لپٹ جاتا ہے اور ٹروفوبلاسٹ سیلز کی تحلیل کے سبب اس میں جذب ہو کر کوریان فرونڈوسم (Chorion Frondosum) کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فریٹلائزڈ اووم کے ارد گرد جو باقی کوریان جھلی ہوتی ہے وہ ملائم اور ہموار صورت اختیار کر لیتی ہے جسے کوریان لیوے (Choreon Laeve) کہتے ہیں

حمل کے ابتدائی زمانہ میں فیٹس، یوٹرس کے سارے خلاء کو پوری طرح نہیں بھرتا بلکہ یوٹرس کا کافی حصہ خالی ہوتا ہے لیکن جوں جوں فیٹس نشوونما پاتا جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے لگتا ہے اور حمل کے تیسرے ماہ وہ یوٹرس کے خلاء پر مکمل طور پر قابض ہو جاتا ہے اور یوٹرس بھی اس وقت تک خاصا بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ یوٹرس کی جھلی کے اس حصہ پر جہاں فریٹلائزڈ اووم نے پہلے پہل آ کر ڈیرہ جمایا تھا وہاں تیسرے مہینے آہستہ آہستہ پلے سینٹا کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ فیٹس پلے سینٹا سے جڑی نال امبالائیکل کارڈ کے ذریعے اپنی غذا ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے۔ امبالائیکل کارڈ کا ایک حصہ بچے کی ناف سے جڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف یوٹرس کے ذریعے ماں کے جسم کی شریانوں سے جڑا ہوتا ہے چنانچہ یوٹرس میں فیٹس کو غذا اور آکسیجن ماں کے خون سے حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح فیٹس کے فضلات کا اخراج بھی ماں کے خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ فیٹس اور اس کے ارد گرد پائی جانے والی ایک اور جھلی ایمنیا کے درمیانی خلاء میں ایک خاص قسم کا مائع بھرا رہتا ہے جسے لائیکور ایمنیائی (Liquor Amnii) یا ایمینیا ٹک فلوئیڈ (Amniotic Fluid) بھی کہتے ہیں۔ یہ مائع فیٹس کو بیرونی جھکوں اور صدموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مائع سیال و شفاف ہوتا ہے اور اس میں فیٹس کو ملائم رکھنے والے ذرات اور فیٹس کے جسم سے الگ ہونے والے روئیں بھی پائے جاتے ہیں۔ فیٹس اس مائع میں تیرتا رہتا ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں اس مائع کی مقدار تقریباً ایک لٹر ہو جاتی ہے۔ وضع حمل کے وقت یوٹرس کے سکڑنے کی وجہ سے یہ رطوبت والی جھلی پھٹ جاتی ہے اور یوں یہ رطوبت خارج ہو کر بچے کی ولادت کے راستے کو چکنا کر دیتی ہے جسکے باعث بچے کی ولادت سہولت کیساتھ ہو جاتی ہے۔



پلے سینٹا اور اس کے افعال

(PLACENTA & ITS FUNCTIONS)

تعارف (Introduction): پلا سینٹا کو آنول بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نرم سفیدی ساخت کا عضو ہے اور اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے پلا سینٹا ایک ایسا عضو ہے جو کہ ایمبریو اور یوٹرس کے درمیان موجود ہوتا ہے یہ عام طور پر یوٹرس کے بالائی حصے فنڈس میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس پلے سینٹا ہی کے ذریعے ایمبریو اور فٹس کے خون کی نالیاں یوٹرس میں ماں کی خون کی نالیوں کیساتھ قریبی تعلق پیدا کرتی ہیں اور اس طرح پلا سینٹا ایمبریو اور فٹس کو ماں کے خون سے غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا کرتا ہے جبکہ یہی پلا سینٹا امبریو اور فٹس کے فاسد مادے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بھی کرتا ہے۔ ایک مکمل پلا سینٹا کا قطر تقریباً پندرہ سے بیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور وزن پانچ سو گرام تک ہوتا ہے جبکہ اسکی موٹائی تقریباً تین سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ایک پلا سینٹا میں تقریباً پندرہ سے لیکریس تک خانے (Lobes) ہوتے ہیں۔ پلا سینٹا کی بیرونی سطح قدرے غیر ہموار ہوتی ہے جبکہ اندرونی سطح نرم اور ہموار ہوتی ہے۔

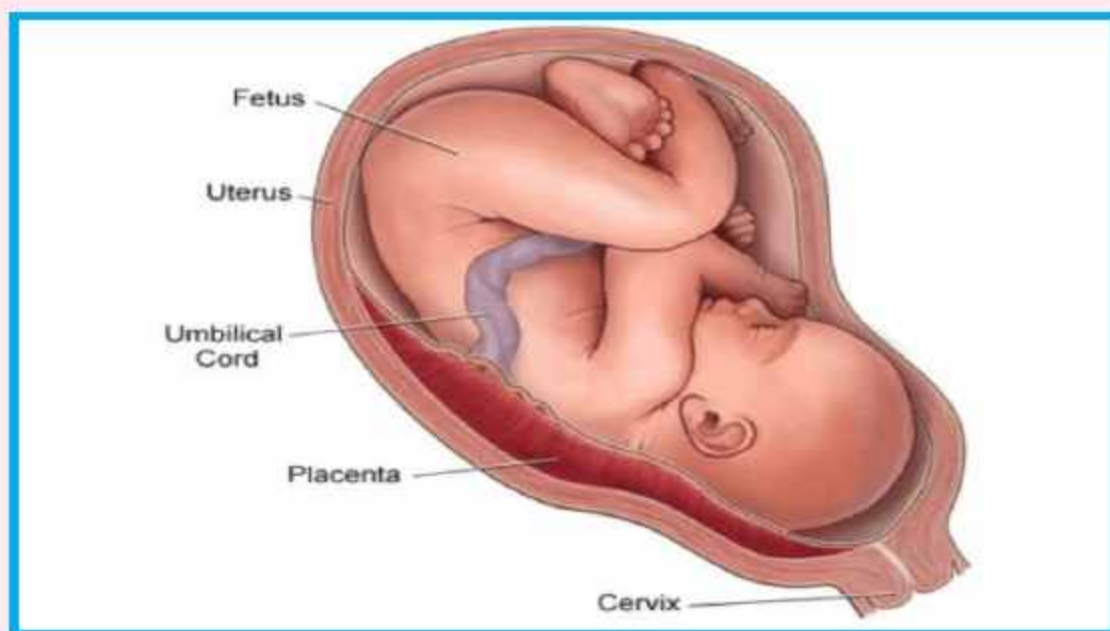
ایک پلا سینٹا دو حصوں میں مشتمل ہوتا ہے ایک میٹریل حصہ جو کہ یوٹرس کی جانب ہوتا ہے اور یہ میٹریل حصہ یوٹرس کی میوکس ممبرین سے بنتا ہے اور دوسرا فیٹل حصہ جو کہ کوریان سے بنتا ہے۔ پلا سینٹا کے فیٹل حصے کے درمیان میں امبالائیگل کارڈنگی ہوتی ہے امبالائیگل کارڈ ایک نالی کی طرح کا عضو ہے جس کے ایک سرے پر پلا سینٹا کا فیٹل حصہ اور دوسرے سرے پر ایمبریو فٹس لگا ہوا ہوتا ہے۔ امبالائیگل کارڈ کی بیرونی سطح پر ایک ٹیوڈرم کی تہہ ہوتی ہے اور درمیان میں میزوڈرم ہوتی ہے۔ میزوڈرم میں دو عدد امبالائیگل آرٹریز اور ایک عدد امبالائیگل وین ہوتی ہے۔ امبالائیگل کارڈ فٹس کی نشوونما کے مختلف مراحل کے دوران سائز میں بڑھتی رہتی ہے چنانچہ حمل کے تیسرے مہینے میں امبالائیگل کارڈ کی لمبائی چھ انچ اور نویں مہینے میں امبالائیگل کارڈ کی لمبائی بیس انچ تک ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پلا سینٹا اور بچے کے ارد گرد کی جھلیاں ایمینیان، کوریان اور یوٹرس کی میوکس ممبرین جسے ڈیسیڈوا (Decidua) کہتے ہیں باہر خارج ہو جاتی ہیں۔ ان کا اخراج یوٹرس کی دیواروں کے سکڑاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

پلا سینٹا کے افعال مندرجہ ذیل ہیں:

- ☆..... پلا سینٹا ماں اور بچے کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے۔
- ☆..... پلا سینٹا کے ذریعے بچے کو ماں کے خون سے غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔
- ☆..... پلا سینٹا کے ذریعے بچے کو ماں کے خون سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔
- ☆..... پلا سینٹا کے ذریعے یوٹرس میں موجود بچہ اپنے فاسد مادے خارج کر سکتا ہے۔



Human Foetus In Uterus



Foetus, Placenta and Umbilical Cord

- ☆..... پلاسینٹا کے ذریعے یوٹرس میں موجود بچہ کاربن ڈی آکسائیڈ کا اخراج کر سکتا ہے۔
- ☆..... پلاسینٹا کے ذریعے ماں سے مختلف ہارمونز بچے میں منتقل ہوتے ہیں جو بچے کی صحت اور نشوونما کیلئے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔
- ☆..... پلاسینٹا خود بھی ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمون پیدا کرتا ہے۔
- ☆..... پلاسینٹا کے ذریعے ماں کے خون سے مختلف اینٹی باڈیز بچے میں منتقل ہوتی ہیں جو بچے کی قوت مدافعت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
- ☆..... پلاسینٹا کے ذریعے یوٹرس میں موجود بچہ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
- ☆..... پلاسینٹا کے ذریعے یوٹرس میں موجود بچہ مختلف قسم کے جراثیموں سے محفوظ رہتا ہے۔
- ☆..... پلاسینٹا خود ایک ہارمون جسے کوریونک گونیدوٹرافن کہتے ہیں پیدا کرتا ہے۔



پلے سینٹا کی خرابیاں

(DEFECTS OF PLACENTA)

- تعارف (Introduction):** حاملہ عورتوں میں عموماً پلے سینٹا نارمل ہوا کرتا ہے لیکن کئی مرتبہ پلے سینٹا میں درج ذیل خرابیاں بھی پائی جاسکتی ہیں:
- ☆..... پلے سینٹا کے وزن میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر پلے سینٹا کا وزن تقریباً پانچ سو گرام تک ہوتا ہے لیکن اگر حاملہ عورت خدانخواستہ ذیابیطس کا شکار ہو تو پھر پلے سینٹا کا وزن بڑھ جایا کرتا ہے۔
 - ☆..... پلے سینٹا عام طور پر یوٹرس کے فنڈس میں پیوست ہوتا ہے لیکن بعض صورتوں میں پلے سینٹا یوٹرس کے نچلے حصے میں پیوست ہو جاتا ہے جسے پلے سینٹا پریویا (Placenta Previa) کہتے ہیں جسکی وجہ سے حمل اور زچگی کے دوران پیچیدگیاں اور غیر معمولی طور پر خون کا اخراج ہو سکتا ہے
 - ☆..... عموماً پلے سینٹا کی شکل و صورت ایک پلیٹ کی طرح ہوتی ہے لیکن بعض اوقات یہ دو یا تین توہڑوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔
 - ☆..... عام طور پر یوٹرس میں ایک پلے سینٹا ہوا کرتا ہے لیکن بعض اوقات اضافی پلے سینٹا اصل پلے سینٹا سے کچھ فاصلے پر موجود ہوتا ہے جو کہ اصل پلے سینٹا سے بلڈ ویسلز کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے اس اضافی پلے سینٹا کو اضافی پلے سینٹا (Accessory Placenta) کہتے ہیں۔
 - ☆..... پلے سینٹا میں کوریان ولائیز (Chorion Villis) ماں کی جانب ہوتی ہے لیکن بعض اوقات یہ کوریان ولائیز ماں کی جانب ہونے کی بجائے بچے کی جانب ہوتی ہیں۔ پلے سینٹا کی ایسی حالت کو پلے سینٹا ڈیفوزا (Placenta Defusa) کہتے ہیں۔
 - ☆..... بعض اوقات پلے سینٹا کے فیٹل سرفیس کی جانب پلے سینٹا کے گرد ایک سفید سارنگ بن جاتا ہے جو کہ کوریونک ولائیز کی غیر معمولی نشوونما کے باعث بنتا ہے اسے پلے سینٹر سرکم ویلیٹ (Placenta Circumvallate) کہتے ہیں۔

☆..... پلے سینٹا عام طور پر اچھا خاصا موٹا ہوا کرتا ہے لیکن بعض اوقات کسی نقص کی بناء پر پلے سینٹا موٹا ہونے کی بجائے زیادہ پھیل کر پتلا جھلی کی طرح ہو جاتا ہے ایسے پلے سینٹا کو پلے سینٹا ممبرنوس (Placenta Membranous) کہا جاتا ہے۔

☆..... اگر پلے سینٹا امبالائیجکل کارڈ سے دور یوٹرس میں پیوست ہو تو اسے پلے سینٹا ویلا میٹوسا (Placenta Velamentosa) کیا جاتا ہے

☆..... اگر پلے سینٹا کے ولائی غیر طبعی حد تک یوٹرس میں داخل ہو کر یوٹرس کی دیواروں اور پلے سینٹا کوٹھوس حالت میں تبدیل کر دیں تو اسے پلے سینٹا انسرتا (Placenta Inserta) کہتے ہیں۔

☆..... بعض اوقات پلے سینٹا کے ولائی یوٹرس کی اندرونی تہہ سے داخل ہو کر بیرونی تہہ تک دھنس جاتے ہیں اور ٹھوس حالت اختیار کر لیتے ہیں۔

اس طرح پلے سینٹا یوٹرس ہی کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ پلے سینٹا کی اس خرابی کو پلے سینٹا پرسیا (Placenta Persia) کہا جاتا ہے۔ اس خرابی میں زچگی کے تیسرے مرحلے میں پلے سینٹا مکمل طور پر یوٹرس سے جدا نہیں ہو سکتا۔



پلے سینٹا کے امراض

(DISEASES OF PLACENTA)

تعارف (Introduction): اگر پلے سینٹا کا درمیانی حصہ انفیکشن سے متاثر ہو کر خراب ہو جائے تو ایسی بیماری کو پلے سینٹا فنسٹریٹا (Placenta Fenestrata) کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات پلے سینٹا میں کناروں کے نزدیک سفید رنگ کے حصے دکھائی دیتے ہیں جو کہ ٹروفو بلاسٹ میں فیبری نائیڈ ڈی جنریشن (Febrinoid Degeneration) کے نتیجے میں بنتے ہیں تاہم اس حالت میں خوراک کے اجزاء اور آکسیجن کی فراہمی برقرار رہتی ہے۔ اسے پلے سینٹا کی فیبری نائیڈ ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ بعض اوقات ولائیڈز میں خون جم جانے کی وجہ سے پلے سینٹا کے متاثرہ حصے کو خون کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے اور متاثرہ حصوں پر سرخ رنگ کے مرہ حصے ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تھرامبوسس کہتے ہیں۔ بعض دوسرے حصوں تک پھیل جائے تو بچے کی خوراک اور آکسیجن کی فراہمی میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کو انٹرا ولس تھرامبوسس کہتے ہیں۔ بعض اوقات نامعلوم وجوہات کی بناء پر پلے سینٹا سیاہ رنگ کے انکور کے گچھوں کی مانند خلیات میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے ہائیڈائیڈ فارم مول کہتے ہیں۔ حاملہ عورت کے جسم میں موجود کینسر یا ٹیومر پلے سینٹا کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور کوریوکارینوما (Chorio Carcinoma) یا پھر ایک اور صورت کوریو انجیوما (Chorio Angioma) بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح پلے سینٹا کی میٹرل سرفیس کوریان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کیلشیم جمع ہو جاتا ہے جو کہ سفید سفید ٹکڑوں کی صورت میں نظر آتا ہے اسے پلے سینٹل کیلسی فیکیشن (Placental Calcification) کہتے ہیں۔



یونٹ: 8

حمل اور اس کی ممکنہ پیچیدگیاں

(PREGNANCY AND IT'S COMPLICATIONS)

حمل

(PREGNANCY)

تعارف (Introduction): حمل عورتوں کے جسم میں ایک فزیولا جیکل عمل ہے جو کہ بلوغت کے بعد کسی مرد سے جنسی تعلق قائم کرنے پر ہوتا ہے۔ حمل عام طور پر کم و بیش 28 سے 36 ہفتے تک قائم رہتا ہے۔

حمل کی نشانیوں / علامات (Signs / Symptoms Of Pregnancy): حاملہ ہو جانے پر عورت میں مندرجہ ذیل طبعی، جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ عورت حاملہ ہے۔ عورت کے جسم میں پیدا ہونیوالی یہ طبعی، جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں دراصل حمل کی نشانیاں اور علامات ہوا کرتی ہیں یہ نشانیاں اور علامات درج ذیل ہیں:

1۔ **حیض کا بند ہو جانا (Amenorrhoea):** حیض کی بندش حمل کی پہلی نشانی ہے لیکن بعض اوقات بندش حیض کی کوئی اور وجہ مثلاً چوٹ لگ جانا۔ پاؤں بھیک جانا۔ موسمی تبدیلیاں یا کوئی اندرونی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے بندش حیض ہمیشہ حمل کی یقینی علامت نہیں ہوا کرتی جب تک کہ حمل سے متعلقہ دوسری علامات کا اظہار نہ ہو۔ اسی طرح خون کی شدید کمی بھی حیض کے بند ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔

2۔ **صبح کی متلی اور تھکن (Morning Sickness & Fatigue):** اکثر عورتیں حمل کے دوسرے ہفتے سے چھٹے ہفتے کے درمیان متلی اور تھکن کی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں اور صبح بستر سے اٹھتے وقت تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں۔ ایسا عام طور پر تین مہینے تک ہوتا ہے جو کہ جسم میں ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ہوا کرتا ہے۔

3۔ **کھٹی چیزوں کی خواہش (Craving For Bitter Food):** حاملہ عورت کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کھٹی چیزیں مثلاً لیموں یا اچار کھانے کی خواہش کرتی ہے۔ بعض اوقات عورتیں حمل کے دوران مٹی اور کوئلہ بھی کھانے لگتی ہیں۔ ایسا عموماً کیشیم کی کمی کے باعث ہوتا ہے۔

4۔ **پستانوں کا بڑھ جانا (Engorgement Of Breasts):** حمل ٹھہرنے کے بعد چھاتیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے اوپر کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ دبانے سے پستان درد کرتے ہیں۔ نپلز بڑھ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد موجود ایریولا کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جسم میں ہارمونل تبدیلیوں کے باعث ہوا کرتا ہے۔

5۔ **پستانوں میں دودھ آنا (Milk In Breasts):** تیسرے مہینے کے بعد چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ ایسا حاملہ میں پرولیکٹن ہارمون کے زیادہ ہو جانے کے باعث ہوتا ہے۔ پرولیکٹن ہارمون اینٹریئر پکچوٹری سے پیدا ہوتا ہے اور یہ عورتوں کے پستانوں میں دودھ پیدا کرتا ہے۔

6۔ **پیٹ کا بڑھنا (Enlargement Of Abdomen):** جیسے جیسے حمل کے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حاملہ کا پیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پیٹ کا یہ بڑھنا بچے کی پیدائش تک جاری رہتا ہے۔

7۔ **جلدی تبدیلیاں (Skin Changes):** حاملہ کی جلد پر بھورے رنگ کے داغ بن جاتے ہیں یہ داغ خاص طور پر ماتھے پر، منہ، ناف کے ارد گرد اور ناف کے نیچے، کولہے کے سامنے کی ہڈی کے درمیان موجود لائن پر ہوتے ہیں۔ یہ داغ ہارمونل تبدیلیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔

8۔ **رحم میں تبدیلی (Changes In Uterus):** حمل کے دوران حاملہ کے یوٹرس کا منہ یعنی سرویکس نرم ہو جاتا ہے اور اس کا بیرونی منہ OS تھوڑا سا کھل جاتا ہے جس میں سے تھوڑا سا سفید چکنامادہ نکلتا رہتا ہے جو سرویکس کو چکنا، نرم اور ملائم رکھتا ہے۔

9۔ **وہجائے رنگ میں تبدیلی (Chage In Colour Of Vagina):** دوران حمل، حاملہ کی وہجائے کی جانب خون زیادہ سپلائی ہوتا ہے اور خون کی اسی زیادتی کی وجہ سے حاملہ کی وہجائے کی رنگت تبدیل ہو کر بینگنی ہو جاتی ہے۔

10۔ **قبض (Constipation):** حاملہ عورت کو اکثر قبض ہو جاتی ہے کبھی کبھی حاملہ عورت کو بواسیر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔

11۔ **ٹانگوں میں اکڑائیاں (Spasms In Legs):** ساتویں مہینے میں حاملہ عورت کی ٹانگوں میں درد اور اکڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسا ٹانگوں کے اعصاب اور رگوں پر رحم کا دباؤ پڑنے سے ہوتا ہے۔

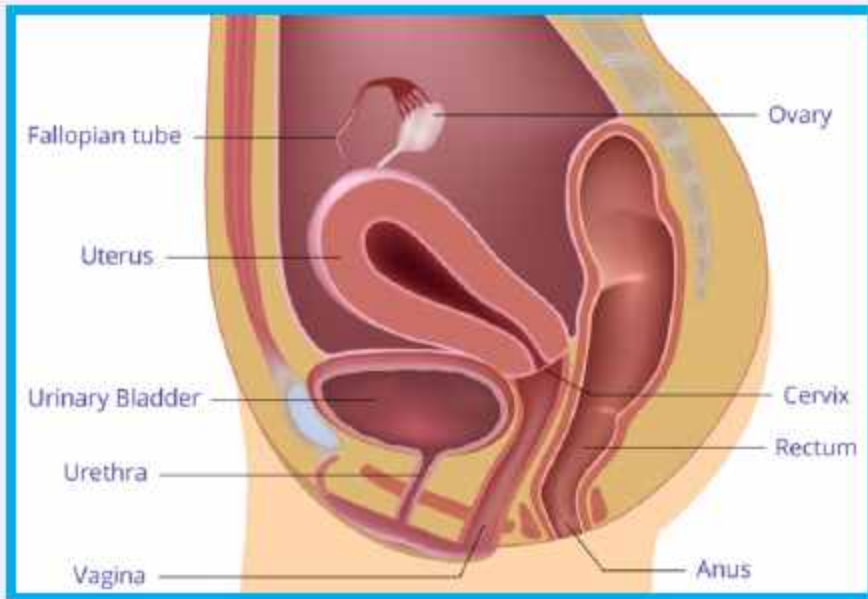
12- سانس لینے میں تکلیف (Difficulty In Respiration): حمل کے آخری مہینوں میں رحم کے بڑھ جانے اور اوپر چڑھ جانے سے حاملہ چھاتی میں تنگی محسوس کرتی ہے جس کی وجہ سے حاملہ کو سانس لینے میں قدرے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

13- پیشاب کا بار بار اور جلد آنا (Urgency In Urine): جیسے جیسے حمل بڑھتا ہے تو یوٹرس کا سائز بھی دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ بڑھا ہوا یوٹرس اپنے سامنے موجود مثانے پر دباؤ ڈالتا ہے جس کے باعث حاملہ کو پیشاب بار بار اور جلد کرنے کی خواہش محسوس ہوتی ہے لہذا حمل کے دوران پیشاب کا بار بار آنا بھی حمل کی ایک نشانی ہے۔

مندرجہ بالا تمام علامات کو سامنے رکھتے ہوئے حمل کی تشخیص کی جاسکتی ہے لیکن حمل کی یقینی تشخیص کے لئے درج ذیل علامات بھی ہوا کرتی ہیں:

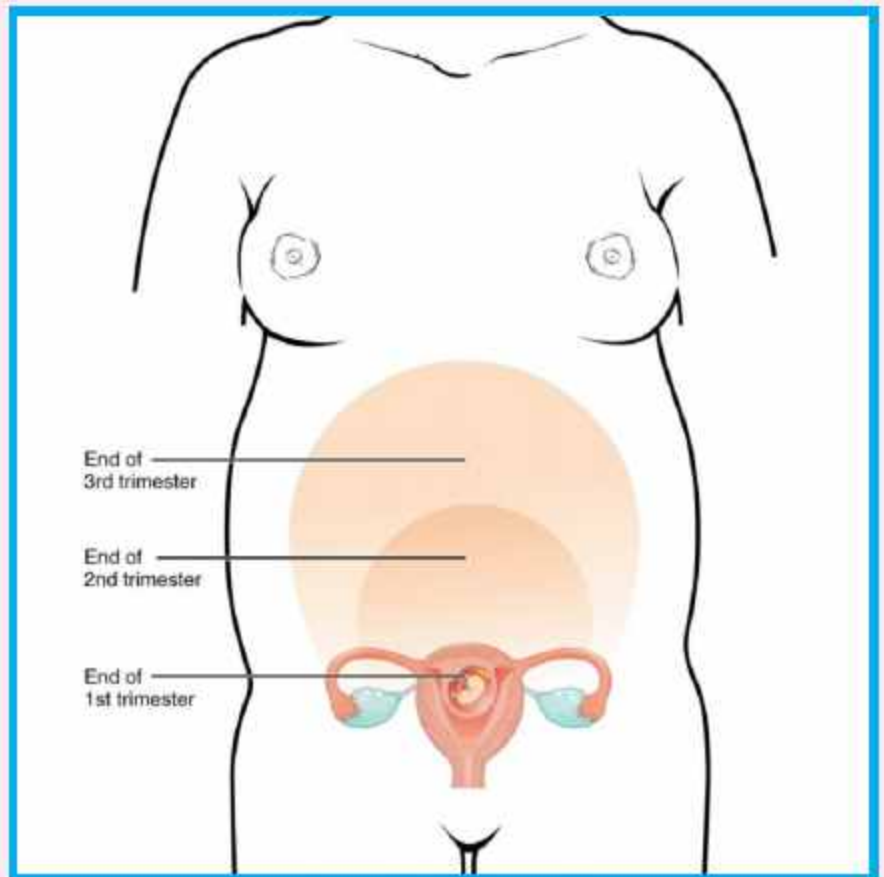
- ☆..... حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں تو کبھی کبھی یوٹرس کی حرکات ہاتھ کو محسوس ہوتی ہیں۔
- ☆..... پانچویں مہینے کی ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکات کو ہاتھ لگانے سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔
- ☆..... ماں کو خود بھی بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
- ☆..... حاملہ کے پیٹ پر کان لگا کر بچے کے دل کی آواز کو بھی سنا جاسکتا ہے۔
- ☆..... یہ آواز اکثر حاملہ کے پیٹ کے بائیں طرف ناف اور چڈے کے درمیان ہوتی ہے۔
- ☆..... بچے کے دل کی رفتار 130 سے 160 فی منٹ ہوتی ہے۔
- ☆..... چھٹے مہینے میں اگر عورت کی ویجائنہ میں انگلی ڈال کر رحم کو اوپر کی طرف کیا جائے تو بچہ اوپر ہو کر پھر نیچے آتا محسوس ہوتا ہے اس طریقے کو بلاٹمنٹ (Ballotement) کہتے ہیں۔
- ☆..... رحم کی بھری ہوئی رگوں کی آواز حاملہ کے پیٹ پر کان لگا کر سنی جاسکتی ہے جسے یوٹرائن سوفلز (Uterine Suffles) کہتے ہیں





**Normal
Anatomical
Position Of
Female
Genitalia**

**Trimester
Wise
Uterine
Growth**



حمل کی تشخیص

(DIAGNOSIS OF PREGNANCY)

کسی بھی عورت میں حمل کی تشخیص درج ذیل طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

1۔ پیشاب کا پرگ نیسی ٹیسٹ (Urine For Pregnancy): حاملہ عورت کے پیشاب میں ہیومن کوریونک گونیڈ وٹروفن ہارمون موجود ہوتا ہے لہذا حاملہ عورت کے پیشاب میں اسی ہارمون کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ پیشاب میں اگر یہ ہارمون موجود ہو تو حمل کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیشاب کا یہ پرگ نیسی ٹیسٹ آخری حیض ہونے کے چالیس دن کے بعد کیا جانا چاہیے۔ اس ٹیسٹ کو یورین فار پرگ نیسی کہتے ہیں۔

2۔ تشخیص بذریعہ الٹراساؤنڈ (Ultrasound): پیٹ کے الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی حمل ٹھہرنے کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے نہ صرف حمل کی تشخیص کی جاسکتی ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکات، بچے کے سر کی پیمائش، ایک سے زائد بچوں کی موجودگی، بچے کی پوزیشن، بچے کی بیماریاں، پلے سینا کی پوزیشن، بچے کے دل کی دھڑکن و رفتار، بچے کی جنس اور بچے کے زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

3۔ معائنہ بذریعہ ایکس رے (X-Ray Examination): اگرچہ حمل کی تشخیص اور دیگر حقائق معلوم کرنے کے لئے ایکس رے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایکس رے کے بد اثرات کی بناء پر اس کا استعمال بتدریج کم ہو رہا ہے تاہم بسا اوقات ایکس رے کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایکس رے کے معائنے کے ذریعے بچے کی پوزیشن، عمر و سائز اور ایک سے زیادہ بچوں کی موجودگی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

4۔ پیٹ کا معائنہ (Abdominal Examination): حمل کی تشخیص میں حاملہ کے پیٹ کا معائنہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ حاملہ کے پیٹ کے معائنے کے ذریعے یوٹرس کا سائز، بچے کا سائز اور پوزیشن، بچے کے دل کی دھڑکن اور بچے کے زندہ و مردہ ہونے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

5۔ شرم گاہ کا معائنہ (Vaginal Examination): حمل کے دوران شرم گاہ کا معائنہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شرم گاہ کے معائنے کے دوران شرم گاہ میں ہونیوالی تبدیلیوں، حمل کی مدت، یوٹرس اور سرویکس کی بے قاعدگیوں، یوٹرس کی پوزیشن کا اندازہ کرنے کے علاوہ حاملہ عورت کے پیلوں کے مختلف حصوں کی بھی پیمائش کی جاتی ہے۔

☆☆☆

دوران حمل احتیاطیں

(PRECAUTIONS DURING PREGNANCY)

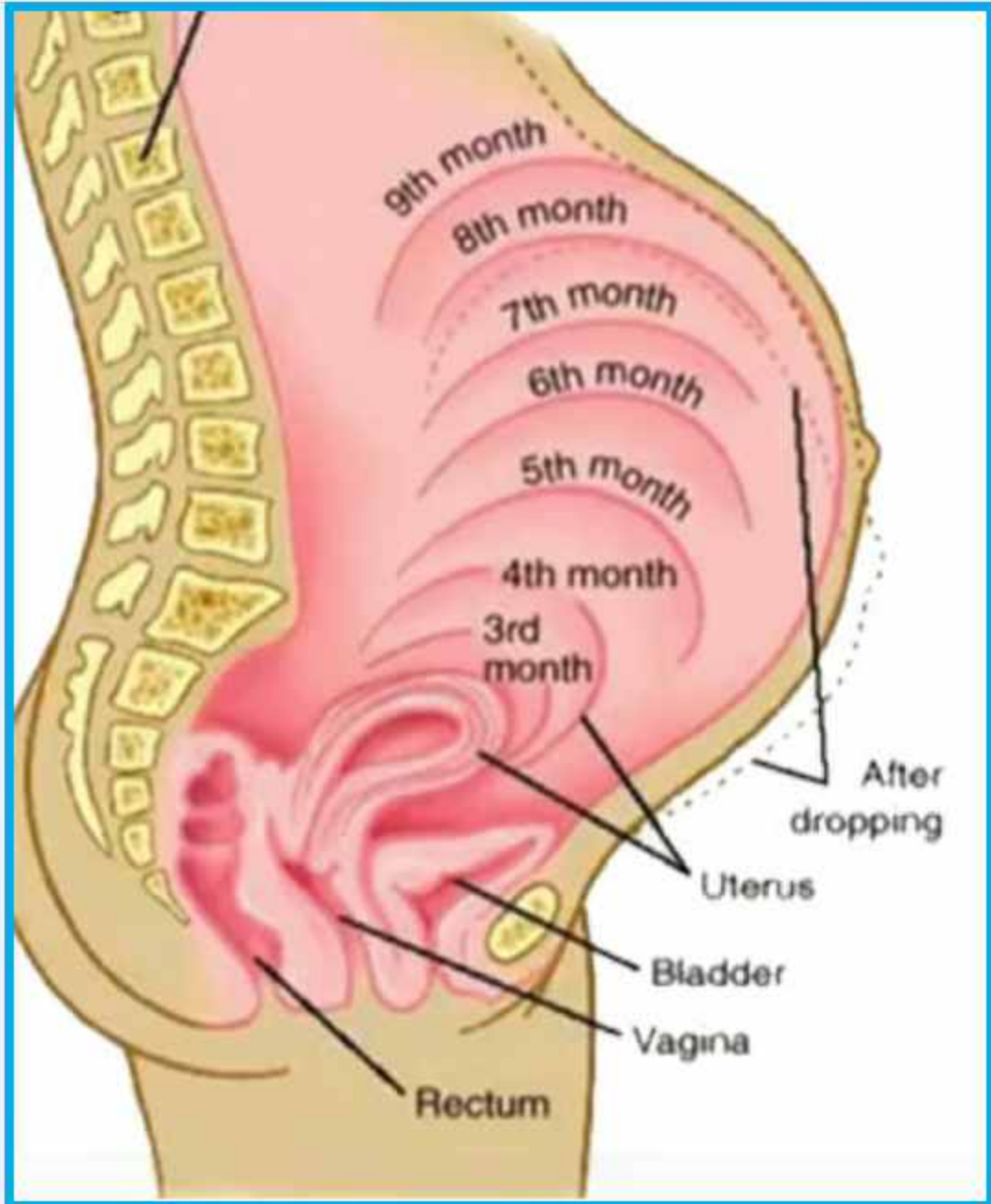
- 1- دوران حمل عورت کو مقوی اور طاقت بخش غذا کھانا چاہیے۔ کیونکہ دوران حمل اس کے جسم نے بچے کی بھی پرورش کرنا ہوتی ہے۔
- 2- حاملہ کو اپنی روزانہ معمول کی خوراک میں تھوڑا سا اضافہ کر دینا چاہیے۔
- 3- حاملہ عورت کو لباس آرام دہ اور ڈھیلا ڈھالا پہننا چاہیے اور قمیض کے کندھے لٹکے ہوئے ہونے چاہئیں۔
- 4- حاملہ کو اپنے پیٹ اور پیروں کو سردی لگنے سے محفوظ رکھنا چاہیے کیونکہ سردی لگنے سے سردرد، درقونج اور اسقاط حمل کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
- 5- دوران حمل ہلکی پھلکی ورزش حاملہ کیلئے ضروری ہے۔ چہل قدمی حاملہ عورت کیلئے بہت اچھی ورزش ہے۔
- 6- حاملہ عورت کو روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔
- 7- حاملہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو تفکرات اور پریشانیوں سے دور رکھے اور ان جگہوں پر جانے سے گریز کرے جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔
- 8- حاملہ عورت کو بھاری وزن اٹھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔
- 9- حاملہ عورت کو کوئی بھی بھاری کام نہیں کرنا چاہیے۔
- 10- حاملہ عورت کو چھلانگ نہیں لگانی چاہیے۔
- 11- حاملہ عورت کو اپنا میڈیکل چیک اپ مستقل طور پر کراتے رہنا چاہیے۔
- 12- حاملہ عورت کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔



عورتوں کے لئے تشنج سے بچائو کے ٹیکے

ٹیکہ	ٹیکہ کب لگایا جائے
1- ٹی۔ ٹی۔	☆..... حمل کے دوران۔
2- ٹی۔ ٹی۔	☆..... پہلے ٹیکے کے چار ہفتے بعد۔
3- ٹی۔ ٹی۔	☆..... دوسرے ٹیکے کے چھ ماہ بعد یا دوسرے حمل کے دوران۔
4- ٹی۔ ٹی۔	☆..... تیسرے ٹیکے کے ایک سال بعد یا اسکے بعد والے حمل کے دوران۔
5- ٹی۔ ٹی۔	☆..... چوتھے ٹیکے کے ایک سال بعد یا اگلے حمل کے دوران۔





Monthly Uterine Growth
During Pregnancy

حمل اور مرض کی علامات میں مشابہت

(RESEMBLANCE BETWEEN PREGNANCY & DISEASE)

تعارف (Introduction): عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کو حیض مقررہ وقت پر نہ آئیں تو خیال کیا جاتا ہے کہ حمل قرار پا گیا ہے، بعض اوقات یہ بات درست ثابت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کسی خرابی کی وجہ سے تھا یہ حمل نہیں تھا۔ لہذا جب کبھی حیض نہ آئے تو باقاعدہ ٹیسٹ کروانا چاہئے۔ تاکہ درست حیثیت کا تعین ہو سکے۔ حمل کے علاوہ حیض درج ذیل وجوہات کی وجہ سے رُک سکتا ہے:

(Diseases Of Female Reproductive Organs)	☆..... زنانہ اعضائے تولید کی بیماریوں کی وجہ سے۔
(During Lactation)	☆..... دودھ پلانے والی عورتوں میں۔
(Severe Disease)	☆..... کسی شدید قسم کے مرض کی وجہ سے۔
(Sadness, Tension, Depression & Anxiety)	☆..... غم، تناؤ، دباؤ، فکر و پریشانی۔
(Fear & Frights)	☆..... ڈر، خوف۔
(Environmental Changes)	☆..... ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی سے۔
(Hormonal Disturbances)	☆..... ہارمونز کے نظام میں خرابیاں۔
(After Surgical Procedure)	☆..... کسی آپریشن کے بعد۔
(Severe Anaemia)	☆..... خون کی شدید کمی کی وجہ سے۔
(Menopause)	☆..... سن یاس کے شروع ہونے پر۔

پستان میں تبدیلی آنا (Breast Changes): جب حمل قرار پاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پستانوں میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ان کا سائز بڑھنے لگتا ہے، اس میں دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پستانوں کے نپلز میچور ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات حمل کے علاوہ بھی درج ذیل وجوہات کی بناء پر پستانوں میں حمل جیسی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہے۔

(Hormonal Disturbances)	ہارمون کے نظام میں خرابیاں واقع ہونے سے۔	☆.....
(Breast Cyst)	پستانوں میں کسی سسٹ کے بننے سے۔	☆.....
(Breast Tumour)	پستانوں کے اندر کسی رسولی کے بننے سے۔	☆.....
(Reproductive Organs Cyst)	تولیدی نظام میں کسی سسٹ کے بننے سے۔	☆.....
(Reproductive Organs Tumour)	نظام تولید کی رسولی کی وجہ سے۔	☆.....
(Diseases Of Breasts)	پستانوں کی مختلف امراض میں۔	☆.....

صبح کی متلی (Morning Sickness): صبح کے وقت متلی کا ہونا حمل کی بہت بڑی علامت ہے جو حمل قرار پانے کے بعد اکثر عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں میں قے بھی آتی ہے۔ اس علامت کی شدت کا انحصار عورت کے نازک مزاج ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ علامت حمل کی علامات میں سے ایک ہے لیکن ایسا کئی اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ حمل بالکل نہ ہو ایسا درج ذیل باتوں میں ایسا ہو سکتا ہے؛

(Gastric Disturbance)	ہضم کی خرابی سے ایسا ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Headache)	سر درد کے باعث متلی ہو سکتی ہے۔	☆.....
(Gastritis)	معدہ کی سوزش سے ایسا ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Biliary Colic)	پتہ کے تونج میں متلی ہو سکتی ہے۔	☆.....
(Renal Colic)	گردے کی درد میں ایسا ہو سکتا ہے۔	☆.....
(Acute Infection)	ایکیوٹ انفیکشن میں یہ حالت ہو سکتی ہے۔	☆.....
(Abdominal Worms)	پیٹ کے کیڑوں سے متلی ہو سکتی ہے۔	☆.....
(Migrain)	درد شقیقہ یعنی مائیگرن متلی پیدا کر سکتا ہے۔	☆.....
(Use Of Medicines)	ادویاتی استعمال میں ایسا ہو سکتا ہے۔	☆.....

پیٹ کے سائز کا بڑھنا (Enlargement Of Abdomen): حمل کے قرار پانے کے بعد جیسے جیسے ایمریو کا سائز بڑھتا ہے اور پھر وہ فیٹس کے مرحلے میں بڑھتا ہے تو اس کی مناسبت سے پیٹ کا سائز بڑھنے لگتا ہے لیکن حمل کے علاوہ بھی دیگر کئی وجوہات سے پیٹ کا سائز بڑھ سکتا ہے۔

☆.....	مونایا کی وجہ سے پیٹ کا سائز بڑھ سکتا ہے۔	(Obesity)
☆.....	آنتوں کی سوزش سے پیٹ بڑھ سکتا ہے۔	(Infection Of Intestine)
☆.....	زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ سکتا ہے۔	(Over Eating)
☆.....	پیٹ میں پانی پڑنے سے اس کا سائز بڑھ سکتا ہے۔	(Oedema Abdomen)
☆.....	ورزش نہ کرنے سے پیٹ بڑھ سکتا ہے۔	(Lack Of Exercise)
☆.....	مرغن اور چربی غذا کے استعمال سے۔	(Fat Riched Food)
☆.....	پیٹ کے اندر رسولی بننے کی وجہ سے۔	(Abdominal Tumour)
☆.....	یوٹرائن فائبرائیڈز کی وجہ سے پیٹ بڑھ سکتا ہے۔	(Utrine Fibroids)

رحم میں تبدیلیاں واقع ہونا (Changes In Uterus): استقرار حمل کے بعد یوٹرس میں بچے کی نشوونما کے لئے مسلسل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس میں پھیلاؤ آتا ہے، حرکات محسوس ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح کی حالت دیگر وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہیں مثلاً؛

☆.....	یوٹرائن فائبرائیڈز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔	(Fibroid of Uterus)
☆.....	یوٹرائن سسٹ بننے سے ایسا ہوتا ہے۔	(Uterine Cyst)
☆.....	اینڈومیٹریٹس کی سوزش سے یوٹرس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔	(Endometritis)
☆.....	یوٹرس میں پیپ پڑنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔	(Pyometritis)
☆.....	سرویکس کی سوزش یوٹرس میں تبدیلی لا سکتی ہے۔	(Cervicitis)
☆.....	اوورین سسٹ ایسا کر سکتی ہے۔	(Ovarian Cyst)

پیشاب کی کثرت (Polyuria): دوران حمل رحم کے پھیل جانے سے مثانہ پر دباؤ آتا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بعض امراض میں بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے مثلاً؛

(Cystitis)	☆.....	مثانہ کی سوزش سے پیشاب کی کثرت ہو سکتی ہے۔
(Bladder Stone)	☆.....	مثانہ کی پتھری سے پیشاب بار بار آ سکتا ہے۔
(Bladder Cyst)	☆.....	مثانہ کے اندر سٹ بننے سے ایسا ہو سکتا ہے۔
(Nephritis)	☆.....	گردوں کی سوزش سے ایسا ہو سکتا ہے۔
(Diuretic Drugs)	☆.....	پیشاب لانے والی ادویات کے استعمال سے۔

جسمانی نظاموں کی تبدیلیاں (Changes In Body Systems): جب فریٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو رحم کے اندر بچے کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عورت کے تولیدی اعضاء میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر دیگر نظاموں میں بھی تبدیلی آتی ہے یہ جسمانی نظاموں کی تبدیلیاں بھی دراصل بچے کیلئے ہوتی ہیں اور اس کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ہوتی ہیں تاکہ وہ رحم مادر سے اپنا محدود وقت گزار کر دنیا کی رعنائیوں میں آ سکے۔ مختلف نظاموں میں درج ذیل تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں؛

(Hormonal Changes)	☆.....	ہارمون کے نظام کی تبدیلیاں۔
(Changes In Vagina)	☆.....	ویجائنا کی تبدیلیاں۔
(Changes In Uterus)	☆.....	یوٹرس کی تبدیلیاں۔
(Changes In Breasts)	☆.....	پستانوں کی تبدیلیاں۔
(Changes In Skeleton)	☆.....	ڈھانچہ کی تبدیلیاں۔
(Changes In Digestive System)	☆.....	نظام انہضام کی تبدیلیاں۔
(Changes In Respiratory System)	☆.....	نظام تنفس کی تبدیلیاں۔
(Changes In Cardio Vascular System)	☆.....	نظام خون کی تبدیلیاں۔
(Changes In Skin)	☆.....	جلد کی تبدیلیاں۔
(Changes In Body Weight)	☆.....	جسمانی وزن میں تبدیلی۔

☆..... ہارمون کے نظام کی تبدیلیاں (Hormonal Changes): جسم کے اندر ہارمونز کا ایک مکمل نظام کام کرتا ہے، دوران حمل اس نظام میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔

☆..... ایسٹروجن (Oestrogen): حمل قرار پانے کے بعد کارپس لیوٹم کا کام کمزور پڑ جاتا ہے جس کے باعث پلے سینا ایسٹروجن ہارمون کا اخراج کرتا ہے۔ یہ خارج ہونے والا ہارمون پستان اور یوٹرس میں واقع ہونے والی تبدیلیوں میں کام آتے ہیں۔

☆..... پروجسٹران (Progesterone): یہ ہارمون حمل قرار پانے کے 12 ہفتے بعد پیدا ہونے لگتا ہے اور یہ بہت سی تبدیلیوں میں حصہ لیتا ہے۔

☆..... ایچ۔سی۔ جی ہارمون (H.C.G. Hormone): اس کا اخراج حمل کے آغاز میں ہوتا ہے اور بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے۔

☆..... ایچ۔پی۔ ایل (H.P.L): جب H.C.G ہارمون کم ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونے لگتا ہے یہ دوران حمل گلوکوز کے میٹابولزم میں حصہ لیتا ہے۔

☆..... پچوٹری ہارمونز (Pituitary Hormones): یہ ہارمون حمل کے دوران اہم کام کرتے ہیں۔ مختلف ہارمونز کے اخراج کو اعتدال پر رکھتے ہیں۔ اس کا خاص حصہ بڑھ کر ہارمونز کی کارکردگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی کارکردگی سے ولادت کے وقت آکسی ٹوسن (Oxytocin) پیدا ہو کر اور یوٹرس کو سکیز کر بچے کی ولادت کو آسان بناتے ہیں۔

☆..... وِجائنا کی تبدیلیاں (Changes in Vagina): حمل قرار پانے کے بعد وِجائنا میں درج ذیل تبدیلیاں آنے لگتی ہیں؛

1	وِجائنا کی اپی تھیلیئم (Epithelium) میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
2	وِجائنا کے اندر موجود خون کی نالیاں زیادہ ابھرتی ہیں۔
3	وِجائنا کے اندر سے بعض اوقات مخصوص رطوبت خارج ہوتی ہے۔
4	دوران حمل وِجائنا کے اندر باقاعدہ پھڑکن محسوس کی جاسکتی ہے۔
5	وِجائنا کی میوکس ممبرین کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے یہ جامنی رنگ کی ہو جاتی ہے۔
6	وِجائنا کے اندر اس کی عضلاتی تہہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
7	وِجائنا کی پلک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کافی حد تک پھیل سکتی ہے۔
8	وِجائنا کی اندر کی تیزابی حالت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

☆.....رحم کی تبدیلیاں (Changes in Uterus): حمل قرار پانے کے بعد یوٹرس کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے اہم تبدیلیاں آتی ہیں۔ اعطائے تولید میں یوٹرس کو سب سے بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس میں دوران حمل درج ذیل تبدیلیاں آتی ہیں۔

1	رحم میں حمل قرار پانے کے بعد اس کی تہہ اینڈومیٹریئم ڈیسی ڈوالمیں تبدیل ہو جاتی ہے۔
2	اس ڈیسی ڈوالمیں تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر زائیکوٹ چپک جاتا ہے اور نشوونما کے مراحل طے کرتا ہے۔
3	یہ ڈیسی ڈوالمبتدائی طور پر بلاسٹوسٹ کوگلائی کو جن فراہم کرتی ہے۔
4	رحم کی درمیانی تہہ جو مایومیٹریئم کہلاتی ہے اس میں بھی واضح تبدیلیاں آتی ہیں۔
5	مایومیٹریئم کے موٹا ہونے سے رحم کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
6	یوٹرس کی بیرونی تہہ پیری میٹرم کہلاتی ہے اس نے تمام یوٹرس کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے اور یہ یوٹرس کے پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔
7	یوٹرس کی گردن سرویکس اہم کام کرتی ہے۔ یہ یوٹرس کو ہر طرح کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔
8	سرویکس کی وجہ سے حمل برقرار رہتا ہے۔
9	سرویکس سے ایک گاڑھی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو گردن پر پلگ کا کام کرتی ہے اور یوٹرس انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔
10	حمل کے آخری دنوں میں یوٹرس کی گردن نرم ہو جاتی ہے اور بچہ یا آسانی ڈلیور ہو جاتا ہے۔

☆.....رحم کے سائز میں حمل کے بعد درج ذیل اضافہ ہو جاتا ہے۔

اعشاریہ	حمل سے قبل	حمل کے بعد
Lenght	7.5 CM	30.0 CM
Width	5.0 CM	23.0 CM
Depth	2.5 CM	20.0 CM
Weight	60-70 GM	400 GM

☆..... پستانوں کی تبدیلیاں (Changes In Breasts): حمل کے دوران پستانوں میں درج ذیل تبدیلیاں آتی ہیں؛

1	حمل کے آٹھویں ہفتے میں پستانوں کا سائز بڑھنے لگتا ہے۔
2	پستانوں کے نیپلز بڑھ کر بڑے ہو جاتے ہیں۔
3	نیپلز کے گرد امیریولا گہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ گہرے بھورے یا سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔
4	پستانوں کے اندر خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔
5	پستان پر موجود رگیں پھول جاتی ہیں۔
6	حمل کے آخری مرحلہ پر دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
7	پستانوں کے گلینڈ یولرٹشوز (Glandular Tissues) میں اضافہ ہوتا ہے۔
8	پستانوں کے اندر ایک تناؤ کی حالت آ جاتی ہے۔
9	تیسرے مہینے میں پستان کے نیپلز دبانے سے رطوبت سی خارج ہوتی ہے جسے کولاسٹرم (Colostrum) کہتے ہیں۔
10	حمل کے آخر میں پستان بچے کو دودھ پلانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔

☆..... ڈھانچے کی تبدیلیاں (Changes In Skeleton): حمل قرار پانے کے بعد حاملہ کے ڈھانچے میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں؛ یہ تبدیلیاں بچے کی پیدائش سے متعلق ہوتی ہیں؛

1	حمل کے آخر میں پیلوس میں بچے کی پیدائش کیلئے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔
2	حمل کے آخر میں پیلوس میں پروجسٹران کام کرتا ہے۔
3	سیمنفی سس پبلس (Symphysis Pubis) نرم ہو جاتی ہے۔
4	کاکس (Coccyx) عقبی جانب ہٹ جاتی ہے۔
5	اس تبدیلی کے باعث ولادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

☆..... نظام انہضام کی تبدیلیاں (Changes In Digestive System): دوران حمل انہضام میں درج ذیل تبدیلیاں آتی ہیں:

1	دوران حمل لعاب دہن کی پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے۔
2	حمل قرار پانے سے متلی اور قے ہوتی ہے، بالخصوص صبح کو متلی ہوتی ہے۔
3	حمل کے دوران مرچ مصالحہ والی اور ترش اشیاء کھانے کو جی چاہتا ہے۔
4	دوران حمل عجیب و غریب اشیاء کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے جیسے مٹی، گاجی، پنسل کاسک، کوئلہ وغیرہ۔
5	حمل کے دوران منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
6	بعض حاملہ عورتوں کو قبض بھی ہو جاتی ہے۔
7	بعض حاملہ عورتوں میں سینے کی جلن پیدا ہو جاتی ہے۔
8	نظام انہضام کی تبدیلی بعض اوقات مسوڑھوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

☆..... نظام تنفس کی تبدیلیاں (Changes In Respiratory System): حمل کی وجہ سے نظام تنفس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔

1	حمل کے آخری دنوں میں نظام تنفس میں وقت پیدا ہو جاتی ہے۔
2	گیسوں کے تبادلے کا نظام متاثر ہو جاتا ہے اور حاملہ کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔
3	ہارمونز کی تبدیلی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کر کے آکسیجن کو بڑھا دیتی ہے۔
4	حاملہ میں تکسیر کا عارضہ بھی ہو سکتا ہے۔
5	بعض حاملہ عورتوں میں ناک بند ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے۔

☆..... نظام خون کی تبدیلیاں (Changes In Cardio Vascular System): دوران حمل نظام دوران خون میں بہت سی

تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

1	دل کا کام بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ بعض حالتوں میں عارضی طور پر دل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔
2	خون کا دورانیہ بھی متاثر ہوتا ہے، دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ یوٹرس کی جانب دوران خون بڑھ جاتا ہے۔
3	یوٹرس کی طرف جانے والے خون کا کچھ حصہ پلے سینا کی طرف بھی جاتا ہے۔
4	خون کے اندر سے فیشس کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔

5	بعض اوقات حاملہ کی خون کا شکار ہو جاتی ہے۔
6	حاملہ عورتوں میں بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے۔
7	عورتوں میں بلڈ پریشر کم اور بعض میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔
8	دوران حمل جسم RBCs کی مقدار بڑھالیتا ہے تاکہ ماں اور بچے کی ضروریات پوری ہو سکیں RBCs سے فیس کو آکسیجن ملتی ہے۔
9	WBCs میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس سے جسم کے مدافعتی نظام میں اضافہ ہوتا ہے اور ماں و بچہ امراض سے بچے رہتے ہیں۔
10	پلازما کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے۔
11	دوران حمل فولاد کی ضرورت ہوتی ہے حمل کے آخری دنوں میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے تاکہ بچے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔
12	دوران حمل خون جمنے کا وقت (Clotting Time) کم ہو جاتا ہے۔ یہ وقت 12 منٹ سے کم ہو کر 8 منٹ تک رہ جاتا ہے۔

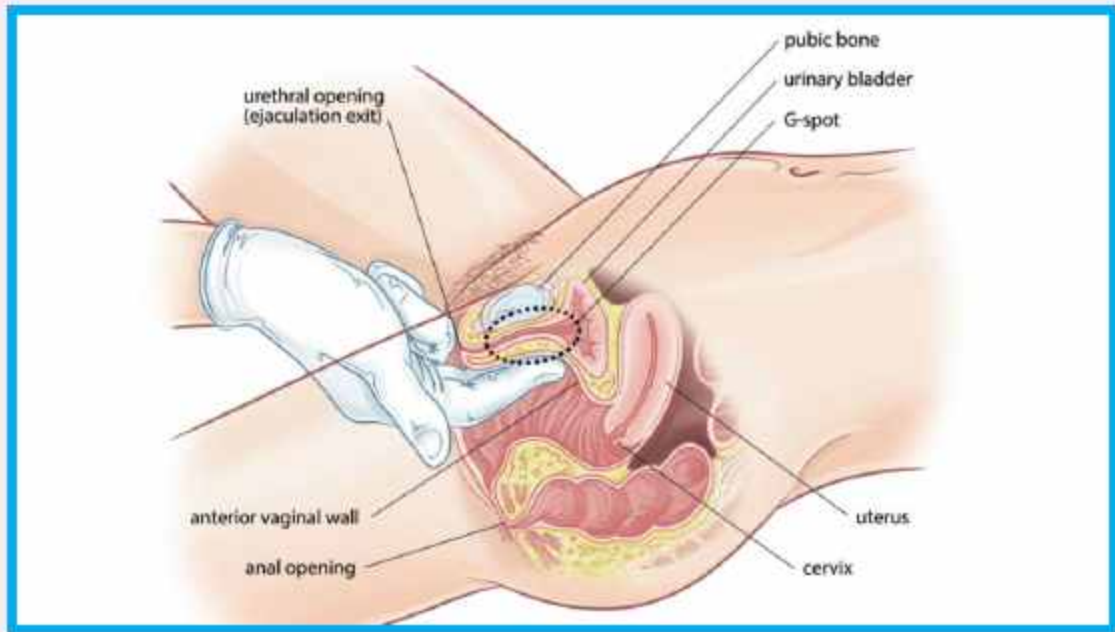
☆.....چلد کی تبدیلیاں (Changes In Skin):

1	چلد کی رنگت متاثر ہوتی ہے چلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔
2	بعض عورتوں کے چہرے پر بھورے داغ بن جاتے ہیں۔ چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔
3	چلد کی تبدیلی ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
4	بیرونی جنسی اعضاء کی رنگت بدل جاتی ہے۔
5	پیٹ پر لکیریں بن جاتی ہیں۔
6	حاملہ عورت میں پسینہ کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔

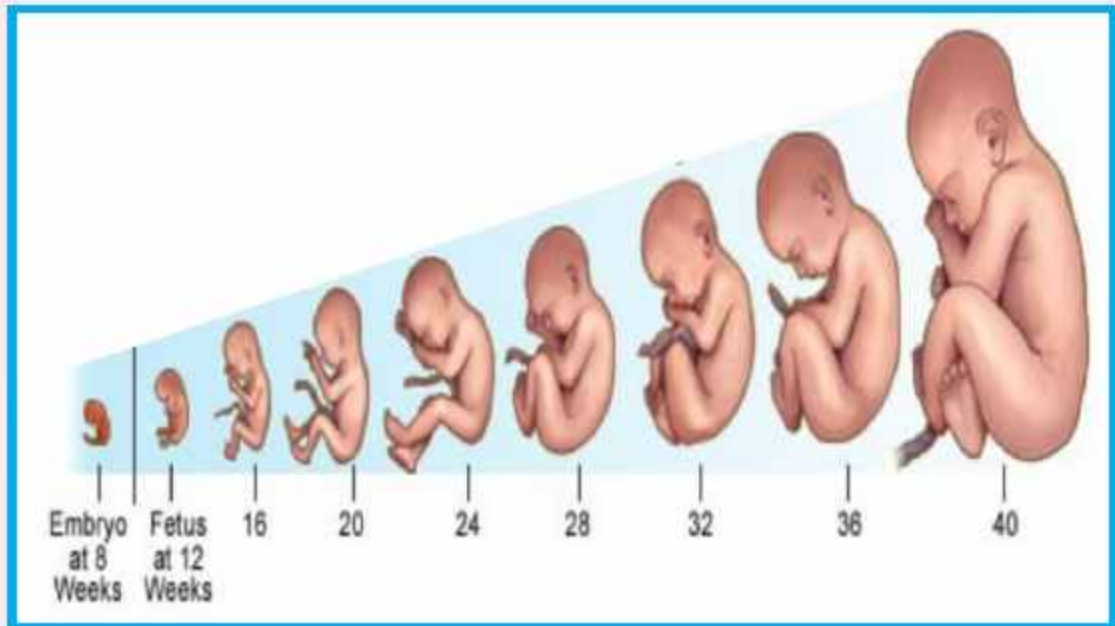
☆.....جسمانی وزن میں تبدیلی (Changes In Body Weight): جیسے جیسے عورت کے یوٹرس میں زائیکوٹ سے ایمبریو اور پھر فٹس بڑھتا جاتا ہے اور اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حاملہ کا جسمانی وزن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے لئے مخصوص فارمولا نہیں ہے لیکن ایک اوسط اندازہ درج ذیل ہے:

1	حمل کے پہلے 20 ہفتوں میں 2 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔
2	20 ہفتوں کے بعد ہر ہفتہ 1/2 کلو وزن بڑھتا ہے۔
3	حمل کے آغاز سے آخر تک عورت کے جسمانی وزن میں تقریباً 12 کلو کا اضافہ ہو جاتا ہے۔





Vaginal Examination



Fetal Growth from 8 to 40 weeks

ملٹی پل حمل

(MULTIPLE PREGNANCY)

تعارف (Introduction): ایسے بھی ہوتا ہے کہ استقرار حمل کے دوران ایک سے زیادہ زائگوٹ بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے یوٹرس کے اندر ایک سے زیادہ فیٹس نشوونما پاتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ جنین کا حمل (Multiple Pregnancy) کہلاتا ہے۔ اس طرح کے حمل میں عام طور پر دو بچے ہوا کرتے ہیں لیکن بعض اوقات خاص حالات میں یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر حاملہ عورت کے یوٹرس میں دو بچے ہوں تو یہ ٹوئن پریگننسی (Twin Pregnancy) کہلاتی ہے۔

تشخیص (Diagnosis): اس طرح کے حمل کی تشخیص کیلئے بہت سے طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں؛

☆..... **ٹوئل کر (Plapation):** یہ ٹوئل کر پیٹ کے حالات معلوم کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر یا L.H.V ٹنولنے کے طریقہ سے اس طرح کے حمل کا معلوم کر لیتی ہے لیکن اس کیلئے انتہائی مہارت بہت ضروری ہے۔

☆..... **نظری معائنہ (Inspcetion):** دوران حمل معمول کے معائنہ کے دوران بھی اس طرح کے جزواں حمل کا علم حاملہ کے یوٹرس اور پیٹ کے انتہائی بڑھے ہوئے سائز سے ہو جایا کرتا ہے۔

☆..... **الٹراسونوگرافی (Ultrasonography):** حاملہ کے الٹراساؤنڈ سے اس بات کا یقینی علم ہو جاتا ہے کہ حمل کتنے جنین کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جنس بھی معلوم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی اینارملٹی کا علم بھی ہو جاتا ہے۔

☆..... **ایکسرے (X-Ray):** ایکسرے کے ذریعے بھی یوٹرس میں بچوں کی تعداد معلوم ہو جاتی ہے لیکن ایکسرے ایک نقصان دہ طریقہ ہے۔

☆..... **آسکل ٹیشن (Auscultation):** آسکل ٹیشن بذریعہ فیتو سکوپ بچے کے دل کی آواز سننے کا عمل ہے۔ ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر اس طرح کے معائنہ کے دوران یہ معلوم کر لیتی ہے کہ رحم میں ایک سے زیادہ جنین موجود ہیں۔



جڑواں حمل کی اقسام (KINDS OF TWIN PREGNANCY)

تعارف (Introduction): ایسا حمل جس میں رحم کے اندر دو جنین ہوں جڑواں حمل کہلاتا ہے۔ یہ جڑواں حمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے اس میں ان کے استقرار حمل کے حوالہ سے فرق ہوتا ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام کا ذکر کر کے ان کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

یونی اوویولر ٹوئنز (UNI-OVULAR TWINS):

1	اس طرح کا حمل مونوزائیگوٹ (Monozygot) قسم کے جڑواں بچوں کا حمل کہلاتا ہے۔
2	اس طرح کے حمل میں موجود بچوں کی اشکال ایک جیسی ہوتی ہیں بے شک وہ لڑکے ہوں لڑکیاں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوں۔
3	اس طرح کے استقرار حمل میں زائیگوٹ بننے کے بعد وہ قدرتی طور پر تقسیم ہو کر دو بن جاتے ہیں اور اس طرح دو جنین نشوونما پاتے ہیں
4	اس قسم کے حمل میں بچوں میں ایک ہی کوریان (Chorion) ہوتا ہے۔
5	اس طرح کے حمل میں ایمینیان (Amnion) دو ہوتے ہیں۔
6	اس طرح کے حمل میں دونوں بچوں کی پلے سینا ایک ہی ہوتی ہے۔
7	جنین کی جنس کا کوئی فارمولہ نہیں بلکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔
8	عموماً اگر دوران پیدائش یا بعد میں ایک مرجائے تو دوسرا بھی مرجاتا ہے۔ اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا بھی بیمار ہو جاتا ہے۔

بائی اوویولر ٹوئنز (BI-OVULAR TWINS):

1	یہ جڑواں حمل ڈائی زائیگوٹ (Dizygot) قسم کا جڑواں حمل ہوتا ہے۔
2	اس میں استقرار حمل کے دوران الگ الگ سپرم اور اوومل کرووزائیگوٹ بنتے ہیں اور الگ الگ نشوونما پاتے ہیں۔
3	اس طرح کے جڑواں بچوں کی اشکال ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔
4	اس طرح حمل میں کوریان (Chorion) الگ الگ ہوتے ہیں۔
5	اس طرح کے جڑواں حمل میں ایمینیان (Amnion) دو ہوتے ہیں۔
6	اس طرح کے جڑواں حمل میں پلے سینا الگ الگ ہوتی ہیں۔
7	ان کی جنس ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔
8	یہ جڑواں رہتے تو اکٹھا ہیں لیکن تمام اشیاء الگ الگ ہوتی ہیں۔



ملٹی پل حمل کی اقسام

(KINDS OF MULTIPLE PREGNANCY)

تعارف (Introduction): ملٹی پل حمل سے مراد عورت کے یوٹرس میں ایک سے زیادہ جنین (Fetus) کا موجود ہونا ہے۔ ان کی تعداد 2 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ملٹی پل حمل کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

ٹوئن پرگ نیسی (Twin Pregnancy): یہ ایسا حمل ہوتا ہے جس میں یوٹرس کے اندر دو جنین (Fetus) ہوتے ہیں۔ انکی تفصیل ہم پہلے درج کر چکے ہیں، یہ حمل جزواں حمل کہلاتا ہے۔

ٹریپلٹس پرگ نیسی (Triplets Pregnancy): اس طرح کے حمل میں یوٹرس کے اندر تین جنین (Fetus) موجود ہوتے ہیں۔

کیوآڈرپلٹس پرگ نیسی (Quadruplets Pregnancy): اس طرح کے حمل میں یوٹرس کے اندر چار جنین موجود ہوتے ہیں۔

کیونٹوپلٹس پرگ نیسی (Quintuplets Pregnancy): اس طرح کے حمل میں یوٹرس کے اندر پانچ جنین (Fetus) ہوتے ہیں۔

اگر عورت کے یوٹرس میں دو جنین ہوں تو نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن اگر تین یا چار یا پانچ جنین ہوں تو نارمل ڈیلیوری ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اس طرح کی ڈیلیوری بذریعہ آپریشن سی سیکشن (Cesarean Section) ہوتی ہے۔



ملٹی پل حمل کی پیچیدگیاں

(COMPLICATIONS OF MULTIPLE PREGNANCY)

تعارف (Introduction): جب حمل ملٹی پل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حاملہ عورت کو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے حمل میں درج ذیل پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں:

استقاط (Abortion): اس طرح کے حمل میں ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یوٹرس اس طرح کے حمل کو سنبھال نہ سکے اور ابارشن ہو جائے۔ یوٹرس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اس طرح کے حمل کی نشوونما کر سکے تو پھر اس صورت میں ابارشن ہو سکتا ہے یوٹرس کی خرابی سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔

ایمنیا ٹک ممبرین کا پھٹ جانا (Rupture Of Amniotic Membrane): ایک سے زیادہ جنین کے حمل کی وجہ سے ایک پیچیدگی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبل از وقت ایمنیا ٹک ممبرین پھٹ سکتی ہے اور اسکے پھٹنے سے ایمنیا ٹک فلوئڈ بہہ جاتا ہے اور اسکی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور جنین کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔

ایمنیٹک فلوئڈ کی زیادتی (Poly Hydramnios): اگر کسی وجہ سے دوران حمل ایمنیٹک فلوئڈ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ بہت تشویش کی بات ہوتی ہے اور جب حمل بھی ایک سے زیادہ جنین کا ہو تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سے حاملہ عورت کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔

فیٹل اینارملٹی (Fetal Abnormality): جب حمل ایک سے زیادہ جنین کا ہوتا ہے تو ان کی مناسب نشوونما نہیں ہو پاتی اور اس نشوونما نہ ہونے سے جنین میں کوئی نہ کوئی جسمانی خرابی رہ جاتی ہے اور اس وجہ سے پیدا ہونے والے بچے نارمل نہیں ہوتے بلکہ ان میں نقصان رہ جاتے ہیں۔

جڑے ہوئے بچے (Conjoined Twins): یہ حمل کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں بچوں کے جسم کے کوئی دو حصے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور اس صورت میں نارمل ولادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لئے صرف بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے اور ولادت کے بعد ایسے بچوں کو ماہرانہ سرجری کے ذریعے سے الگ کر دیا جاتا ہے جبکہ ایسی صورت میں بچے مر بھی سکتے ہیں۔

جکڑے ہوئے بچے (Locked Twins): یہ حالت جڑے ہوئے بچوں سے مختلف ہوتی ہے یہ بچے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ آپس میں پھنسے ہوتے ہیں یہ کسی پوزیشن میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ قسم کی پیچیدگی ہوتی ہے۔ اس حالت میں نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، آپریشن ضروری ہوتا ہے اور آپریشن کے بعد ان جکڑے ہوئے بچوں کو الگ کر لیا جاتا ہے۔

لیبر میں تاخیر (Prolonged Labour): ایک سے زیادہ بچوں کے حمل کی وجہ سے لیبر کا مرحلہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور یہ طوالت زچہ بچہ دونوں کیلئے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس میں یوٹرس کے افعال میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

امبالائیکل کارڈ کا باہر آ جانا (Prolapes Of Umbilical Cord): اس طرح کے حمل میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے امبالائیکل کارڈ پروپرس ہو جائے یعنی باہر نکل آئے اور یہ ایک خطرناک صورت ہوتی ہے۔

پلے سینٹا کا قبل از وقت اخراج (Prematuer Expulsion Of Placenta): قدرتی عمل یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد پلے سینٹا کا اخراج ہو لیکن کسی پیچیدگی کی وجہ سے پلے سینٹا کا اخراج قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے عمل میں اس طرح کی حالت پیدا ہو جائے تو بہت بڑی پیچیدگی سامنے آ سکتی ہے۔ اس سے بچے کی جان کو بہت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔

بعد از ولادت جریان خون (Post Partum Haemorrhage): اس طرح کے زیادہ جنین والے حمل میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ حاملہ کو بعد از ولادت جریان خون بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جریان خون بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اس سے زچہ کی جان بھی جاسکتی ہے۔



جڑواں حمل کی احتیاط

(CARE DURING TWIN PREGNANCY)

تعارف (Introduction): اگر حمل جڑواں بچوں کا ہو تو پھر اس کی احتیاط بھی نارمل حمل سے زیادہ کی جاتی ہے۔ ایسی صورت حال میں مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے:

1	ڈاکٹر کے مشورے سے غذائی چارٹ تیار کروا کر غذا استعمال کروائیں تاکہ مناسب غذا کی وجہ سے بچوں کی درست نشوونما ہو۔
2	حاملہ کو متوازن اور پروٹین، وٹامن، فولاد والی غذائیں استعمال کروائیں۔
3	حاملہ کو زیادہ سے زیادہ آرام کروائیں اور اسے بے جا سفر نہ کرنے دیں۔
4	حاملہ گھر کے نارمل کام تو کرے لیکن وزن کا کام ہرگز نہ کرے۔
5	حاملہ کیلئے مناسب ماحول اور لباس وغیرہ کا خاص رکھنا چاہیے۔
6	حاملہ کی نیند پر سکون ہونی چاہئے اور اسے سوتے وقت ایک گلاس نیم گرم دودھ کا دینا چاہیے۔
7	حاملہ کو روزانہ صبح یا شام کے وقت مناسب چہل قدمی کرنے کی ہدایت کی جائے۔
8	حاملہ کو غم، فکر، ٹینشن، ڈپریشن، خوف اور پریشانی سے دور رکھنا چاہیے۔
9	حاملہ کو دوران حمل آرام دہ ڈھیلے کپڑے استعمال کروانا چاہیے۔
10	حاملہ کو آرام دہ اور ایڑھی کے بغیر جوتی کے استعمال کا مشورہ دینا چاہیے۔
11	سردی کا موسم ہو تو حاملہ کو روزانہ چند منٹ دھوپ میں بیٹھنے کا مشورہ دیں اس سے وٹامن D حاصل ہوتا ہے۔
12	کسی بھی پیچیدگی یا بیماری کی صورت میں کوالیفائیڈ مستند لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور عطائیوں سے بچیں۔



نارمل فل ٹرم بچہ

(NORMAL FULL TERM BABY)

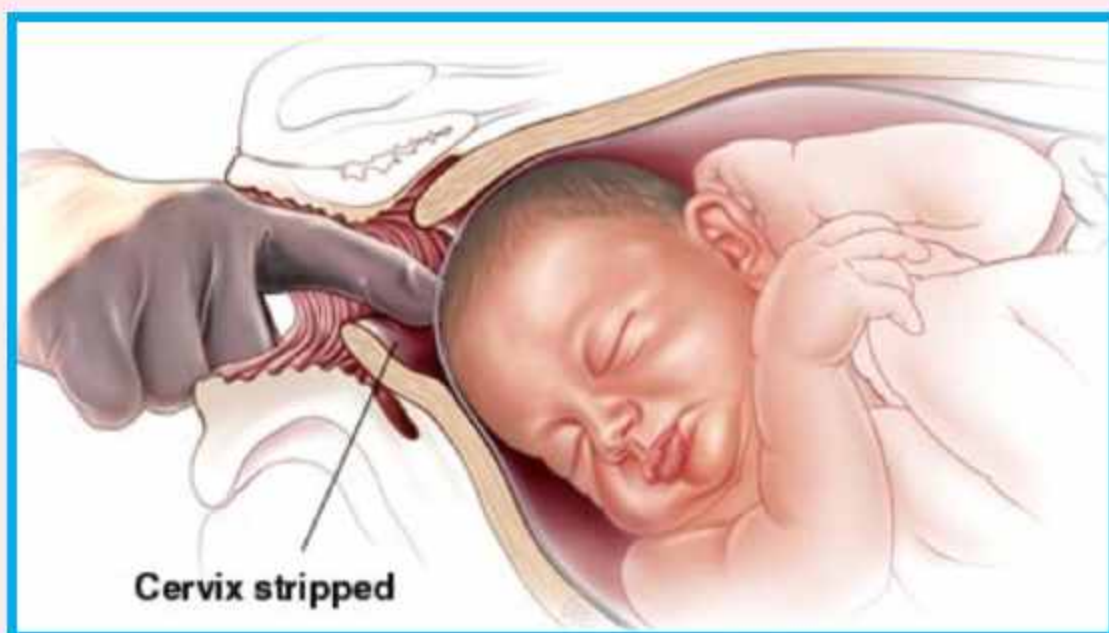
تعارف (Introduction): وہ بچہ جو حمل کا دورانیہ بغیر کسی پیچیدگی کے بخیر و خوبی گزار کر نارمل ڈیلیوری کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، نارمل فل ٹرم بچہ کہلاتا ہے۔ ایسا پیدا ہونے والا بچہ بالکل نارمل اور صحت مند ہوا کرتا ہے اور ایسے بچے میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں؛

1	پیدائش کے وقت ایک نارمل بچے کا وزن ساڑھے تین کلوگرام ہوتا ہے۔
2	پیدائش کے وقت ایک نارمل بچے کا قد تقریباً 50 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔
3	پیدائش کے وقت ایک نارمل بچے کے دل کی رفتار 120 سے 140 فی منٹ ہوتی ہے۔
4	پیدائش کے وقت ایک نارمل بچے کے سانس کی رفتار تقریباً 30 سے 40 فی منٹ ہوتی ہے۔
5	پیدائش کے وقت بچے کے معدہ کی گنجائش تقریباً 30 ملی لیٹر ہوتی ہے۔
6	پیدائش کے بعد ایک نارمل بچے کا میکونیم 24 گھنٹے میں خارج ہو جاتا ہے۔
7	پیدائش کے بعد 72 گھنٹے کے اندر معدہ صاف ہو جاتا ہے۔
8	پیدائش کے بعد بچے کا درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے۔
9	پیدائش کے بعد بچے کے دیکھنے کی ریٹج چند سینٹی میٹر ہوتی ہے جو بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے۔
10	پیدائش کے بعد بچہ چند دنوں میں ارد گرد کی آوازیں سننے لگتا اور ماحول کو پہچاننے لگتا ہے۔





Abdominal Striae In Full Term Pregnancy



Head Palpation During Labour

حمل کی ممکنہ پیچیدگیاں

(COMPLICATIONS OF PREGNANCY)

تعارف (Introduction): حمل ٹھہرنا ایک قدرتی عمل ہے، بسا اوقات حمل کے دوران کچھ ایسی علامات اور نشانیوں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن سے حاملہ اور بچے دونوں کی صحت کے نقصان کا زیادہ احتمال ہوتا ہے لہذا ایسی علامات و نشانیوں کا پہلے ہی سے تدارک کر لینا چاہیے، نہیں تو یہی علامات بڑھ کر کسی پیچیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ حالت حمل میں جو بیماریاں یا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں یا بڑھ کر پیچیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں وہ ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں:

1۔ صبح کی متلی (Morning Sickness): کئی حاملہ عورتوں میں حمل ٹھہر جانے کے بعد دوسرے ماہ سے متلی و قے کا رجحان ہو جاتا ہے جو کہ عام طور پر تیسرے ماہ کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کئی حاملہ عورتوں میں ہلکی غذا کے استعمال سے بھی متلی و قے کا رجحان کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی متلی اور قے انتہائی شدت اختیار کر جائیں تو حاملہ اور حمل دونوں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اور حاملہ کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو سکتی ہے ایسی صورت میں بذریعہ ورید ڈرپ لگا کر حاملہ کی اس پیچیدگی کو بروقت کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اگر حاملہ کی یہی متلی و قے انتہائی صورت اختیار کر جائے تو اس کنڈیشن کو ہائپر ایمی سس گریوی ڈیوم (Hyperemesis Gravidivum) کہتے ہیں۔

2۔ سینے کی جلن (Heart Burning): حمل کے دوران اکثر حاملہ عورتیں معدے یا سینے میں جلن کی شکایت کرتی ہیں جو کہ حمل کے آخری دنوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ معدے و سینے میں جلن کی وجہ سے معدے میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ غذا کی نالی ایسوفیگس میں داخل ہو کر جلن کا باعث بنتا ہے، ایسی صورت میں ٹھنڈے دودھ اور اینٹاسیڈز دواؤں سے اس پیچیدگی کا علاج ممکن ہے۔

3۔ قبض (Constipation): دوران حمل قبض کا ہو جانا بھی ایک عام شکایت ہے، مستقل قبض حاملہ عورت کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے لہذا ایسی صورت میں حاملہ کو ہلکی پھلکی غذا کے استعمال سے، بزیوں، پھل اور فروٹ کے استعمال سے یا اسپغول کے چھلکے کے استعمال سے قبض کو دور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ادویات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے اور قبض کو قدرتی طریقوں سے ٹھیک ہونے کا موقع دینا چاہیے۔

4۔ اسہال (Diarrhoea): بسا اوقات کسی بھی وجہ سے حاملہ عورتوں میں اچانک اسہال کی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ کھانے پینے کی بد احتیاطی یا جراثیموں کے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسہال کی بیماری میں حاملہ پانی اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ پیچیدگی کے طور پر اس کا اپارشن بھی ہو سکتا ہے لہذا ابتداء ہی سے اسہال پر توجہ دینی چاہیے اور وقت پر مناسب علاج کرنا چاہیے۔

5۔ **بواسیر (Piles):** جو خواتین کسی بھی وجہ سے دوران حمل پیدل چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر قبض کا بھی شکار ہو جائیں تو عموماً حمل کے آخری دنوں میں بواسیر کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی حاملہ کو قبض دور کر نیوالی غذاؤں اور سیال اشیاء کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔

6۔ **اڈیما (Oedema):** حمل کے دوران کئی عورتوں میں اڈیما کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ حاملہ عورتیں اکثر چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جانے کی شکایت کرتی ہیں۔ ایسا عموماً حاملہ کے خون کے پتلا ہو جانے یا پھر بلڈ سرکولیشن میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بہر صورت حاملہ کے اس اڈیما کو تشخیص کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے اور پیشاب کے علاوہ اس کے دوسرے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی کئے جاتے ہیں تاکہ اڈیما کی اصل وجوہات معلوم کر کے اس کا بروقت صحیح طور پر علاج کیا جائے۔

7۔ **ٹانگوں کی وریدوں کا پھولنا (Varicose Veins):** کئی حاملہ عورتوں میں حمل کے آخری دنوں میں ٹانگوں کی وریدیں پھول جاتی ہیں جسکی عام وجہ بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی واقع ہو جانا ہے۔ ٹانگوں کی وریدیں پھول جانے کے بعد ان میں اڈیما اور سوجن و درد بھی ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک کھڑا ہونے یا پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے پرہیز کرے۔

8۔ **شرم گاہ کی خارش (Pruritis Vulvae):** کئی حاملہ عورتوں میں ویجائنہ کے راستے خارش وار رطوبتوں کا اخراج ہوا کرتا ہے جو کہ شرم گاہ کی خارش اور تکلیف کا باعث بنا کرتا ہے لہذا حاملہ کو چاہیے کہ وہ اپنی شرم گاہ کی صفائی کا خاص خیال رکھے تاکہ شرم گاہ کی یہ خارش مزید نہ بڑھنے پائے۔

9۔ **تھوک کی زیادتی (Excessive Ptyalism):** حمل کے دوران کئی حاملہ عورتیں تھوک کی کثرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے منہ کا ذائقہ بد مزہ ہو جاتا ہے اور وہ مرچ مصالحوں والی ترش و چٹ پٹی اشیاء کھانا پینا پسند کرتی ہیں۔

10۔ **مٹی کھانے کی خواہش (Mud Eatings):** حمل کے دوران کیلشیم کی کمی کے باعث کئی حاملہ عورتوں میں مضرت اشیاء مثلاً مٹی، گچی، چاک، کوئلہ وغیرہ کھانے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی مضرت اشیاء کھانے کے استعمال سے حاملہ عورت کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے اور خون کی کمی ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ حاملہ، حمل اور بچے سب کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

11۔ **نیند کی کمی (Insomnia):** حمل کے آخری مہینوں میں یوٹرس کا سائز بڑھ جانے اور مثانہ پردہ پاؤ پڑنے سے حاملہ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاملہ کو رات میں بھی بار بار پیشاب آتا ہے اور وہ صحیح طور پر اپنی نیند پوری نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ پیٹ میں موجود بچے کی حرکات کی وجہ سے بھی حاملہ گہری نیند نہیں سو سکتی اور یوں اس کی نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

12- خون کی کمی (Anaemia): حاملہ عورت کو روزمرہ خوراک میں آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے علاوہ بچے کے آئرن کی بھی ضرورت پوری کر سکے لیکن بسا اوقات غیر متوازن غذا کے استعمال سے غذا کی کمی، بھوک کی کمی اور اسہال کی بیماری کی وجہ سے حاملہ میں خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے اور ایسا عموماً ان حاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کئی بچوں کو جنم دے چکی ہوں۔



اسقاط حمل

(ABORTION)

تعارف (Introduction): حمل ٹھہر جانے کے بارہ ہفتوں کے بعد اور اٹھائیس ہفتوں سے پہلے اگر فیٹس یوٹرس میں مرجائے یا پھر یوٹرس سے خارج ہو جائے تو اسے اسقاط حمل یا حمل کا ضائع ہونا یعنی ابارشن (Abortion) کہا جاتا ہے۔

ابارشن کی وجوہات (Etiology): ابارشن کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں؛

1	کروموسومز کی وجہ سے زائیکوٹ کا صحیح نہ بننا۔
2	فیٹس کا ماں کی قوت مدافعت کے خلاف ری ایکشن کرنا۔
3	ماں کو لاحق بیماریوں مثلاً خسرہ، سفلس، ذیابیطس یا غیر متوازن غذا یا غذا کی کمی کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
4	یوٹرس کی خرابیوں مثلاً یوٹرس میں جھلی پیدا ہونے سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
5	یوٹرس میں رسولی یا کینسر کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
6	کئی ادویات کے استعمال مثلاً کوئینین، ارگٹ، زہریات یا پچوٹری ہارمون سے تیار کردہ ادویات کے استعمال سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
7	حادثاتی طور پر گر جانے سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
8	اچانک جذباتی دباؤ مثلاً ڈر، خوف، صدمہ، ذہنی و نفسیاتی دباؤ کے باعث بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
9	اینڈوکرائن ہارمونز کی کمی کی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔ خصوصاً پروجیسٹرون ہارمون کی کمی ابارشن کا باعث بن سکتی ہے۔
10	اسی طرح اگر ماں اور بچے کے خون کا آرائیج فیکٹر ایک دوسرے سے متضاد ہو تو بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔

11	وٹامن ای کی کمی وجہ سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔
12	خون کی کمی کی شکار عورتوں میں بھی ابارشن ہو جایا کرتا ہے۔
13	کئی بچوں کو جنم دینے والی ماؤں میں سرویکس کے ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے بھی ابارشن ہو جایا کرتا ہے۔
14	حاملہ عورت کو اگر بہت زیادہ قے و دست آئیں اور جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو جائے تو بھی اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔
15	یوٹرس کا کینسر بھی ابارشن کا باعث بن سکتا ہے۔
16	سرویکس کا کینسر بھی ابارشن کا باعث بن سکتا ہے۔
17	اسی طرح دوران حمل وزن اٹھانے سے بھی ابارشن ہو سکتا ہے۔



ابارشن کی اقسام

(TYPES OF ABORTIONS)

تعارف (Introduction): ابارشن ایک غیر فزیو لاجیکل کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

1۔ **کاذب اسقاط حمل (Threatened Abortion):** ابارشن کی اس قسم میں اسقاط کا عمل تو شروع ہو جاتا ہے لیکن ضروری تدابیر اختیار کرنے اور بروقت کسی مستند ماہر اور کوالیفائیڈ لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینے پر اس اسقاط حمل کو روکا جاسکتا ہے۔

2۔ **لازمی اسقاط حمل (Inevitable Abortion):** ابارشن کی اس قسم میں ابارشن کا عمل تو شروع ہو جاتا ہے لیکن ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ادویات استعمال کر لینے پر بھی یہ اسقاط حمل ہو کر ہی رہتا ہے۔

3۔ **مکمل اسقاط حمل (Complete Abortion):** ابارشن کی اس قسم میں فیشس کے تمام اعضاء پلے سینا اور امبالائیگل کارڈ سب کچھ یوٹرس سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے اور یوٹرس بالکل خالی ہو جاتا ہے۔

4۔ **نا مکمل اسقاط حمل (Incomplete Abortion):** ابارشن کی اس قسم میں فیشس تو یوٹرس سے خارج ہو جاتا ہے لیکن پلے سینا یوٹرس کے اندر ہی رہ جایا کرتا ہے۔

5۔ عادی استقاط حمل (Habitual Abortion): ابارشن کی اس قسم میں حمل ٹھہرنے کے بعد بار بار استقاط حمل ہوتا ہے جس کی عمومی وجہ حاملہ میں وٹامن ای کی کمی، بروسیلا یا ٹاکسوپلازما کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔

6۔ معالجاتی استقاط حمل (Therapeutic Abortion): ایسی ابارشن جو کہ میڈیکل بنیاد پر ماں کی جان بچانے کے لئے کی جائے معالجاتی استقاط حمل کہلاتی ہے یہ ایک ایسا جائز استقاط حمل ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر حاملہ کی جان بچانے کیلئے کرتے ہیں کیونکہ بسا اوقات ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ حمل اور حاملہ دونوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے لہذا ایسی حالت میں ڈاکٹر بچے کی قربانی دے کر ماں کی جان بچانے کیلئے حمل کو ساقط کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے معالجاتی استقاط حمل (Therapeutic Abortion) کہتے ہیں۔

7۔ مجرمانہ استقاط حمل (Criminal Abortion): ایسی ابارشن جو کہ جان بوجھ کر کی جائے اور حالات اس قسم کے ابارشن کی اجازت نہ دیں، مجرمانہ استقاط حمل کہلاتی ہے۔ ایسا ابارشن عموماً حمل کو چھپانے یا پیدا ہونے والے بچے سے جان چھڑانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

8۔ حادثاتی استقاط حمل (Accidental Abortion): ایسی ابارشن جو اچانک کسی حادثے کے نتیجے میں ہو جائے حادثاتی استقاط حمل کہلاتی ہے

9۔ عفنی ابارشن (Septic Abortion): ایسی ابارشن جو کہ یوٹرس کے انفیکشن کے باعث ہو جائے، سپٹک ابارشن کہلاتی ہے۔

10۔ مخفی استقاط حمل (Missed Abortion): ایسی ابارشن جس میں کسی بھی وجہ سے فیس یوٹرس کے اندر ہی مرجائے اور اسی مردہ حالت میں کئی ہفتوں تک یوٹرس کے اندر ہی رہے جبکہ حاملہ کو اس کا علم نہ ہو، مسڈ ابارشن یا مخفی ابارشن کہلاتی ہے۔

ابارشن کی علامات (Signs & Symptoms Of Abortion): جب کسی حاملہ کو ابارشن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں درج ذیل علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں:

1	مریضہ کو پیڑو کے مقام پر درد شروع ہو جائے گا۔	(Hypogastric pains)
2	مریضہ کی اندام نہانی سے خون کا اخراج شروع ہو جائے گا۔	(Vaginal bleeding)
3	مریضہ انیمیا کا شکار ہو جائے گی۔	(Anaemia)
4	نبض کی رفتار تیز ہو جائے گی۔	(Rapid pulse)
5	بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔	(Hypotention)

6	پیلوس میں دردیں ہوتی محسوس ہوں گی۔	(Pelvic pains)
7	جسمانی کمزوری محسوس ہوگی۔	(General weakness)
8	مریضہ کو حیض جیسی دردیں محسوس ہوں گی۔	(Menstrual like pains)
9	دیجائز کے ذریعے فیٹس پلے سینٹایا کارڈ کے حصوں کا اخراج ہوگا۔	(Vaginal expulsion of products)
10	مریضہ شاک میں جاسکتی ہے۔	(Shock may occur)



غیر قانونی اسقاط (CRIMINAL ABORTION)

تعارف (Introduction): یہ مصنوعی اسقاط کی ایک صورت ہے اور اس میں عورت کی رضامندی شامل ہوتی ہے لیکن یہ کسی قانونی اور جائز وجہ کے بغیر کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کو غیر قانونی یا مجرمانہ ابارشن (Criminal Abortion) کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل وجہ سے کیا جاتا ہے:

1	اگر کوئی کنواری لڑکی زنا کی وجہ سے حاملہ ہو جائے تو مجرمانہ اسقاط کروایا جاتا ہے۔
2	بیوی خاوند کے علاوہ کسی کے گناہ سے حاملہ ہو جائے تو گناہ کو چھپانے کیلئے اسقاط کروایا جاتا ہے۔
3	جائیداد کے جھگڑے میں وارث کم کرنے کیلئے غیر قانونی اسقاط کروایا جاتا ہے۔
4	بعض ماڈرن لوگ بچوں کی تعداد کم کرنے کیلئے مجرمانہ اسقاط کرواتے ہیں۔
5	ناجائز جنسی تعلقات چھپانے کیلئے بھی مجرمانہ اسقاط کروایا جاتا ہے۔
6	کسی عورت کا خاوند ملک سے باہر ہو اور وہ ناجائز طور پر حاملہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسقاط کروایا جاتا ہے۔
7	کسی کا خاوند نامرد ہو اور عورت کسی اور شخص سے حاملہ ہو جائے تو بھی جرم چھپانے کیلئے اسقاط کروایا جاتا ہے۔
8	کوئی بیوہ گناہ کر بیٹھے تو اس کو چھپانے کیلئے اسقاط کرواتا ہے۔



مجرمانہ اسقاط حمل کے طریقہ

(METHODS OF CRIMINAL ABORTION)

تعارف (Introduction): مجرمانہ اسقاط حمل چونکہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی فعل ہے لہذا عام طور پر ایسا مجرمانہ اسقاط حمل چھوٹی سطح پر ہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کیلئے عام طور پر درج ذیل دو طرح کے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں:

- (1) میکاکی طریقہ (Mechanical Method) (2) ادویاتی طریقہ (Medicinal Method)

(1) میکاکی طریقہ (Mechanical Method):

1	کسی ایسے راستے پر سفر کیا جاتا ہے جو ناہموار ہو اور وہاں جھپ لگیں اس طرح حمل ضائع ہونے کا چانس لیا جاتا ہے۔
2	زیادہ وزن اٹھا کر رُسہ کو دکر حمل ضائع کیا جاتا ہے۔
3	تیز گرم پانی اور تیز ٹھنڈے پانی میں باری باری نہا کر جسمانی رد عمل سے اسقاط کیا جاتا ہے۔
4	اندام نہانی یا سیون کے اندر جو نکلیں لگوا کر اسقاط کیا جاتا ہے۔
5	پیٹ کے نچلے حصہ میں سینگیاں لگوا کر اسقاط کی حالت پیدا کی جاتی ہے۔

(2) ادویاتی طریقہ (Medicinal Method):

1	غیر قانونی اسقاط حمل کیلئے مختلف ادویات کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔
2	ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو رحم پر اثر کر کے رحم کا منہ کھول دیتی ہیں مثلاً کونین ارگٹ، آکسی ٹوسن، متھر جن، ارگٹ وغیرہ۔
3	مذکورہ ادویات کو اصل مقدار سے زیادہ استعمال کر کے اسقاط کی حالت پیدا کی جاتی ہے۔
4	بعض حالتوں میں جلاب آور ادویات استعمال کر کے اسقاط کی حالت پیدا کی جاتی ہے۔
5	مذکورہ طریقہ کیلئے لیگنزیٹو ادویات یا کیسر آئل استعمال کیا جاتا ہے۔
6	بعض زہروں کے اثر سے نظام تولید میں ایسا اثر پیدا کیا جاتا ہے کہ اسقاط ہو جاتا ہے۔
7	اندام نہانی میں آرسینک، مرکری یا سوڈیم کلورائیڈ کا محلول ڈال کر یہ حالت پیدا کی جاتی ہے۔
8	رحم میں صابن کا محلول ڈال کر اسقاط کروایا جاتا ہے۔

نوٹ: ہم نے مذکورہ ادویات کا ذکر ایک علم کے حوالہ سے کیا اس معلومات سے غلط فائدہ اٹھانے والا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔



مجرمانہ اسقاط کے نقصانات

(SIDE EFFECTS OF CRIMINAL ABORTION)

تعارف (Introduction): مجرمانہ اسقاط حمل کا کوئی بھی طریقہ ہو خواہ مکینیکل میٹھڈ ہو یا میڈیسنل میٹھڈ ہو کوئی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مجرمانہ اسقاط سے مندرجہ ذیل نقصانات ہو سکتے ہیں؛

1	رحم کے اندر سوزش کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔	(Metritis)
2	رحم کی جھیلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کی سوزش ہو سکتی ہے۔	(Endometritis/Myometritis)
3	اس صورت سے جریان خون زیادہ ہونے سے جان جا سکتی ہے۔	(Haemorrhage/Death)
4	اندام نہانی کی سوزش ہو سکتی ہے وہاں چھوت کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔	(Vaginitis/Vaginal Infection)
5	قاذف نالیوں میں سوزش ہو سکتی ہے اور ان میں پیپ پڑ سکتی ہے۔	(Salpingitis)
6	نظام تولید کی کسی بھی خرابی سے زچہ شک میں جا سکتی ہے۔	(Shock may occur)
7	اوزار کے استعمال سے اندرونی اعضا زخمی ہو سکتے ہیں۔	(Internal wounds may occur)
8	کسی اندرونی خرابی کے زیر اثر عورت ہمیشہ کیلئے بانچھ ہو سکتی ہے۔	(Permanent sterility)
9	پیٹ کی جھلی کی سوزش ہو سکتی ہے۔	(Peritonitis)
10	حیض کے نظام میں خرابی آ سکتی ہے۔	(Menstrual disturbances)
11	لیکوریہ کا موزی مرض پیدا ہو سکتا ہے۔	(Leucorrhoea may occur)
12	اس کے اثرات کسی ایک عضو یا بہت سے اعضا تک پھیل سکتے ہیں۔	(Infection may spread)



اسقاط حمل کا علاج (TREATMENT OF ABORTION)

تعارف (Introduction): گزشتہ صفحات میں اسقاط (Abortion) کی مختلف اقسام بیان کی گئی ان کی قسم کے حوالے سے ان کا علاج قدرے مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر اسقاط کی صورت میں کچھ مشترکہ حالتیں ہوتی ہیں ان کے حوالہ سے ادویات کا ذکر کیا جا رہا ہے؛

اسقاط (Abortion) کے علاج کا مقصد اسقاط کا لوٹنا ہوتا ہے لیکن اسقاط کی وہ حالت جس میں اسقاط کو لوٹنا ناممکن نہیں ہوتا ہے وہاں اسقاط کے بعد کے حالات کو کنٹرول کرنا اس کا علاج تصور کیا جاتا ہے ممکنہ علاج درج ذیل ہے؛

خون روکنے کے لئے (Anti-Haemorrhage):

(Anaroxyl Inj)	☆..... اناروکسل انجکشن۔
(Transamine Inj)	☆..... ٹرانز امین انجکشن۔
(Azeptil Inj)	☆..... ازپٹیل انجکشن

وریدی ڈرپ (Intra-Venous Dirp):

(Gelafundin IV Drip 500cc)	☆..... جیلیفنڈین ڈرپ۔
(Haemaccel IV Drip 500cc)	☆..... ہیماکسل ڈرپ۔
(Haessteril Inf)	☆..... ہیزسٹرل ڈرپ۔
(Dextrose-Saline 5%)	☆..... ڈیکسٹروز سیلائن۔

درد کش ادویات (Analgesic Drugs):

(Pethidine Inj)	☆..... پیتھڈین انجکشن۔
(Liometacen Inj)	☆..... لیو میتا سین انجکشن۔
(Dicloran Inj / Tab)	☆..... ڈیکلوران انجکشن / گولیاں۔
(Brufen 400mg Tab)	☆..... بروفن گولیاں۔
(Temrol Inj)	☆..... ٹیمرال انجکشن۔
(Tramal Inj / Tab)	☆..... ٹرامال انجکشن / گولیاں۔
(Temgesic Inj / Tab)	☆..... ٹیم جیزک انجکشن / گولیاں۔

اینٹی بائیوٹک ڈرگز (Anti-Biotic Drugs):

(Amoxil Cap)	☆..... ایماکسل کپسول۔
(Velosef Cap)	☆..... ویلوسیف کپسول۔
(Claforan Tab)	☆..... کلینفوران گولیاں۔
(Ocibid Tab)	☆..... اوسی بیڈ گولیاں۔
(Proloxab Tab)	☆..... پرو لوکساب گولیاں۔
(Ofloxed Tab)	☆..... او فلو میڈ گولیاں۔
(Cipromed Tab)	☆..... سپرو میڈ گولیاں۔
(Novidat Inj / Tab)	☆..... نووی ڈیٹ انجکشن / گولیاں۔

☆☆☆

اسقاط حمل کے اسباب

(CAUSES OF ABORTION)

تعارف (Introduction): اسقاط حمل کے بہت سے اسباب یا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ان وجوہات کا تعلق ماں یا باپ یا بچے کسی سے ہوتا ہے۔ اس میں تولیدی اعضاء کی خرابی اور نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ذیل میں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے؛

بچے سے متعلق اسباب (Fetal Causes): بچے سے متعلق ابارشن کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں؛

1	دوران حمل ضرورت سے زیادہ ایکس رے کروانے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
2	کسی مرض کے باعث یوٹرس میں بچے کے مرجانے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
3	ٹروفوبلاسٹ کی خرابی کی وجہ سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
4	فیشس کو کوئی چوٹ لگے تو اسقاط ہو سکتا ہے۔
5	فیشس کی نامکمل نشوونما کے باعث بھی اسقاط ہو سکتا ہے۔

باپ سے متعلق اسباب (Paternal Causes): باپ سے متعلق ابارشن کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں؛

1	کسی خاوند کی طرف سے کثرت جماع کے باعث اسقاط ہو سکتا ہے۔
2	خاوند اگر دوران حمل جماع کے مشکل اور تکلیف دہ طریقے اختیار کرے تو اسقاط ہو سکتا ہے۔
3	اگر باپ کے اندر سوزاک کے اثرات ہوں تو ان اثرات کے بچے میں منتقل ہونے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
4	باپ کی طرف سے آتشکاز ہر بچے میں منتقل ہونے سے بھی اسقاط ہو سکتا ہے۔

ماں سے متعلق اسباب (Maternal Causes): ماں سے متعلق ابارشن کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں:

1	عورت کے اندر کسی بیماری کے جراثیم کی وجہ سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
2	ذیابیطس، سوزاک، آتشک، ملیریا کے اثرات سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
3	یوٹرس کے اندر کوئی خرابی ہو تو اسقاط ہو سکتا ہے۔ یوٹرس کی سوزش سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
4	یوٹرس کے ٹل جانے سے یا یوٹرس کی رسولی سے بھی اسقاط ہو سکتا ہے۔
5	جنین کی نشوونما ہو رہی ہو لیکن کسی خرابی سے یوٹرس نہ پھیل رہا ہو تو اسقاط ہو سکتا ہے۔
6	عورت کی جسمانی کمزوری یا اس میں خون کی کمی اسقاط کا باعث بن سکتی ہے۔
7	غیر متوازن اور زیادہ گرم اشیاء کے استعمال سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
8	زیادہ سخت کام کرنے سے یا بوجھ اٹھانے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
9	ہارمونز کے نظام کی خرابی سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
10	اورری میں کسی نقص کے پیدا ہونے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
11	یوٹرس کے اندر موجود ایمینیا ٹک ممبرین کی رطوبت بڑھ جانے سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
12	یوٹرس کے اندر موجود کوئی زخم اسقاط کا باعث بن سکتا ہے۔
13	ادویات کے غلط اور غیر مناسب استعمال سے اسقاط ہو سکتا ہے۔
14	فکر، پریشانی، غم سے بھی اسقاط ہو سکتا ہے۔



مس کیرج (MISCARRIAGE)

تعارف (Introduction): حمل ٹھہر جانے کے بارہ ہفتوں یا تین ماہ کے اندر اندر یوٹرس سے بچے کے اخراج کو مس کیرج کہتے ہیں۔ جبکہ حمل ٹھہر جانے کے بارہ ہفتوں کے بعد اور اٹھائیس ہفتوں سے پہلے حمل کے ضائع ہونے کو ہارشن کہتے ہیں۔

اگر یوٹرس میں کوئی خورش دوایا اوزار وغیرہ ڈال کر بارہ ہفتوں اور اس سے کم کے فیس کو یوٹرس سے خارج کر دیا جائے تو یہ قانوناً جرم ہے اور مجرمانہ مس کیرج کہلاتا ہے البتہ اگر حاملہ کسی خطرناک مرض تپ دق، ذیابیطس، ایڈز یا گردوں کے امراض وغیرہ میں مبتلا ہو اور حمل جاری رہنے کی صورت میں حمل اور حاملہ دونوں کے لئے خطرہ ہو تو ایسی صورت میں حاملہ کو بچانے کے لئے قانونی طور پر ڈاکٹرز کی ہدایت پر بارہ ہفتوں یا اس سے کم فیس کو یوٹرس سے خارج کر دینا معالجاتی یعنی تھیراپیونک مس کیرج کہلاتا ہے۔

ڈی اینڈ سی (D&C)

(DILATATION AND CURETTAGE OF UTERUS)

تعارف (Introduction): ڈی اینڈ سی سے مراد مصنوعی طور پر یوٹرس کی صفائی کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یوٹرس کی صفائی لازم ہو جاتی ہے یہ ضرورت کئی وجوہات کے باعث پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈی اینڈ سی کی ممکنہ وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں:

1	اگر عورت کو حمل قرار نہ پارہا ہو تو طبی نقطہ نظر سے بعض اوقات یوٹرس کی صفائی کے لئے ڈی اینڈ سی کرنی پڑتی ہے۔
2	یوٹرس کی اندرونی خرابی کے پیش نظر ڈی اینڈ سی کرنا پڑتی ہے۔
3	اگر قدرتی استقاط میں مکمل اندرونی صفائی نہ ہو تو پلے سینفا کا کوئی ٹکڑا اندر رہ جانے پر ڈی اینڈ سی کرنا پڑتی ہے۔
4	کسی اناڈی دایہ کی غلطی سے دوران زچگی پلے سینفا کا کوئی ٹکڑا اندر رہ جائے تو بھی ڈی اینڈ سی کرنی پڑتی ہے۔

ڈی اینڈی کا طریقہ کار (Procedure For D & C): ڈی اینڈی کرنے کیلئے درج ذیل خاص طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے:

1	عورت کو ایک خاص طریقہ سے کمر کے بل لٹا دیا جاتا ہے یہ حالت لیٹھوٹومی (Lithotomy) کہلاتی ہے۔
2	عورت کے پاؤں اٹھا کر لیبر ٹیبل کی مخصوص جگہ پر رکھ دیئے جاتے ہیں اور ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔
3	عمل شروع کرنے سے قبل لیڈی ہیلتھ وزیٹر اپنے ہاتھ اور اوزار جراثیم سے مکمل طور پر پاک کرتی ہے۔
4	عورت کے بیرونی اعضاء کے بال صاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس حصہ کو جراثیم کش محلول سے صاف کیا جاتا ہے۔
5	عمل شروع کرنے کیلئے ایک خاص آلہ سپیکولم (Spaculum) کو بیچائے میں داخل کیا جاتا ہے۔
6	سپیکولم سے یوٹرس کے سرویکس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور سرویکس پرویزلین (Vaseline) لگا دی جاتی ہے۔
7	سرویکس کھولنے کیلئے ڈائی لیٹر (Dialator) استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف سائز کے ڈائی لیٹر دستیاب ہوتے ہیں۔
8	اس مرحلہ پر اوزار کی مدد سے یوٹرس کی دیواروں کو اندر سے اچھی طرح صاف کر کے اسکے اندر کوئی چیز موجود ہو تو نکال دی جاتی ہے
9	ڈی اینڈی کا عمل مکمل ہونے پر یوٹرس کو جراثیم کش ادویات سے دھو کر پیڈر رکھ دیا جاتا ہے۔
10	پھر مریض کو آرام دہ بستر پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔

علاج (Treatment): درد کی حالت کنٹرول کرنے کیلئے درج ذیل ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں:

Morphine Inj	مارفین انجکشن	Acupan Inj	ایکوپان انجکشن
Temgesic Inj	ٹیم جیزک انجکشن	Diagesic Inj	ڈایا جیزک انجکشن
Cataflam Tab	کیٹا فلیم گولیاں	Tamrol Inj	ٹیمرال انجکشن
Dolobid Tab	ڈولوبڈ گولیاں	Froben Tab	فروبین گولیاں

☆ مناسب اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں۔

Vibramycin Cap	ویبرامائین سپسول	Kanacyn Inj	کینا سین انجکشن
Penglobe Tab	پنگلوب گولیاں	Velosef Inj	ویلو سیف انجکشن
Novidate Inj	نودی ڈیٹ انجکشن	Dalacin Cap	ڈیلا سین سپسول
Augmentin Tab	آگمین ٹین گولیاں	Oflomed Tab	اؤفلومیڈ گولیاں



بانجھ پن

(STERILITY)

تعارف (Introduction): بانجھ پن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک جوڑا نارمل طور پر کم از کم ہفتے میں دو مرتبہ جنسی فعل سرانجام دیتا ہے اور اگر دو سال کے بعد بھی ان کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا تو اس حالت کو بانجھ پن کہتے ہیں۔

بانجھ پن کی اقسام (Types Of Sterility): بانجھ پن کی درج ذیل دو اقسام ہیں:

1۔ **پرائمری بانجھ پن (Primery Sterility):** ایک ایسا جوڑا جس کے ہاں شادی کے بعد کبھی بھی حمل نہ ٹھہرا ہو۔

2۔ **سیکندری بانجھ پن (Secondry Sterility):** ایک ایسا جوڑا جس کے ہاں کم از کم پہلے ایک مرتبہ حمل ٹھہرا ہو چاہے پھر اس حمل کی خود بخود اہارشن ہو گئی ہو۔

عورتوں میں بانجھ پن کی وجوہات (Causes Of Sterility In Females): عورتوں میں بانجھ پن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً عورتوں میں بانجھ پن کی ایک وجہ عمر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بلوغت سے پہلے اور سن یاس کے بعد حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ عورتوں میں بانجھ پن کی ایک وجہ عام جسمانی بیماری مثلاً تپ دق، گردوں کی بیماری، ریتقان، جگر کی تختی اور ذیابیطس وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کی ایک اور وجہ خوراک کی کمی یا غیر متوازن خوراک بھی ہے۔ شادی کے بعد جنسی تعلقات میں کمی بھی بانجھ پن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کی ایک اور بڑی وجہ عورتوں میں نفسیاتی پیچیدگیاں بھی ہیں مثلاً خوف، ڈر، پریشانی، گھبراہٹ، ذہنی تناؤ اور دباؤ وغیرہ۔ شادی کے بعد کے گھریلو جھگڑے وغیرہ بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتے ہیں۔ عورتوں میں فیلوپین ٹیوبز سکڑ کر بانجھ پن پیدا کر سکتی ہیں اور لڑائی جھگڑے و نفسیاتی پیچیدگیوں کے باعث جنسی تعلقات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن کی ایک اور بڑی عام وجہ اووریز کافیل ہو جانا ہے۔ کئی مرتبہ جنسی ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ عورت کی فیلوپین ٹیوبز میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جانے کے بعد بھی حمل نہیں ٹھہرتا اور بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں یوٹرس میں فائبرائیڈز یا رسولی کے باعث بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ اینڈومیٹریٹس کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کی ایک اور اہم وجہ تھائی رائیڈ گلینڈ کا کم یا زیادہ کام کرنا بھی ہے۔ ذیابیطس کی بیماری بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ کئی مرتبہ یوٹرس اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یا اس میں ہل پڑ جانے کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ یوٹرس پیدائشی طور پر ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بانجھ پن

دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی مرتبہ میچائندہ سے خراش دار مادے لیکوریا کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے جس سے میچائندہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جو مرد کے اسپرمز کو ہلاک کر دیتی ہے اور یوں بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی عورتوں میں سرویکس قدرتی طور پر کافی تنگ ہوتا ہے یا سرویکس کے مقام پر سوزش ہوتی ہے، جو بانجھ پن کا سبب بنتی ہے۔ کئی عورتوں میں مردانہ اوصاف کے زیادہ ہو جانے پر بھی بانجھ پن نظر آتا ہے۔ حیض کی بے قاعدگی اور دیگر جنسی بیماریاں و دیگر خرابیاں بھی بانجھ پن کا موجب ہو سکتی ہیں۔ جماع کے دوران شدید تکلیف بھی بانجھ پن پیدا کر سکتی ہیں۔ کئی مرتبہ شوہر اور بیوی میں ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔

عورتوں میں بانجھ پن کی تشخیص (Diagnosis Of Sterility In Females): عورتوں میں بانجھ پن کی تشخیص کیلئے درج ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں:

1- **سروائیکل سمیر (Cervical Smear):** عورت کے سرویکس کا مواد لے کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جاسکے کہ کوئی نقصان دہ مادہ تو خارج نہیں ہو رہا جو بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

2- **اینڈومیٹریل بائیوپسی (Endometrial Biopsy):** اینڈومیٹریل بائیوپسی بھی بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں اینڈومیٹریل کا انتہائی چھوٹا سا ٹکڑا لیکر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا اینڈومیٹریل کی پرانی سوزش یا بی یا کیفر تو نہیں یا کسی اور وجہ سے اینڈومیٹریل تباہ تو نہیں ہو گئی۔

3- **ٹیوبل پوٹنسی ٹیسٹ (Tubal Potency Test):** ٹیوبل پوٹنسی ٹیسٹ بھی بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں سرویکس کے راستے آلات کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس داخل کر کے اسکی آواز ناف کے نیچے میٹھو سکوپ کی مدد سے سنی جاتی ہے آواز آنے کا مطلب فیلوپین ٹیوب کھلی اور نارمل حالت میں ہیں۔

4- **پوسٹ کوئٹل ٹیسٹ (Post Coital Test):** بانجھ پن کی تشخیص میں ایک اہم ٹیسٹ پوسٹ کوئٹل ٹیسٹ ہے۔ اس میں جنسی ملاپ کے چھ سے اٹھارہ گھنٹوں کے درمیان سرویکس کے قریب رطوبت حاصل کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اسپرمز کس حالت میں ہیں؟ مردہ ہیں یا نیم مردہ ہیں۔

5- **اوورین ریزرو ٹیسٹنگ (Ovarian Reserve Testing):** اس ٹیسٹ میں عورت کی اووریز میں موجود میچور اور ایم میچور ایگز کا معائنہ کر کے بانجھ پن کی وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

6- **پیلوک الٹراساؤنڈ (Pelvic Ultrasound):** الٹراساؤنڈ سے بھی پیلوئس کے اعضاء کا مشاہدہ بانجھ پن کی تشخیص میں مدد دیتا ہے۔

7- **ہیسترو سالپنگو گرافی (Hystero-salpingo Graphy):** اس ٹیسٹ میں انجکشن کے ذریعے کنٹراسٹ فلوئیڈ عورت کے یوٹرس میں داخل کر کے ایکس رے کئے جاتے ہیں اور ایکس رے کے ذریعے یوٹرس کی خرابی اور فیلوپین ٹیوبز کے کھلے یا بند ہونے کو دیکھا جاتا ہے۔

8۔ ہارمونل ایسے (Hormonal Assay): عورت کے خون میں ایسٹروجن، پروجسٹران، پرولکٹین، لیوٹی ٹائزنگ اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز چیک کئے جاتے ہیں۔ ان ہارمونز کی کمی یا بیشی عورتوں میں بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔

9۔ لپراسکوپ (Laparoscopy): اس ٹیسٹ میں عورت کی ناف کے قریب سرجیکل طریقے سے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا کر اس میں اینڈوسکوپک کیمرہ ڈال کر یوٹرس، فیلوپین ٹیوبز اور اووریز کی جانچ کی جاتی ہے۔

10۔ دیگر خون اور پیشاب کے ٹیسٹ (Other Blood & Urine Tests): اس کے علاوہ دیگر جنسی امراض کی تشخیص کے لئے بھی خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کئے جاسکتے ہیں۔

مردوں میں بانجھ پن کی وجوہات (Causes Of Sterility In Males): مردوں میں بانجھ پن کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مردوں میں بانجھ پن کی ایک وجہ عمر بھی ہے بلوغت سے پہلے یا عمر کے آخری حصے میں مرد بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مرد کی عام صحت اور غذا اگر اچھی نہ ہو تو بھی بانجھ پن کا مرض ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کا انحصار عورت سے ازدواجی تعلقات پر بھی ہے۔ اسی طرح بانجھ پن کا انحصار مرد کی نفسیاتی حالت پر بھی ہے۔ جنسی ہارمونز کی کمی بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ مرد کے اعضاء تناسل پر چوٹ بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ کئی مرتبہ کن پیڑوں یعنی مہمس کی بیماری کی پیچیدگی کے طور پر بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مردوں میں سپرمز کی کمی یعنی اولی گو سپرمیا (Oligospermia) یا سپرمز کی پیدائش کا نہ ہونا یعنی ایزوسپرمیا (Azoospermia) بھی بانجھ پن کا موجب ہوتا ہے۔ تھائی رائیڈ گلیٹڈ اگر اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہ دے تو بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کی بیماری بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ آتشک کی بیماری بھی بانجھ پن کا موجب ہو سکتی ہے۔ سوزاک کی بیماری بھی بانجھ پن کا موجب ہو سکتی ہے۔ مردوں میں خصیوں یعنی ٹیسٹیز کا پیٹ میں رہ جانا (Undescended Testes) بھی بانجھ پن پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے مرد جو ذہنی طور پر زنانہ خصوصیات کے حامل ہوں بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مردوں میں منی کی مقدار میں کمی بھی بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ بسا اوقات سپرمز کی حرکات سست اور صحیح سمت میں نہیں ہوتیں جو کہ بانجھ پن پیدا کر سکتی ہے۔ ٹیسٹیز کا سپرمز پیدا نہ کرنا بھی بانجھ پن کر سکتا ہے۔ وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ شوہر اور بیوی میں ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔

مردوں میں بانجھ پن کی تشخیص (Diagnosis Of Sterility In Males): مردوں میں بانجھ پن کی تشخیص کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں:

1۔ منی کا ٹیسٹ (Semen Analysis): سپرمز کی تعداد، صحت، بناوٹ اور حرکات دیکھنے کیلئے منی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

2- سکروٹم / ٹیسٹیز کا الٹراساؤنڈ (Scrotal / Testicular Ultrasound): سکروٹم یعنی خسیوں کی تھیلی اور خسیوں کا الٹراساؤنڈ بھی بانجھ پن کی تشخیص میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

3- ٹیسٹی کولر بائیوپسی (Testicular Biopsy): ٹیسٹی کولر بائیوپسی کی مدد سے خسیوں میں کسی بھی قسم کی پتھالوجی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

4- ہارمونل ایسے (Hormonal Assay): مردوں میں جنسی ہارمونز کی مقدار کا بھی ٹیسٹ کر کے بانجھ پن کی وجہ معلوم کی جاسکتی ہے۔ مرد کے خون میں ٹیسٹوسٹیرون، پرولکٹین، لیوٹی ٹائروپین اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز چیک کئے جاتے ہیں۔ ان ہارمونز کی کمی یا بیشی مردوں میں بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔

5- دیگر خون اور پیشاب کے ٹیسٹ (Other Blood & Urine Tests): اس کے علاوہ دیگر جنسی امراض کی تشخیص کے لئے بھی خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کئے جاسکتے ہیں۔

بانجھ پن کا علاج (Treatment Of Sterility): بانجھ پن کا علاج کسی بھی معالج کی انتہائی ذہانت اور قابلیت مانگتا ہے۔ بانجھ پن کا علاج عموماً تشخیص مکمل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ بانجھ پن کا علاج مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پر شروع کیا جاتا ہے۔ بانجھ پن کے علاج میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ بانجھ پن کی وجوہات کی تشخیص ہے اور بانجھ پن کی اسی تشخیص کی مناسبت سے عورت یا مرد یا دونوں کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو بانجھ پن کے علاج میں انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ بانجھ پن کا علاج نہایت صبر آزما، طویل اور مہنگا ہوتا ہے لہذا بانجھ پن کے کسی بھی مریض یا جوڑے کو علاج کے سلسلے میں اپنے معالج کیساتھ مکمل تعاون اختیار کرنا چاہیے۔ بانجھ پن کا علاج درج ذیل اصولوں پر کریں:

(No treatment for Azoospermia)	☆..... مردوں کی منی میں اگر اسپرمز نہ ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔
(Antibiotics for semen infection)	☆..... مردوں کی منی میں انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹکس دیں۔
(Antibiotics for urinary infection)	☆..... مردوں میں یورینری انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹکس دیں۔
(Neotonophos for Oligospermia)	☆..... مردوں میں اسپرمز کی کمی ہو تو نیوٹونوفاس گولیاں دیں۔
(Tab Pro-viron for Neurasthenia)	☆..... مردوں میں سیکس کی کمی ہو تو پرو ویرن گولیاں دیں۔
(Tab E-Vion 400mg for weak sex)	☆..... سیکس کی طاقت کیلئے ای ویان 400 ملی گرام گولیاں دیں۔
(Tab Anafranil for early discharge)	☆..... مردوں میں سرعت انزال کیلئے اینا فرانل گولیاں دیں۔
(Hormonal drugs for low hormones)	☆..... مردوں میں مردانہ ہارمونز کم ہوں تو ہارمونل ڈرگز دیں۔

(Antibiotics for U.T.I in females)	☆..... عورتوں میں یورینری انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹکس دیں۔
(Tab Flagyl 400mg for Leucorrhoea)	☆..... عورتوں میں لیکوریا ہو تو فلیجیل 400 ملی گرام گولیاں دیں
(Vaginal cream for vaginal infection)	☆..... ویجائٹل انفیکشن ہو تو ویجائٹل کریم کا استعمال کریں۔
(Antifungal cream for fungal infection)	☆..... فنگل انفیکشن ہو تو اینٹی فنگل کریم کا استعمال کریں۔
(Surgical treatment for uterine fibroid)	☆..... یوٹرائن فائبرائیڈ ہو تو سرجیکل علاج کریں۔
(Hormonal drugs for ovarian cyst)	☆..... اوورین سسٹ ہو تو ہارمونل ڈرگز کا استعمال کریں۔
(Hormonal drugs for menses problem)	☆..... ماہواری کی خرابیاں ہوں تو ہارمونل ڈرگز کا استعمال کریں۔
(Colmiphen citrate for idiopathic causes)	☆..... کوئی وجہ تشخیص نہ ہو تو دونوں کوکلو می فن سائیٹ ریٹ دیں۔



بے محل حمل

(ECTOPIC GESTATION)

تعارف (Introduction): اگر حمل یوٹرس کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً فیلوپین ٹیوب، اووری، سرویکس وغیرہ میں ٹھہر کر بڑھنے لگے تو ایسی کنڈیشن کو ایکٹا پک جیسٹیشن یا بے محل حمل کہتے ہیں۔ عام طور پر حمل فیلوپین ٹیوب میں ہی قرار پاتا ہے جو کہ بعد میں یوٹرس کی جانب ٹرانسفر ہوتا ہے اور یوں بچہ نو مہینے تک یوٹرس میں ہی بڑھتا رہتا ہے۔

بے محل حمل کی وجوہات (Causes Of Ectopic Gestation):

ایکٹا پک جیسٹیشن کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں؛
 اگر فیلوپین ٹیوب میں کوئی نقص ہو تو حمل وہیں پر بڑھنے لگتا ہے۔ بسا اوقات اووم کا حجم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس میں داخل نہیں ہو سکتا، کئی مرتبہ فیلوپین ٹیوب غیر معمولی طور پر لمبی گہری اور خم دار ہو سکتی ہیں۔ پروجسٹران ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے فیلوپین ٹیوب کی حرکات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ فیلوپین ٹیوب کی سوزش کی وجہ سے ٹیوب کی سیلری موومنٹ ناکارہ ہو سکتی ہے اور اووم حرکات نہ ہونے کی وجہ سے وہیں رک کر بڑھنے لگتا ہے۔

بعض اوقات عورت کی فیلوپین ٹیوب میں ایک کی جگہ دو یا کئی سوراخ ہو سکتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوب کی اس حالت کو ایکسری لیومن (Accessory Lumen) کہتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوب کی سوزش کی صورت میں ٹیوب کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور اووم وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اگر ٹیوب سکڑ کر بند ہو گئی ہو تو بھی بے محل ٹھہر سکتا ہے۔ فیلوپین ٹیوب کی نشوونما صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی بے محل حمل قرار پا سکتا ہے۔ اگر یوٹرس کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریم غیر معمولی طور پر موٹی ہو جائے تو بھی ایکٹا پک جیسٹیشن کا عمل وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔

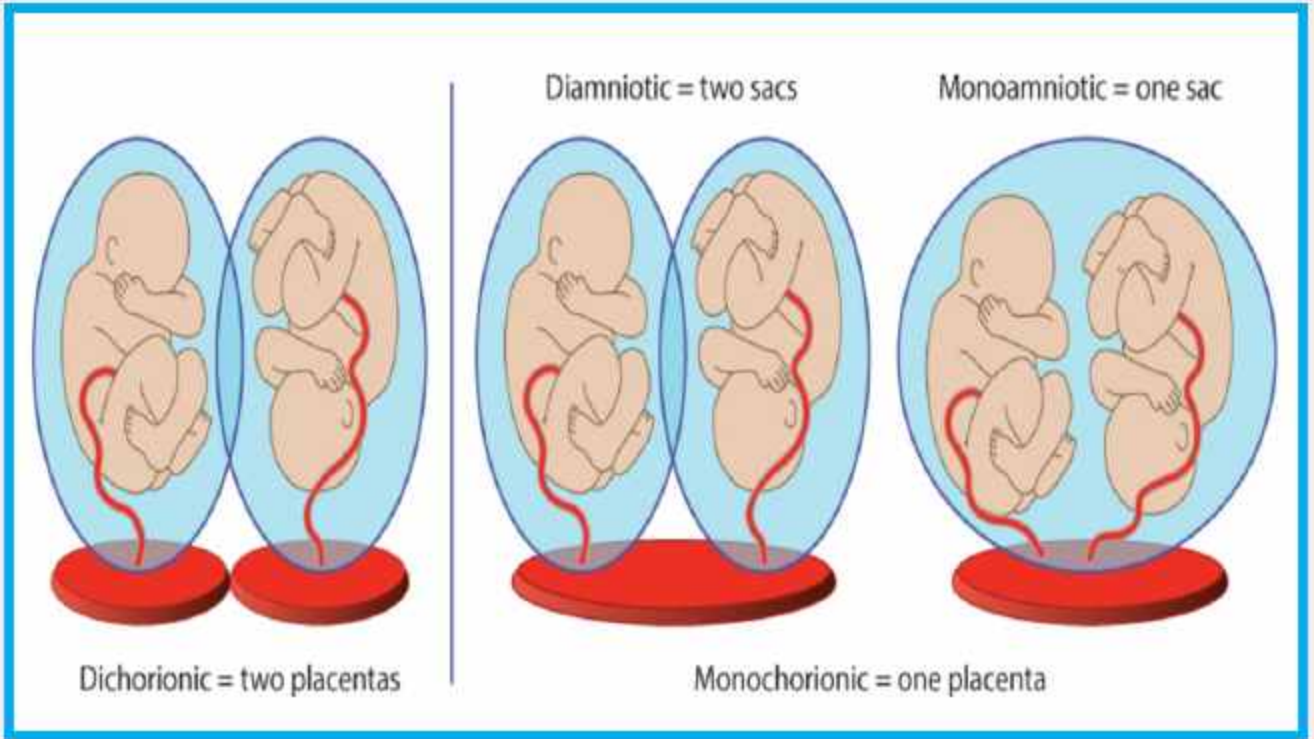
بے محل حمل کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Ectopic Gestation): بے محل حمل یعنی ایکٹا پک جیسٹیشن کی

درج ذیل علامات ہو سکتی ہیں:

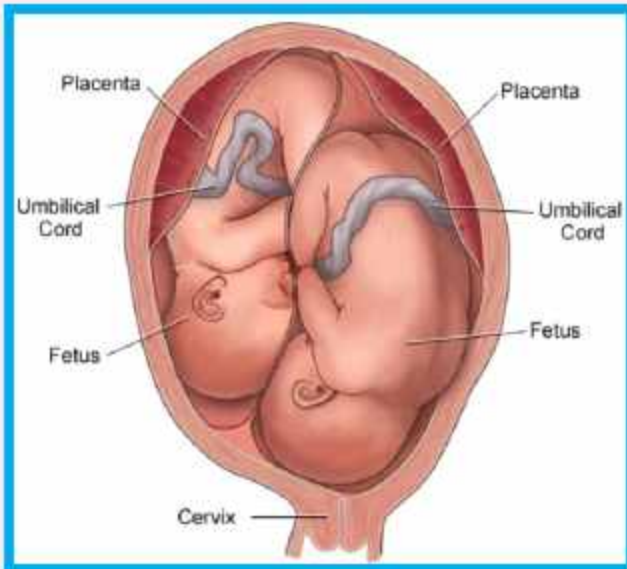
1	مریضہ پیلووس میں ہر وقت ہلکے ہلکے درد کی شکایت کرتی ہے۔	(Dull pelvic pains)
2	یہ درد کبھی کبھی شدید بھی ہو جاتا ہے۔	(May become severe)
3	ایسی خواتین میں ہر وقت فیلوپین ٹیوب کے مقام پر غیر معمولی کھنچاؤ رہتا ہے۔	(Stretch on fallopian tube)
4	ایسی خواتین میں فیلوپین ٹیوب کے مقام پر درد ہوتا رہتا ہے۔	(Pain on fallopian tube)
5	مریضہ کو پیشاب بار بار آتا ہے۔	(Polyuria)
6	مریضہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے۔	(Anaemia)
7	مریضہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں۔	(Dark circles around eyes)
8	درد کی کیفیت میں مریضہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔	(Pallor during pain)
9	شدید درد کی صورت میں مریضہ شاک میں جا سکتی ہے۔	(May go in shock)
10	شدید درد کی صورت میں بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔	(Hypotension)
11	مریضہ کو متلی اور قے ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں۔	(Nausea, vomiting, giddiness)
12	جب فیشس کی موت واقع ہو جائے تو جریان خون شروع ہو جاتا ہے۔	(Vaginal bloody discharge)

بے محل حمل کا علاج (Treatment Of Ectopic Gestation): جب مریضہ کو پیڑ و میس شدید درد ہوتا ہے یا پھر ویجائٹل بلیڈنگ ہوتی

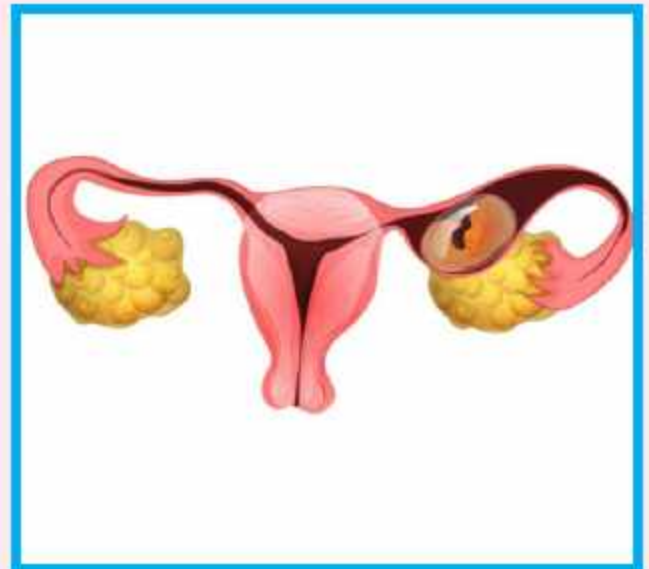
ہے تو مریضہ کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے جس سے کہ ایکٹا پک جیسٹیشن کی تشخیص ہوتی ہے اور پھر مریضہ کو سرجری کے لئے ریفر کر دیا جاتا ہے جہاں کہ مریضہ کا پیٹ سرجری کے ذریعے چاک کر کے حمل ضائع کر دیا جاتا ہے اور متاثرہ فیلوپین ٹیوب نکال دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علاج کے طور پر درج ذیل ادویات دی جاتی ہیں:



Multiple Pregnancy



Twin Pregnancy



Ectopic Pregnancy

Diagesic Tab	ڈایا جیزک گولیاں (درد کیلئے)	Dicloran Inj	ڈکلوران انجکشن (درد کیلئے)
Velosef Cap	ویلو سیف کپسول (انفیکشن کیلئے)	Amoxil Inj	ایمکسل انجکشن (انفیکشن کیلئے)
Transamin Cap	ٹرانز امین کپسول (بلیڈنگ کیلئے)	Transamin Inj	ٹرانز امین انجکشن (بلیڈنگ کیلئے)
Buscopan Tab	بسکو پان گولیاں (سپازم کیلئے)	Gravinate Inj	گریویٹ انجکشن (متلی کیلئے)



حمل کے نفسیاتی وجہ باتی پہلو

(EMOTIONAL ASPECTS OF PREGNANCY)

تعارف (Introduction): افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہنا جملہ ذی حیات مخلوقات میں ایک قدرتی اور طبعی عمل ہے۔ اسی طرح نسل انسانی میں بھی عورتوں کو شادی کے بعد حمل قرار پانا ایک طبعی اور قدرتی عمل ہوتا ہے لیکن اسکے باوجود عورت کو نہ صرف پہلی مرتبہ بلکہ بعد ازاں بھی ہر بار حمل قرار پانے پر مختلف اقسام کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو زیادہ تر مندرجہ ذیل ہوتے ہیں۔ جسمانی افعال میں جو گونا گوں تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

(Nausea)	جی متلانا۔	1
(Vomiting)	قے ہونا۔	2
(Changes in appetite habits)	بھوک کی کیفیت کا بدل جانا۔	3
(Dislikings from good foods)	کئی ایک اچھی غذاؤں سے نفرت ہو جانا۔	4
(Like to eat muddy things)	گچی اور مٹی وغیرہ کھانے کی رغبت پیدا ہو جانا۔	5
(Polyuria)	پیشاب کا بار بار آنا۔	6
(Piles)	بواسیر کی شکایت کا لاحق ہونا۔	7
(Constipation)	قبض کا ہو جانا۔	8
(Depress and restless)	غمزدہ اور بے چین رہنا۔	9
(Irritability)	چڑچڑاپن پیدا ہو جانا۔	10

زمانہ حال میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ حمل کے دوران ابارشن ہو جانے کے کیس آئے دن سنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں ایسے کیسوں میں بھی کوئی کمی نہیں جن میں وضع حمل کا مرحلہ با آسانی طبعی انداز سے سرانجام پانے کی بجائے ایسی غیر طبعی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ زچہ اور بچہ دونوں کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور کئی ایک بچوں کی پیدائش تو چیر بھاڑ یعنی آپریشن کے بغیر ہو ہی نہیں پاتی۔ اس نوعیت کے واقعات جب ایک حاملہ بار بار سنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ انجانے خوف، دہشت اور تشویش کا شکار رہنے لگتی ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حاملہ عورت کو اس نوعیت کی کیفیات سے دوچار ہونا پڑے۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ حاملہ کو ذہنی طور پر پہلے سے مناسب انداز سے ان تغیرات کو خوش دلی سے برداشت کرنے کے لئے تیار کیا جائے جن سے وہ حمل کے دوران دوچار ہو سکتی ہے اور پختگی کے ساتھ ان امراض کو ذہن نشین کروایا جائے کہ مذکورہ تغیرات سے پیدا ہونیوالی پریشانیوں اور تفکرات پر قابو پانے میں ہی خود حاملہ کی اور آنے والے بچے کی بہتری مضمر ہے دوسری صورت میں بے جا فکر و تر دیا خوف و دہشت سے خود حاملہ کو اور آنیوالے بچے کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے

پیچیدگیاں (Complication): حمل کے جذباتی پہلوؤں میں جہاں عورت میں جذبات کی شدت ہوتی ہے وہاں اس شدت سے بعض اوقات کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاص کر ایسی عورتوں میں جنہوں نے بلوغت کے بعد تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا ہو اور طبعی خرابیاں شروع سے ہی موجود ہوں۔ بہت سی عورتوں کو حمل کے دوران تحفظ، محبت اور توجہ حاصل نہیں ہو پاتی یا وہ خاندانی و معاشرتی انتشار کا شکار ہوتی ہیں اور یوں کئی بیماریاں طبعی حالات کے مطابق مختلف شکل میں اپنا اثر قائم کر لیتی ہیں۔ اکثر شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو حاملہ نہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے بلکہ رد عمل کے طور پر مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کا اثر جنین پر بھی پڑتا ہے۔

علاج (Treatment): عورت کے جذباتی پہلوؤں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس کا شوہر بہت حد تک مددگار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران جو تکالیف ہوتی ہیں وہ ذہنی احساسات، خوف، خوشی اور جذبات سے تعلقات رکھتی ہیں اس وقت شوہر کی طرف سے مثبت انداز اور دلجوئی حاملہ کیلئے تمام تر دواؤں سے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ شوہر کے علاوہ نرس اور ڈاکٹر حاملہ کو زچگی کے طریقہ کار سے آگاہ کرتے رہیں تو حاملہ کے ذہن کا انتشار اور خوف بہت کچھ کم ہو سکتا ہے۔ دوران حمل کسی بھی ڈاکٹر کی یہ از حد کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے حاملہ کو دواؤں کے استعمال سے بچایا جائے لیکن اگر دواؤں کا استعمال انتہائی ضروری ہو تو اس صورت میں معالج ایسی ادویہ کا استعمال حاملہ کو کرائے جس سے ذہنی سکون اور وضع حمل کے قریب در دوں میں کمی رہے اس کے علاوہ حفظان صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زود و ہضم اور متناسب غذا حاملہ کو دوسری تکالیف سے بچاتی ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

یونٹ: 9

حاملہ کی ہسٹری اور طبی معائنہ

(HISTORY & CLINICAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMAN)

تعارف (Introduction): گائنا اینڈ آسٹینرکس کی کلینکل پریکٹس کے دوران کسی بھی حاملہ خاتون کی ہسٹری لینا اور اس کا تفصیلی طبی معائنہ کرنا اس کی اور پیدا ہونے والے بچے کی صحت کیلئے انتہائی اہم ہے۔ حاملہ خاتون کی ہسٹری لیتے وقت اور معائنہ کرتے وقت کئی اہم اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ذیل میں حاملہ خاتون کی ہسٹری لینے کا طریقہ کار اور معائنہ تفصیلاً درج کیا جا رہا ہے:

ہسٹری (History): کسی بھی حاملہ خاتون کی ہسٹری لیتے وقت اس کی پہچان کیلئے درج ذیل چند چیزوں کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے:

(Name)	نام۔	☆
(Age)	عمر۔	☆
(Address)	پتہ۔	☆
(Husband's Name)	خاندان کا نام۔	☆
(Husband's Occupation)	خاندان کا پیشہ۔	☆

ماہواری کی ہسٹری (Menstrual History): حاملہ خاتون سے پہلی مرتبہ آنے والی ماہواری کی ہسٹری پوچھیں۔ جب کسی بالغ خاتون کو پہلی مرتبہ ماہواری آتی ہے تو اسے مینارک (Menarche) کہتے ہیں۔ حاملہ کے مینسٹروئل سائیکل (Menstrual Cycle) کے دورانیے کے متعلق پوچھیں۔ یہ دورانیہ آخری ماہواری کے پہلے دن سے اگلی ماہواری کے پہلے دن تک ہوتا ہے اور عموماً یہ دورانیہ سات سے اٹھائیس دن تک ہو سکتا ہے۔ ماہواری میں باقاعدگی، خون کی مقدار اور ماہواری کتنے دنوں تک جاری رہتی ہے؟، کے متعلق تفصیلاً پوچھیں۔ ایک صحت مند خاتون میں عموماً ماہواری کے دوران خون کا اخراج دو سے سات دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کے دوران درد سے متعلق پوچھیں۔ آخری ماہواری آنے کی تاریخ انتہائی احتیاط سے پوچھیں جسے گائنا کی اصطلاح میں Date of Last Menstrual Period یعنی L.M.P کہتے ہیں۔ حاملہ سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں (Oral Contraceptive Pills) تو نہیں لیتی رہی کیونکہ بعض اوقات ان گولیوں کو چھوڑنے کے بعد خاتون میں ماہواری کی بندش یا اے مینوریہ کی شکایت ہو سکتی ہے جسے وہ حمل سمجھ بیٹھتی ہے۔

ڈیلیوری کی ممکنہ تاریخ (Expected Delivery Date): اسے مختصراً E.D.D بھی کہتے ہیں۔ اسے آخری ماہواری کے پہلے دن سے گنتے ہوئے 280 دن تک شمار کرتے ہیں۔ اسے نیگلز کے طریقے (Neagele's Method) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقے میں 9 مہینے اور 7 دن آخری ماہواری کے پہلے دن سے جمع کیے جاسکتے ہیں مثال کے طور پر:

11-01-16 = آخری ماہواری کے پہلے دن کی تاریخ

18-10-16 = ڈیلیوری کی ممکنہ تاریخ (E.D.D)

لیکن اس ضمن میں شرط یہ ہے کہ اس خاتون کی ماہواری کا سائیکل باقاعدہ چلتا ہو۔



آبسنیٹرکس کی اہم اصطلاحات (Important Obstetrical Terminology): آبسنیٹرک ہسٹری لینے کے طریقہ کار سے پہلے درج ذیل چند بنیادی اصطلاحات کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ آبسنیٹرک ہسٹری بنانے میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو:



پیریٹی (Parity): پیریٹی کا مطلب ہے کہ خاتون نے کتنے بچوں کو اٹھائیں یا اٹھائیں سے زائد ہفتوں کے بعد جنم دیا ہے چاہے بے شک وہ بچے زندہ پیدا ہوئے ہوں یا مردہ پیدا ہوئے ہوں، خواہ وہ حمل ایک بچے والا تھا یا کہ جڑواں بچوں والا یعنی ملٹی پل پریگ نیسی (Multiple Pregnancy) والا، اس بچے کی پیدائش جس طرح بھی ہوئی ہو یعنی ویجائن کے راستے سے یا سیزیرین سیکشن (Caesarean Section) کے طریقے سے، لہذا ایسی خاتون کو پیرس (Parous) کہیں گے اگر اس نے کسی بچے کو اٹھائیں ہفتوں پر یا اٹھائیں ہفتوں کے بعد جنم دیا ہو۔



گریویڈا (Gravida): اگر گریویڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شادی شدہ خاتون کو کتنی مرتبہ حمل ہو چکا ہے؟ ہمیں اس بات سے قطعی غرض نہیں ہوتی کہ یہ حمل کس جگہ پر ہوا تھا اور اس حمل کا دورانیہ کتنا تھا؟ گریویڈا میں انٹرایوٹرائن پریگ نیسی (Intrauterine Pregnancy)، ابارشن (Abortion) اور ایکٹا پک پریگ نیسی (Ectopic Pregnancy) والے تمام حمل بھی شمار ہوتے ہیں۔



پریگنی گریویڈا (Primigravida): جو خاتون زندگی میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے اسے پریگنی گریویڈا (Primigravida) کہتے ہیں۔



پریگی پیرا (Primipara): اگر کسی خاتون نے پہلی مرتبہ اٹھائیس یا اٹھائیس ہفتوں سے زائد حمل کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہے تو اسے پریگی پیرا (Primipara) کہتے ہیں۔



ملٹی گریویڈا (Multigravida): جو خاتون زندگی میں دوسری مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ حاملہ ہو چکی ہو اسے ملٹی گریویڈا (Multigravida) کہتے ہیں۔



نلی پیرا (Nullipara): ایسی خاتون جس نے ایک بھی بچے کو اٹھائیسویں ہفتے یا اس کے بعد جنم نہ دیا ہو اسے نلی پیرا (Nullipara) کہتے ہیں۔



گرینڈ ملٹی پیرا (Grand Multipara): اگر کسی خاتون نے چھ یا چھ سے زائد بچوں کو اٹھائیسویں ہفتے میں یا اٹھائیسویں ہفتے سے زائد حمل کے بعد جنم دیا ہو، ایسی خاتون کو آسٹریٹک کی زبان میں گرینڈ ملٹی پیرا (Grand Multipara) کہتے ہیں۔



جسٹیشنل ایج (Gestational Age): عالمی ادارہ صحت (W.H.O) کے مطابق کسی حاملہ خاتون کی جسٹیشنل عمر سے مراد اس کی آنے والی آخری ماہواری کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ جسٹیشنل عمر کو دنوں یا ہفتوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔



زندہ بچے کی پیدائش (Live Birth): اگر ماں سے پراڈکٹ آف کنسپشن (Product of Conception) مکمل طور پر ڈیلیوری ہو جائے یا نکال دیا جائے، بے شک حمل کا دورانیہ جتنا بھی ہو، اور پیدا ہونے والا بچہ سانس لے یا اس میں زندگی کے دوسرے آثار جیسے دل کی دھڑکن، امیلائیکل کارڈ میں نبض کا ہونا، عضلات کی حرکت موجود ہو چاہے بے شک ابھی بچے کا امیلائیکل کارڈ نہ کٹا ہو یا پلے سینٹا ابھی تک ماں کے یوٹرس میں لگا ہوا ہو تو ایسی پیدائش کو زندہ بچے کی پیدائش یا لائیو برتھ (Live Birth) کہتے ہیں۔



پارچوریشن (Parturition): بچے کی پیدائش کے عمل کو پارچوریشن (Parturition) بھی کہتے ہیں۔



ڈیلیوری (Delivery): ڈیلیوری سے مراد پیدائش کا وہ سارا عمل ہے جس کے دوران پراڈکٹ آف کنسپشن (Product of Conception) مکمل طور پر بشمول پلے سینٹا (Placenta) باہر آجائے۔

پارچورینٹ (Parturient): وہ خاتون جو لیبر یعنی ڈیلیوری کے مرحلے سے گزر رہی ہو پارچورینٹ (Parturient) کہلاتی ہے۔



اسل برتھ (Still Birth): ایسا بچہ جو کہ اٹھائیسویں ہفتے کے حمل کے بعد پیدا ہوا اور جو مکمل طور پر پیدا ہونے کے بعد نہ تو سانس لے سکے اور نہ اس میں زندگی کے کوئی اور آثار موجود ہوں تو اسے مردہ بچہ یا اسل برتھ (Still Birth) کہتے ہیں۔ اسل برتھ دو طرح کی ہو سکتی ہیں؛



ابارشن (Abortion): ابارشن سے مراد پلے سینا ممبرین کا کچھ حصہ مکمل طور پر نکل جانا یا نکال دینا بے شک اس میں فیش کی پہچان ہو سکے یا وہ بغیر فیش کے ہو اور اس وقت اس فیش (زندہ یا مردہ) کا وزن پانچ سو گرام سے کم ہو، ابارشن کہلاتا ہے۔



آبسٹریٹک ہسٹری

(OBSTETRIC HISTORY)

تعارف (Introduction): کسی بھی حاملہ خاتون کی آبسٹریٹک ہسٹری (Obstetric History) اس کے پہلے حمل سے شروع کی جاتی ہے۔ اس میں درج ذیل نکات پر غور کیا جاتا ہے؛

☆.....	بچے کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟
☆.....	بچے کی جنس (Sex) کیا تھی؟
☆.....	بچے کا وزن (Weight) کتنا تھا؟
☆.....	حمل کا دورانیہ کتنا تھا؟
☆.....	لیبر (Labour) کا دورانیہ کتنا تھا؟
☆.....	ڈیلیوری کس طرح کی تھی؟
☆.....	ڈیلیوری گھر پر ہوئی یا کہ ہسپتال میں ہوئی؟
☆.....	ڈیلیوری کسی تربیت یافتہ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوئی تھی یا کسی دائی یا ایل ایچ وی (LHV) کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔

اگر بچہ پری میچور (Premature) پیدا ہوا تھا تو ایسی صورت میں درج ذیل چیزیں بھی اضافی طور پر پوچھنی چاہئیں؛

(Duration of Pregnancy)	☆..... حمل کا دورانیہ۔
(Hypertension)	☆..... بلڈ پریشر کی زیادتی۔
(Antepartum Hemorrhage)	☆..... اینٹی پارٹم ہیمرج۔
(Hypertension During Pregnancy)	☆..... دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی۔
(Renal Disease)	☆..... گردوں کی بیماری۔
(Placental Insufficiency)	☆..... پلے سینٹل ان سفی شینسی۔
(Weight of Baby)	☆..... پیدائش کے بعد بچے کا وزن کیا تھا؟
(Live birth or still birth)	☆..... کیا بچہ زندہ تھا یا نہیں؟

میڈیکل ہسٹری (Medical History): اس موقع پر حاملہ کی میڈیکل ہسٹری بھی لینی چاہئے اور درج ذیل نکات پوچھنے چاہئیں؛

(Diabetes)	☆..... ذیابیطس۔
(Heart Diseases)	☆..... دل کی بیماریاں۔
(Hypertension)	☆..... بلڈ پریشر کی زیادتی۔
(Renal Disease)	☆..... گردوں کی بیماری۔
(Tuberculosis)	☆..... تپ دق۔

مندرجہ بالا بیماریوں کے بارے میں اس لئے پوچھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر حاملہ خاتون میں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری موجود ہے تو پھر ایسی خاتون کی زیادہ میڈیکل کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایسی خواتین جنہیں دوران حمل ذیابیطس، بلڈ پریشر کی زیادتی یا گردوں کی بیماری ہو تو ایسی خواتین کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے اور ان کی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین جنہیں ذیابیطس ہوتی ہے ان میں فیٹس کا وزن اور جسامت زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے؛

☆.....	ماضی میں کسی ہسپتال میں داخلے کی ہسٹری؟
☆.....	ادویات کے استعمال کی ہسٹری؟
☆.....	ادویات سے الرجی کی ہسٹری؟

سرجیکل ہسٹری (Surgical History): اس موقع پر حاملہ کی سرجیکل ہسٹری بھی لینا ضروری ہے۔ سرجیکل ہسٹری نوٹ کرنے کے دوران درج ذیل نکات ذہن میں رکھے جاتے ہیں؛

☆.....	ماضی میں کسی آپریشن کی ہسٹری؟
☆.....	کیا پہلے کبھی سیزیرین سیکشن (C-Section) تو نہیں کروانا پڑا تھا؟

فیملی ہسٹری (Family History): فیملی ہسٹری میں موروثی امراض سے متعلق درج ذیل اہم چیزیں پوچھی جاتی ہیں؛

☆.....	ذیابیطس۔	(Diabetes)
☆.....	دل کی بیماریاں۔	(Heart Diseases)
☆.....	بلڈ پریشر کی زیادتی۔	(Hypertension)
☆.....	تپ دق۔	(Tuberculosis)
☆.....	خون کی بیماریاں۔	(Blood Disorders)

مندرجہ بالا بیماریوں کے بارے میں استفسار اس لئے ضروری ہے کہ ان بیماریوں کا آگے بچوں میں مستقل ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔
ذیابیطس، سکل سیل انیمیا (Sickle Cell Anaemia) اور پورفائیریا (Porphyria) خاندان میں موروثی طور پر چلا کرتے ہیں۔ کچھ خاندانوں میں کینسر (Cancer) اور دل کی بیماریاں بھی نسل در نسل چلا کرتی ہیں۔

ازدواجی ہسٹری (Marital History): حاملہ کی ازدواجی ہسٹری بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں درج ذیل نکات پوچھے جاتے ہیں:

☆.....	شادی کا دورانیہ؟
☆.....	پہلے کبھی بے اولادی کا مسئلہ تو نہیں رہا؟
☆.....	اگر بانجھ پن (Infertility) کا مسئلہ رہا ہے تو اس کا دورانیہ کتنا تھا؟
☆.....	ازدواجی زندگی میں زیادہ مسائل تو درپیش نہیں آئے؟
☆.....	مباشرت (Coitus) کتنے عرصے بعد کرتے تھے؟
☆.....	آرگیزم (Orgasm) کی ہسٹری؟
☆.....	جنسی تسکین (Sexual Satisfaction) حاصل ہوتی تھی یا کہ نہیں؟
☆.....	اگر حاملہ خاتون اس سے پہلے بھی شادی شدہ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں پچھلی شادی کا دورانیہ اور اس شادی کا نتیجہ کیا نکلا؟

ان سوالات کا پوچھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان سوالات کے بعد اس خاتون کی سماجی اور نفسیاتی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔

سوشل ہسٹری (Social History): حاملہ خواتین کی سوشل ہسٹری یعنی سماجی ہسٹری بھی لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں حاملہ کے گھر کی مالی حالت اور معاشی طور پر پوزیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بعض بیماریاں مثلاً اینڈومیٹریوسس (Endometriosis) امیر طبقے میں جبکہ تپ دق (Tuberculosis) وغیرہ غریب طبقے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ خاتون سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھیں اور اس کی مصروفیات کے بارے میں ضرور استفسار کریں یعنی وہ گھریلو خاتون ہے یا کہ کوئی ملازمت پیشہ خاتون ہے کیونکہ دوران حمل خاتون کو درپیش بعض مسائل کا تعلق اس کی مصروفیات اور پیشہ سے بھی ہوتا ہے۔

موجودہ حمل کی ہسٹری (History of Present Pregnancy): حاملہ خاتون کے موجودہ حمل سے متعلق بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس ضمن میں حاملہ خاتون کے موجودہ حمل سے متعلق مکمل ہسٹری لی جاتی ہے اور اس میں حاملہ خاتون کے طبی معائنہ میں درج ذیل چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔

☆.....	خاتون کا وزن کیا جاتا ہے۔
☆.....	اس کا قد نوٹ کیا جاتا ہے۔
☆.....	اس کے علاوہ خاتون کی چال میں لڑکھڑاہٹ یا کسی نقص کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔
☆.....	حاملہ خاتون کے پیلوک گرڈل کا بھی معائنہ اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ آیا عورت نارمل طور پر ویجائٹل ڈیلیوری کے قابل ہے یا نہیں۔

حاملہ کا کلینیکل ایگزامی نیشن

(CLINICAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMAN)

تعارف (Introduction): اس میں حاملہ کا جنرل فزیکل ایگزامی نیشن کیا جاتا ہے اس عمومی طبی معائنے میں درج ذیل چیزیں چیک کرتے ہیں:

(Pulse)	نبض۔	☆.....
(Temperature)	درجہ حرارت۔	☆.....
(Blood Pressure)	بلڈ پریشر۔	☆.....
(Respiratory Rate)	عمل تنفس کی رفتار۔	☆.....
(Pallor)	پیلہاٹ۔	☆.....
(Koilonychia)	کوائلو نائشیا۔	☆.....
(Anaemia)	خون کی کمی۔	☆.....
(Oedema)	سوجن۔	☆.....
(Jaundice)	یرقان۔	☆.....
(Dehydration)	پانی کی کمی۔	☆.....
(Oral Hygiene)	منہ کی صفائی۔	☆.....
(Enlargement of Thyroid Gland)	تھائیرائیڈ گلینڈ کی جسامت میں اضافہ۔	☆.....
(Examination of Lymph Glands)	لمف گلینڈز کا معائنہ۔	☆.....



Abdominal Examination



Abdominal Ultrasound



Abdominal Auscultation



Fetoscopy

چھاتیوں کا معائنہ

(BREASTS EXAMINATION)

تعارف (Introduction): بریسٹ ایگزامی نیشن میں حاملہ کی دونوں چھاتیوں کا بغور معائنہ کیا جاتا ہے اور درج ذیل چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے؛

(Swelling in Breast)	چھاتی میں سوجن کا ہونا۔	☆.....
(Tumour in Breast)	چھاتی میں کسی رسولی کا ہونا۔	☆.....
(Inversion of Nipple)	نیل کا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہونا۔	☆.....
(Discharge from Nipple)	نیل سے کسی رطوبت کا اخراج۔	☆.....
(Tenderness in Breasts)	چھاتیوں میں دبائے پر درد کا احساس ہونا۔	☆.....



پیٹ کا معائنہ

(ABDOMINAL EXAMINATION)

تعارف (Introduction): کسی بھی حاملہ میں پیٹ کا معائنہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں حاملہ کے پیٹ کا معائنہ درج ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے؛

(Inspection)	عام آنکھ سے معائنہ۔	☆.....
(Palpation)	ہاتھ سے ٹول کر معائنہ۔	☆.....
(Auscultation)	اسٹیتھو اسکوپ کی مدد سے معائنہ۔	☆.....

عام آنکھ سے معائنہ (Inspection Of Abdomen): پیٹ کے انسپکشن میں درج ذیل نکات نوٹ کئے جاتے ہیں؛

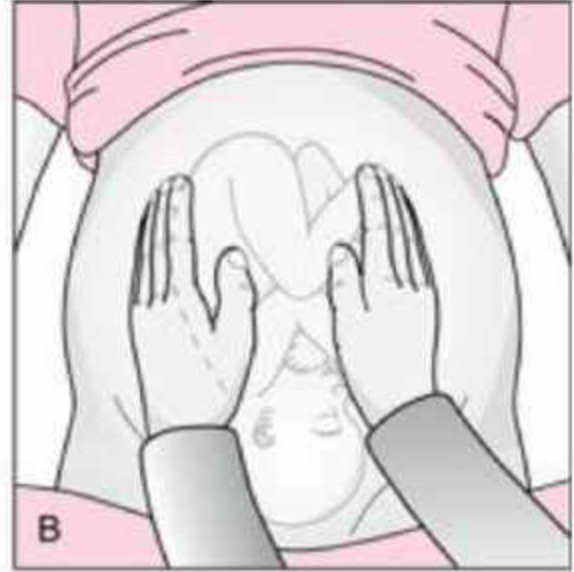
(Size)	☆.....	پیٹ کی جسامت اور سائز
(Shape)	☆.....	پیٹ کی ظاہری شکل
(Striae Gravidarum)	☆.....	پیٹ پر گزشتہ حمل کے نشانات (سٹرائی گریوڈ میم)
(Linea Nigra)	☆.....	پیٹ پر گزشتہ حمل کے باعث پڑنے والی عمودی لائن (لینیا نائیگرا)
(Scar)	☆.....	پرانے زخم کا نشان
(Varicose Veins)	☆.....	پیٹ کی ابھری ہوئی وریدیں

ہاتھ سے ٹول کر پیٹ کا معائنہ (Palpation Of Abdomen): حاملہ کی ایبڈامینل پیل پشن تین طریقوں سے کی جاتی ہے؛

(Fundal Palpation)	☆.....	فنڈل پیل پشن۔
(Lateral Palpation)	☆.....	لیٹرل پیل پشن۔
(Pelvic Palpation)	☆.....	پیلوک پیل پشن۔

فنڈل پیل پشن (Fundal Palpation): فنڈل پیل پشن میں لیڈی ڈاکٹر حاملہ کے پیٹ پر ایک ہاتھ سے پیل پشن (Palpation) کرتی ہے جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ حاملہ کے یوٹرس کو ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ فنڈل پیل پشن میں لیڈی ڈاکٹر حاملہ خاتون کے دائیں طرف کھڑے ہو کر اپنے بائیں ہاتھ کی ریڈیئل (Radial) یا الٹرنسائیڈ (Ulnar Side) کی مدد سے حاملہ کے یوٹرس کے اوپری حصے فنڈس (Fundus) کا اندازہ لگاتی ہے۔ یاد رکھیں جب یوٹرس کے اندر حرکات (Contractions) پیدا ہوں تو پیل پشن روک دینی چاہیے۔

لیٹرل پیل پشن (Lateral Palpation): اس میں لیڈی ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوٹرس کی باڈی (Body) پر رکھ کر نیچے کی طرف حرکت دیتی ہے اور پھر حاملہ کی لیٹرل پیل پشن کرتی ہے۔ اس میں کمر ایک ہموار پڑی ہوئی سطح کی طرح محسوس ہوتی ہے جبکہ ٹانگیں اور بازو بے ترتیب اجسام کی طرح ہاتھوں کے درمیان سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس پر دیکھیں لیڈی ڈاکٹر کا ایک ہاتھ ایک جگہ پر رہتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے پیل پشن کی جاتی ہے پھر دوسرا ہاتھ غیر متحرک ہو جاتا ہے اور پہلے ہاتھ کی مدد سے پیل پشن کی جاتی ہے۔



Abdominal Palpation During Obstetrical Examination

پیلوک پیل پشٹن (Pelvic Palpation): پیلوک پیل پشٹن میں لیڈی ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھ حاملہ کے یوٹرس کے نچلے پول کی اطراف میں رکھتی ہے اور فٹس (Fetus) کے سر کو محسوس کرتی ہے جو کہ سخت، ہموار، متحرک یعنی بیلائٹبل (Ballotable) ہوتا ہے۔

آسکل ٹیشن (Auscultation): کسی بھی حاملہ کے یوٹرس میں موجود زندہ بچے کے دل کی دھڑکن کی آوازیں آسکل ٹیشن یعنی اسٹیٹھو سکوپ کی مدد سے سنی جاسکتی ہیں۔ عام طور پر فٹس کے دل کی آوازیں کندھے کی عقبی جانب سنی جاسکتی ہیں۔ جب ایک لائن اس طرح بنائی جائے کہ وہ اینٹیریر سپیریئر ایلک سپائن (Anterior Superior Iliac Spine) سے ہو کر امبلایکس (Umbilicus) تک جائے تو اس لائن پر فٹس کے دل کی آوازیں، با آسانی آکسپٹوپوسٹیریور پوزیشن (Occipitoposterior Position) میں سنی جاسکتی ہیں۔ عموماً فٹس کے دل کی آوازیں 120 سے 160 مرتبہ فی منٹ تک ہوتی ہیں۔



ویجائنل ایگزامی نیشن

(VAGINAL EXAMINATION)

اگر کوئی خاتون پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی ہے تو وہ جس وقت بھی معائنہ کے لئے آئے اس کا پہلا معائنہ اسی وقت ہو جانا چاہیے جبکہ دوسرا معائنہ حمل کے چھتیسویں ہفتے میں یا لیبر کے دوران ہونا چاہیے تاکہ پیلوس کے بارے میں صحیح اندازہ ہو سکے۔ پہلے ویجائنل ایگزامی نیشن کا مقصد ماہواری کی بندش اور یوٹرس کی جسامت کے درمیان مطابقت کا پتہ چلانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورت کے اس ابتدائی معائنے کے نتیجے میں کچھ پیچیدگیوں کا وقت سے پہلے ہی پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اووری کے ٹیومرز (Ovarian Tumors) یا فائبرائیڈ (Fibroid) وغیرہ۔ اسی طرح ولوا (Vulva) اور ویجائنہ (Vagina) کا معائنہ کرتے وقت کسی قسم کے اخراج (Discharge)، سوجن (Swelling)، رگوں کا پھولا ہوا ہونا (Varicosities)، زخم (Lacerations)، رنگ میں تبدیلی (Discoloration) یا پروپلس (Prolapse) کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

دونوں ہاتھوں سے ویجائنل معائنہ (Bimanual Vaginal Examination): اس معائنے کے طریقے میں دائیں ہاتھ کی ایک یا دو انگلیاں ویجائنہ میں نرمی کے ساتھ داخل کی جاتی ہیں جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھا جاتا ہے۔ اگر حاملہ کی ویجائنہ میں دوا انگلیاں داخل کی جائیں تو بھی اتنی ہی معلومات حاصل ہوتی ہیں جتنا کہ ایک انگلی ویجائنہ میں ڈالنے سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس لئے ویجائنل ایگزامی نیشن میں ایک ہی انگلی داخل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ حاملہ اس سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دوران معائنہ حاملہ کا مثانہ خالی ہونا چاہیے۔

سرویکس کا معائنہ (Cervical Examination): سرویکس (Cervix) کا معائنہ کرتے وقت درج ذیل چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے؛

(Cervical Size)	سرویکس کی جسامت	☆.....
(Cervical Shape)	سرویکس کی شکل	☆.....
(Cervical Consistency)	سرویکس کی ساخت	☆.....
(Cervical Tear)	سرویکس میں چیر یا زخم	☆.....

اس کے بعد سرویکس کی باڈی (Body) کو درج ذیل چیزوں کے لئے چیک کیا جاتا ہے۔

(Cervical Body Size)	سرویکس کی باڈی کی جسامت	☆.....
(Cervical Body Position)	سرویکس کی باڈی کی پوزیشن	☆.....

اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرویکس کی باڈی اینٹی ورنڈ (Anteverted) ہے یا کہ ریٹرو ورنڈ (Retroverted) ہے۔ اس کے بعد حاملہ کے ایڈیکس (Adnexa) کا بھی کسی پیچیدگی کیلئے معائنہ کیا جاتا ہے۔

لیبر کے دوران وچ پائل ایگری نیشن (Vaginal Examination During Labour): لیبر کے دوران حاملہ خاتون کے وچ پائل کے راستے سے دو انگلیاں نرمی سے داخل کی جاتی ہیں اور انہیں آہستگی سے اوپر کی طرف دھکیلا جاتا ہے کہ دونوں انگلیاں حاملہ خاتون کے سیکرل پرومونٹری (Sacral Promontory) تک پہنچ جائیں۔ اب سمفائی سس پوبس (Symphysis Pubis) کے ٹچلے ہارڈر سے پرومونٹری (Promontory) تک کے فاصلے کی پیمائش بھی کر لی جاتی ہے۔

اب حاملہ کی اچھیل اسپائن (Ischial Spine) کو ٹوٹل کران کے پرامی نینس یا ابھار (Prominence) چیک کئے جاتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ سیکرو سپائینس لگا منٹ (Sacrospinous Ligament) کی پیمائش اس طرح کی جاتی ہے کہ انگلیوں کو اچھیل سپائن سے حرکت دے کر سیکرم تک کا فاصلہ معلوم کر لیا جاتا ہے۔

سیکرم کی سامنے کی سطح (Anterior Surface) آگے کی طرف مقعر (Concave) ہونی چاہیے اور اس پر کوئی چیز نکلی ہوئی یعنی کوئی پروجیکشن (Projection) یا پرامی نینس (prominence) نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آؤٹ لیٹ (Outlet) کا اینٹرو پوسٹیرئیر ڈایامیٹر (Anteroposterior Diameter) کی بھی پیمائش کر لینا چاہیے۔ جو کہ حاملہ خاتون کے سیکرم کی نوک (Tip of Sacrum) اور سمفائی سس پوبس (Symphysis Pubis) کے درمیانی فاصلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تمام ڈایامیٹرز کے علاوہ حاملہ خاتون کے سرویکس کو درج ذیل چیزوں کے لئے بھی چیک کیا جاتا ہے؛



Breast Examination



Vaginal Examination



Blood Pressure Examination



Examination For Anaemia

(Cervical Dilatation)	☆..... سرویکس کی ڈائیلٹیشن۔
(Cervical Effacement)	☆..... سرویکس کی ای فیس منٹ۔
(Cervical Position)	☆..... سرویکس کی پوزیشن۔
(Cervical Consistency)	☆..... سرویکس کی ساخت۔
(Cervical Relation to Presenting Part)	☆..... سرویکس کا پریزنٹنگ پارٹ سے تعلق۔

اسی طرح بچے کے سر کی پوزیشن کو چیک کیا جاتا ہے کہ آکسپٹو، انٹرنیر (Occipito-Anterior)، ٹرانس ورس (Transverse) یا پوسٹرنیر (Posterior)، فلکشن (Flexion) یا ڈی فلکشن (Deflexion) کی ڈگری اور انگیجمنٹ (Engagement) کتنی ہے۔ حاملہ کے یوٹرس میں بچے کے سر کو اس وقت انگیجڈ (Engaged) کہتے ہیں جب ویجائٹل ایگزامینیشن (Vaginal Examination) پر والٹ آف سکل (Vault of Skull) حاملہ کے انچیل اسپائن (Ischial Spine) کے درمیان آجائے۔ اسی طرح حاملہ کی یوٹرس میں موجود جھلیوں یا میمبرینز (Membranes) کو چیک کیا جاتا ہے کہ جھلیاں برقرار بھی ہیں یا کہ پھٹ چکی ہیں اگر جھلیاں پھٹ چکی ہیں تو لیکور ایمنیائی (Liquor Amnii) کی رنگت کیسی ہے اگر لیکور ایمنیائی میں میکونیم (Meconium) شامل ہو تو پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیکور ایمنیائی میں میکونیم تازہ ہے یا کہ پرانا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ نسلی میڈیسن

یونٹ: 10

حاملہ کا عمومی طبی معائنہ

(جنرل فزیکل ایگزامی نیشن)

(GENERAL PHYSICAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMAN)

تعارف (Introduction): کسی بھی حاملہ خاتون کے گائنا کولاجیکل اور آبسٹریٹریکل ایگزامی نیشن کے علاوہ اس کا جنرل فزیکل ایگزامی نیشن کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ حاملہ کی عام جسمانی صحت اور بیماریوں سے متعلق جنرل فزیکل ایگزامی نیشن ہی کے ذریعے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جنرل فزیکل ایگزامی نیشن کے سلسلے میں درج ذیل چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں:

(Pulse Rate)	☆..... نبض کی رفتار۔
(Blood Pressure)	☆..... بلڈ پریشر۔
(Respiratory Rate)	☆..... عمل تنفس کی رفتار۔
(Height)	☆..... قد۔
(Weight)	☆..... وزن۔
(Anaemia)	☆..... خون کی کمی۔
(Jaundice)	☆..... یرقان۔
(Cyanosis)	☆..... سایانوسس۔
(Oedema Face)	☆..... چہرے پر سوجن۔
(Oedema Arms / Legs)	☆..... بازوؤں یا ٹانگوں پر سوجن۔
(Pretibial Oedema)	☆..... پری ٹیبیئل۔
(Pre-sacral Oedema)	☆..... پری سیکرل اڈیما
(Examination of Neck)	☆..... گردن کا معائنہ

چھاتیوں کا معائنہ (Breast Examination): پہلے اینٹی ٹیل وزٹ پر چھاتیوں کا معائنہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ٹیل کی خرابیاں مثلاً ان کی مکمل نشوونما کا نہ ہونا، اندر کی طرف وحنسا ہونا، کٹا پھٹا ہونا جیسی کنڈیشن کا علاج اینٹی ٹیل پیریڈ میں کیا جاسکتا ہے۔



Pulse Examination



Blood Pressure Measurement



Respiratory Rate Measurement



Examination For Anaemia

پیٹ کا معائنہ (Abdominal Examination): پیٹ کے معائنے کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حاملہ کے یوٹرس کی جسامت اور جئیشنل ایجن میں مطابقت ہے یا کہ نہیں اور اسکے ساتھ کوئی دیگر پیچیدگی تو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حاملہ کی جلد پر موجود کسی قسم کے داغ و بھبھ یا جلد کی رنگت میں تبدیلی (Skin Pigmentation) اور لکیریں (Striae) وغیرہ بھی دیکھنے کیلئے لیڈا مینٹل ایگزامی نیشن ضروری ہوتا ہے۔ اگر حمل چوبیس ہفتے سے زائد ہے تو ایسی صورت میں پیٹ کے معائنہ پر فٹل ہارٹ ساؤنڈز (Fetal Heart Sounds) کو بھی سنا جاسکتا ہے۔

ویجائٹل ایگزامی نیشن (Vaginal Examination): کسی بھی حاملہ خاتون میں جنرل فزیکل ایگزامی نیشن کے دوران اس کا ویجائٹل ایگزامی نیشن بھی کرنا از حد ضروری ہے کیونکہ ویجائٹل ایگزامی نیشن میں ایکسٹرنل اور انٹرنل کیس آرگنز سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ویجائٹل ایگزامی نیشن کرنے کے دوران درج ذیل نکات کا خصوصی طور پر خیال کیا جاتا ہے؛

1۔ بیرونی جنسی اعضاء کا معائنہ کرتے ہوئے درج ذیل نکات ذہن میں رکھیں؛

☆..... پرانے زخم۔	(Old Injuries)
☆..... ویری کوز وینز۔	(Varicose Veins)
☆..... ویجائٹل جلدی بیماری۔	(Vaginal Skin Disease)
☆..... ویجائٹل ڈسچارج۔	(Vaginal Discharge)

2۔ سرویکس، یوٹرس اور ایڈینکسا کا معائنہ کریں اور اس میں دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل چیزیں نوٹ کریں؛

☆..... جسامت۔	(Size)
☆..... پوزیشن۔	(Position)
☆..... ساخت۔	(Consistency)

اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یوٹرس نرم ہے یا کہ سخت ہے اور اسی طرح یوٹرس کا ہموار پن بھی چیک کیا جاتا ہے۔

3۔ اووریز کے ٹیومرز یا فائبرائیڈز وغیرہ چیک کئے جاتے ہیں۔

4۔ سروائیکل سمر (Cervical Smear) لے کر اس کا سائیکل لاجیکل ایگزامی نیشن کروایا جاتا ہے۔

5۔ پیلوٹس کا معائنہ کر کے اس میں گنجائش (Capacity) اور اس کی شکل کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے۔

لیبارٹری ٹیسٹ (Laboratory Investigations): اسی طرح حاملہ کے جنرل فزیکل ایگزامی نیشن کا ایک اہم حصہ اس کے لیبارٹری ٹیسٹ یعنی لیبارٹری انوسٹی گیشن ہے۔ اس سلسلے میں حاملہ کے درج ذیل ٹیسٹ وغیرہ کئے جاتے ہیں جن سے حاملہ کی صحت اور بیماری سے متعلق بہت اہم، مفید اور بروقت جسمانی معلومات حاصل ہوتی ہیں؛



Height Measurement



Weight Measurement



Examination For Jaundice



Examination For Cyanosis

خون کا مکمل ٹیسٹ (Complete Blood Examination): اگر اس ٹیسٹ میں کوئی پیچیدگی نظر آئے تو پھر مریضہ سے مزید معلومات لی جاتی ہیں اور تفصیلاً معائنہ کیا جاتا ہے۔

بلڈ گروپنگ (Blood Grouping): پریگی گریوڈا میں بلڈ گروپنگ ضرور کروائی جاتی ہے۔ اس میں ABO بلڈ گروپنگ اور RH بلڈ گروپنگ دونوں ضروری ہوتی ہیں لیکن اگر ملٹی گریوڈا میں بلڈ گروپنگ کا پہلے سے پتہ ہے تو پھر دوبارہ بلڈ گروپنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر خاتون RH نیگیو (RH-Negative) ہے تو اس میں اینٹی باڈیز ٹیٹر (Antibodies Titre) کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔

پیشاب کا تجزیہ (Urinalysis): اگر پیشاب کے مکمل تجزیے کے ٹیسٹ یورین روٹین ایگزامینیشن (Urine R/E) میں شوگر مثبت ہو تو ایسی صورت میں یہ حاملہ خاتون ذیابیطس کا شکار ہو سکتی ہے اور اگر پیشاب میں البیومن آرہی ہو تو یہ حمل کے دوران بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لہذا یورین روٹین ایگزامینیشن بھی حمل کے دوران کیا جانے والا ایک اہم ٹیسٹ ہے۔

سینے کا ایکسرے (X-Ray Chest): اسے صرف اس صورت میں کروایا جاتا ہے جب حاملہ خاتون ٹی بی یا کسی اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں اور رسپائرٹری انفیکشن کے شک کی بناء پر بھی سینے کا ایکسرے کرایا جاتا ہے۔

ای سی جی (E.C.G): اگر حاملہ خاتون کو کسی قسم کے دل کا عارضہ لاحق ہے تو ایسی صورت میں ای سی جی کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔

سفلس (آفک) کے لئے ٹیسٹ (Test for Syphilis): سفلس کیلئے کئی سیرولوجیکل ٹیسٹ (Serological Test) دستیاب ہیں۔ انہیں حمل کے دوران پہلے بکنگ وزٹ پر کروانا اس لئے ضروری ہے تاکہ اگر حاملہ خاتون میں یہ بیماری موجود ہے تو بچے کو یہ مرض لاحق نہ ہو۔

روبیلا اینٹی باڈیز (Rubella Antibodies): حمل کے ابتدائی دنوں میں روبیلا کیخلاف پیدا ہونیوالی اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔

ٹاکسوپلازموس (Toxoplasmosis): ٹاکسوپلازموس ایک خطرناک مرض ہے اسکے خلاف بھی اینٹی باڈیز کو حمل کے ابتدائی دنوں میں ضرور ٹیسٹ کروائیں۔ اگر کسی حاملہ میں ٹاکسوپلازموس کا مرض موجود ہے تو ایسی حاملہ خاتون میں ابارشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

مخصوص ٹیسٹ (Special Investigations): مندرجہ بالا تمام ٹیسٹوں کے علاوہ اگر کسی حاملہ خاتون میں کسی اور مرض کی علامات موجود ہوں تو پھر اس خاص مرض کے لئے انفرادی طور پر مخصوص ٹیسٹ کروائے جاسکتے ہیں۔

